

TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

MARCO 3 – COMPROMISSO 8

6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE GOVERNO ABERTO



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Educação Popular em Saúde

TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

MARCO 3 – COMPROMISSO 8

6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE GOVERNO ABERTO

BRASÍLIA - DF

2026

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva
Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa
Coordenação-Geral de Educação Popular em Saúde

TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS:

Marco 3, do Compromisso 8, do 6º Plano de Ação Nacional de Governo Aberto

Presidente da República

Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidente da República

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

Ministro da Saúde

Alexandre Rocha Santos Padilha

Secretário Executivo do Ministério da Saúde

Adriano Massuda

Diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa

André Luis Bonifácio de Carvalho

Coordenadora-Geral de Educação Popular em Saúde

Maria Rocineide Ferreira da Silva

Coordenação do Projeto

André Luis Bonifácio de Carvalho

Maria Rocineide Ferreira da Silva

Autores(as)

Ana Suelen Pedroza Cavalcante

Lucas Dias Soares Machado

Marcos Aguiar Ribeiro

Maria Rocineide Ferreira da Silva

Revisão

Angela Fernandes Leal Silva

Gabriel Calazans Baptista

Hanna Gabrielle Santos Moreira dos Santos

Juliana Ramos Bruno

Maria Rocineide Ferreira da Silva

Colaboração

Coordenação de Monitoramento de Pisos Salariais (Comips/CGPRP/Degerts/SGTES/MS)

- Adauto Martins Soares Filho

Coordenação Geral de Educação Popular em Saúde (Cgeps/Dgip/SE/MS)

- Anderson Luiz Gomes De Sá
- Beatriz Amaral Ferreira da Silva
- Gabriel Calazans Baptista
- Hanna Gabrielle Santos Moreira Dos Santos
- Maria Rocineide Ferreira da Silva
- Renata Pekelman
- Talita Maria Lima da Silva
- Teresa Maria Passarella
- Tiago Souza Leal

Coordenação Geral de Gestão da Informação Estratégica em Saúde (Cggie/Seidigi/MS)

- Juliana Ramos Bruno

Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde (Deppros/Saps/MS)

- Angela Fernandes Leal Silva
- Raíssa Rodrigues Organista

Gabinete do Diretor de Gestão Interfederativa e Participativa (Dgip/SE/MS)

- Marcelo Machado de Carvalho

Design e Diagramação

Hanna Gabrielle Santos Moreira dos Santos

Talita Maria Lima da Silva

SUMÁRIO

<u>APRESENTAÇÃO</u>	006
PRODUTO 01	012
PRODUTO 02	088
PRODUTO 03	150
PRODUTO 04	266
ENCAMINHAMENTOS E DESDOBRAMENTOS	282



APRESENTAÇÃO

O 6º Plano de Ação Nacional de Governo Aberto do Brasil (2024–2027) representa o compromisso do país com a Parceria para Governo Aberto (OGP), visando ampliar a transparência e a participação social. O plano concentra-se em ações como o fortalecimento do acesso à informação, formulação e implementação de políticas públicas através do envolvimento e colaboração de órgãos governamentais e representantes da sociedade civil, buscando transformar e aprimorar os espaços de diálogos e interação entre os atores (Brasil, 2023).

Em outubro de 2024, representantes da Coordenação-Geral de Articulação Interfederativa e Participativa, do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (CGAIP/DGIP/SE/MS), renomeada Coordenação Geral de Educação Popular Saúde (CGEPS/DGIP/SE/MS) a partir do Decreto nº 12.708 de 31 de outubro de 2025, participaram de oficina promovida pela Coordenação-Geral de Promoção de Governo Aberto, da Diretoria de Governo Aberto e Transparência, da Secretaria de Integridade Pública/Controladoria-Geral da União-CGU.

A Oficina de cocriação foi referente ao tema/compromisso 8 “Participação Social com Educação Popular e Digital nos Territórios”, com vistas a desenvolver o 6º Plano de Ação Nacional da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership - OGP). Esse processo de construção coletiva conta com a participação paritária de especialistas do governo e da sociedade civil, com amplo debate para definição conjunta de compromissos que serão implementados até dezembro de 2027.

Destaca-se os diversos movimentos, reuniões, encontros, seminários e oficinas realizados, que proporcionaram diálogos potentes ao trazer para o cenário a relevância da participação social e da educação popular como pilares estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva da gestão compartilhada, da inclusão de sujeitos historicamente alijados do ciclo das políticas públicas e do protagonismo popular.

A parceria é uma iniciativa internacional, integrada por aproximadamente 76 países, da qual o Brasil é membro-fundador, e tem o objetivo de incentivar iniciativas relacionadas à transparência pública, à participação social, à responsividade e à inovação, para aprimorar políticas e serviços e solucionar questões de interesse público.

O 6º Plano é resultado de um esforço de cooperação que envolveu 80 instituições, sendo 47 organizações da sociedade civil e 33 entidades do governo. Sua construção vem sendo executada conforme metodologia definida previamente entre governo e sociedade, que prevê a realização de três etapas: Definição dos Temas, Oficinas de Co-criação, e Aprovação do Plano.

A definição dos temas que compõe o 6º Plano de Ação Nacional de Governo Aberto contou com ampla participação da sociedade e dos órgãos de governo. Esses 8 (oito compromissos podem ser acessados em: Confira os oito temas que compõem o 6º Plano de Ação Nacional de Governo Aberto — Controladoria-Geral da União (<https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/a-ogp/planos-de-acao>)).

A atuação da Cgeps/Dgip, enquanto representantes do Ministério da Saúde, teve interlocução com o compromisso: "definir/mapear territórios saudáveis e sustentáveis" (marco 3), como forma de "estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis", do 6º Plano de Ação de Governo Aberto do Brasil.

O conceito de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (TSS) surge ancorado no período da redemocratização do Estado brasileiro, a partir de reflexões sobre a relação entre território e saúde, no bojo da Reforma Sanitária, que promoveram a inclusão de movimentos sociais e populares na agenda da saúde.

Esse novo cenário ampliou o conceito de saúde e trouxe a questão da determinação social do processo saúde-doença para o centro do debate, tendo como foco os problemas reais, as necessidades sociais em saúde, que emergem de forma muito específica nos diferentes territórios do país, em especial entre as comunidades mais vulnerabilizadas, bem como a promoção da saúde territorializada, que leva em conta as singularidades das distintas comunidades.

A caracterização de TSS envolve a análise de condições mensuráveis por meio de pesquisas e sistemas de informação, assim como construtos não contemplados por esses. Assim sendo, sua caracterização pode, a priori, ser realizada a partir de determinantes de saúde (fatores sociais, econômicos e ambientais), indicadores de condições de saúde da população, indicadores de serviços de saúde e acesso, bem como indicadores ambientais.

O desafio é sem dúvida complexo, dada a necessidade de se trabalhar indicadores de base nacional, estadual e municipal, as questões de classe, raça/cor/ etnia e gênero, a violência, o saneamento básico, os desdobramentos da crise climática, considerando-se, ainda, a regionalização no SUS, desde seus microterritórios (ou unidades territoriais básicas) até as macrorregiões de saúde, para o devido reconhecimento das conformações comunitárias e suas especificidades.

De todo modo, é certo que as ações territoriais passam necessariamente pela promoção da saúde, pela vigilância em saúde de base territorial, hoje um debate profícuo em discussão do campo da vigilância popular em saúde, e pelo fortalecimento da atenção primária em saúde, buscando-se o reconhecimento do território cotidianamente e a escuta sensível e qualificada das vozes que emergem dessas comunidades.

A partir dos desafios que permeiam o desenvolvimento do marco 3, a CGAIP/DGIP/SE/MS planejou etapas (elaboração de produtos-estudos) que contribuíssem para o alcance desse compromisso no Brasil, buscando atender, no âmbito de nossa governabilidade, o cronograma pactuado e repactuado nas reuniões de monitoramento organizadas pela CGU.

O primeiro estudo teve como objetivo geral mapear as evidências sobre territórios saudáveis e sustentáveis, tendo sido observada uma polissemia no que concerne ao termo. Foi realizada uma revisão de escopo, conduzida a partir das orientações contidas no manual do Instituto Joana Briggs, além de buscas, em novembro de 2024, na National Library of Medicine and National Institutes of Health (MEDLINE/PubMed), na Scielo, na Scopus, na Biblioteca Virtual da Saúde e no google scholar.

Constatou-se que “sustentáveis” era um dos qualificadores dos “territórios saudáveis” e foi encontrada uma gama de indicadores que se relacionam predominantemente à sustentabilidade ambiental, à determinação social e ao acesso à saúde. Ressalta-se a importância de estudos adicionais que contribuam para identificação de indicadores que se adequam ao território brasileiro e assim qualificar a identificação de territórios saudáveis e sustentáveis.

O segundo estudo objetivou analisar o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis, segundo pressupostos metodológicos de Walker e Avant (2019) objetivando analisar a estrutura e função dos elementos constituintes do conceito em tela, considerando revisão de escopo com identificação e proposição de indicadores qualitativos e quantitativos. O terceiro estudo apresentou o mapeamento georreferenciado sobre territórios saudáveis e sustentáveis com foco nos indicadores, visando geração de evidências científicas.

Os resultados identificaram antecedentes (bases teóricas e influências conceituais; fundamentos político-institucionais; inclusão e mobilização da sociedade civil; diagnóstico e planejamento baseado em evidências; e cooperação multinível e redes), atributos (qualidade do espaço urbano; equidade e acesso universal; governança participativa; intersetorialidade; promoção da saúde; economia inclusiva e diversificada; pertencimento e coesão social; planejamento urbano inclusivo; inovação e monitoramento contínuo; e qualidade de vida e bem-estar integral) e consequentes (melhoria da saúde e qualidade de vida; redução de desigualdades e inclusão social; desenvolvimento ambiental; fortalecimento da governança e políticas públicas; engajamento coletivo e autonomia comunitária; benefícios econômicos e eficiência; promoção de estilos de vida saudáveis; e resiliência e preparação para crises), com a maioria dos estudos concentrada nas Américas, especialmente no Brasil.

A discussão destacou que territórios saudáveis exigem governança participativa e intersetorialidade, equidade no acesso a serviços básicos e saúde, sustentabilidade ambiental com espaços verdes/azuis e mobilidade sustentável, além de monitoramento contínuo com indicadores como o Índice de Território Saudável e Sustentável.

A análise conceitual permitiu delimitar territórios saudáveis como espaços geográficos e sociais nos quais a produção da vida emerge da interação dialética entre sociedade e natureza, mediada por uma abordagem integral da saúde como eixo estruturante da qualidade de vida e do bem-estar coletivo.

O estudo evidenciou a complexidade do conceito, reforçando a necessidade de padronização e aplicação prática em políticas públicas, com futuros estudos devendo desenvolver instrumentos de avaliação e fortalecimento da intersetorialidade para consolidação de territórios saudáveis como modelo de desenvolvimento urbano equitativo e sustentável, além da necessidade de ampliação do conceito para abarcar territórios não urbanos.

Na etapa de síntese e seleção preliminar, foram identificados os indicadores mais relevantes, considerando também a análise de conceito desenvolvida no primeiro estudo. Posteriormente, os indicadores foram submetidos a uma avaliação de qualidade, com base em critérios como relevância para o contexto brasileiro e disponibilidade de dados em fontes públicas.

O terceiro estudo apresentou o mapeamento georreferenciado sobre territórios saudáveis e sustentáveis com foco nos indicadores, visando geração de evidências científicas. O objetivo geral foi sistematizar evidências sobre indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis, com vistas a realizar um mapeamento georreferenciado.

O itinerário metodológico foi estruturado em quatro etapas principais: (1) revisão de escopo; (2) síntese e seleção preliminar de indicadores; (3) avaliação de critérios de qualidade dos indicadores; e (4) georreferenciamento dos indicadores selecionados.

Esses indicadores foram organizados em dimensões e subdimensões, refletindo a complexidade e a transversalidade dos fatores que compõem a noção de sustentabilidade territorial. Os indicadores foram distribuídos entre temas relacionados à sustentabilidade ambiental, condições socioeconômicas, saúde, participação comunitária, equidade, governança, planejamento e monitoramento, população, segurança, indicadores específicos e inovação e dados. Essa diversidade evidencia a multiplicidade de aspectos que devem ser considerados na formulação de políticas públicas comprometidas com o fortalecimento de territórios mais justos, resilientes e sustentáveis.

A partir de então, os indicadores taxa de mortalidade infantil (2023), percentual de cobertura da Atenção Primária à Saúde (2023), Índice de Equidade e Dimensionamento – IED (2024), incremento anual do desmatamento na Amazônia Legal (2008–2023) e a localização das Unidades de Conservação Ambiental (2023), territórios indígenas, quilombolas e assentamentos rurais foram georreferenciados com o apoio do software Quantum GIS (QGIS) 3.3, possibilitando a visualização espacial e estratégica dos territórios a partir das evidências sistematizadas. Esse mapeamento permitiu observar padrões territoriais e sobreposições críticas, revelando, por exemplo, a concentração de piores indicadores de saúde e sustentabilidade nas regiões Norte e Nordeste do país.

O quarto produto foi elaborado a partir de um encontro representações de populações e movimentos sociais populares de diferentes territórios, planejado para criar um espaço participativo de produção coletiva, além de validar e ampliar os resultados já encontrados. Como resultado da apresentação dos materiais e do debate dos presentes foram elaboradas diferentes dimensões que podem auxiliar na qualificação do debate sobre as TSS. Foram sistematizadas 11 categorias: sustentabilidade e manejo ecológico da terra; direitos territoriais e justiça socioambiental; saberes, ancestralidade e pertencimento; inovação comunitária e tecnologias sociais; conflitos e desafios estruturais; soberania e projeto de sociedade; justiça territorial e economia da vida; coletividade e poder popular; pertencimento e ancestralidade; território como espaço ético e político; sus forte

Na sequência deste relatório serão apresentados os produtos elaborados pelos quatro estudos citados, além da análise de seus resultados e os possíveis desdobramentos.



PRODUTO 01

DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO ESTUDO DEMONSTRANDO BUSCA E ANÁLISE CONCEITUAL SOBRE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS, COM O OBJETIVO DE REVISÃO DE ESCOPO E DETERMINAÇÃO DE ATRIBUTOS VISANDO CONTRIBUIÇÃO ÀS DISCUSSÕES DO MARCO 3, DO COMPROMISSO 8 LIGADOS AO 6º PLANO DE AÇÃO BRASILEIRO.

Autora: Ana Suelen Pedroza Cavalcante

1. INTRODUÇÃO

A multicausalidade e a determinação social da saúde têm demandado de gestores, profissionais de saúde e da população a adoção de uma perspectiva transversal sobre os territórios, visando torná-los mais favoráveis à saúde. A criação de ambientes propícios à promoção da saúde envolve a proteção do meio ambiente, a conservação de recursos naturais, o monitoramento de mudanças ambientais e a valorização do trabalho e do lazer como fontes de bem-estar (WHO, 1986).

Nesse contexto, o Ministério da Saúde do Brasil tem direcionado esforços para orientar, incentivar e promover a implementação e expansão de territórios saudáveis, considerando a heterogeneidade e a vasta dimensão territorial do país. No entanto, documentos relevantes e regulatórios que servem como referência para a organização das ações e serviços de saúde — como a Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2017), a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (Brasil, 2013), a Política Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2018) e as diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2010) — abordam o conceito de territórios favoráveis à saúde de maneira diversa e, por vezes, imprecisa.

Além disso, pesquisas científicas em âmbito nacional e internacional tratam do tema por meio de definições como territórios de saúde, territórios saudáveis e territórios sustentáveis (Siri, 2016; Tsouros; Green, 2013; DePriest et al., 2025). Essas abordagens podem, em alguns casos, distanciar-se, aproximar-se ou se interseccionar, revelando a necessidade de um aprofundamento conceitual que alinhe as recomendações às diretrizes ministeriais e às necessidades de saúde reconhecidas pela e para a população.

Uma revisão preliminar da literatura realizada pelos autores não identificou produções que descrevam a essencialidade do conceito de territórios saudáveis e sustentáveis, contemplando seus atributos, antecedentes e consequentes, de modo a permitir a distinção entre seus elementos próprios e comuns. Diante disso, questiona-se: Quais são as evidências disponíveis sobre territórios saudáveis e sustentáveis?

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi mapear as evidências sobre territórios saudáveis e sustentáveis e os específicos foram: 1) caracterizar a produção científica sobre territórios saudáveis e/ou sustentáveis; 2) analisar o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis; e 3) identificar indicadores qualitativos e quantitativos para o monitoramento de territórios saudáveis e sustentáveis.

2. METODOLOGIA

2.1 PROTOCOLO E REGISTRO

Trata-se de uma revisão de escopo, que foi conduzida a partir das orientações contidas no manual do Instituto Joana Briggs (Aromataris et al., 2024) e pelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses - Extension for Scoping Review (PRISMA-ScR) (Tricco et al., 2018). O registro deste protocolo está contido na plataforma Open Science Framework (<https://osf.io/external-login/email>) sob o DOI 10.17605/OSF.IO/A75HQ.

2.2 FONTES DE INFORMAÇÃO

Foram realizadas buscas na National Library of Medicine and National Institutes of Health (MEDLINE/PubMed), na Scielo, na Scopus e na Biblioteca Virtual da Saúde. Como literatura cinzenta buscou-se no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e no google Scholar, considerando os 200 primeiros resultados da busca. A estratégia complementar consistiu na consulta às referências dos estudos incluídos. As buscas foram realizadas em novembro de 2024.

2.3 ESTRATÉGIA DE BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

A estratégia foi formulada a partir de termos sensíveis à pesquisa, incluindo palavras-chave ou descritores, de acordo com cada plataforma de busca (Quadro 1). Foram utilizados operadores booleanos: “OR”, entre os termos similares, e “AND” entre as formulações dos acrônimos.

Quadro 1. Equações de busca. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2024.

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
MEDLINE / PUBMED	((("Sociocultural territory") OR ("Popular health surveillance")) OR ("Healthy Territories")) OR ("healthy city") OR ("healthy cities")
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("Sociocultural territory") OR TITLE-ABS-KEY ("Popular health surveillance") OR TITLE-ABS-KEY ("Healthy Territories") OR TITLE-ABS-KEY (healthy city) OR TITLE-ABS-KEY ("healthy cities")

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
BVS	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
BDTD	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
SCIELO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
GOOGLE ACADÊMICO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")

Fonte: elaboração própria.

Dois pesquisadores de forma interdependente realizaram as buscas para validação da equação assim como para a seleção. A seleção dos estudos foi feita a partir da análise dos títulos e resumos; seguida pela leitura na íntegra, em ambas as etapas foram considerados os critérios de elegibilidade elencados nesta revisão.

Os resultados das buscas foram salvos em formato .csv ou .ris e transferidos para o software Rayyan, em sua versão de acesso público, para organização dos estudos identificados e para garantia da blindagem dos estudos na etapa de seleção pelos avaliadores de forma independente. Além disso, nesse mesmo software foi feita a remoção das duplicatas.

2.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

O protocolo desta revisão de escopo foi baseado na seguinte pergunta norteadora: Quais as evidências sobre territórios saudáveis e/ou sustentáveis? Para o delineamento da questão de pesquisa foi utilizado uma adaptação do acrônimo PCC, onde delimitaram-se dois conceitos “território saudável” e “território sustentável”.

Foram selecionados os documentos independente do idioma de publicação, país, período de publicação, e que possuam ênfase sobre o problema desta revisão. Neste sentido, não foram utilizados filtros a fim de tornar a busca mais abrangente, de fosse possível a identificação de estudos que possam responder à pergunta desta revisão. Os critérios de inclusão foram divididos em três dimensões, a saber: 1. Conteúdo e termos bordados: Estudos que contemplem em seu título, resumo e/ou texto na íntegra os termos territórios saudáveis e/ou sustentáveis.

Demarca-se como termos correspondentes/similares a territórios: espaços geográficos, ambientes, cidades, localidades, entre outros; 2. Tipos de estudo: Uma perspectiva teórico-conceitual ou reflexiva dos conceitos de territórios saudáveis e sustentáveis; A aplicação prática do conceito, incluindo o uso do termo no desenvolvimento e construção de territórios saudáveis; Análises ou avaliações de experiências ou estudos sobre territórios saudáveis e sustentáveis; e 3. Abordagem ampliada de saúde: Estudos que tratamos territórios saudáveis sob a perspectiva do conceito ampliado de saúde, considerando suas múltiplas dimensões.

Já os critérios de exclusão foram: estudos de revisão, como revisões sistemáticas, revisões integrativas, revisões de escopo ou outros formatos similares; estudos que abordem os territórios exclusivamente por uma visão epidemiológica, limitando-se a analisar o comportamento de doenças no território, sem considerar a perspectiva ampliada de saúde ou os aspectos relacionados à sustentabilidade; estudos que se limitaram a descrever uma experiência específica de território saudável e/ou sustentável. Ressalta-se que em caso de estudos similares, mas de formatos diferentes, como por exemplo, dissertação e artigo que apresentassem os resultados do mesmo estudo, optou-se pelo formato de artigo, devido a avaliação por pares às cegas.

2.5 PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Foi construído um instrumento de extração de dados (Documento suplementar 1) pelos autores a fim de alinhar esse processo. A primeira parte do instrumento se relaciona ao perfil das produções incluídas no estudo, a segunda parte a análise de conceitos dos territórios saudáveis e sustentáveis e a terceira aos indicadores.

A extração de dados foi realizada por dois pesquisadores, de modo que cada um dos pesquisadores ficou com extração de metade das produções/documentos selecionadas (os), sendo supervisionada por outros dois pesquisadores para que ocorra a validação.

2.6 SÍNTESE E ANÁLISE DOS RESULTADOS

As etapas de identificação, triagem e inclusão foram sumarizadas conforme o instrumento Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA). Ressalta-se que para elaboração do PRISMA, que será apresentado nos resultados, foram elaboradas ainda duas tabelas, a saber: uma com todos os estudantes excluídos, após a retirada das duplicatas, com seus respectivos motivos de exclusão; e uma com os estudos incluídos, contendo a caracterização dos estudos.

Utilizou-se de análise de conteúdo (Bardin, 2016) para delimitação dos antecedentes, atributos e consequentes do conceito territórios saudáveis e para categorização dos indicadores identificados. De modo complementar foi elaborado um infográfico, baseado em estatística descritiva, com vistas a melhor ilustrar as características dos estudos selecionados na revisão de escopo. Os elementos foram apresentados em textos descritivos e quadros, junto a frequência absoluta e relativa de sua presença nos estudos selecionados. Os objetivos foram consolidados a partir de nuvem de palavras, obtida a partir da utilização do software Nvivo. Para visualização dos antecedentes, consequentes e atributos foi utilizado o Iramutec para análise de similitude a fim de identificar as relações entre as palavras que mais se destacaram no corpus textual.

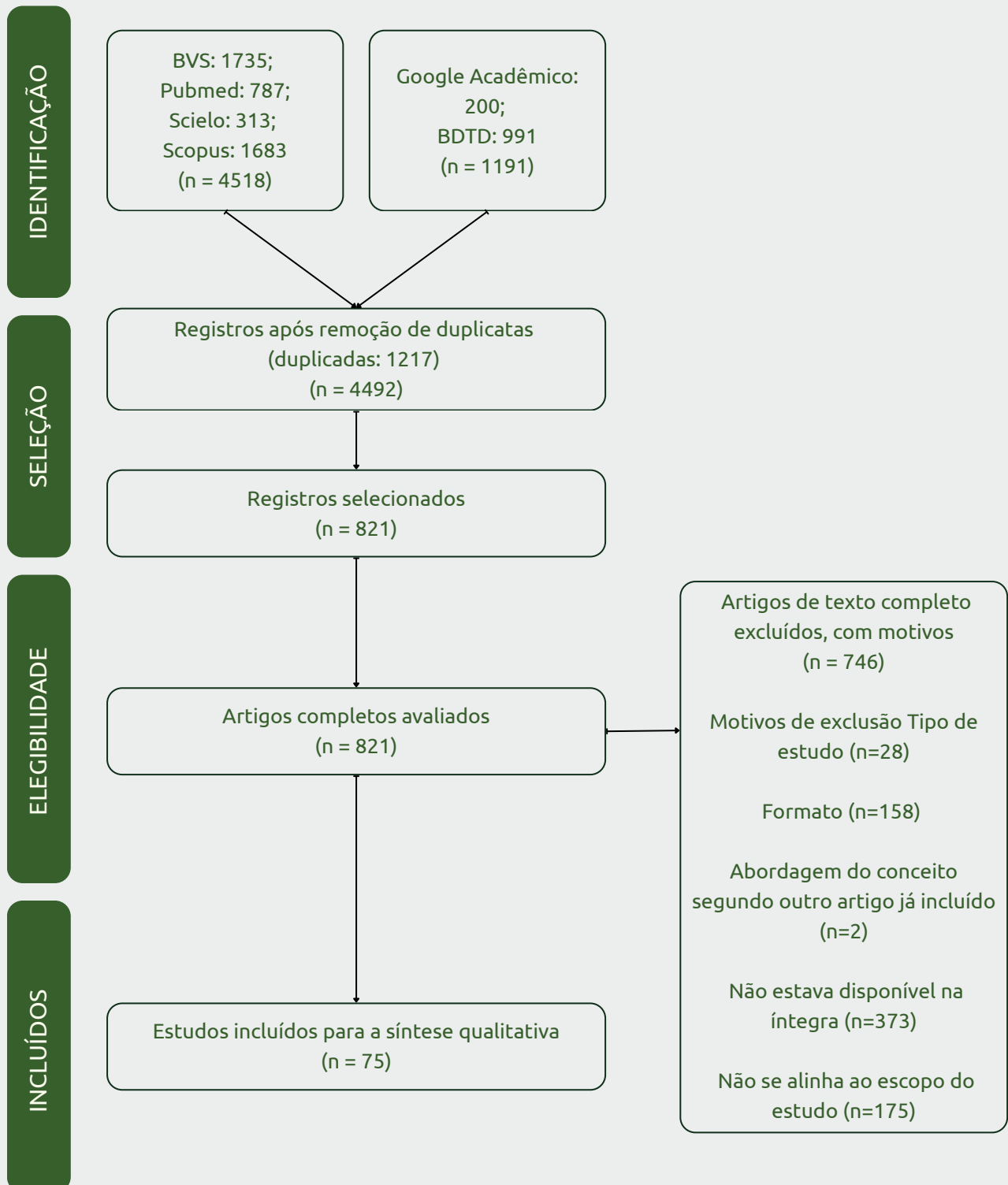
Além disso, na síntese e análise de dados desta revisão de escopo, foram identificados e examinados indicadores utilizados para a avaliação de Territórios Saudáveis e Sustentáveis. O foco foi conhecer quais indicadores utilizados para identificar territórios saudáveis e sustentáveis. Os indicadores foram sistematizados a partir da ocorrência nos textos selecionados para este estudo. Além disso, sistematizou em quadro dimensões e sub-dimensões que os sintetizaram.

O nível de evidência seguiu a referência de Stillwell et al. (2010), sendo classificada a partir do tipo de estudo, como sendo Nível I- evidências de revisões sistemáticas e/ou metanálises de ensaios clínicos randomizados; Nível II- evidências de um ensaio clínico com aleatorização, controlado e bem delineado; Nível III- evidências de estudos bem delineados, controlados e sem aleatorização; Nível IV- evidências de estudos de coorte ou caso controle; Nível V- evidências de revisões sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível VI- evidências de estudo descritivo e/ou qualitativo; e Nível VII- evidências de opiniões de autoridades ou relatórios de comitês de especialistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da utilização dos critérios de elegibilidade elencados nesta revisão, foram encontrados $n = 4492$ nas seis bases de dados ou repositórios utilizados na busca deste estudo. Após as etapas da triagem resultaram em 75 documentos selecionados para análise desta revisão, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. PRISMA. Brasil, 2024.



Fonte: elaboração própria.

O quadro 2 apresenta uma síntese da caracterização dos estudos selecionados, conforme título, autor(es), ano de publicação, país, objetivo, tipo de estudo e classificação por nível de evidência. E o documento suplementar 01 apresenta os estudos que foram excluídos com seus respectivos motivos.

Quadro 2. Síntese dos estudos relacionados ao conceito territórios saudáveis e sustentáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2024.

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A1	Editorial: The physical environment and health: implications for the planning and management of Heath cities	Yang et al.	2023	China	Não especificado	Editorial	VII
A2	Policymaking in European healthy cities	De Leeuw et al.	2015	Europa	Avaliar o desenvolvimento de políticas em, com e para cidades Saudáveis na Região Europeia da Organização Mundial da Saúde	Não especificado	-
A3	Towards healthy One Planet cities and communities: planetary health promotion at the local level	Hancock T	2021	Canadá	Não especificado	Teórico- reflexivo	VII
A4	Does Health Promotion Program Affect Local Resident' Emotions?	Lee et al.,	2019	Coreia	Definir qualitativamente a correlação entre o desempenho de um programa de cidade saudável e as emoções dos moradores locais usando o índice de felicidade pessoal como parâmetro.	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A5	European Healthy City network Phase V: patterns emerging for healthy urban planning	Grant	2015	Inglaterra	Não especificado	Estudo de caso	VI
A6	Can Healthy Cities be made really healthy?	Cole et al.	2017	Espanha	Não especificado	Comentário	VII
A7	Healthy Cities indicators-a suitable instrument to measure health?	Webster; Sanderson	2013	Reino Unido	Propor e analisar uma versão simplificada de indicadores para avaliação de cidades saudáveis.	Não especificado	-
A8	Comprehensive evaluation of global health cities development levels	Wen et al.	2024	Amsterdã, Boston, Buenos Aires, Dubai, Joanesburgo, Londres, Los Angeles, Melbourne, Nova York, Paris, Santiago, Xangai, Cingapura, Tóquio e Toronto	Identificar e analisar as diferenças nos níveis de desenvolvimento de saúde entre cidades globais, auxiliar os departamentos de gestão urbana a identificarem com precisão os pontos fortes e os problemas e avaliar e diagnosticar razoavelmente os níveis gerais de saúde e as deficiências das cidades da amostra	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A9	European Healthy Cities come to terms with health network governance.	De Leeuw et al.	2015	Andorra, Bósnia e Herzegovina, Grécia, Itália, Mónaco, Montenegro, Portugal, Espanha, San Marino, Israel, Turquia, Sérvia e Antiga República Jugoslava da Macedónia, Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, República da Moldávia, Federação Russa, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido	Analisar até que ponto elas realmente introduzem e alinham conceitos e abordagens de governança com seus compromissos de governo local.	Não especificado	-
A10	Cidade saudável: o diagnóstico do território urbano por meio dos determinantes sociais de saúde: o caso Maracanaú	Moura et al.	2021	Brasil	Compreender o território urbano através da análise dos Determinantes Sociais da Saúde como pressuposto para a estruturação de uma agenda de cidade saudável.	Transversal	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A11	Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro	Petersen et al.	2020	Brasil	Desenvolver o Índice de Território Saudável e Sustentável, com indicadores de dados secundários de 2010, para classificação territorial em prioridade de ação em território saudável e sustentável.	Não especificado	-
A12	Territórios saudáveis e sustentáveis: contribuição para saúde coletiva, desenvolvimento sustentável e governança territorial	Machado et al.	2017	Brasil	Contribuir com o debate teórico-metodológico para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis	Ensaio teórico	VII
A13	Ciudades saludables: una estrategia de referencia en las políticas locales de salud pública	Llorca et al.	2010	Espanha	Não especificado	Editorial	VII
A14	Los espacios virtuales de asistencia técnica del programa nacional de municipios y comunidades saludables	Waynsztok; Rossi; Chiara	2011	Argentina	Não especificado	Opinião	VII
A15	Limitantes de la estrategia de Municipios Saludables como política pública en Antioquia	Chavez; Blanca	2009	Colômbia	Avaliar o processo de formulação e implementação da estratégia de municípios saudáveis como política pública em Antioquia, Colômbia, entre 2001 e 2005	Descritivo	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A16	Agentes populares no contexto da pandemia de Covid-19: educação popular em saúde na construção de territórios saudáveis e sustentáveis	Da Silva et al.	2024	Brasil	Não especificado	Documental	VI
A17	Sustainability of the Healthy Municipalities Strategy in Guatemala	Laureano-Eugenio et al.	2021	Guatemala	Avaliar a sustentabilidade da estratégia de Municípios Saudáveis na Guatemala para ter evidências sólidas para apoiar a tomada de decisões	Não especificado	-
A18	Healthy city evaluation based on factor analysis-Taking cities in the Guangxi Zhuang Autonomous Region as an example	Huang et al.	2024	China	Medir os níveis de saúde das cidades de Nanning e Chongzuo na Região Autônoma de Guangxi Zhuang para preencher as lacunas e deficiências na pesquisa nesta área. Além disso, ao construir um índice de cidade saudável (HCI) e avaliar de forma abrangente o nível de construção de cidades saudáveis na Região Autônoma de Guangxi Zhuang	Não especificado	-
A19	Ciudades saludables: una estrategia de referencia en las políticas locales de salud pública	Llorca et al.	2010	Espanha	Não especificado	Editorial	VII

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A20	Caminho para a construção coletiva de ambientes saudáveis: São Paulo, Brasil	Sperandio et al.	2004	Brasil	Mostrar estratégias de construir espaços saudáveis por meio de uma parceria estabelecida entre OPAS, Unicamp, IPES e Comunidades/Cidades	Relato de experiência	VI
A21	Cidade saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e intersetorialidade	Westphal; Mendes	2000	Brasil	Abordar as cidades saudáveis sob uma ótica da interdisciplinaridade e intersetorialidade.	Reflexão	VII
A22	O modelo de atenção na perspectiva de saúde integral: a promoção de saúde e a estratégia de "municípios saudáveis"	Westphal	2000	Brasil	Não especificado	Reflexão	VII
A23	A pertinência da adoção da filosofia de cidades saudáveis no Brasil	Ferraz	1993	Brasil	Colaborar seja para um maior conhecimento, seja para uma reflexão sobre a pertinência de adoção da proposta de Cidades Saudáveis, seja para a elaboração de uma estratégia que vise sua introdução no Brasil.	Reflexão	VII
A24	Movimento "São Paulo - cidade saudável"	Secretaria Municipal de São Paulo	1990	Brasil	Não especificado	Não especificado	-
A25	Twenty steps for developing a healthy cities project. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen, 1992.	Pilon	1993	Brasil	Não especificado	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A26	O direito a cidades justentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional	Matias; Campos	2022	Brasil	Contribuir para o debate acerca das cidades sustentáveis, procurando definir com maior precisão as balizas de sua conceituação, à luz da ordem jurídica nacional e a da doutrina, o que ensejará a melhor compreensão do direito a cidades sustentáveis.	Descritivo / Bibliográfico	VI
A27	Construindo cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde, a partir do Planejamento Estratégico Situacional	Lima; Lima	2020	Brasil	Apresentar a evolução histórica do conceito de cidade saudável e as concepções paradigmáticas que lhe deram corpo no âmbito da saúde pública e, por fim, apresentar uma proposta de um enquadramento do conceito cidade saudável, a partir de ideias do Planejamento Estratégico Situacional.	Não especificado	-
A28	Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro	Petersen et al.	2020	Brasil	Desenvolver o ITSS, com indicadores de dados secundários de 2010, para classificação territorial em prioridade de ação em território saudável e sustentável.	Não especificado	-
A29	Mapeando iniciativas territoriais saudáveis, suas características e evidências de efetividade	Freire; Salles; Franco	2016	Brasil	Compartilhar e difundir as questões apreendidas das experiências de territórios saudáveis que possam estimular o debate e a reflexão acerca do tema, no âmbito da gestão, da academia e dos demais setores interessados	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A30	Política de promoção da saúde e planejamento urbano: articulações para o desenvolvimento da cidade saudável	Sperandio; Francisco Filho; Mattos	2016	Brasil	Apontar as interfaces entre a promoção da saúde e o planejamento urbano quando são completados 10 anos da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) no Brasil, a de 2006 e sua revisão em 2014, a PNaPS2, reafirmando a importância da intersetorialidade e da interdisciplinaridade para o desenvolvimento das cidades saudáveis	Não especificado	-
A31	Planejamento governamental e políticas públicas: a estratégia "Cidades Saudáveis"	Keinert	1997	Brasil	Não especificado	Não especificado	-
A32	Cidades inteligentes e sustentáveis: percepções sobre a cidade de Curitiba/PR a partir dos planos plurianuais de 2014 a 2021	Santos et al.	2022	Brasil	Analisar se os Planos Plurianuais propostos pela Prefeitura Municipal de Curitiba/PR para o período de 2014 a 2021 refletem os conceitos adotados de smart city (cidades inteligentes) e de cidades sustentáveis	Exploratório descritivo	VI
A33	Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias para qualidade de vida	Salas-Zapata et al.	2016	Brasil	Discutir a relação entre as propostas de desenvolvimento sustentável e cidades saudáveis como estratégias decorrentes da promoção da saúde	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A34	Healthy cities and municipal administrations in Türkiye: the case of Denizli Metropolitan Municipality	Cetin	2024	Turquia	Examinar a estrutura conceitual, metas, campos de ação e contribuições do conceito de Cidade Saudável, enfatizando sua importância para governos locais, particularmente municípios; e analisar práticas de Cidade Saudável em Denizli. Denizli se destaca como uma cidade proeminente com atividades, planos e projetos da Denizli MM relacionados ao conceito de Cidade Saudável em Türkiye.	Não especificado	-
A35	The EWM-Based Evaluation of Healthy City Construction Levels in East China under the Concept of "Making Improvements Is More Important Than Reaching Standards"	Li et al.	2024	China	Não especificado	Não especificado	-
A36	Exploring the relationship between the perceived importance of healthy city indicators and satisfaction levels towards the local government in shaping a healthy city	Lim et al.,	2023	Malásia	Explorar a correlação entre a importância percebida dos indicadores de cidade saudável e seus níveis de satisfação em relação à eficácia do governo na criação de um ambiente de cidade saudável; e oferecer uma oportunidade única para entender o que constitui uma "cidade saudável" conforme percebido pelo público.	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A37	Countermeasures to promote sustainable construction and coordinated development of healthy cities: a case study of Dandong City	Liu	2024	China	Analisar a meta geral da construção de cidades saudáveis em Dandong usando o processo de hierarquia analítica	Não especificado	-
A38	Factors affecting the development of a healthy city in Suburban areas, Thailand	Iamtrakul; Chayphong	2023	Tailândia	Usa o conceito de cidade saudável para analisar os fatores que afetam a saúde da população usando a província de Pathum Thani como estudo de caso de 1055 questionários estruturados em entrevistas presenciais	Estudo de caso	VI
A39	A set of 99 healthy city indicators for application in urban planning and design	Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska	2023	Reino Unido	Desenvolver 99 indicadores para uma cidade saudável	Não especificado	-
A40	O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a qualidade de vida	Westphal	2000	Brasil	Apresentar o projeto Cidades Saudáveis, conforme concebido pela OMS, suas adaptações à realidade brasileira, as possibilidades e desafios que tem trazido para técnicos, acadêmicos, políticos e aos cidadãos de nossas cidades, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida	Não especificado	-
A41	How to Make Future Cities Smart in the Realm of Environmentally Friendly Healthy Cities? Looking from the Perspective of Ease of Living Index	Gupta; Sethi	2024	Índia	Desenvolver uma ferramenta integrada para avaliação baseada em dados do programa de cidades saudáveis proposto pela Índia, criando uma lista abrangente de indicadores abrangendo ambas as estruturas.	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A42	Comparative Study on the Evaluation of Healthy City Construction in Typical Chinese Cities Based on Statistical Data and Land Use Data	Lv et al.	2022	China	Introduz o conceito de desenvolvimento sustentável na avaliação de cidades saudáveis e constrói um conjunto de sistemas de índices de avaliação para cidades saudáveis que leva em conta tendências de desenvolvimento urbano e desenvolvimento sustentável, e seleciona uma série de diferentes escalas e tipos de cidade típica, coletando dados estatísticos e dados de uso do solo, e usando o método de polígono de matriz inteira (EAP) para avaliar e comparar o nível de desenvolvimento saudável de cada cidade típica.	Não especificado	-
A43	Updating Healthy City Variables for the Post-pandemic Era Using Delphi Method	Cacique et al.	2022	México	Atualizar as variáveis usadas para medir a Cidade Saudável usando o Método Delphi, uma vez que a atual Pandemia tornou necessário repensar e reavaliar toda a complexa noção de Cidade Saudável	Não especificado	-
A44	Impact Evaluation of Healthy City Implementation in Makassar City	Fitry et al.	2020	Indonésia	Avaliar o impacto da implementação de cidades saudáveis com base em aspectos do nível de envolvimento	Fenomenológico	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A45	Governance and the promotion of sustainable and Healthy territories: The experience of bocaina, Brazil	Setti et al.,	2016	Brasil	Descrever e analisar o processo de governança em desenvolvimento sustentável aplicado ao território, no contexto da gestão estratégica, integrada e participativa, do Projeto Bocaina Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS)	Pesquisa-ação	VI
A46	Sustainable cities and healthy cities: Are they the same?	Portney; Sansom	2017	Estados Unidos	Investigar até que ponto as cidades nos EUA que têm as iniciativas de sustentabilidade mais agressivas exibem melhores resultados de saúde do que cidades com iniciativas de sustentabilidade menos agressivas	Não especificado	-
A47	Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index	Pineo et al.,	2018	Inglaterra	Apresentar o desenvolvimento de um índice global para ajudar os líderes e profissionais da cidade a entender seu papel na entrega de resultados de saúde por meio de políticas e programas de ambiente urbano	Não especificado	-
A48	Research into the applicability of the healthy cities movement in Dakar district (Senegal): Methodology and results	Ly et al.	1998	Senegal	Relatar as descobertas da pesquisa participativa realizada em três assentamentos em Dacar, que buscaram desenvolver ações concretas para alcançar “cidades e vilas saudáveis” e que também identificaram as restrições a tais ações	Não especificado	-

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A49	Território e saúde: apontamentos conceituais para a proposta de territórios sustentáveis e saudáveis	Monken	2024	Brasil	Discutir o potencial analítico e operacional do conceito de território para formulação de propostas que visam promover a criação de territórios sustentáveis e saudáveis	Opinião	VII
A50	Promoção de territórios saudáveis: assessoria técnica à habitação social no Setor 1 da Colônia Juliano Moreira	Domingues, Silva; Ravera	2024	Brasil	Contribuir continuamente para o debate sobre princípios e estratégias promotoras de territórios saudáveis e sustentáveis	Relato de experiência	VI
A51	'O povo cuidando do povo': Agentes Populares na promoção de territórios mais sustentáveis e saudáveis	Niemeyer et al.,	2024	Brasil	Compartilhar a dinâmica constitutiva e os desafios desse projeto	Relato de experiência	VI
A52	Territórios Sustentáveis e Saudáveis no SUS: a relação intrínseca com a Agenda 2030	Gadelha; Ameixa	2024	Brasil	Não especificado	Opinião	VII
A53	Agentes populares no contexto da pandemia de Covid-19: educação popular em saúde na construção de territórios saudáveis e sustentáveis	Silva et al.,	2024	Brasil	Analisar as experiências desenvolvidas pelos Agentes Populares de Saúde (AgPS) na Campanha Mãos Solidárias, entre os anos 2020 e 2022, suas aproximações com a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e com o conceito de Territórios Saudáveis e Sustentáveis	Documental	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A54	Assessing the construction of a Healthy City in China: a conceptual framework and evaluation index system	Zhao et al.,	2023	China	Explorar os padrões espaciais e temporais da construção da Cidade Saudável em 341 cidades chinesas	Não especificado	-
A55	Healthy Cities: Facilitating the Active Participation and Empowerment of Local People	Dooris; Heritage	2011	Europa	Descrever o contexto político relevante, fornecendo uma visão geral da teoria e da prática e considera criticamente como as cidades na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS integraram a participação e o empoderamento da comunidade em seu trabalho	Não especificado	-
A56	The Healthy Cities approach — reflections on a framework for improving global health	Awofeso	2003	Australia	Não especificado	Editorial	VII
A57	The Beneficial Evaluation of the Healthy City Construction in China	Wang; Wangm; Guan	2017	China	Conduzir uma avaliação abrangente da criação de cidades saudáveis na província de Henan, na China central	Não especificado	-
A58	Comparing the Use of Spatially Explicit Indicators and Conventional Indicators in the Evaluation of Healthy Cities: A Case Study in Shenzhen, China	Yang et al.,	2020	China	Comparar a diferença entre os resultados de avaliação gerados usando indicadores convencionais e indicadores derivados pela abordagem espacialmente explícita	Estudo de caso	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A59	Impact of the Social Agendas – Agenda 21 and Healthy Cities – upon Social Determinants of Health in Brazilian municipalities: measuring the effects of diffuse social policies through the dimensions of the Millennium Development Goals	Nascimento et al.,	2014	Brasil	Relatar, sobre a temática dos DSS, uma abordagem metodológica quantitativa, como parte de um estudo multicêntrico usando “métodos mistos”	Não especificado	-
A60	Território, intersetorialidade e escalas: requisitos para a efetividade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Gallo; Setti	2014	Brasil	Analisar a consistência da formulação da Agenda do Desenvolvimento pós-2015 em relação ao desenvolvimento sustentável e as potencialidades e os desafios para a sua implantação efetiva, considerando especialmente a intersetorialidade e a interesalaridade em seu rebatimento sobre o território, e sua expressão em agendas territorializadas, cuja governança e gestão estratégica, em especial a avaliação de efetividade, são destacadas.	Documental	VI
A61	Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: a sustainable movement for change and innovation at the local level	Tsouros	2015	Europa	Não especificado	Opinião	VII

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A62	Strengthening community leadership: evaluation findings from the california healthy cities and communities program	Kledger; Norton; Aronson	2008	Estados Unidos	Não especificado	Não especificado	-
A63	Key componentes of a statewide healthy communities effort	Lee; Fuccillo; Wolff	2000	Estados Unidos	Destacar os principais componentes de um esforço estadual de Comunidades Saudáveis	Teórico	VII
A64	The development and application of a two-step surveillance process for Healthy China Initiative based on wide coverage interagency data	Liu et al.,	2023	China	Desenvolver e aplicar um processo de vigilância em duas etapas para a Iniciativa China Saudável com base em dados interinstitucionais de ampla cobertura	Ecológico	VI
A65	A abordagem territorial nos Territórios Sustentáveis e Saudáveis: um alargamento conceitual a partir da antropologia	Penaforte	2024	Brasil	Expandir o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis a partir da antropologia	Teórico	VII
A66	A ativação de redes sociotécnicas na cidade estrutural/DF, Brasil: construindo um território saudável e sustentável	Sellera et al.,	2019	Brasil	Descrever iniciativas para a ativação de redes sociotécnicas na Cidade Estrutural como estratégia para implementar a Agenda 2030, visando tornar o território saudável e sustentável por meio de um novo processo de produção local.	Relato de experiência	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A67	Healthy Cities in Europe: Editorial	Tsouros; Green	2013	Europa	Avaliar a evolução do trabalho realizado na fase IV (2003–2008) da Rede Europeia de Cidades Saudáveis (WHO-EHCN), contextualizando os avanços na fase V (2009–2013) e os objetivos para a fase VI (2014–2018), alinhados à política Health 2020 da OMS.	Editorial	VII
A68	Achieving Healthy City Development in Ghana: Referencing Sustainable Development Goal 11	Botchway et al.,	2023	Gana	Avaliar a percepção dos profissionais das Assembleias Distritais sobre o desenvolvimento de cidades saudáveis em Gana, com foco no alcance do ODS 11	Não especificado	-
A69	A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida?	Adriano et al.,	2000	Brasil	Discutir a importância do Movimento Cidades Saudáveis como estratégia para melhorar a qualidade de vida e apresentar uma experiência piloto desenvolvida nos municípios mineiros de Dionísio e São José do Goiabal entre 1996 e 1998	Relato de experiência	VI
A70	A construção de um município saudável: descentralização e intersetorialidade - experiência de Fortaleza	Ribeiro	1997	Brasil	Relatar as experiências do Município de Fortaleza na busca de soluções para os problemas de saúde da população, desde o processo de municipalização ocorrido em 1990 até a mudança organizacional iniciada em 1997, destacando a descentralização e a intersetorialidade como fundamentais na construção de um novo modelo que visa à "saúde como melhoria de qualidade de vida" rumo a um Município Saudável	Relato de experiência	VI

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A71	Achieving organizational change: Findings from case studies of 20 California Healthy Cities and Communities coalitions	Kegler; Norton; Aronson	2008	Estados Unidos	Avaliar até que ponto as coalizões participantes do programa CHCC demonstraram capacidade de alavancar recursos financeiros, expandir programas comunitários e influenciar políticas organizacionais, promovendo a saúde e a qualidade de vida nos territórios	Estudo de caso	VI
A72	City environmental conditions are associated with health outcomes in people living there: Insights from the Alliance for Healthy Cities (AFHC) Japan	Yoshizawa	2013	Japão	Explorar como as cidades membros da AFHC promovem iniciativas de Cidades Saudáveis, investigando os fatores que influenciam o sucesso dessas iniciativas, como a participação comunitária, o financiamento e as redes colaborativas	Não especificado	-
A73	Editorial: The Healthy Cities	Kamper-Jorgensen	2010	Dinamarca	Avaliar o desenvolvimento de políticas em, com e para Cidades Saudáveis na Região Europeia da OMS, destacando saúde, equidade, justiça social e sustentabilidade urbana	Editorial	VII

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A74	Developing a Health-Spatial Indicator System for a Healthy City in Small and Midsized Cities	Luo et al.,	2022	China	Desenvolver um sistema de indicadores espaciais de saúde para avaliar e orientar iniciativas de Cidades Saudáveis em cidades pequenas e médias, conectando o design urbano e a saúde pública	Não especificado	-
A75	A Intersetorialidade como Requisito para Construção de uma Cidade Saudável: política de Saneamento e de Saúde no Recife (gestão 2001/2004) - Estudo de Caso	Galindo; Furtado	Não especificado	Brasil	Avaliar o nível de intersetorialidade no Projeto de Saneamento Integrado Mangueira e Mustardinha (PSIMM) e refletir sobre os êxitos e desafios na construção de uma Cidade Saudável	Estudo de caso	VI

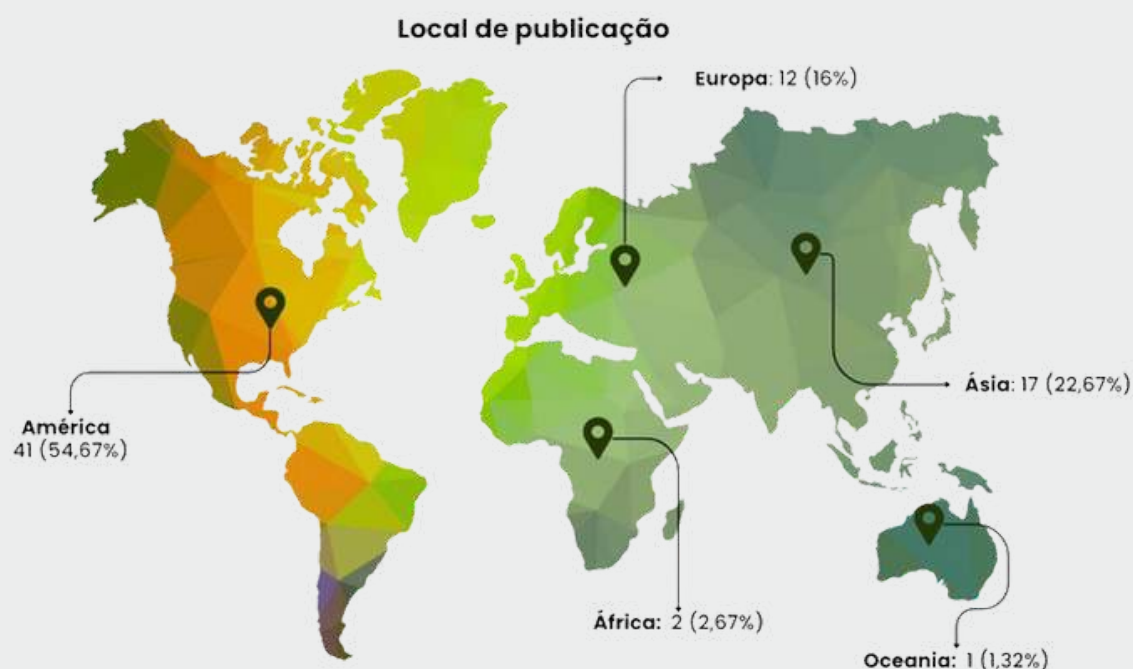
Fonte: elaboração própria.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS

O primeiro estudo publicado e disponível está datado em 1990 (n=01). Verificou-se que houve um aumento de produções relacionadas a territórios saudáveis nos últimos dois anos (2023: n= 07; 2024: n=13), seguidos pelos anos 2000, 2020 e 2022 (n=05 cada ano). Nos últimos 21 anos não houve publicação somente em 1994, 1995, 1996, 2005, 2006, 2007 e 2012. Assim, 39 estudos foram publicados nos anos; 1993 (n=02); 1997 (n=02); 1998 (n=01); 2003 (n=01); 2004 (n=02); 2008 (n=02); 2009 (n=01); 2010 (n=03); 2011 (n=02); 2013 (n=03); 2014 (n=02); 2015 (n=04); 2016 (n=04); 2017 (n=04); 2018 (n=01); 2019 (n=02) e 2021 (n=03).

Foram identificados estudos em todos os continentes do mundo (Figura 02). Foram verificados 41 estudos realizados exclusivamente na América, sendo 32 estudos no Brasil (Moura et al., 2021; Petersen et al., 2020; Machado et al., 2017; Da Silva et al., 2024; Sperandio et al., 2004; Westphal; Mendes, 2000; Westphal, 2000; Ferraz, 1993; Secretaria Municipal de São Paulo, 1990; Pilon, 1993; Matias; Campos, 2022; Lima; Lima, 2020; Petersen et al., 2020; Freire; Salles; Franco, 2016; Sperandio; Francisco Filho; Mattos, 2016; Keinert, 1997; Santos et al., 2022; Salas-Zapata et al., 2016; Westphal, 2000; Setti et al., 2016; Monken, 2024; Domingues, Silva; Ravera, 2024; Niemeyer et al., 2024; Gadelha; Ameixa, 2024; Silva et al., 2024; Nascimento et al., 2014; Gallo; Setti, 2014; Penaforte, 2024; Sella et al., 2019; Adriano et al., 2000; Ribeiro, 1997; Galindo; Furtado, 2004), quatro nos Estados Unidos (Portney; Sansom, 2017; Kledger; Norton; Aronson, 2008; Lee; Fuccillo; Wolff, 2000; Kegler; Norton; Aronson, 2008), um no Canadá (Hancock, 2021) um na Argentina (Waynsztok; Rossi; Chiara, 2011), um na Colômbia (Chavez; Blanca, 2009), um na Guatemala (Laureano-Eugenio et al., 2021) e um no México (Cacique et al., 2022). 17 estudos foram realizados exclusivamente na Ásia, sendo 10 na China (Yang et al., 2023; Huang et al., 2024; Li et al., 2024; Liu, 2024; Lv et al., 2022; Zhao et al., 2023; Wang; Wangm; Guan, 2017; Yang et al., 2020; Liu et al., 2023; Luo et al., 2022) e um em cada um dos países a seguir: Indonésia (Fitry et al., 2020), Turquia (Cetin, 2024), Malásia (Lim et al., 2023), Coreia (Lee et al., 2019), Tailândia (Iamtrakul; Chayphong, 2023), Índia (Gupta; Sethi, 2024) e Japão (Yoshizawa, 2013). Dos 12 estudos realizados exclusivamente na Europa, quatro não especificaram o país onde foram realizados (De Leeuw et al., 2015; Dooris; Heritage, 2011; Tsouros, 2015; Tsouros; Green, 2013), três foram na Espanha (Cole et al., 2017; Llorca et al., 2010; Llorca et al., 2010), dois foram na Inglaterra (Grant, 2015; Pineo et al., 2018), dois foram no Reino Unido (Webster; Sanderson, 2013; Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023) e um na Dinamarca (Kamper-Jorgensen, 2010). Apenas dois estudos foram realizados na África, sendo um em Senegal (Ly et al., 1998) e outro em Gana (Botchway et al., 2023); e um estudo foi realizado na Oceania (Austrália) (Awofeso, 2003).

Figura 02. Estudos sobre territórios saudáveis realizados exclusivamente em um dos continentes do mundo. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2024.



Fonte: elaboração própria.

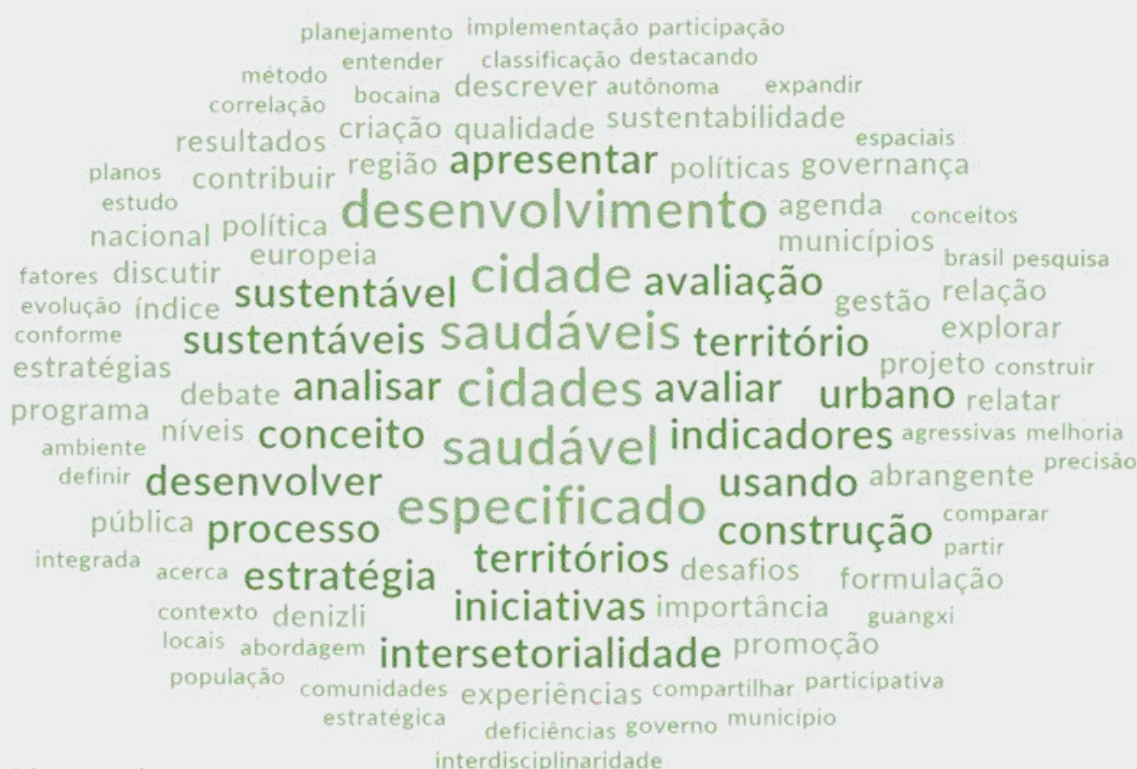
vale salientar que dois estudos foram realizados em mais de um continente (1,32%), a saber: Ásia, Europa e América (Amsterdã, Boston, Buenos Aires, Dubai, Joanesburgo, Londres, Los Angeles, Melbourne, Nova York, Paris, Santiago, Xangai, Cingapura, Tóquio e Toronto) (Wen et al., 2024); Europa e Ásia (Andorra, Bósnia e Herzegovina, Grécia, Itália, Mônaco, Montenegro, Portugal, Espanha, San Marino, Israel, Turquia, Sérvia e Antiga República Jugoslava da Macedónia, Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, República da Moldávia, Federação Russa, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido) (De Leeuw et al., 2015).

Em relação a língua de publicação dos estudos, verifica-se a predominância da língua inglesa (n=38) (Yang et al., 2023; De Leeuw et al., 2015; Hancock, 2021; Lee et al., 2019; Grant, 2015; Cole et al., 2017; Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024; De Leeuw et al., 2015; Laureano-Eugenio et al., 2021; Huang et al., 2024; Cetin, 2024; Li et al., 2024; Lim et al., 2023; Liu, 2024; Iamtrakul; Chayphong, 2023; Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Gupta; Sethi, 2024; Lv et al., 2022; Cacique et al., 2022; Fitry et al., 2020; Setti et al., 2016; Portney; Sansom, 2017; Pineo et al., 2018; Ly et al., 1998; Zhao et al., 2023; Dooris; Heritage, 2011; Awofeso, 2003; Wang; Wangm; Guan, 2017; Tsouros, 2015; Kledger; Norton; Aronson, 2008; Lee; Fuccillo; Wolff, 2000; Liu et al., 2023; Tsouros; Green, 2013; Botchway et al., 2023; Kegler; Norton; Aronson, 2008; Kamper-Jorgensen, 2010; Luo et al., 2022).

Seguido pela portuguesa (n=32) (Moura et al., 2021; Petersen et al., 2020; Machado et al., 2017; Da Silva et al., 2024; Sperandio et al., 2004; Westphal; Mendes, 2000; Westphal, 2000; Ferraz, 1993; Secretaria Municipal de São Paulo, 1990; Pilon, 1993; Matias; Campos, 2022; Lima; Lima, 2020; Petersen et al., 2020; Freire; Salles; Franco, 2016; Sperandio; Francisco Filho; Mattos, 2016; Keinert, 1997; Santos et al., 2022; Salas-Zapata et al., 2016; Westphal, 2000; Monken, 2024; Domingues, Silva; Ravera, 2024; Niemeyer et al., 2024; Gadelha; Ameixa, 2024; Silva et al., 2024; Yang et al., 2020; Nascimento et al., 2014; Gallo; Setti, 2014; Penaforte, 2024; Sellera et al., 2019; Adriano et al., 2000; Ribeiro, 1997; Webster; Sanderson, 2013); espanhola (n=04) (Llorca et al., 2010; Waynsztok; Rossi; Chiara, 2011; Chavez; Blanca, 2009; Llorca et al., 2010) e japonesa (n=01) (Yoshizawa, 2013).

Os objetivos estavam explícitos em 58 dos estudos selecionados para esta revisão evidenciando-se os conceitos de territórios, saudáveis, sustentáveis, políticas intersetorialidade, participativa, agendas, dentre outros que culminam no desenvolvimento das cidades e de suas comunidades, conforme apresentado em destaque na Figura 03.

Figura 03. Síntese dos objetivos dos estudos selecionados. Fortaleza, Brasil, Ceará, 2024.



Fonte: elaboração própria.

Dos 75 estudos incluídos nesta revisão, 36 documentos não tiveram os seus tipos de estudos especificados pelos autores (De Leeuw et al., 2015; Lee et al., 2019; Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024; De Leeuw et al., 2015; Petersen et al., 2020; Laureano-Eugenio et al., 2021; Huang et al., 2024; Secretaria Municipal de São Paulo, 1990; Pilon, 1993; Lima; Lima, 2020; Petersen et al., 2020; Freire; Salles; Franco, 2016; Sperandio; Francisco Filho; Mattos, 2016; Keinert, 1997; Salas-Zapata et al., 2016; Cetin, 2024; Li et al., 2024; Lim et al., 2023; Liu, 2024; Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Westphal, 2000;

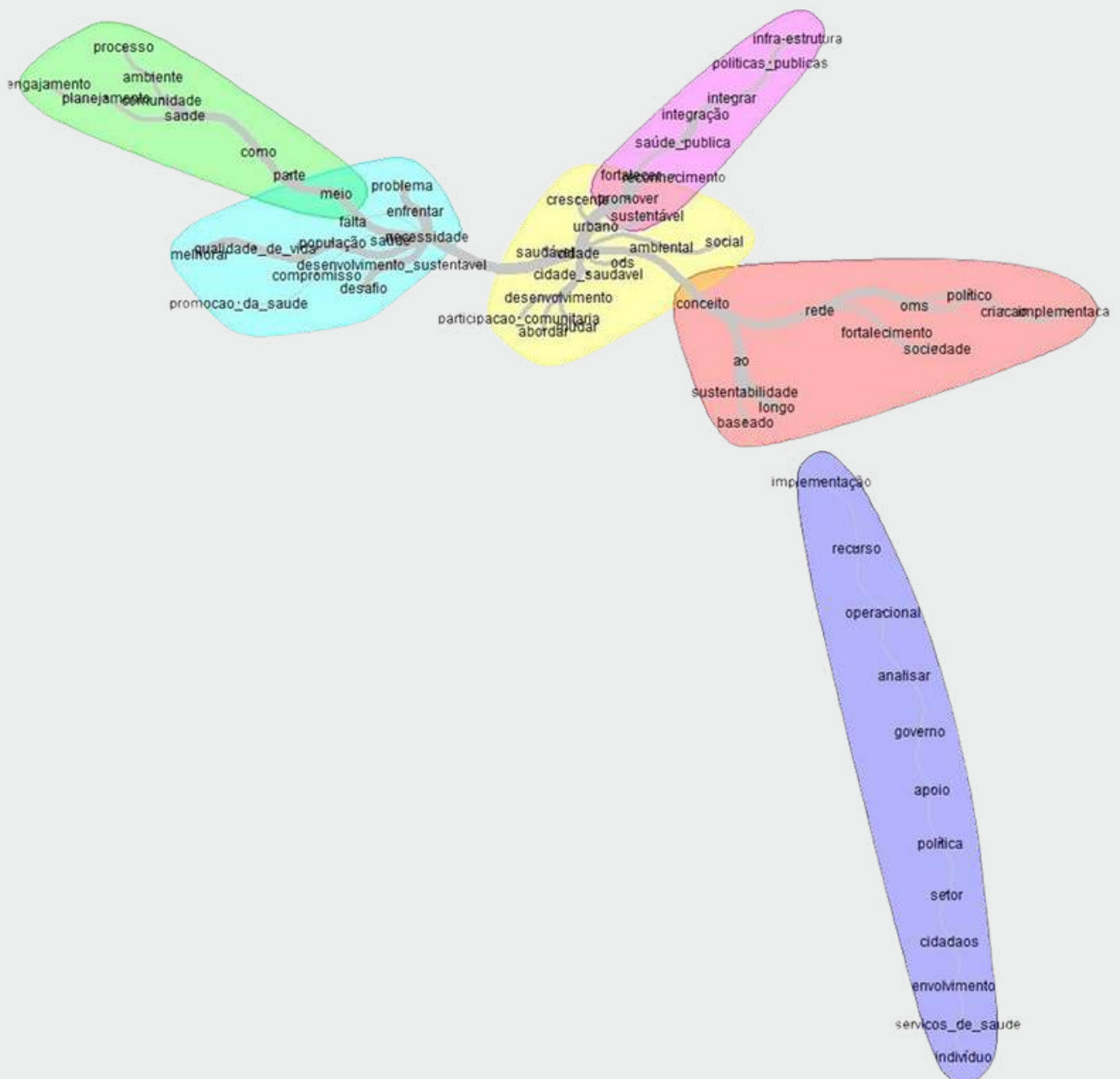
Gupta; Sethi, 2024; Lv et al., 2022; Cacique et al., 2022; Portney; Sansom, 2017; Pineo et al., 2018; Ly et al., 1998; Zhao et al., 2023; Dooris; Heritage, 2011; Wang; Wangm; Guan, 2017; Nascimento et al., 2014; Kledger; Norton; Aronson, 2008; Botchway et al., 2023; Yoshizawa, 2013; Luo et al., 2022). Dos 39 restantes, havia 07 teóricos/reflexivos (Hancock, 2021; Machado et al., 2017; Westphal; Mendes, 2000; Westphal, 2000; Ferraz, 1993; Lee; Fuccillo; Wolff, 2000; Penaforte, 2024), 06 editoriais (Yang et al., 2023; Llorca et al., 2010; Llorca et al., 2010; Awofeso, 2003; Tsouros; Green, 2013; Kamper-Jorgensen, 2010), 06 relatos de experiência (Sperandio et al., 2004; Domingues, Silva; Ravera, 2024; Niemeyer et al., 2024; Sellera et al., 2019; Adriano et al., 2000; Ribeiro, 1997), 05 estudos de casos (Grant, 2015; Iamtrakul; Chayphong, 2023; Yang et al., 2020; Kegler; Norton; Aronson, 2008; Galindo; Furtado, 2004), 04 artigos de opinião (Waynsztok; Rossi; Chiara, 2011; Monken, 2024; Gadelha; Ameixa, 2024; Tsouros, 2015), 03 descritivos (Chavez; Blanca, 2009; Matias; Campos, 2022; Santos et al., 2022), 03 documentais (Da Silva et al., 2024; Silva et al., 2024; Gallo; Setti, 2014), 01 comentário (Cole et al., 2017), 01 transversal (Moura et al., 2021), 01 ecológico (Liu et al., 2023), 01 Fenomenológico (Fitry et al., 2020) e 01 pesquisa-ação (Setti et al., 2016).

Em relação ao nível de evidência 21 estudos foram classificados no VI (Grant, 2015; Moura et al., 2021; Chavez; Blanca, 2009; Da Silva et al., 2024; Sperandio et al., 2004; Matias; Campos, 2022; Santos et al., 2022; Iamtrakul; Chayphong, 2023; Fitry et al., 2020; Setti et al., 2016; Domingues, Silva; Ravera, 2024; Niemeyer et al., 2024; Silva et al., 2024; Yang et al., 2020; Gallo; Setti, 2014; Liu et al., 2023; Sellera et al., 2019; Adriano et al., 2000; Ribeiro, 1997; Kegler; Norton; Aronson, 2008; Galindo; Furtado, 2004), 18 estudos no VII (Yang et al., 2023; Hancock, 2021; Cole et al., 2017; Machado et al., 2017; Llorca et al., 2010; Waynsztok; Rossi; Chiara, 2011; Llorca et al., 2010; Westphal; Mendes, 2000; Westphal, 2000; Ferraz, 1993; Monken, 2024; Gadelha; Ameixa, 2024; Awofeso, 2003; Tsouros, 2015; Lee; Fuccillo; Wolff, 2000; Penaforte, 2024; Tsouros; Green, 2013; Kamper-Jorgensen, 2010) e 36 estudos não foi possível realizar a classificação (De Leeuw et al., 2015; Lee et al., 2019; Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024; De Leeuw et al., 2015; Petersen et al., 2020; Laureano-Eugenio et al., 2021; Huang et al., 2024; Secretaria Municipal de São Paulo, 1990; Pilon, 1993; Lima; Lima, 2020; Petersen et al., 2020; Freire; Salles; Franco, 2016; Sperandio; Francisco Filho; Mattos, 2016; Keinert, 1997; Salas-Zapata et al., 2016; Cetin, 2024; Li et al., 2024; Lim et al., 2023; Liu, 2024; Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Westphal, 2000; Gupta; Sethi, 2024; Lv et al., 2022; Cacique et al., 2022; Portney; Sansom, 2017; Pineo et al., 2018; Ly et al., 1998; Zhao et al., 2023; Dooris; Heritage, 2011; Wang; Wangm; Guan, 2017; Nascimento et al., 2014; Kledger; Norton; Aronson, 2008; Botchway et al., 2023; Yoshizawa, 2013; Luo et al., 2022), uma vez que não foi descrito o tipo de estudo.

3.2 DEFINIÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Nas Figuras 04, 05 e 06 estão sintetizadas as evidências sobre os antecedentes, atributos e consequentes, respectivamente. Verifica-se que os termos “promoção da saúde” e a “qualidade de vida” são fatores comuns aos antecedentes, atributos e consequentes. Denota-se então a importância da transversalidade da promoção da saúde para atingir a qualidade de vida, de forma que não existirá territórios saudáveis e sustentáveis sem o investimento em políticas públicas intersetoriais que busquem o fortalecimento dessa prática de cuidado.

Figura 04. Síntese das evidências sobre os antecedentes do conceito “territórios saudáveis e sustentáveis”. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2025



Fonte: elaboração própria.

A Figura 4 apresenta os elementos fundamentais que constituem a base para o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, demonstrando como esses componentes se inter-relacionam. Essa abordagem integrada requer a implementação de políticas públicas que articulem três dimensões essenciais: o fortalecimento do capital social, o engajamento comunitário ativo e a gestão estratégica de recursos materiais, financeiros e humanos. O objetivo central dessa integração é estabelecer uma convergência efetiva entre as ações de saúde pública, as estratégias de promoção da saúde e as múltiplas dimensões da qualidade de vida. Tal articulação visa criar ambientes que favoreçam simultaneamente o desenvolvimento sustentável e o bem-estar coletivo, promovendo condições estruturais e sociais que sustentem a saúde da população em seu sentido mais amplo.

O planejamento ambiental, fundamentado na participação comunitária e na gestão colaborativa, constitui a base para a criação de territórios saudáveis, uma vez que considera a necessidade de atender demandas, valores e necessidades sociais. Essa abordagem exige não apenas uma escuta ativa, mas também a implementação de ações que integrem essas perspectivas nos processos decisórios (Bick, 2024).

A participação social desempenha um papel central nesse contexto, pois assegura a sensibilidade cultural e a adequação das propostas às realidades locais, aumentando sua aceitação e efetividade (Chu et al., 2016). Essa sensibilidade deriva de um conhecimento aprofundado sobre os indivíduos que vivenciam o território em sua dinâmica cotidiana, incluindo nuances que podem passar despercebidas pelos gestores. Apesar de sua relevância, a inclusão social nos processos decisórios raramente é ponderada em conjunto com fatores biofísicos e econômicos, os quais frequentemente recebem maior atenção (Bryan et al., 2010).

A participação da comunidade no planejamento fortalece o senso de pertencimento e a corresponsabilização local, criando um ciclo virtuoso que reforça o engajamento, a preservação ambiental e a promoção da saúde (Mert-Cakal; Miele, 2020). Entre as estratégias aplicáveis a esse planejamento, destacam-se o uso integrado de Sistemas de Informação em Saúde e Geográficos para análises causais mais robustas, a realização de consultas públicas com atores-chave (como lideranças comunitárias e representantes sociais) e coletivas (por meio de fóruns, conferências e conselhos de saúde), a formação de grupos de trabalho e conselhos consultivos que garantam representatividade e mediação entre comunidade e gestores, e a tradução do conhecimento com base em evidências científicas provenientes de pesquisas no território ou em contextos similares (Bick, 2024; Tobey et al., 2019; Cho; Kim; Lee, 2023).

A convergência entre participação comunitária, planejamento aplicado e gestão colaborativa favorece o desenvolvimento sustentável, consolidando o compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida, elementos centrais desse paradigma. Iniciativas de promoção da saúde visam criar e sustentar territórios que favoreçam o bem-estar físico, mental e social, reconhecendo a saúde como um fenômeno complexo e dinâmico, influenciado por determinantes sociais (Pederson; Rootman, 2017).

Esse campo teórico-prático compreende a determinação social do processo saúde-doença-cuidado, enfatizando a capacitação da população para a tomada de decisões e o exercício da autonomia (Evans; Kazarian, 2001; Buss et al., 2020). Suas ações baseiam-se na interdisciplinaridade e intersetorialidade, materializando-se por meio de educação popular em saúde (Cruz et al., 2024), transformações ambientais favoráveis e políticas públicas que incentivem comportamentos saudáveis (Folkvord; Hermans, 2020).

A qualidade de vida, por sua vez, abrange dimensões subjetivas e multidimensionais do bem-estar, incluindo aspectos físicos, mentais, sociais e ambientais (Stuifbergen et al., 2005). Ressalta-se ainda que a qualidade de vida deve estar inserida também no ambiente laboral, portanto sendo influenciada pela determinação social sobretudo dos fatores sociodemográficos que interferem no processo de trabalho e consequentemente em sua produtividade (Meller et al., 2020).

Tanto a promoção da saúde quanto a qualidade de vida são componentes fundamentais de territórios saudáveis, englobando espaços urbanos adequados para atividade física, acesso a alimentos saudáveis, inclusão social, redução da poluição, segurança e senso de pertencimento (Rojas-Rueda; Norberciak; Morales-Zamora, 2024; Urbinatti et al., 2023). Territórios saudáveis, a partir de uma perspectiva que garanta para além do acesso à saúde, o enfrentamento da determinação social, contribuem para a qualidade de vida de indivíduos e populações, a partir de políticas públicas que garantam uma efetiva articulação intersetorial do poder público, da mobilização da população e de inovações na gestão pública para o desenvolvimento local integrado e sustentável, que considere a nova Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS (Buss et al., 2020).

Estratégias para implementar tais territórios incluem educação popular em saúde que valorize saberes populares e amplie a capacidade decisória dos indivíduos, criação de espaços para lazer e atividade física, garantia de acesso a alimentação saudável, promoção de saúde mental com combate a estigmas, acesso a serviços essenciais e engajamento comunitário em iniciativas alinhadas às prioridades locais (Park; Yom; Sok, 2019; Rojas-Rueda; Norberciak; Morales-Zamora, 2024; Jongen; McCalman; Bainbridg, 2017; Klingberg et al., 2024; Cruz et al., 2024).

Apesar do potencial transformador dessas iniciativas, desafios persistem, como recursos limitados, resistência a mudanças, capacitação insuficiente de gestores, desigualdades sociais, interferências político-partidárias e particularidades culturais (Patnaik; Jha, 2020; Shaya; Gbarayor, 2006). Além disso, a promoção da saúde constitui um processo contínuo, demandando ações intersetoriais sustentáveis para alcançar efetividade duradoura, o que reforça a necessidade de comprometimento político e social com essas práticas.

Nessa perspectiva, as políticas públicas intersetoriais desempenham um papel fundamental no fortalecimento da saúde de um território, exigindo a consideração integrada de aspectos econômicos, sociais, ambientais e políticos (Stephen, 2020; Buss et al., 2020). Para que sejam efetivas, tais políticas devem transcender abordagens fragmentadas, articulando-se de forma transversal com temas e cuidados pertinentes à saúde. Essa integração é essencial para superar a fragmentação dos serviços e construir territórios mais resilientes e favoráveis ao bem-estar coletivo (Hasdell, 2019).

A integração das políticas de saúde pressupõe a incorporação de questões sanitárias em outras áreas por meio de ações intersetoriais, bem como o desenvolvimento de planos, programas e políticas alinhados ao conceito de "saúde em todas as políticas". Essa abordagem visa assegurar que os efeitos sobre a saúde sejam considerados em todas as etapas – formulação, implementação e avaliação – das políticas públicas (Peters et al., 2016). Tal processo demanda colaboração entre diferentes setores e atores sociais, reconhecendo a multidimensionalidade da saúde e seus determinantes (Lin et al., 2023).

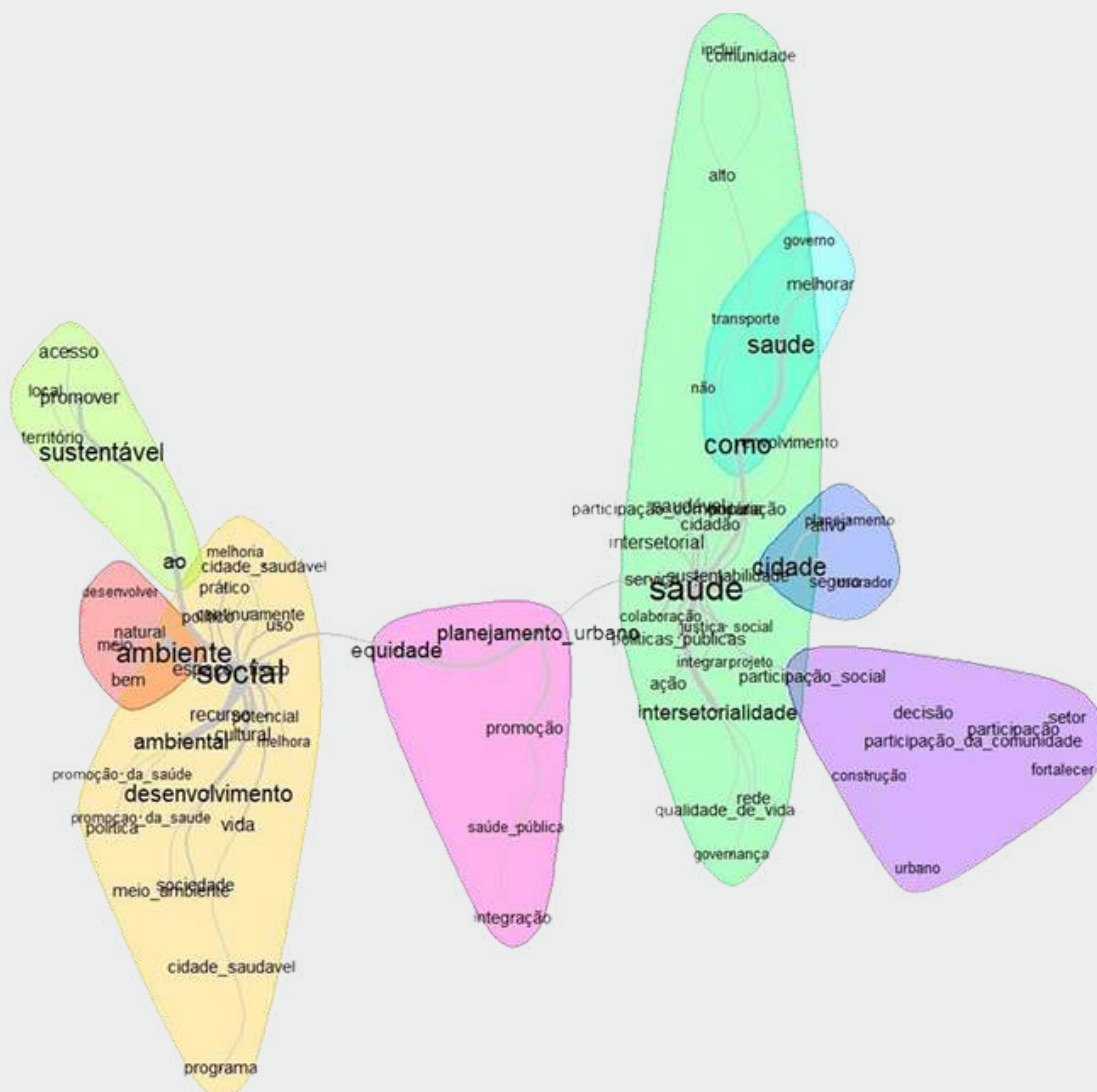
A construção de agendas comuns e ações coordenadas pode potencializar intervenções mais eficazes em territórios saudáveis (Urbinnatti et al., 2023). No entanto, essa articulação exige a compreensão dos interesses, relações de poder e conflitos inerentes aos diferentes setores, além da consideração dos danos ambientais e das iniquidades em saúde amplificadas pelo capitalismo contemporâneo (Gilmore et al., 2023). A participação ativa da comunidade também se mostra crucial, pois agrega perspectivas locais e fortalece a governança democrática (Bonab et al., 2024).

As políticas públicas saudáveis adotam uma concepção ampliada de saúde, que engloba não apenas seres humanos, mas também animais e ecossistemas (Stephen, 2020). Essa visão inclui a análise crítica das influências de políticas setoriais, como as derivadas do neoliberalismo, que tendem a reduzir a regulação estatal e priorizar lógicas de mercado, muitas vezes em detrimento dos impactos sanitários e ambientais (Gilmore et al., 2023).

Apesar de seu potencial, a integração de políticas enfrenta obstáculos significativos, como a falta de liderança e compromisso político nos âmbitos legislativo e executivo, a insuficiência de recursos e de profissionais qualificados, e a carência de sistemas robustos de monitoramento baseado em evidências (Banwell et al., 2021).

Tais desafios exigem estratégias institucionais inovadoras e um fortalecimento permanente da governança em saúde, que exigem planejamento para desenvolvido conforme evidencia as relações da Figura 05.

Figura 05. Síntese das evidências sobre os atributos do conceito “territórios saudáveis e sustentáveis”. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2025.



Fonte: elaboração própria.

Na figura 05, as palavras “ambiente”, “social”, “sustentável”, “ambiental”, “planejamento urbano”, “equidade”, “intersetorialidade”, “saúde”, “cidade” e “desenvolvimento” estão em destaque, demonstrando a importância que tem para os atributos. No entanto, é importante enfatizar que o contexto urbano foi preponderante, nesse contexto, uma vez que a constituição de territórios saudáveis ocorre por meio de processos mutualísticos entre o homem, seus coletivos e o meio ambiente.

A compreensão de territórios saudáveis é múltipla e refere-se a delimitações geográficas e/ou espaciais distintas e por vezes complementares, tais como cidades, municípios e comunidades saudáveis e/ou sustentáveis, no esforço de operacionalizar suas proposições em malhas territoriais de menor definição.

Para a Organização Mundial da Saúde, a definição de cidade saudável caracteriza-se por meio de três aspectos fundamentais, sendo eles: capacidade de prover serviços essenciais à população e ao planeta; aprimoramento contínuo dos ambientes natural, construído e social; e promoção sistêmica do bem-estar coletivo e da saúde (Tsouros, 1995).

Essa definição inspirou o movimento cidades saudáveis em diversas regiões como Canadá, Europa e China, modificando-se conforme particularidades contextuais, temporais e sociais. Hodiernamente, uma cidade saudável reconhece a importância de incorporar, como eixo estruturante de suas políticas e ações, o direito à saúde, o bem-estar social, a equidade, a sustentabilidade, a paz, a justiça social, a igualdade de gênero, a solidariedade e a inclusão social. Entre seus princípios fundamentais, destacam-se a universalização da saúde, a governança intersetorial, a abordagem da saúde em todas as políticas, a participação ativa da comunidade, a coesão social e a promoção da inovação (OMS, 2020).

O conceito “cidade saudável” foi um destaque como referencial teórico adotado (Wen et al., 2024; Sellera et al., 2019; Botchway et al., 2023; Kegler; Norton; Aronson, 2008; Yoshizawa, 2013; Kamper-Jorgensen, 2010; Luo et al., 2022; Galindo; Furtado, 2004), sendo muitas vezes um sinônimo para territórios saudáveis. Além disso, foi possível verificar que o termo “sustentável” é um qualificador para território sustentável, evidenciando que um depende do outro. Sobretudo, nesse cenário de mudanças climáticas, torna-se urgente políticas públicas intersetoriais que elaborem e executem estratégias para mitigar tais impactos na saúde da população.

As variações do clima afetam a saúde humana, animal e vegetal, contribuindo para alteração da microbiologia do solo e da água que inviabilizam a continuidade de espécies de plantas e causam crises de abastecimento de alimentos (Moreira et al., 2025). Já existem evidências de que com os aumentos das temperaturas globais também há maiores chances de aumento de mortalidade por essa causa e por maiores riscos de câncer devido a exposição ao sol (Silva; Xavier; Rocha, 2020).

Por sua vez, Machado et al. (2017) aborda os territórios saudáveis como espaços que favorecem as relações, fortalecem o sentimento de pertencimento e propiciam meios para uma vida saudável, seja por meio de ações comunitárias ou políticas públicas. Esses fatores buscam, ao longo do tempo, promover o desenvolvimento em seus múltiplos espaços, nas dimensões ambiental, cultural, econômica, política e social.

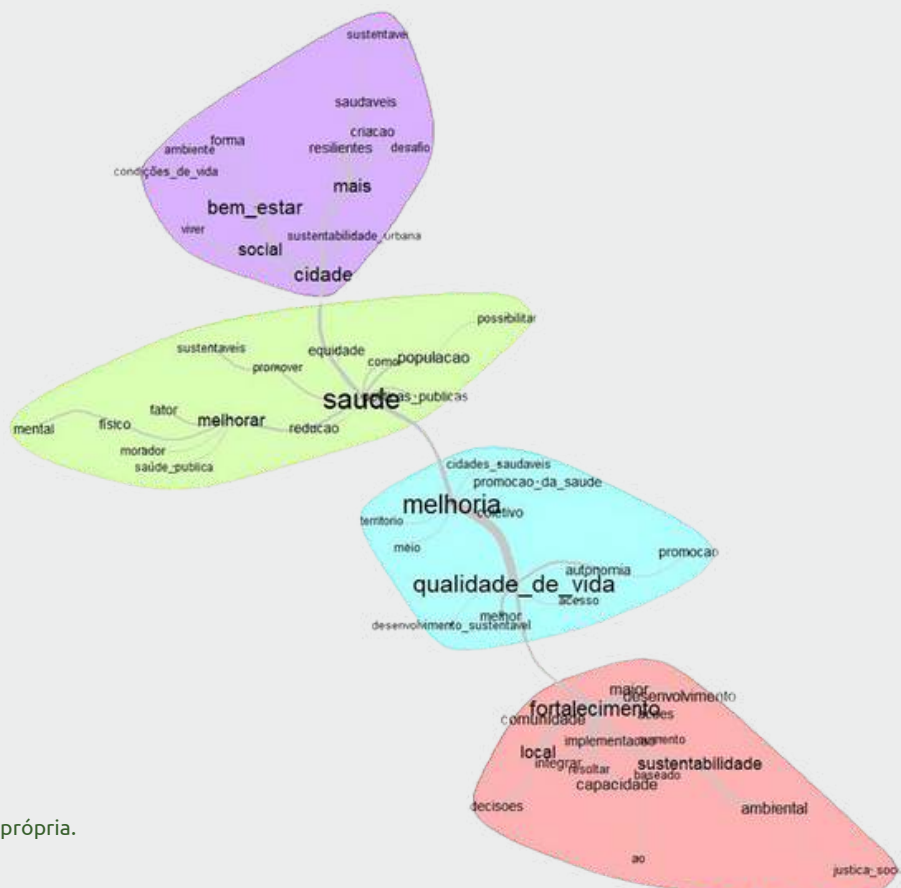
Sob este prisma, os territórios saudáveis demarcam-se pelo seu compromisso com a saúde do homem, animais e ecossistemas, de modo sustentável, equitativo e transversal as políticas públicas.

Desse modo, busca-se continuamente alcançar a promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar, preservando seus princípios de participação social, capacitação, autonomia, singularidade e interferência positiva sobre os determinantes sociais de saúde.

Os conceitos destacados articulam-se na sustentação dos territórios saudáveis de modo complementar e abordagem holística. A sustentabilidade e o meio ambiente estão diretamente relacionados, uma vez que a primeira refere-se ao uso consciente dos recursos naturais sem comprometer sua disponibilidade para gerações vindouras (Lázaro; Soares, 2024). Por sua vez, o meio ambiente é a fonte desses recursos, contemplando a água, o ar, o solo, a fauna e a flora (Scott; Hislop, 2024). O planejamento ambiental adequado do uso dos recursos naturais contribui tanto para a sustentabilidade desses quanto para mitigar agravos à saúde decorrentes dessa utilização. Para além, o planejamento urbano inclui a distribuição adequada dos recursos sociais no território, o crescimento econômico integrado à proteção ambiental, o desenvolvimento, preservação e utilização de zonas azuis e verdes, a equidade e qualidade de vida (Esfandi et al., 2024).

Assim, os territórios saudáveis e sustentáveis contemplam, dentre outros, a redução de poluição, a mobilidade sustentável, habitação adequada, alimentação saudável, participação social, tecnologias e inovação (Liu et al., 2022; Rojas-Rueda; Norberciack; Morales-Zamora, 2024; Schelings et al., 2023; Chiang, 2023).

Figura 06. Síntese das evidências sobre os consequentes do conceito “territórios saudáveis e sustentáveis”. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2025.



Fonte: elaboração própria.

Na figura 06, os destaques são para os termos “qualidade de vida”, “fortalecimento”, “local”, “melhoria”, “bem-estar”, “social” e “sustentabilidade”. Evidencia-se assim que o fortalecimento da sustentabilidade local melhora o bem-estar social coletivo.

O desenvolvimento de territórios saudáveis é uma estratégia de operacionalização da promoção da saúde, cujo objetivo reside em fortalecer a qualidade de vida da população (Adriano et al., 2000). Iniciativas como a formação de agentes populares corroboram para o fortalecimento da população local, onde lideranças das diferentes comunidades são reconhecidos como sujeitos de transformação social que colaboram para a existência e a manutenção de territórios saudáveis e sustentáveis (Niemeyer et al., 2024).

Neste contexto, destaca-se a vigilância popular em saúde como uma ferramenta estratégica que se consolidou na pandemia da COVID-19, onde se reconhece o território a partir da interseccionalidade de classe, gênero e raça, na construção do Sistema Único de Saúde, de forma a popularizar os conhecimentos em novas formas de saber-fazer para democratizá-los e incentivar soluções territoriais que contribuam para superar as desigualdades sociais para o enfrentamento de desafios que atingem a toda população com as emergências climáticas (Oliveira et al., 2024; Niemeyer et al., 2024).

Dessa forma, refletir sobre qualidade de vida e territórios saudáveis exige compreender que sua concepção não se restringe exclusivamente à categorização de antecedentes, atributos e consequentes. Sua visão deve ser transversal. Isto é, compõe um elemento de predisposição, ao demandar que as estruturas governamentais demonstrem lógica e comprometimento com a saúde e a qualidade de vida (Sperandio et al., 2004); é um atributo, ao ter como vertente idealizadora a qualidade de vida (Ferraz, 1993; Freire, Sales; Franco, 2016); e resulta em processos que favorecem a satisfação e a qualidade de vida (Lee; Park; Yoon, 2019; Matias; Campos, 2022).

Em termos definitórios, a qualidade de vida transcende a visão de saúde (Adriano et al., 2000) e constitui uma percepção individual do sujeito sobre seu lugar e existência, a partir de contexto, cultura, valores, normas, experiências, expectativas e ambiente (Salas-Zapata et al., 2016). No âmbito das pesquisas urbanas, esse conceito se revela complexo, delimitado a partir de três concepções principais: 1) satisfação e bem-estar com a cidade como fruto da individualidade; 2) pertencimento e posição do indivíduo em comunidade, em nível social e econômico; e 3) acesso a bens e serviços em qualidade e quantidade (Tanguay; Rajaonson; Bilodeau, 2023).

Portanto, considerando que os territórios saudáveis têm como fundamento a melhoria do ambiente habitacional, infere-se que, entre os resultantes do seu fortalecimento, encontra-se a qualidade de vida em suas dimensões individual, coletiva e material.

Além da perspectiva saudável, é essencial relacionar a sustentabilidade como um processo que assegura a manutenção dos meios e das ações ao longo do tempo (Laureano- Eugenio et al., 2021). Segundo Crane et al. (2021), a concepção de territórios sustentáveis requer desenvolver o presente com sensibilidade, assegurando espaços e recursos para as gerações futuras. Nesse sentido, um território sustentável equilibra meio ambiente, equidade em renda, emprego, moradia, serviços básicos, infraestrutura social e transporte (Santos et al., 2021), integrando-se ao conceito amplo de território saudável.

3.3 SÍNTESE DOS INDICADORES

Dos 75 estudos selecionados para esta revisão, 41 estudos não mencionaram indicadores para análise, dois não especificaram com detalhes indicadores e 32 estudos descreveram indicadores que foram agrupados e sintetizados em 12 dimensões e 44 subdimensões em ordem decrescente pelo quantitativo de indicadores, conforme verifica-se no Quadro 03 a seguir.

Quadro 03. Síntese das dimensões e subdimensões dos indicadores de territórios saudáveis e sustentáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (N=168)	Transporte/Mobilidade urbana	35
	Espaços verdes	34
	Infraestrutura	29
	Outros relativos a sustentabilidade	21
	Energia	13
	Qualidade da água	12
	Qualidade /Poluição do ar	11
	Qualidade do som	06
	Qualidade do solo	04
	Aquecimento global	03

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
SOCIOECONÔMICO (N=113)	Habitação	26
	Saneamento básico	24
	Segurança alimentar	17
	Esporte e lazer	16
	Educação	15
	Renda	05
	Acesso a internet	02
	Outros	08
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (N=49)	Serviços de saúde	24
	Profissionais de saúde	11
	Materno-infantil	07
	Promoção à Saúde e prevenção de doenças	04
	Saúde do idoso	02
	Saúde mental	01
ECONOMIA (N=46)	Emprego, benefícios e desemprego	19
	Gastos, investimentos e outros	18
	Economia saudável e sustentável	09
SAÚDE (N=40)	Doenças/Agravos e outros	20
	Mortalidade	17
	Longevidade	03
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA LOCAL (N=25)	Democracia	12
	Solidariedade	09
	Engajamento/Liderança	04

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
EQUIDADE (N=18)	Acessibilidade	09
	Diversidades das populações	07
	Situações de calamidade pública	02
GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO (N=17)	Gestão	07
	Planejamento	06
	Monitoramento	04
POPULAÇÃO (N=11)	Geral	07
	Individual	04
FALTA DE SEGURANÇA (N=06)	Ocorrência de crimes	06
ESPECÍFICOS (N=05)	Índices	05
DADOS/INOVAÇÃO (N=03)	Pesquisa	03

Fonte: elaboração própria.

A dimensão “Sustentabilidade Ambiental” está composta por 10 subdimensões com 168 indicadores, sendo a que teve o maior quantitativo, de forma a evidenciar o destaque do componente “ambiente sustentável e saudável” para a definição de “território saudável”, que compreende o acesso a diferentes tipos de transporte, inclusive a qualidade do espaço para os pedestres assim como a mobilidade urbana; espaços verdes para melhorar o ecossistema; infraestrutura que compreende a organização de bairros, quarteirões e outros espaços geográficos; qualidade do solo; da água; do som; a utilização de energias renováveis; indicadores relacionados ao aquecimento global e outros relativos a sustentabilidade, como por exemplo a reciclagem.

A subdimensão “Transporte/Mobilidade urbana” é formada pelos seguintes indicadores: - Pedestrianização (Webster; Sanderson, 2013); - Número de ruas exclusivas para pedestres (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Rotas de ciclismo (Webster; Sanderson, 2013); - Acesso ao transporte público (Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024); - Alcance do transporte público (Webster; Sanderson, 2013); - Proporção da população que tem acesso a transporte público, por sexo, idade e deficiência (Matias; Campos, 2022); - Densidade de tráfego (Huang et al., 2024); - Proporção do transporte de passageiros do negócio postal (Huang et al., 2024);

- Compartilhamento de transporte ferroviário de passageiros (Huang et al., 2024); - Compartilhamento de transporte ferroviário de passageiros (Huanget al., 2024); - Número total de viagens por carro privado e sua duração em comparação ao número de viagens de transporte coletivo e sua duração (Matias; Campos, 2022); - Aumento da conectividade de ruas e número de cruzamentos (Lim et al., 2023); - Melhorar a acessibilidade a espaços públicos, conectividade de ciclismo, redes e infraestruturas de pedestres (Lim et al., 2023); - Disponibilidade e eficiência de serviços de transporte público (Lim et al., 2023); - Reduzir a velocidade e o volume do tráfego (Lim et al., 2023); - % de bairros com paragens de transportes públicos no seu centro geográfico (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros com ciclovias e ciclovias (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Densidade ferroviária (km/km²) (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Lv et al., 2022); - Densidade de estradas (km/km²) (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros conectados ao centro da cidade por uma linha de transporte público (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros conectados à floresta urbana por uma linha de transporte público (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Veículos de transporte público por 10.000 pessoas (Lv et al., 2022); - Projetos de cidade para pedestres (Cacique et al., 2022); - Rede para ciclismo nas cidades (Cacique et al., 2022); - Cobertura da rede de transporte público (Cacique et al., 2022); - Transporte público e segurança (Cacique et al., 2022); - % de passageiros que usam um meio de transporte para trabalhar diferente de um veículo pessoal (Pineo et al., 2018); - Quilômetros de ciclovias e ciclovias por 100.000 pessoas (Pineo et al., 2018); - Quilômetros de transporte público de alta capacidade por 100.000 pessoas (Pineo et al., 2018); - Quilômetros de transporte público ligeiro de passageiros por 100.000 pessoas (Pineo et al., 2018); - Número de ônibus por 10.000 pessoas (Zhao et al., 2023); - Número de paradas e estações de trânsito por 10.000 habitantes (n.º/10.000 pessoas) (Yang et al., 2020); - Uso de bicicletas como transporte sustentável (Yoshizawa, 2013); - Foco em mobilidade urbana sustentável (Yoshizawa, 2013); - Transporte sustentável e inclusivo (Botchway et al., 2023); - Forma urbana e transporte (Luo et al., 2022).

Os “espaços verdes” formam a subdimensão que é composta pelos indicadores a seguir: - Infraestrutura /Espaço verde (Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024); - Taxa de cobertura florestal (Huang et al., 2024); - Área de reflorestamento (Huanget al., 2024); - Área verde do Parque da Cidade (Huang et al., 2024); - Área verde de jardim urbano (Huanget al., 2024); - Meio ambiente limpo, seguro e de alta qualidade (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Ecossistema estável agora e sustentável por muitos anos (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Melhorar e aumentar a cobertura verde, os espaços azuis e as redes verdes (Lim et al., 2023); - A área per capita de parque verde (Li et al., 2024); - Espaço verde per capita (m²/pessoa) (Yang et al., 2020); - % de bairros que possuem parque (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de edifícios certificados com um padrão de sustentabilidade (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de áreas verdes urbanas ≥ 20 hectares (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);

- % de bairros que possuem faixas naturais (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Taxa de cobertura florestal (Lv et al., 2022);- Áreas de estada urbana per capita (Lv et al., 2022); - % de terra com espaço verde (Cacique et al., 2022); - % da área urbana coberta por árvores (Pineo et al., 2018); - Número de novos edifícios certificados com um padrão de construção sustentável (por exemplo, BREEAM e LEED) (Pineo et al., 2018);- Índice de Controle de Qualidade de construção (Pineo et al., 2018); - % do parque de edifícios remodelados certificados com uma norma de construção sustentável (por exemplo, BREEAM e LEED) (Pineo et al., 2018); - % da área terrestre com espaços verdes (Pineo et al., 2018); - % da área terrestre com superfícies reflexivas (Pineo et al., 2018); - % de edifícios com telhados verdes (Pineo et al., 2018); - Hectares de área verde por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018);- Variação percentual no número de espécies nativas (Pineo et al., 2018); - % de habitações <300m de espaços verdes (tamanho mínimo de 1 hectare) (Pineo et al., 2018); - Taxa de cobertura verde da área construída (Zhao et al., 2023);- Proporção de áreas verdes (Liu et al., 2023);- Qualidade ambiental e governança (Luo et al., 2022); - Comunidade e instalações (Luo et al., 2022); - Espaço verde e aberto (Luo et al., 2022); - Construção ecológica e biológica (Luo et al., 2022); - Salubridade ambiental (Galindo; Furtado, 2004).

A “Infraestrutura” é formada por: - Número médio de tipos de uso do solo por bairro (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que incluem atividades diurnas e noturnas (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de grandes quarteirões com corte limitado (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de grandes espaços públicos dentro da cidade (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de ruas completas (com todos os modos de mobilidade) (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de terreno urbano alocado a espaço público aberto (excluindo ruas) (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população na zona de acesso ao serviço de banda larga de alta velocidade (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de edifícios em zonas de risco de inundação (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de locais de trabalho noturnos sem estacionamento (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de ruas sem calçadas (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população que vive e trabalha no mesmo bairro (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que possuem um centro comunitário (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);- % de locais históricos vistos, visitados ou utilizados na vida cotidiana (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de provedores de educação localizados em edifícios com design histórico (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de edifícios altos com lojas no térreo e espaço comunitário (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Circularidade da forma urbana (razão entre a área urbana e a área total do círculo que a rodeia) (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Fragmentação da forma urbana (razão entre a área urbana fragmentada e a área urbana total (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de área urbana abandonada (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de edifícios históricos demolidos por ano (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);

- Número de marcos históricos (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros socialmente mistos (Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Ventilação em edifícios (Cacique et al., 2022); - Adaptação para dar suporte às necessidades da pandemia (Cacique et al., 2022); - m² de espaço público interno e externo per capita (Cacique et al., 2022); - índice de controle de qualidade de construção (Cacique et al., 2022); - Porcentagem da população que vive a 500 m de uma rodovia ou estrada principal (Pineo et al., 2018); - Número de catálogos nacionais de proteção do patrimônio cultural imaterial (Zhao et al., 2023); - Taxa de urbanização (Zhao et al., 2023; Liu et al., 2023); - Proteção ao patrimônio cultural e natural (Botchway et al., 2023).

Outros indicadores relativos a sustentabilidade foram agrupados a seguir: - Relação da taxa de consumo de terra em relação à taxa de crescimento populacional (Matias; Campos, 2022); - Sítios industriais abandonados (Webster; Sanderson, 2013); - Espaço de vida (Webster; Sanderson, 2013); - Resiliência (Wen et al., 2024); - Utilidades e serviços (Wen et al., 2024); - Incômodo (referente à quantidade de população afetada por poluição sonora, visual e por odor) (Matias; Campos, 2022); - IVS-infraestrutura, que reflete as condições de acesso a redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, tempo gasto de deslocamento entre a moradia e o local de trabalho pela população ocupada de baixa renda (Petersen et al., 2020); - Sustentabilidade político- jurídica (Acordos locais e arranjos legais; Planos locais usando uma abordagem de desenvolvimento sustentável e HP; Diretrizes para a implementação da estratégia; Responsabilidade) (Petersen et al., 2020); - Sustentabilidade econômica (Recursos econômicos para saúde, água e saneamento; Recursos econômicos para ações operacionais; Recursos econômicos para avaliação) (Laureano-Eugenio et al., 2021); - Taxa de penetração do gás urbano (Huang et al., 2024); - Comprimento do tubo de drenagem urbana (Huang et al., 2024); - Área de terreno para construção urbana (Huang et al., 2024); - Fornecimento de gás natural urbano (Huang et al., 2024); - Grau de urbanização (Huang et al., 2024); - Proporção da população que vive em cidades que implementam planos de desenvolvimento urbano e regional, integrando projeções populacionais e necessidades de recursos, por tamanho da cidade (Matias; Campos, 2022); - Verde/patrimônio cultural e espaços públicos (porcentagem de áreas verdes, públicas e de patrimônio local necessitada de reparos (Matias; Campos, 2022); - “sustentabilidade única” (a ser elaborado e identificado por cada centro-urbano (Matias; Campos, 2022); - meio ambiente e urbanização, com variáveis referentes a mudanças climáticas; risco de desastres; congestionamentos e poluição do ar (Matias; Campos, 2022); - reciclagem (Cacique et al., 2023); - Serviços de saúde ambiental (água, ruído, ar, solo) (Cacique et al., 2023); - Redução de impactos de desastres naturais (Botchway et al., 2023); - Redução dos impactos ambientais nas cidades (Botchway et al., 2023).

A “Qualidade /Poluição do ar (Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2023; Cacique et al., 2022)” é integrada por: - Níveis médios anuais de emissão de partículas finas (Matias; Campos, 2022); - Número de dias por ano em que os níveis seguros de ar são ultrapassados e o trânsito parado (Matias; Campos, 2022); - Proporção de dias com boa qualidade do ar (Li et al., 2024; Lv et al., 2022); - Número de dias com poluição severa e acima (Li et al., 2024); - Taxa de segurança de fontes centralizadas de água potável (Li et al., 2024); - Concentração de $PM_{2,5}$ $\mu g/m^3$ (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Lv et al., 2022; Pineo et al., 2018); - Valor médio do ruído ambiental regional (Lv et al., 2022); - Concentração de NO_2 $\mu g/m^3$ (Pineo et al., 2018); - Contração de PM_{10} $\mu g/m^3$ (Pineo et al., 2018); - Dias de qualidade do ar (API) em ou acima do nível (Zhao et al., 2023); - Proporção de dias com qualidade do ar boa e excelente (%) (Liu et al., 2023).

A subdimensão “Qualidade da água (Webster; Sanderson, 2013; Cacique et al., 2022)” possui os seguintes indicadores: - Percentual de abastecimento de água por rede geral (Petersen et al., 2020); - Fornecimento total de água superficial (Huang et al., 2024); - Taxa de penetração de água urbana (Huang et al., 2024); - % de edifícios com abastecimento de água potável (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de edifícios atendidos por coleta de águas residuais (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Consumo de água per capita (Matias; Campos, 2022; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Porcentagem de área de água (Lv et al., 2022); - Acesso à água potável segura (Cacique et al., 2022); - Qualidade do rio (Cacique et al., 2022); - % da população com serviço de abastecimento de água potável (Cacique et al., 2022; Pineo et al., 2018); - % da população atendida pela coleta de águas residuais (Cacique et al., 2022; Pineo et al., 2018); - Porcentagem da população com abastecimento de água encanada (Nascimento et al., 2014).

Já a subdimensão “Energia” incluir tanto aspectos relacionados ao consumo (quantidade) quanto ao tipo de energia utilizada, destacando a legalidade e a utilização de energias renováveis, como pode-se observar a seguir: - Consumo de energia (quantidade de óleo equivalente por habitante por ano) (Matias; Campos, 2022); - % de energia derivada de energias renováveis (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população com serviço de eletricidade autorizado (Cacique et al., 2022; Pineo et al., 2018); - % de energia derivada de renováveis (Cacique et al., 2022); - Consumo de eletricidade por ano (Cacique et al., 2022); - % da população com serviço de eletricidade autorizado (Pineo et al., 2018); - % de bairros residenciais com iluminação pública adequada (Pineo et al., 2018); - Consumo residencial de eletricidade per capita (Pineo et al., 2018); - Consumo de eletricidade de edifício público por ano – kWh/M^2 (Pineo et al., 2018); - Porcentagem de energia derivada de energias renováveis (Pineo et al., 2018); - % do estoque de edifícios com eficiência energética (Pineo et al., 2018); - % de famílias vivendo em pobreza energética (Pineo et al., 2018); - Taxa de redução do consumo de energia por unidade do PIB (Zhao et al., 2023).

A “Qualidade do som” integra tanto a poluição quanto os níveis de decibéis considerados não propícios a saúde, integrada pelos seguintes indicadores: - Poluição sonora (Cacique et al., 2022); - % da população exposta à poluição sonora medida em $L_{den} > 55dB$ (Pineo et al., 2018); - % de moradores expostos a níveis de ruído superiores a 35dB durante a noite (Pineo et al., 2018); - % de moradores expostos a níveis de ruído superiores a 45dB durante o dia (Pineo et al., 2018); - % de moradores que relatam incômodo com ruído (Pineo et al., 2018); - Poluição sonora (Wen et al., 2024).

A “Qualidade do solo” é composta pelos indicadores: - Acidificação do solo (depósito de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e/ou amônia por hectare) (Matias; Campos, 2022); - Toxicificação do ecossistema (presença de certas substâncias tóxicas em determinadas quantidades no ambiente (Matias; Campos, 2022); - Poluição do solo (Cacique et al., 2022); - Mistura de uso do solo: número médio de tipos de uso do solo por bairro (Pineo et al., 2018).

Ainda há a subdimensão “Aquecimento global (Matias; Campos, 2022)” que é integrada por: - Quantidade de emissões de gases de efeito estufa (Matias; Campos, 2022); - Toneladas per capita de emissões de gases com efeito de estufa (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Pineo et al., 2018); - Índice de calor urbano (Pineo et al., 2018).

A subdimensão “Socioeconômico (Webster; Sanderson, 2013)” evidencia a influência da determinação social na constituição dos territórios saudáveis, incluindo 113 indicadores relativos à habitação; saneamento básico; segurança alimentar; esporte e lazer; educação; renda; acesso a internet; e outros que dizem respeito ao grau de pobreza e acesso à necessidades humanas básicas.

Os indicadores relacionados a “Habitação” incluem quantidade de pessoas com moradia de qualidade e com o mínimo necessário para viver, sendo eles: - Habitação (Wen et al., 2024; Moura et al., 2021) e edifícios (Wen et al., 2024); - Número de pessoas sem abrigo por 100000 habitantes (Pineo et al., 2018); - Qualidade da moradia (percentual da população afetada por falta de moradia ou que habita ambientes degradados/insalubres) (Matias; Campos, 2022); - Moradia (Petersen et al., 2020); - Habitação e serviços básicos, com variáveis sobre melhoramentos de favelas e prevenção de favelização; acesso à habitação adequada; garantia de acesso ao serviço de água potável; garantia de acesso ao serviço de esgotamento sanitário e à drenagem urbana; acesso a energias domésticas limpas; acesso aos meios de transportes sustentáveis (Matias; Campos, 2022); - Medidas para melhorar a qualidade e eficiência energética da habitação (Lim et al., 2023); - % de famílias que consideram a sua casa adaptável (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de unidades habitacionais construídas por ano (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que possuem cooperativa habitacional (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);

- % de novas habitações em áreas degradadas (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); -% de habitação subsidiada em bairros de classe média (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que possuem zoneamento excludente (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros com ativos de propriedade comunitária (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de famílias que se mudaram mais de uma vez nos últimos três anos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de casas médias anexas (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Porcentagem da população em habitação inadequada (Webster; Sanderson, 2013); - Quantidade de espaço habitável (Cacique et al., 2022); - Proporção de população urbana vivendo em favelas, assentamentos informais ou habitações inadequadas (Matias; Campos, 2022); - Adequação das instalações habitacionais (Cacique et al., 2022); - % de moradias (Cacique et al., 2022); - Acessibilidade à moradia (Cacique et al., 2022); - % da população vivendo em acomodações precárias (Cacique et al., 2022); - Taxa de desabrigados (Webster; Sanderson, 2013; Cacique et al., 2022); - % da população que vive em favelas (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Cacique et al., 2022; Pineo et al., 2018); - Acessibilidade à habitação (Pineo et al., 2018); - Número de pessoas sem abrigo por 10 000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Acesso a habitação segura e acessível (Botchway et al., 2023).

A subdimensão “Saneamento básico” é composta por: - Manejo de resíduos (toneladas de resíduos produzidos por habitantes por ano) (Matias; Campos, 2022); - Percentual de saneamento básico adequado - relacionado aos domicílios com acesso a serviços de rede geral de abastecimento de água, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e coleta de lixo (Petersen et al., 2020); - Tratamento de resíduos domésticos (Webster; Sanderson, 2013); - Coleta de esgoto (Webster; Sanderson, 2013); - Volume de remoção de resíduos sólidos urbanos (Huang et al., 2024); - Taxa de tratamento de esgoto urbano (Huang et al., 2024); - Proporção de resíduos sólidos coletados e devidamente descartados em relação ao total de resíduos sólidos gerados, por cidades (Matias; Campos, 2022); - Taxa de tratamento inofensivo de resíduos domésticos (Li et al., 2024); - Densidade de banheiros públicos (Li et al., 2024); - Cobertura de sanitários não perigosos (zona rural) (Li et al., 2024); - Proporção de condados sanitários (cidades) (Li et al., 2024); - Número de banheiros públicos na cidade (Huang et al., 2024); - % de edifícios atendidos pela coleta de resíduos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de reciclagem de esgoto (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de reciclagem de resíduos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Taxa de tratamento inofensivo de lixo doméstico (Lv et al., 2022); - Taxa de utilização abrangente de resíduos sólidos industriais gerais (Lv et al., 2022); - Gestão de resíduos (Cacique et al., 2022); - Porcentagem de poluentes da água removidos do esgoto total produzido (Cacique et al., 2022); - % da população com coleta regular de resíduos sólidos (Pineo et al., 2018); - Taxa de descarte inofensivo de lixo doméstico (Zhao et al., 2023); - Taxa de utilização abrangente de resíduos sólidos industriais (Zhao et al., 2023); - Taxa de tratamento centralizado de esgotos domésticos urbanos (Zhao et al., 2023); - Avaliação de intervenções de saneamento (Moura et al., 2021).

A “Segurança alimentar” corresponde ao acesso aos alimentos em diferentes lugares, a distância para obtê-los e a qualidade proteica/calórica dos alimentos, incluindo: - Acesso a alimentos (Wen et al., 2024); - Segurança alimentar; - Inspeção de amostragem de alimentos por lote por 1000 pessoas (Li et al., 2024); - Integrar instalações e instituições públicas por meio de desenvolvimento misto, bem como melhorar o ambiente alimentar (Lim et al., 2023); - % de escolas alimentadoras (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros com lojas de alimentos frescos em suas localizações geográficas centrais (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que possuem horta comunitária (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros com restaurantes baratos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - higiene alimentar (Cacique et al., 2022); - Nutrição (Cacique et al., 2022); - Signatário do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão (Pineo et al., 2018); - Acessibilidade: Tempo Médio de caminhada até lojas de alimentos que vendem frutas e vegetais (Pineo et al., 2018); - Acessibilidade: % de domicílios sem veículo que vivem a mais de 0,9 milhas de distância radial de um supermercado (Pineo et al., 2018); - Número de lojas de alimentos que vendem frutas e vegetais em um raio de 500m de propriedades residenciais (Pineo et al., 2018); - Número de lojas de alimentos que vendem frutas e vegetais em um raio de propriedade comerciais e de varejo (Pineo et al., 2018); - % de moradores que respondem “há uma grande variedade de alimentos com baixo teor de gordura disponível no meu bairro” (Pineo et al., 2018); - Porcentagem de crianças menores de 1 ano de idade com subnutrição proteica/calórica (Nascimento et al., 2014); - Porcentagem de crianças de 1 a 2 anos com subnutrição proteica/calórica (Nascimento et al., 2014).

A subdimensão “Esporte e lazer” compreende indicadores relativos a instalações que dão acesso as pessoas a aparatos que permitam elas viverem além do trabalho, tais como: - Instalações desportivas (Webster; Sanderson, 2013) e de lazer (Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024; Moura et al., 2021); - Atividades de fitness; -Área do Estádio X10 per capita na cidade (Li et al., 2024); - Proporção do número de instrutores de esportes sociais por 1000 pessoas (Li et al., 2024); - A proporção de residentes urbanos e rurais que atingiram os “Padrões Nacionais de Medição de Aptidão Física” ou acima (Li et al., 2024); - Proporção da população que pratica regularmente atividade física (Li et al., 2024); - Fornecer instalações públicas, áreas recreativas e comerciais que estejam próximas de locais de trabalho e áreas residenciais (Lim et al., 2023); - M^2 de espaço público de recreação interna per capita (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - População que pratica exercício físico regularmente (Cacique et al., 2022); - m^2 de espaço público de recreação interna per capita (Pineo et al., 2018); - m^2 de espaço público de recreação ao ar livre per capita (Pineo et al., 2018); - Acesso a instalações de lazer e recreação: Instalações dentro de 600m por 100.000 (Pineo et al., 2018); - Equipamentos e estrutura físicas para parques infantis pré-escolares (Pineo et al., 2018); - Centros de fitness por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018); - Instalações desportivas por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018); - Área de campo esportivo per capita (Zhao et al., 2023); - Instalações desportivas por 10.000 habitantes residentes ($n.^o/10.000$ pessoas) (Yang et al., 2020).

A “Educação” compreende o acesso a diferentes níveis de ensino, em faixas etárias, considerando evasão e distorção nas séries, e incluem: - Número de estudantes universitários por 10.000 pessoas (Zhao et al., 2023); - Volume de livros em bibliotecas públicas por 10.000 pessoas (Zhao et al., 2023); - % de bairros que possuem escola pública (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - O nível de literacia em saúde dos residentes – Alfabetização em saúde (Li et al., 2024); - % da população com educação acadêmica em ciências (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - A quantidade de livros da biblioteca por 10.000 pessoas (Lv et al., 2022); - Idade média na conclusão do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Porcentagem de crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Taxa de abandono escolar no 1º ano do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Distorção idade-série no 4º ano do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Distorção idade-série no 8º ano do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Proporção de gênero dos alunos matriculados no ensino fundamental (Nascimento et al., 2014); - Proporção de gênero dos alunos matriculados no ensino secundário (Nascimento et al., 2014); - Proporção de gênero dos alunos matriculados no ensino superior (Nascimento et al., 2014); - IDHM-educação, que corresponde aos níveis de escolaridade da população adulta e fluxo escolar adequado da população jovem (Petersen et al., 2020).

A “Renda” incluem os seguintes indicadores: - Condições econômicas (Moura et al., 2021); - Emprego de pessoas com deficiência (Webster; Sanderson, 2013); - Índice de Vulnerabilidade Social (IVS); - Renda e trabalho; desocupação de adultos, ocupação informal de adultos pouco escolarizados, dependência à renda de idosos e a presença do trabalho infantil (Petersen et al., 2020); - % de pessoas ganhando menos do que a renda per capita média (Cacique et al., 2022); - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM); - Renda, que reflete a renda per capita municipal (Petersen et al., 2020).

E a subdimensão “Acesso à internet” compreende: - Taxa de penetração da Internet (Zhao et al., 2023); - Taxa de penetração da internet nos residentes (Lv et al., 2022).

Outros indicadores estão relacionados a pobreza extrema que causam falta de acesso a necessidades humanas básicas e outros serviços essenciais, a partir de: - Pobreza (Webster; Sanderson, 2013); - Taxa de aborto (Webster; Sanderson, 2013); - Crescimento demográfico (A 10); - IVS - capital humano, composto por mortalidade infantil, crianças e jovens que não frequentam a escola, mães precoces e chefes de família com baixa escolaridade e filhos menores, ocorrência de baixa escolaridade para adultos e jovens que não trabalham e não estudam (Petersen et al., 2020); - Necessidades básicas (comida, água, casa, salário, segurança, trabalho) para todos moradores da cidade (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Um ótimo serviço apropriado para assistência social e educacional, com acesso a todos os moradores (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990);

- Justiça social (Porcentagem da população afetada pela pobreza, desemprego, falta de acesso à educação, informação, treinamento e lazer) (Matias; Campos, 2022); - Aumento do número de populações, residências unidades, atividades empresariais e espaços comerciais em uma área (Lim et al., 2023); - % de famílias vivendo abaixo do nível nacional de pobreza (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023).

A dimensão “Assistência à saúde” formada por 49 indicadores, é composta por acesso à serviços de saúde que considerem as singularidades das pessoas e as coloquem como centro do cuidado; quantidade de diferentes profissionais de saúde, com destaque para o número de médicos, evidenciando ainda o modelo medicalocêntrico; a saúde materno-infantil; a promoção da saúde e prevenção de doenças, com indicadores relativos a educação em saúde e a imunização; a saúde do idoso e saúde mental.

Em relação aos “Serviços de saúde (Webster; Sanderson, 2013)” a maioria dos indicadores são sobre acesso de forma a considerar as especificidades e a qualidade das ações e serviços ofertados, a saber: - Porcentagem da população coberta por seguro de saúde (Webster; Sanderson, 2013); - Disponibilidade de serviços em línguas estrangeiras (Webster; Sanderson, 2013); - Debates sobre saúde na Câmara Municipal (Webster; Sanderson, 2013); - Condições de ofertas públicas de saúde (Moura et al., 2021); - Um ótimo serviço apropriado para saúde pública, assistência médica, com acesso a todos os moradores (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Alto nível de saúde (alto nível de saúde e baixo nível de doença) (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Taxa de reembolso de despesas de hospitalização no seguro médico básico (Li et al., 2024); - Número de leitos em unidades de saúde por 1000 pessoas (Li et al., 2024); - Proporção de instituições médicas e de saúde primárias que prestam serviços de medicina chinesa (Li et al., 2024); - % da população que se sente com boa saúde (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população que percebe estresse na vida diária (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros que possuem um centro de saúde primário (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de leitos hospitalares por 1000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de farmácias por 1000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros onde estão instalados exames médicos digitais gratuitos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de hospitais públicos em áreas de baixa renda e vulneráveis (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de centros de saúde que também oferecem assistência médica virtual (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de leitos hospitalares por 10.000 pessoas (Lv et al., 2022); - Cobertura por seguro de saúde (Cacique et al., 2022); - Descrição do mecanismo/rede de apoio social (Cacique et al., 2022); - Hospitais e instalações de saúde comunitárias, escolas, centros comunitários (Cacique et al., 2022); - Taxa de cobertura do seguro médico básico para residentes urbanos e rurais (Zhao et al., 2023); - Número de instituições médicas (Liu et al., 2023); - Serviço amigável de saúde (Luo et al., 2022).

A subdimensão “Profissionais de saúde” de saúde compila indicadores que dizem respeito ao número de profissionais por habitantes, na maioria, sendo a categoria médica, em destaque; e aparecendo a categoria da enfermagem e de profissionais de saúde pública em menor proporção, como verifica-se a seguir: - Habitantes por profissional de saúde primário (Webster; Sanderson, 2013); - Habitantes por enfermeiro (Webster; Sanderson, 2013); - Número de médicos por 1000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Assistência médica (Distribuição Hospitalar; Distribuição de enfermeiros registrados) (Huang et al., 2024); - Número de médicos generalistas por 10.000 pessoas (Li et al., 2024); - Número de profissionais de saúde pública por 10.000 pessoas (Li et al., 2024); - Número de médicos em clínicas comunitárias por 10.000 habitantes (nº/10.000 pessoas) (Yang et al., 2020); - Número de profissionais de psiquiatria (assistentes) (por 1000 habitantes) (Liu et al., 2023); - Número de enfermeiros registrados (por 1.000 habitantes) (Liu et al., 2023); - Proporção de pessoas pelo número de médicos (Zhao et al., 2023); - Número de Médicos por 10.000 pessoas (Lv et al., 2022).

Verifica-se que a saúde “Materno-infantil” tem uma perspectiva da mulher como genitora, não sendo evidenciado indicador específico aos cuidados das mulheres para além do período gestacional, e está representada pelos indicadores a seguir: - Serviços de saúde materno-infantil (Li et al., 2024); - Taxa de gestão da saúde infantil (Li et al., 2024); - Taxas de gestão materna sistemática (Li et al., 2024); - Porcentagem de partos institucionais (Nascimento et al., 2014); - Proporção de cobertura de gestações com 7 ou mais consultas pré-natais (Nascimento et al., 2014); - Disponibilidade de cuidados infantis (Webster; Sanderson, 2013); - Idade das mães no momento do parto (Webster; Sanderson, 2013).

A “Promoção à saúde e prevenção de doenças” é composta por indicadores relativos a imunização, a saber: - Taxa de vacinação do programa de imunização para crianças em idade escolar por município (%) (Liu et al., 2023); - Taxas de imunização (Webster; Sanderson, 2013; Cacique et al., 2022); e por indicadores que abordam a Educação em Saúde, incluindo: - Programas de educação em saúde da cidade (Webster; Sanderson, 2013); - Existência de programa de educação para a saúde (Cacique et al., 2022).

A “Saúde do idoso”: - Número de leitos de assistência a idosos por 1000 idosos (Li et al., 2024); - Políticas de envelhecimento saudável (Tsouros; Green, 2013)] e a “Saúde mental” [- Taxa de tratamento padronizada de pacientes com transtornos mentais graves (Li et al., 2024)] foram as subdimensões que menos se destacaram. No entanto, é notável que há um cuidado para o incentivo a políticas públicas que colaborem para o envelhecimento saudável.

A dimensão “Economia (Huang et al., 2024)” possui 46 indicadores relativos a emprego formais e informais, incluindo o terceiro setor, benefícios de governo e desemprego; gastos, investimentos com saúde e outras taxas econômicas; e estratégias para promover uma economia sustentável e saudável, que apesar de ser a terceira subdimensão que quantifica os indicadores, evidencia-se a preocupação em garantir subsistência para a classe trabalhadora.

A subdimensão “Emprego, benefícios e desemprego” demonstra dois extremos que são os empregos em diferentes locais e o desemprego, além disso de forma discreta com apenas um indicador demonstra benefício de governo à população mais carente. Ela é formada por:

- Taxa de Desemprego (Webster; Sanderson, 2013; Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Cacique et al., 2022);
- % de negócios de fórmulas (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de trabalhadores na indústria de transformação (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de trabalhadores em estabelecimentos de atacado, varejo e alimentação (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de trabalhadores em serviços profissionais (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Número de pequenas empresas de construção (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % da população que vive e trabalha na cidade (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Número de start-ups e PMEs (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Número de setores econômicos exportadores (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Salário médio dos empregados (Zhao et al., 2023);
- Porcentagem de empregados no setor terciário (Zhao et al., 2023);
- Taxa de participação no seguro-desemprego (Zhao et al., 2023);
- Porcentagem de mulheres assalariadas no setor não agrícola (Nascimento et al., 2014);
- Proporção homem/mulher entre trabalhadores assalariados (Nascimento et al., 2014);
- Porcentagem da indústria secundária em relação ao PIB (Lv et al., 2022);
- Porcentagem da indústria terciária em relação ao PIB (Lv et al., 2022);
- Porcentagem de jovens trabalhadores assalariados com idades entre 15 e 24 anos (Nascimento et al., 2014);
- Porcentagem de famílias beneficiadas pelo FGP (Nascimento et al., 2014);
- Número de locais regulamentados para venda ambulante (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023).

A subdimensão “Gastos, investimentos e outros” é construída por indicadores relativos a gastos públicos e privados, patrimônios, despesas com saúde e assistência social, rendas e receitas, como pode-se observar a partir de:

- Total de gasto (público e privado) per capita na preservação, proteção e conservação do patrimônio cultural e natural, por tipo de patrimônio, nível de governo, tipo de gasto e tipo de financiamento privado (Matias; Campos, 2022);
- Perda econômica direta em relação ao PIB relacionada a desastres (Matias; Campos, 2022);
- Proporção da despesa com saúde na despesa fiscal (Li et al., 2024);
- % de rendas de casas a preços subsidiados (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Proporção de renda e despesa dos residentes (Lv et al., 2022);
- Investimento per capita em fixo (Lv et al., 2022);
- Ativos fixos (Lv et al., 2022);
- Vendas totais no varejo de bens de consumo per capita (Lv et al., 2022);
- Idosos vivendo sozinhos recebendo cuidados (Cacique et al., 2022);

- Gastos com assistência social (Cacique et al., 2022); - Resiliência econômica (Cacique et al., 2022); - Receita orçamental geral per capita das finanças locais (Zhao et al., 2023); - Proporção da produção das indústrias secundárias e terciárias no PIB (Zhao et al., 2023); - Propriedade de patentes por 10.000 pessoas (Zhao et al., 2023); - A proporção das despesas com saúde nas despesas das finanças públicas gerais (Zhao et al., 2023); - Receita municipal per capita proveniente de impostos e transferências constitucionais e legais (Nascimento et al., 2014); - Taxa de gestão da saúde dos idosos com mais de 65 anos (%) (Liu et al., 2023); - Valor total da despesa governamental com saúde (CNY) (Liu et al., 2023).

A “Economia saudável e sustentável” demonstra uma tendência a estratégias que busquem a ampliação da renda a partir de financiamentos para crescimento do PIB, a partir dos seguintes indicadores: - Economia Saudável (PIB, PIB per capita; Taxa de crescimento do PIB; Receita; Valor acrescentado industrial) (Huang et al., 2024); - PIB per capita (Lv et al., 2022; Liu et al., 2023); - Uma economia diversificada, vital e inovadora (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - Proporção de suporte financeiro para os países menos desenvolvidos que é alocado para a construção e adaptação de edifícios sustentáveis, resilientes e eficientes em recursos, utilizando materiais locais (Matias; Campos, 2022); - Economia urbana sustentável (Renda individual total na cidade menos: déficit fiscal da cidade, despesas ambientais e danos à poluição por habitante por ano) (Matias; Campos, 2022); - Economia urbana, com variáveis sobre financiamento local/municipal; acesso ao financiamento habitacional; desenvolvimento econômico local; empregos e meios de vida decentes e integração da economia urbana na política nacional de desenvolvimento (Matias; Campos, 2022); - Buscando a prosperidade da comunidade ampliada e recursos fortalecidos por meio da governança baseada em acesso aos bens comuns e serviços (Lima; Lima, 2020); - Capacidade de alavancar recursos financeiros (Kegler; Norton; Aronson, 2008); - Sustentabilidade financeira e política dos programas (Kegler; Norton; Aronson, 2008).

Apesar de ser conceituada como “Saúde (Webster; Sanderson, 2013)” pela própria literatura, essa dimensão apresenta diversos indicadores relativos a doenças ou agravos, destacando a “ausência de doenças” como um marcador para se ter saúde; diferentes indicadores de mortalidade por diferentes causas, com destaque para a mortalidade infantil; e indicadores relativos a longevidade que versam sobre a expectativa de vida.

Os doenças/Agravos e outros aspectos epidemiológicos apareceram como a subdimensão que mais se destacou em números de indicadores, sendo eles: - Baixo peso ao nascer (Webster; Sanderson, 2013); - Investigação epidemiológica (Moura et al., 2021); - Razão de dependência (Petersen et al., 2020); - Proporção de pessoas vítimas de violência sexual ou física, por sexo, idade e deficiência, nos últimos 12 meses (Matias; Campos, 2022);

- Segurança urbana (percentagem da população afetada seriamente por crimes e acidentes de trânsito (Matias; Campos, 2022); - Incidência de doenças infecciosas de classe A e B (Li et al., 2024; Lv et al., 2022); - Prevalência de hipertensão em pessoas de 18 a 50 anos (Li et al., 2024); - Taxa de tabagismo em pessoas com mais de 15 anos (Li et al., 2024); - Número de feridos em acidentes de trânsito por 10.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Consumo de álcool e outras drogas (Cacique et al., 2022); - Fontes de estresse social (Cacique et al., 2022); - Prevalência da malária (Nascimento et al., 2014); - Incidência de tuberculose (por 100.000 habitantes) (Liu et al., 2023); - Prevalência de tuberculose (casos confirmados) (Nascimento et al., 2014); - Taxa de novos casos de pneumoconiose em trabalhadores com exposição à poeira há menos de 5 anos (%) (Liu et al., 2023); - Taxa de diagnóstico precoce de espécies críticas de câncer em áreas de alta prevalência (%) (Liu et al., 2023); - Taxas de hospitalização evitáveis para condições de sensibilidade aos cuidados ambulatoriais (selecionadas como hipertensão essencial e diabetes tipo 2) (por 100.000 habitantes) (Liu et al., 2023); - Número de casos de intoxicação alimentar por 1000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população com obesidade (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população com diabetes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); % da população com doença respiratória (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023).

A “Mortalidade” infantil até 5 anos, materna e por doenças e agravos conseguem ser identificadas a partir dos indicadores a seguir: - Taxa de Mortalidade da população (Webster; Sanderson, 2013; A 10; Huang et al., 2024; Cacique et al., 2022); - Mortalidade infantil (Moura et al., 2021; Petersen et al., 2020; Li et al., 2024; Lv et al., 2022; Liu et al., 2023); - Mortalidade por arboviroses (Moura et al., 2021); - Número de mortos, desaparecidos e afetados por desastres por 100.000 habitantes (Matias; Campos, 2022); - Principais causas de morte (Webster; Sanderson, 2013; Cacique et al., 2022); - Taxa de mortalidade até 5 anos (Petersen et al., 2020); - Taxa de mortalidade até 5 anos por diarreia (Petersen et al., 2020); - Taxa de mortalidade de menores de 5 anos (Li et al., 2024); - Taxa de mortalidade materna (Li et al., 2024; Lv et al., 2022; Liu et al., 2023); - Mortalidade por Diarreia em crianças menores de 5 anos (Nascimento et al., 2014); - Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares (Nascimento et al., 2014); - Taxas de mortalidade por causas externas (Nascimento et al., 2014); - Mortalidade proporcional de crianças menores de 1 ano (Nascimento et al., 2014); - Coeficiente de Mortalidade Infantil por média móvel (Nascimento et al., 2014); - Razão de mortalidade materna corrigida pela média móvel (Nascimento et al., 2014); - Mortalidade prematura por doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes em pessoas de 30 a 70 anos (%) (Liu et al., 2023); - Número de mortes por acidentes de trânsito por 10.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023).

A subdimensão “Longevidade” apareceu de forma discreta e foi composta por: - Expectativa de vida per capita (Li et al., 2024; Lvet al., 2022; Zhao et al., 2023; Liu et al., 2023); - IDHM-longevidade que reflete a esperança de vida ao nascer (Petersen et al., 2020); - Taxa de natalidade (Huang et al., 2024).

A dimensão “Participação comunitária local (Lee et al., 2019; Yoshizawa, 2013; Galindo; Furtado, 2004)” possui 25 indicadores que consideram aspectos relativos à democracia, com o estabelecimento de espaços que incentivem a participação, tais como: eleições, consultas públicas, dentre outras; à solidariedade, sobretudo a partir do voluntariado e pelo desenvolvimento de capacidades locais com programas comunitários; e o engajamento e liderança como premissas fundamentais para o fortalecimento da participação da comunidade.

A “Democracia” foi evidenciada pelos seguintes indicadores que consideraram a participação como eleitores ou como representantes do povo por candidatura eleita, consultas públicas, dentre outras formas de decisão: - Percentagem total da população que participa nas eleições locais ou como membros ativos em associações para a melhoria urbana e qualidade de vida (Matias; Campos, 2022); - Participação comunitária nas decisões locais (Kegler; Norton; Aronson, 2008); - Participação comunitária nas decisões urbanas (Adriano et al., 2000); - Porcentagem de vereadoras (Nascimento et al., 2014); - Porcentagem de mulheres entre os deputados federais eleitos pelos estados (Nascimento et al., 2014); - Garantindo a participação de todos os indivíduos e comunidades nas decisões que os afetam e afetam os lugares (Lima; Lima, 2020); - % de consultas públicas que buscam identificar problemas urbanos (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de consultas públicas abrangendo antes, durante e depois das intervenções (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de consultas públicas direcionadas a grupos sub-representados (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Proporção de cidades com estrutura para participação direta da sociedade civil, de forma democrática e regular, no planejamento urbano (Matias; Campos, 2022); - Descentralização e fortalecimento das autoridades locais (Matias; Campos, 2022); - Crenças políticas (Lee et al., 2019).

A “Solidariedade” teve um destaque para ajuda pelo agir coletivo a partir do voluntariado, como pode-se verificar em: - Uma comunidade forte, onde as pessoas se ajudam e não se exploram. um alto grau de participação no serviço público e no controle de decisões que afetam a vida, saúde e benefícios dos residentes (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990); - % de voluntários da comunidade (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Número de organizações do setor voluntário (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Participação e os direitos humanos no desenvolvimento urbano; segurança urbana e inclusão e equidade social (Matias; Campos, 2022);

- Comprometendo-se a agir coletivamente com outras cidades na Europa e globalmente, com foco nas pessoas, na participação, na prosperidade, no planeta, em lugares e na paz, para a saúde de todos, para atender às demandas urgentes e transformadoras da agenda 2030 (Lima; Lima, 2020); - Ambiente de saúde / Proporção de voluntários registrados (Li et al., 2024); - Sustentabilidade social (Envolvimento ativo da população; Aceitabilidade da estratégia; Autonomia e capacidades proativas da população; Utilização de tecnologias de inovação e interação social; Nível de impacto) (Laureano-Eugenio et al., 2021); - Desenvolvimento de capacidades locais para saúde articular e sustentabilidade (Adriano et al., 2000); - Expansão de programas comunitários (juventude, educação cívica, etc.) (Kegler; Norton; Aronson, 2008).

A subdimensão “Engajamento/Liderança” demonstrou a importância de se analisar os indicadores a seguir: - % da população que tem facilidade de orientação (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Liderança para reconstruir melhor (Cacique et al., 2022); - Participação de engajamento da comunidade (Cacique et al., 2022); - Engajamento comunitário como indicador-chave de sucesso (Yoshizawa, 2013), como pilar para a participação comunitária.

A dimensão “Equidade (Tsouros; Green, 2013)” extrapolou a área da saúde, composta por 18 indicadores, com evidências sobre a necessidade e urgência da garantia da acessibilidade que permita a inclusão de todos(as) de acordo com suas necessidades específicas; uma perspectiva que reconhece a diversidade das populações; e um olhar assistencialista para situações de calamidades públicas, como redução de riscos para desastres naturais.

A “Acessibilidade (Lee et al., 2019)” compreende indicadores que se relacionam a inclusão, tais como: - Proporção média de áreas construídas que são espaços abertos de uso público de todos, por sexo, idade e deficiência (Matias; Campos, 2022); - % de bairros com serviço de reabilitação de deficientes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % de bairros com ruas adaptadas para deficientes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Estabelecendo ambientes alinhados sociais, físicos e culturais para criar um lugar que seja ativamente inclusivo e facilite a busca da saúde e o bem-estar para todos (Lima; Lima, 2020); - Promovendo a paz por meio de sociedades inclusivas que se concentram em lugares, na participação, na prosperidade e no planeta, enquanto colocam as pessoas no centro de todas as políticas e ações (Lima; Lima, 2020); - Desenvolvimento social e priorizando o investimento nas pessoas para melhorar a equidade e a inclusão, por meio da aprimoramento do poder e da governança (Lima; Lima, 2020); - Inclusão social como estratégia para saúde pública (Kegler; Norton; Aronson, 2008); - Acesso a espaços públicos seguros e inclusivos (Botchway et al., 2023); - Implementação de políticas de inclusão, eficiência no uso de recursos e redução de desastres (Botchway et al., 2023).

A subdimensão “Diversidades das populações” está relacionada a populações vulneráveis e acesso de todas as pessoas a um conjunto de condições de vida que garantam seu bem-estar, a saber: - Questões demográficas, com variáveis referentes a gênero, necessidade dos jovens e idosos, velocidade de urbanização e relação urbano-rural (Matias; Campos, 2022); - Agindo em conjunto para melhorar a saúde e o bem-estar de todos os que vivem, amam, aprendem, trabalham e se divertem em nossas cidades (Lima; Lima, 2020); - % de centros de saúde primários com disponibilidade de serviços em línguas estrangeiras (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Inclusão de populações vulneráveis (como idosos) nas estratégias de desenvolvimento urbano (Yoshizawa, 2013); - Apoio ao desenvolvimento sustentável nas comunidades menos desenvolvidas (Botchway et al., 2023); - Saúde em todas as políticas (Kamper-Jorgensen, 2010); - saúde equitativa, justiça social e sustentabilidade urbana (Kamper-Jorgensen, 2010).

As “Situações de calamidade pública” é integrada por indicadores que abordam a redução de riscos de desastres e incluem: - Proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução do risco de desastres em consonância com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (Matias; Campos, 2022); - Número de países com estratégias nacionais e locais de redução do risco de desastres (Matias; Campos, 2022).

A dimensão “Governança, Planejamento e monitoramento” é constituída por 17 indicadores que envolvem aspectos relativos ao ciclo do planejamento a partir da construção de políticas públicas, não só da saúde, mas intersetorial; o planejamento participativo e sustentável, sobretudo sobre a mobilidade urbana; e o monitoramento, pela análise e criação de salas de situação, fiscalização e avaliação de projetos feitos pelos municípios.

A subdimensão “gestão” engloba os seguintes indicadores: - Sustentabilidade operacional (Disponibilidade de pessoal; Transferência e utilização dos resultados; Ação intersetorial; Rotação na liderança; Monitoramento e acompanhamento; Avaliação da estratégia) (Laureano-Eugenio et al., 2021); - Gestão de desastres e pandemias (Cacique et al., 2022); - governança intersetorial (Tsouros; Green, 2013); - Fortalecimento da intersetorialidade nas políticas públicas (Adriano et al., 2000); - Influência em políticas organizacionais (escolas, governos municipais) (Kegler; Norton; Aronson, 2008); - integração intersetorial (Galindo; Furtado, 2004); - Governança pública e legislação, com variáveis sobre legislação urbana (Matias; Campos, 2022); - Garantindo que a proteção do planeta esteja no centro de todas as políticas da cidade, internas e externas (Lima; Lima, 2020).

Enquanto a de “planejamento” é constituída por: - Elaboração de planos de ação de prevenção e de promoção da saúde (Lima; Lima, 2020); - Fortalecimento do planejamento nacional e regional para integrar sustentabilidade nas cidades (Botchway et al., 2023);

- Planejamento urbano inclusivo (Botchway et al., 2023); - Planejamento urbano e territorial, com variáveis sobre planejamento e projeto urbano sustentável; gestão da terra, inclusive espraiamento urbano; produção de alimentos na área urbana e periurbana; desafios da mobilidade urbana; e capacidade técnica para planejar e gerenciar cidades (Matias; Campos, 2022); - Planejamento de políticas institucionais (Cacique et al., 2022); - Planejamento para trabalhadores migrantes (Cacique et al., 2022).

E a de “monitoramentos” pelos seguintes indicadores: - Análise de situação de saúde local (Lima; Lima, 2020); - Criação de sala de situação de saúde para monitoramento e avaliação das ações e projetos do município (Lima; Lima, 2020); - Padrão de fiscalização do monitoramento (Cacique et al., 2022); - Monitorar saúde urbana, equidade e sustentabilidade com base nas diretrizes da OMS (Kamper-Jorgensen, 2010).

A dimensão “População” é composta por 11 indicadores sobre aspectos da população em geral, como total de pessoas, por idade e por sexo, envelhecimento populacional; e aspectos individuais que se relacionam a fatores de bem-estar, felicidades, dentre outros.

A subdimensão “Geral” é composta por: - População total (Cacique et al., 2022); - Repartição por idade e por sexo (Cacique et al., 2022); - Densidade populacional (população por km²) (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Lv et al., 2022; Cacique et al., 2022; Pineo et al., 2018); - Porcentagem da população (Cacique et al., 2022); - Distribuição étnica (Cacique et al., 2022); - Taxa de crescimento populacional natural (Zhao et al., 2023); - Proporção de idosos nas cidades (Yoshizawa, 2013).

E a “Individual” (Lee et al., 2019) que envolvem também o Aprimoramento de habilidades (Lee et al., 2019) é composta pelos indicadores a seguir: - Índice de felicidade pessoal (correlacionada com a qualidade de vida, satisfação com a vida e estabilidade subjetiva) (Lee et al., 2019); - Efeitos da emoção (as emoções são demonstradas quando os indivíduos estão cientes e lidam adequadamente com as mudanças no ambiente ao redor) (Lee et al., 2019); - Condições de bem-estar (Moura et al., 2021); - Possibilidades acesso para os moradores a uma grande variedade de experiências, recursos, de contatos, interação e comunicação encorajamento de contato com o passado, com a herança cultural e biológica com outros grupos e indivíduos (Secretaria Municipal de São Paulo, 1990).

A subdimensão “Falta de Segurança” compreende seis indicadores que se relacionam a ocorrência de crimes, tais como: - % de crimes contra a propriedade (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - % da população que se sente segura andando sozinha na área onde vive (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023); - Violência doméstica (Cacique et al., 2022); - taxa de ocorrência de crimes (Cacique et al., 2022); - Crimes contra a propriedade por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018); - % de moradores que relatam presença de indícios ambientais de crime e vandalismo (Pineo et al., 2018).

A dimensão “Específicos” foi composta por cinco índices que são a junção de indicadores para medir o nível de territórios saudáveis e sustentáveis, sendo eles: - Índice de Território Saudável e Sustentável (Petersen et al., 2020), que é formado pela vulnerabilidade social (ausência ou insuficiência de políticas públicas para infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, que repercutem nas condições de bem-estar das populações); e o desenvolvimento humano (aumento da liberdade de escolhas das pessoas, para uma vida longa e saudável, na aquisição de conhecimentos e do padrão de vida decente) (Petersen et al., 2020); - Índice básico de avaliação da construção da cidade saudável de Dandong (Liu, 2024); - Índice de Desempenho Municipal (MPI), que visa aprimorar a governança urbana e a infraestrutura a partir da avaliação do desempenho dos municípios nas áreas de Governança, Tecnologia, Planejamento, Serviços e Finanças (Gupta; Sethi, 2024); e o Índice de Gini (Petersen et al., 2020).

A dimensão “Dados/Inovação (Lee et al., 2019)” é composta por três indicadores de pesquisa (Lee et al., 2019) que ajudam a entender a satisfação do usuário e a uma avaliação de impactos da economia na saúde, sendo eles: - Pesquisa de Percepção do Cidadão (Gupta; Sethi, 2024); - Percepção sobre saúde e bem-estar (Cacique et al., 2022); - Avaliação do impacto da economia na saúde (Cacique et al., 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão de escopo foi possível identificar as características das produções existentes sobre territórios saudáveis e sustentáveis. Verificou-se que a mais antiga data de 1990 e que nos dois últimos anos há um crescimento de publicações relacionados ao tema. Além disso, observou-se que há produções em todos os continentes do mundo, destacando a América-Brasil, onde mais houve publicações. Apesar disso, o idioma que mais se destacou foi o inglês, com nível de evidência baixo devidos a preponderância ter sido estudos de abordagem qualitativa, de forma descritiva.

A partir da análise dos antecedentes, atributos e consequentes notou-se que os termos “promoção da saúde” e a “qualidade de vida” são fatores comuns, evidenciando a importância da transversalidade da promoção da saúde para atingir a qualidade de vida, de forma que não existirá territórios saudáveis e sustentáveis sem o investimento em políticas públicas intersetoriais que busquem o fortalecimento dessa prática de cuidado.

Constatou-se também que “sustentáveis” era um dos qualificadores dos “territórios saudáveis”. Evidência também constatada a partir da síntese dos 501 indicadores identificados em dimensões e subdimensões que destacaram a sustentabilidade ambiental, a determinação social em múltiplos fatores e o acesso à saúde, a partir do desenvolvimento urbano local.

Neste contexto, são necessários mais estudos que analisem quais indicadores se adequam aos territórios brasileiros para haver esse mapeamento. Destaca-se como limitação deste estudo, a falta de informações nos documentos selecionados, uma vez que muitos não especificaram o tipo de estudo, por exemplo. Mas ainda assim, foi importante a síntese das evidências encontradas para compreender o que se tem produzido sobre territórios saudáveis e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

ADRIANO, J. R.; WERNECK, G. A. F.; SANTOS, M. A. dos; SOUZA, R. de C. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida? *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 53–62, 2000. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100006>.

ADRIANO, J.R.; WERNECK, G.A.F.; SANTOS, M.A.; SOUZA, R.C. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida? *Cien. Saúde Coletiva*. v.5, n.1, 53-62, 2000.

AROMATARIS, E. et al. JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI; 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>. Acesso em: 01 mar. 2025.

AWOFESO, N. The Healthy Cities approach: Reflections on a framework for improving global health. *Bulletin of the World Health Organization*, v. 81, p. 222-223, 2003.

BANWELL, N.; LAW, R.; MACKEY, B.; RUTHERFORD, S. Implementation of national health adaptation policy: a case study of policy principles and implementation barriers in the Philippines. *Regional Environmental Change*. v.21, n.93, 2021.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil; [1977] 2016.

BICK, N. Citizen involvement in local sustainability policymaking: an in-depth analysis of staff activities and motivations. *Sustain Sci*. v. 19, p.1865–1880, 2024.

BONAB, M.R.; RAJABI, F.; VEDADHIR, A.; MAJDZADEH, R. Sustainable political commitment is necessary for institutionalizing community participation in health policy-making: Insights from Iran. *Health Res Policy Syst*. v.22, n.1, 2024.

BOTCHWAY, E.A.; AGYEKUM, K.; KOTEI-MARTIN, J.N.; PITTRI, H.; DOMPEY, A.M.A.; AFRAM, S.O.; ASARE, N.E. Achieving Healthy City Development in Ghana: Referencing Sustainable Development Goal 11. *Sustainability*. v.15, n.19, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2017

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2761, de 19 de novembro de 2013, que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). 2013

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRYAN, B.A.;RAYMOND, C.M.; CROSSMAN,N.D.; MACDONALD, D.H. Targeting the management of ecosystem services based on social values: Where, what, and how? Landscape and Urban Planning. v.97, n.2, p.111-122, 2010.

BUSS, P.M.; HARTZ, Z.M.A.;PINTO, L.F.; ROCHA, C.M.F. Health promotion and quality of life: a historical perspective of the last two 40 years (1980-2020). Cien. Saúde Coletiva. v.25, n12, p.4723-4735, 2020.

CACIQUE, M. et al. Updating Healthy City Variables for the Post-pandemic Era Using Delphi Method. In: Proceedings of 2021 4th International Conference on Civil Engineering and Architecture. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. p. 455- 466.

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Territórios Saudáveis e Sustentáveis – Número Especial, Saúde em debate, v.48, n. esp. 1, Rio de Janeiro, 2024.

ÇETIN, Z.O. Healthy cities and municipal administrations in Türkiye: the case of Denizli Metropolitan Municipality. Humanities and Social Sciences Communications. v11, 2024.

CHÁVEZ, B.M. Limitantes de la estrategia de municipios saludables como política pública en Antioquia. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. v.27, n.3, p.264-270, 2009.

CHIANG, C. A systematic literature network analysis of green information technology for sustainability: Toward smart and sustainable livelihoods. Technological Forecasting and Social Change, v. 199, p. 123053, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123053>

CHO, H-J.; Kim, J-H.; Lee, E-A. A Study on the Advancement of Spatial Maps and the Improvement of the Legal System as a Key Tool for Sustainable National Landscape Planning: Case Study of South Korea. Land. v.12, n.5, 2023.

CHU, E.; ANGUELOVSKI, I.; CARMIN, J. Inclusive approaches to urban climate adaptation planning and implementation in the GlobalSouth. *Climate Policy*. v.16,n.3, 2016.

COLE, H.; SHOKRY, G.; CONNOLLY, J.J.T.; PÉREZ-DEL-PUGAR, C.; ALONSO, J.; ANGUELOVSKI, I. Can HealthyCities be made really healthy? *Lancet Public Health*. v.2, n.9, e394-e395, 2017.

CRANE, M.; LLOYD, S.; HAINES, A.; DING, D.; HUTCHINSON, E.; BELESOVA, K.; DAVIES, M.; OSRIN, D.; ZIMMERMANN, N.; CAPON, A.; WILKINSON, P.; TURCU, C. Transforming citiesfor sustainability: A health perspective. *Environment International*, v. 147, p. 106366, fev. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106366>

CRUZ, P. J. S. C. et al. Educação popular em saúde: princípios, desafios e perspectivas na reconstrução crítica do país. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 28, p. e230550, 2024.

DE LEEUW, E. et al. Policymaking in European healthycities. *Health promotion international*, v. 30, n. suppl_1, p. i18-i31, 2015.

DEPRIEST, K.; GLASGOW, L.; BAYER, E.M.; WEISS, S.; HACKER, K. Building healthy, equitable, and resilient communities: lessons learned from multisector community partnerships addressing the social determinants of health. *J PublicHealth Manag Pract*. v.31, n.1, p.83-89, 2025.

DOMINGUES, L.C.S.M.; SILVA, G.A.; RAVERA, C.B. Promoção de territórios saudáveis: assessoria técnica à habitação social no Setor1 da Colônia Juliano Moreira. *Saúde em debate*. v.48, n. esp. 1, 2024.

DOORIS, M.; HERITAGE, Z. Healthy Cities:facilitating the activeparticipation and empowerment of local people. *J Urban Health*. v.90, supl.1, p.74-91, 2013.

ESFANDI, S.; TAYEBI, S.; BYRNE, J.; TAMINIAU, J.; GIYAHCHI, G.; ALAVI, S. A. Smart citiesand urban energyplanning: An advancedreview of promisesand challenges. *Smart Cities*, v. 7, n. 1, p. 414–444, 2024. <https://doi.org/10.3390/smartcities7010016>.

EVANS, D.; KAZARIAN, S.S. Health Promotion, Disease Prevention, and Quality of Life. *Handbook of Cultural Health Psychology*. p. 85-112, 2001.

FERRAZ, S. F. A pertinência da adoção da filosofia de cidades saudáveis no Brasil. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, n. 41, p.45-49, dez. 1993.

FERRAZ, S.T. A pertinência da adoção da filosofia de cidades saudáveis no Brasil. Saúde em Debate. Nº 41, 1993.

FITRY, I.N.; PALUTTURI, S.; THAHA,R.M.; SYAM, A. Impact Evaluation of Healthy City Implementation in Makassar City.Open Access Maced J Med Sci.v.8, T2, pag. 12-5, 2020.

FOLKVORD, F.; ROEL C. J. Hermans Food Marketing in an Obesogenic Environment: a Narrative Overview of the Potential of Healthy Food Promotion to Children and Adults. Current Addiction Reports. v.7, p.431-436, 2020.

FREIRE, M.S.M.; SALLES, R.P.S.; SÁ, R.M.P.F. Mapeando iniciativas territoriais saudáveis, suas características e evidências de efetividade. Cienc. Saude Coletiva. v.21, n.6, p.1757-66, 2016.

GADELHA, P.; AMEIXA, V. Territórios Sustentáveis e Saudáveis no SUS: a relação intrínseca com a Agenda 2030. Saúde debate. v.48, Esp.1., 2024.

GALINDO, E.F.; FURTADO, M.F.R.G. A intersetorialidade como requisito para construção de uma cidade saudável: política de saneamento e de saúde no Recife (gestão 2001/2004) : estudo de caso. 2004.Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

GALLO, E.; SETTI, A.F.F. Território, intersetorialidade e escalas: requisitos para a efetividade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 4383-4396, 2014.

GILMORE, A.B.;FABBRI, A.; BAUM,F.; BERTSCHER, A.; BONDY, K.; CHANG, H. Definingand conceptualising the commercial determinants of health. The Lancet. v.401, n.10383, p.1194-1213, 2023

GRANT, M. European HealthyCity Network Phase V: patternsemerging for healthy urban planning. Health Promot Int. Sup.1, p.54-70, 2015.

GUPTA, S.; SETHI, N.L. How to Make Future Cities Smart in the Realm of Environmentally FriendlyHealthy Cities? Looking from the Perspective of Ease of Living Index. Journal of Environmental & Earth Sciences, v. 6 , n.2, 2024.

HASDELL, R. The Space in Between: Healthy Public Policy Development in Canada's Provincial North. Tese de doutorado [Programa de pós-graduação em Filosofia - DallaLana School of Public Health].University of Toront.240 p., 2019.

HANCOCK, T. Towards healthyOne Planet citiesand communities: planetary health promotion at the local level. *Health Promot Int.* v.36, n. Sup.1, p.i53-i63, 2021.

HUANG, H. et al. Healthy city evaluation basedon factor analysis—Taking cities in the Guangxi Zhuang Autonomous Regionas an example. *Plos one*, v. 19, n. 7, p. e0306344, 2024.

IAMTRAKUL, P.; CHAYPHONG, S. Factors affecting the development of a healthy city in Suburban areas, Thailand. *Journal of Urban Management.* v.12, n.3, 2023.

JONGEN, C.S.; McCALMAN, J.; BAINBRIDG, R.G. The Implementation and Evaluation of Health Promotion Services and Programs to Improve Cultural Competency: A Systematic ScopingReview. *Front Public Health.* v.5, n.24, 2017.

KAMPER-JØRGENSEN, F. Editorial: The Healthy Cities. *Scandinavian journal of public health*, v. 38, n. 2, p. 113-4, 2010.

KEGLER, M.; NORTON, B.L.; ARONSON, R. Achieving organizational change: findings from case studiesof 20 California healthy cities and communities coalitions. *Health Promot Int.* v.32, n.2, p.109-18, 2008.

KEINERT, T.M.M.Planejamento governamental e políticas públicas:a estratégia “cidades saudáveis”. *Saúde Sociedade.* v.6, n.2, p.55-64, 1997.

KLEDGER, M.C.; NORTON, B.L.; ARONSON, R.E. Strengthening Community Leadership: Evaluation Findings from the California HealthyCities and Communities Program. *Health Promotion Practice.* v.9, n.2, p.170-179, 2008.

KLINGBERG, S.; ADHIKARI, B.; DRAPER, C.E.; BOSIRE, E.; NYIRENDA,D.; TIIGAH, P.; MUKUMBANG, F. Enhanced or hindered research benefits? A realist review of community engagement and participatory research practices for non- communicable diseaseprevention in low- and middle-income countries. *BMJ Glob Health.* v.9, n.2, 2024.

LAUREANO-EUGENIO, J.; GÓMEZ-RODRÍGUEZ, R.O.; TASEJO-CORZANTES, J.;RAMÍREZ, A.S.; AGUILAR,R.M.P.; ALCALDE-RABANAL, J.E. Sustainability of the HealthyMunicipalities Strategy in Guatemala. *Rev Panam Salud Publica.* v.45, 2021. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.70>

LAZARO, L. L. B.; SOARES, R. S. The energy quadrilemma challenges – Insights from the decentralized energytransition in Brazil.*Energy Research & Social Science*, [S.l.], v. 113, p. 103533, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103533>

LEE, M.; PARK, S.; YOON, K. Does Health Promotion Program Affect Local Resident' Emotions? Int J Environ Res Public Health. v.16, n.4, 2019. <https://doi.org/10.3390/ijerph16040549>.

LEE, P.R.; FUCCILLO, R.; WOLFF, T. J. Key components of a statewide healthy communities effort. Public Health Reports, v. 115, n. 2-3, p. 134, 2000.

LEEuw, E.; KICKBUSCH, I.; PALMER, N.; SPANSWICK, L. European Healthy Cities come to terms with health network Governance. Health Promot Int. v.30, Suppl 1, p.32-44, 2015.

LI, H.; GUO, J.; PAN, C.; WU, J.; LIU, X. The EWM-Based Evaluation of Healthy City Construction Levels in East China under the Concept of "Making Improvements Is More Important Than Reaching Standards". Sustainability. v.16, n.10, 2024.

LIM, N.H.H.; HASNAN, L.; ABIDIN, N.Z.; CHOWDHURY, S.; JALIL, N.A.S.A.; HASSAN, L.S. Exploring the relationship between the perceived importance of healthy city indicators and satisfaction level towards the local government in shaping a healthy city. Planning Malaysia. v.21, n.29, 2023.

LIMA, F.A.; LIMA, S.C. Construindo cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do Planejamento Estratégico Situacional. Saúde Soc. v.29, n.2, 2020.

LIN, J.S.; WEBBER, E.M.; BEAN, S.I.; MARTIN, A.M.; DAVIES, M.C. Policy actions for the integration of public health and health care in the United States. Public Health. v.11, 2023.

LIU, L. et al. The development and application of a two-step surveillance process for Healthy China Initiative based on wide coverage interagency data. Global Health Research and Policy, v. 8, n. 1, p. 42, 2023.

LIU, X. Countermeasures to promote sustainable construction and coordinated development of healthy cities: a case study of Dandong City. Energy Informatics. v.7, n.60, 2024.

LLORCA, E.; AMOR, M.T.; MERINO, B.; MÁRQUEZ, F.J.; GÓMEZ, F.; RAMÍREZ, R. Ciudades saludables: una estrategia de referencia en las políticas locales de salud pública. Gac Sanit. v.24, n.6, 435-436, 2010.

LUO J.; CHAN, E.; DU, J.; FENG, L.; JIANG, P.; XU, Y. Developing a Health-Spatial Indicator System for a Healthy City in Small and Mid-sized Cities. Int. J. Environ. Res. Public Health. v.19, n.6, 2022.

LV, Z.; GUO, H.; ZHANG, L.; LIANG, D. Comparative Study on the Evaluation of Healthy City Construction in Typical Chinese Cities Based on Statistical Data and Land Use Data. *Sustainability*, v.14, n.5, 2022.

LY, E.H.; SMARD, P.; O'NEILL, M. Research into the applicability of the healthy cities movement in Dakar district (Senegal): Methodology and results. *Environment & Urbanization*. v.10, n.2, 1998.

MACHADO, J.M.H.; MARTINS, W.J.; SOUZA, M.S.; FENNER, A.L.; MACHADO, A.A. Territórios saudáveis e sustentáveis: contribuição para saúde coletiva, desenvolvimento sustentável e governança territorial. *Com. Ciências Saúde*. v.28, n.2, p.243-249, 2017.

MATIAS, J. L. N.; JEREISSATI, L. C.. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. *Revista de Direito da Cidade*, v. 14, n. 1, p. 643–672, jan. 2022.

MATIAS, J.L.N.; JEREISSATI, L.C. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. *Rev. Dir. Cid.* v.14, n.1, p.643-672, 2022.

MELLER, F. O. al. Qualidade de vida e fatores associados em trabalhadores de uma Universidade do Sul de Santa Catarina. *Cadernos saúde coletiva*, v. 28, p. 87-97, 2020.

MERT-CAKAL, T; MIELE, M. 'Workable utopias' for social change through inclusion and empowerment? Community supported agriculture (CSA) in Wales as social innovation. *Agriculture and Human Values*. v.37, p.1241–1260, 2020.

MOREIRA, M.F.R. et al. Mudanças climáticas e suas implicações para a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, produção agrícola e ambiente. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, v. 50, p. eddsst5, 2025.

MONKEN, M. Território e saúde: apontamentos conceituais para a proposta de territórios sustentáveis e saudáveis. *Saúde em Debate*. v.48, n. 1, e8721, 2024.

MOURA, R.A.; FERREIRA, K.P.M. Cidades saudáveis: o diagnóstico do território urbano por meio dos determinantes sociais de saúde: o caso Maracanaú. *Saúde e Pesquisa*. v.14, n.1, p.201-211. 2021.

NASCIMENTO, P.R.; WESTPHAL, M.F.; MOREIRA, R.S.; BALTAR, V.T.; MOYSÉS, S.T.; ZIONI, F. et al. Impact of the Social Agendas – Agenda 21 and Healthy Cities – upon Social Determinants of Health in Brazilian municipalities: measuring the effects of diffuse social

policies through the dimensions of the Millennium Development Goals. Rev. Bras Epidemiol. Suppl DSS, p.1-14, 2014.

NIEMEYER, C.B.; LARA, P.C.; XAVIER, J.B.; AZEVEDO, L.O. 'O povo cuidando do povo': Agentes Populares na promoção de territórios mais sustentáveis e saudáveis. Saúde debate. v.48, n. esp.1, e8739, 2024.

OLIVEIRA, S. S. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e desafios no contexto brasileiro. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, p. e240304, 2024.

PARK, S.; YEOM, H.Y.; SOK, S.R. Effects of health promoting education program for Korean middle-aged women. J Phys Ther Sci. v.31, n.1, p.5–11, 2019.

PATNAIK, S.; JHA, S. Caste, class and gender in determining access to energy: A critical review of LPG adoption in India. Energy Research & Social Science. v.67, 2020.

PEDERSON, A.; ROOTMAN, I. From Health Care to the Promotion of Health: Establishing the Conditions for Healthy Communities in Canada. In: DE LEEUW, E.; SIMOS, J. (eds) Healthy Cities. Springer, New York, NY. 2017.

PENAFORTE, T.R. A abordagem territorial nos Territórios Sustentáveis e Saudáveis: um alargamento conceitual a partir da antropologia. Saúde debate. v.48, n. esp.1, e8726, 2024.

PETERS, D.; HARTING, J.; OERS, H.V.; SCHUIT, J.; VRIES, N.; STRONKS, K. Manifestations of integrated public health policy in Dutch municipalities. Health Promotion International. v.31, n.2, p. 290–302, 2016.

PETERSEN, R.S.; SILVEIRA, M.; FENNER, A.L.D.; CAMPOS, A.S.; MARTINS, W.J.; MACHADO, J.M.H. Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro. Cad. Saúde Pública. v.36, n.11, 2020.

PILON, A.F. Twenty steps for developing a healthy cities project. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen, 1992. Rev. Saúde Pública. v.27, n.4, p.308-10, 1993.

PINEO, H. et al. Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index. Cities & health, v. 2, n. 1, p. 27-45, 2018.
PORTNEY, K.E.; SANSOM, G.T. Sustainable cities and healthy cities: Are they the same? Urban Planning. v.2, n.3, 2017.

RIBEIRO, R.C. A construção de um município saudável: descentralização e intersectorialidade-experiência de Fortaleza. *Saúde e Sociedade*, v. 6, p. 47-54, 1997.

ROJAS-RUEDA, D.; NORBERCIAK, M.; MORALES-ZAMORA, E. Advancing Health Equity through 15-min Cities and Chrono-urbanism. *J Urban Health*. v.101, n.3, p.483-496, 2024.

SALAS-ZAPATA, L.; LÓPEZ-RÍOS, J. M.; GÓMEZ-MOLINA, S.; FRANCO-MORENO, D.; MARTÍNEZ-HERRERA, E. Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias visando qualidade de vida. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, v. 34, n. 1, p. 105–110, 2016.

SALAS-ZAPATA, L.; LÓPEZ-RÍOS, J.M.; GÓMEZ-MOLINA, S.; FRANCO-MORENO, D.; MARTÍNEZ-HERRERA, E. Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias para qualidade de vida. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*. v.34, n.1, p.96-104, 2016.

SANTOS, E.L.; FRANZ, N.M.; SIMÃO, A.G.; TERNOSKI, S.; SILVA, C.L.; SANTOS, GD. Cidades inteligentes e sustentáveis: percepções sobre a cidade de Curitiba/PR a partir dos planos plurianuais de 2014 a 2021. *urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana*. v. 14, e20210299, 2022. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210299>

SCHELINGS, C.; DEFAYS, A.; ELSEN, C. Profiling citizens in the smart city: A quantitative study in Wallonia. *Smart Cities*, v. 6, n. 4, p. 2125–2149, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/smartcities6040098>.

SCOTT, A; HISLOP, M. What does good green and blue infrastructure policy look like: A comparative assessment of UK national planning guidance. *Urban Forestry & Urban Greening*, v. 99, p. 128440, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128440>.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Movimento "São Paulo - cidade saudável". São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde, 1990.

SELLERA, P.E.; MORO, M.F.S.A.; ALBUQUERQUE, R.H.; BRAGA, L.I.; SOUZA, M.S.; LIMA, A.S.; MARTINS, W.J. A ativação de redes sociotécnicas na cidade estrutural/DF, Brasil: construindo um território saudável e sustentável. *Cien. Saúde Coletiva*. v.24, n.6, p.2185-91, 2019.

SETTI, A.F.; RIBEIRO, H.; AZEITEIRO, U.M.; GALLO, E. Governance and the promotion of sustainable and healthy territories: the experience of Bocaina, Brazil. *Journal of Integrated Coastal Zone Management*. v.16, n.1, p.57-69, 2016.

SHAYA, F.T.; GBARAYOR, C.M. The Case for Cultural Competence in Health Professions Education. *Am J Pharm Educ*. v.70, n.6, 2006.

SILVA, C.V.P.; ALBUQUERQUE, P.C.; MELLO, L.M.B.D.; TAVARES, M.S. Agentes populares no contexto da pandemia de Covid-19: educação popular em saúde na construção de territórios saudáveis e sustentáveis. *Interface (Botucatu)*. v.28: e230142, 2024.

SILVA, M.A.; XAVIER, D.R.; ROCHA, V. Do global ao local: desafios para redução de riscos à saúde relacionados com mudanças climáticas, desastre e Emergências em Saúde Pública. *Saúde em Debate*, v. 44, p. 48-68, 2021.

SIRI, J.G. Sustainable, healthy cities: making the most of the urban transition. *Public Health Reviews*. v.37, n. 22, 2016.

SPERANDIO, A.M.; CORREA, C.R.S.; SERRANO, M.M.; RANGEL, H.A. Caminho para a construção coletiva de ambientes saudáveis – São Paulo, Brasil. *Cien. Saude Coletiva*. v.9, n.3, p.643-654, jul. 2004.

SPERANDIO, A.M.G.; FRANCISCO FILHO, L.L.; MATTOS, T.P. Política de promoção da saúde e planejamento urbano: articulações para o desenvolvimento da cidade saudável. *Cien. Saúde Coletiva*. v.21, n.6, p.1931-37, 2016.

STEPHEN, C. Expanding the Concept of Healthy Public Policy for Animals, Health, and Society. In: STEPHEN, C. *Animals, Health, and Society*. 1st ed., CRC Press, 2020.

STILLWELL, S.B. et al. Searching for the Evidence. Strategies to help you conduct a successful search. *American Journal Nursing*, v.110, n.5, p.41-47, 2010.

STUIFBERGEN, A.K.; SERAPHINE, A.; HARRISON, T.; ADACHI, E. An explanatory model of health promotion and quality of life for persons with post-polio syndrome. *Soc Sci Med*. v.60, n.2, p.383-93, 2005.

TANGUAY, G. A.; RAJAONSON, J.; BILODEAU, P. Linking quality of life and sustainability in Canadian cities. *Cities*, v. 143, p. 104608, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104608>.

TOBEY, M. B.; BINDER, R. B.; CHANG, S.; YOSHIDA, T.; YAMAGATA, Y.; YANG, P. P. J. Urban Systems Design: A Conceptual Framework for Planning Smart Communities. *Smart Cities*. v.2, n.4, p.522 – 537, 2019.

TRICCO, A. C. et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med*., v.169, n.7, p. 467-473, 2018.

TSOUROS, A. D. The WHO healthy cities project: state of the art and future plans. *Health Promotion International*, Oxford, v. 10, n. 2, p. 133–141, 1995.

TSOUROS, A.; GREEN, G. Healthy cities in Europe: editorial. *J Urban Health*. v.90, sup. 1, p.1-3, 2013.

TSOUROS, A.D. Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: a sustainable movement for change and innovation at the local level. *Health Promotion International*. v. 30, sup.1, p.3-7, 2015.

URBINATTI, A.M.; OMORI-HONDA, S.L.; CARVALHO, C.M.; FREY, K.; JACOBI, P.R.; GIATTI, L.L. 'Nexus' Narratives in Urban Vulnerable Places: Pathways to Sustainability via Municipal Health Programs in Brazil. *World*. v.4, n.1, 2023.

WANG, Y.; WANG, X.; GUAN, F. The Beneficial Evaluation of the Healthy City Construction in China. *Iran J Public Health*. v.46, n.6, p.843-847, 2017.

WAYNSZTOK, L.; ROSSI, P.; CHIARA, M. Los espacios virtuales de asistencia técnica del programa nacional de municipios y comunidades saludables. *Revista Argentina de Salud Pública*, v. 2, n. 9, p. 40-42, 2011.

WEBSTER, P.; SANDERSON, D. Healthy Cities indicators--a suitable instrument to measure health? *J Urban Health*. v.90, Sup.1, p.52-61, 2013.

WEN, Y.; LI, Y.; ZHANG, Y.; LIU, B. Comprehensive evaluation of global health cities development levels. *Front. Public Health*. v.12, 2024.

WESTPHAL, M.F. O modelo de atenção na perspectiva de saúde integral: a promoção da saúde e a estratégia de "municípios saudáveis". *SANARE – Revista de Políticas Públicas*. v.2, n.3, 2013.

WESTPHAL, M.F. O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a qualidade de vida. *Cien. Saude Coletiva*. v.5, n.1; 2000.

WESTPHAL, M.F.; MENDES, R. Cidade saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e intersetorialidade. *RAP*. v.34, n.6, p.47-61, 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Healthycities: effective approach to a rapidly changing world*. Geneva: World Health Organization, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *The Ottawa charter for health promotion*. Geneva: WHO; 1986.

YANG, J.; LUO, X.; XIAO, Y.; SHEN, S.; SU, M.; BAI, Y.; GONG, P. Comparing the Use of Spatially Explicit Indicators and Conventional Indicators in the Evaluation of Healthy Cities: A Case Study in Shenzhen, China. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. v.17, n.20, 2020.

YANG, L.; HE, B.; CHENG, L.; WANG, R.; AO, Y. Editorial: The physical environment and health: implications for the planning and management of healthy cities. *Front Public Health*. v.11, 1245561, 2023.

YOSHIZAWA, K. WHO Healthy City Initiative in Japan. *Nihon eiseigakuzasshi*, v. 68, n. 2, p. 138-143, 2013.

ZHAO, M.; QIN, W.; ZHANG, S.; QI, F.; LI, X.; LAN, X. Assessing the construction of a Healthy City in China: a conceptual framework and evaluation index system. *Public Health*. v.220, p.88-95, 2023.

ZIAFATI, A.B.; CHESHMEHZANGI, A.; ANKOWSKA, A. A set of 99 healthy city indicators for application in urban planning and design. *Sustainable Development*, v. 31, n. 3, p. 1978-1989, 2023.

APÊNDICE

Documento Suplementar - Instrumento de coleta de dados elaborado pelos autores.
Fortaleza, Ceará, Brasil, 2024.

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS	
TÍTULO	
ANO DE PUBLICAÇÃO	
AUTORES (DOI)	
PAÍS/REGIÃO	
IDIOMA	
OBJETIVO DO ESTUDO	
TIPO DE ESTUDO	
FONTE DE DADOS	
TAMANHO DA AMOSTRA	
NÍVEL DE EVIDÊNCIA	
FEZ USO DE ALGUM REFERENCIAL TEÓRICO / METODOLÓGICO PARA O CONCEITO DO ESTUDO?	
EXTRAÇÃO RELACIONADA AO CONCEITO TERRITÓRIO SAUDÁVEL	
ANTECEDENTES	
ATRIBUTOS	
CONSEQUENTES	

EXTRAÇÃO RELACIONADA AO CONCEITO TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL	
ANTECEDENTES	
ATRIBUTOS	
CONSEQUENTES	
EXTRAÇÃO RELACIONADA AO CONCEITO TERRITÓRIO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL	
ANTECEDENTES	
ATRIBUTOS	
CONSEQUENTES	
INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS	

Fonte: elaboração própria.



PRODUTO 02

DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO ANÁLISE E SÍNTESE DAS EVIDÊNCIAS SOBRE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS A PARTIR DE UMA REVISÃO DE ESCOPO COM IDENTIFICAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA O MAPEAMENTO DOS TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS A PARTIR DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS.

Autor: Lucas Dias Soares Machado

1. INTRODUÇÃO

Os territórios em saúde constituem um objeto de estudo multidisciplinar, compreendidos como espaços dinâmicos de produção da vida social. Esses territórios emergem da interação entre diversos atores sociais, cujas relações são simultaneamente influenciadas e influenciadoras do ambiente circundante, das atividades produtivas e das ações coletivas (Monken, 2024). Essa abordagem pressupõe a análise dos territórios enquanto constructos materiais e simbólicos, constantemente apropriados e transformados por indivíduos e comunidades, gerando processos contínuos de produção de vida e corporeidade em interface com os espaços físicos e os ecossistemas (Monken, 2024).

A complexidade das relações homem-natureza no contexto da urbanização tem fomentado movimentos que propõem novas organizações territoriais voltadas à promoção da saúde. Tais iniciativas representam processos dinâmicos – e não resultados estáticos – orientados para a conquista de melhores níveis de saúde coletiva, mediante o desenvolvimento de consciência social, equidade e engajamento comunitário (Tsouros, 2015). Nessa perspectiva, comunidades adequadamente capacitadas demonstram capacidade de mobilizar recursos endógenos para resolver problemas locais e construir práticas de promoção da saúde contextualizadas, conforme exemplificado pelo movimento de cidades e comunidades saudáveis (Kickbusch, Nutbeam; Aronson, 2008).

O conceito de cidade saudável configura-se como uma proposta de desenvolvimento urbano integral, que coloca a saúde humana no centro de suas preocupações, abarcando dimensões econômicas, políticas, culturais e ambientais inter-relacionadas, com ênfase no planejamento urbano participativo e na gestão compartilhada (Ma et al., 2022). Originalmente cunhado no Canadá em 1984, o termo foi posteriormente caracterizado por Duhl e Hancock (1988) como um modelo que busca harmonizar as relações entre ambiente natural e social, ampliando recursos para o pleno desenvolvimento humano e a conquista de níveis ótimos de saúde (Zhao et al., 2023).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) desempenhou um papel fundamental na consolidação desse movimento, inicialmente por meio da Declaração de Alma-Ata (1977) e posteriormente com o lançamento do Projeto Cidades Saudáveis em 1986 (Kickbusch, Nutbeam; Aronson, 2008). A OMS estabeleceu diretrizes específicas abordando determinantes sociais da saúde, incluindo segurança ambiental, nutrição adequada, acesso à água potável, moradia digna e disponibilidade de serviços essenciais (Wang, Wang; Guan, 2017).

A difusão global do movimento resultou em adaptações regionais, com com iniciativas notáveis na Ásia, Europa e América do Norte, que reinterpretaram os princípios da OMS

conforme particularidades locais quanto à concepção de território e saúde (Zhao et al., 2023). Contudo, essa diversidade de abordagens acarreta certa falta de padronização nas práticas implementadas. Além disso, a compreensão contemporânea de territórios saudáveis transcende demarcações geográficas tradicionais, incorporando questões globais de poder, conflitos, fluxos transnacionais e barreiras estruturais, o que demanda uma abordagem teórica mais abrangente para apreender sua inerente polissemia.

Os conceitos aqui discutidos operam como ferramentas analíticas que conferem significado às experiências cotidianas, permitindo a interpretação de fenômenos sociais sob múltiplas perspectivas. Seu uso consistente no discurso acadêmico e político contribui para a construção de quadros interpretativos compartilhados, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para intervenções práticas e processos decisórios (Monken, 2024).

Entende-se, portanto, que este estudo é relevante ao considerar a capacidade de elucidação das unidades conceituais que sustentam o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis, de modo a reduzir a polissemia empregada no uso do termo, compreender os fatores precipitantes e os resultados sociais, políticos e econômicos advindos de sua implementação. Ademais, o entendimento das particularidades dessa modalidade territorial prevê características necessárias à formulação e à adequação dos territórios sob uma perspectiva saudável e sustentável.

Esta análise insere-se no nível macro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente nos objetivos: 3 – Saúde e Bem-Estar, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades; 10 – Redução das Desigualdades, dada a necessidade de equidade na distribuição de recursos sociais; e 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, destinado à adequação dos espaços sob uma perspectiva segura, inclusiva, resiliente e sustentável. De modo indireto, estabelece intersecções com o objetivo 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, considerando os impactos territoriais das questões climáticas; 15 – Vida Terrestre, pela importância da preservação dos ecossistemas; e 17 – Parcerias e Meios de Implementação, que reforça a necessidade de governança multissetorial.

Sob esse prisma, objetivou-se analisar o conceito de territórios saudáveis, elucidando seus antecedentes, atributos e consequentes.

2. MÉTODO

Este estudo configura-se como uma análise conceitual desenvolvida segundo os pressupostos metodológicos de Walker e Avant (2019), com o objetivo de examinar a estrutura e função dos elementos constituintes de um conceito. Os conceitos, enquanto construções mentais destinadas a organizar estímulos ambientais de maneira coerente, compreendem um conjunto de componentes informacionais - antecedentes, atributos e consequentes - cuja análise demanda rigor metodológico e sistematicidade (Walker; Avant, 2019). Ressalta-se que tais elementos apresentam natureza dinâmica, sofrendo transformações temporais e contextuais, além de estarem sujeitos a processos evolutivos (Fernandes et al., 2011).

A análise conceitual, mesmo quando provisória, relaciona-se diretamente com a promoção de comunicação acadêmica precisa, facilitando tanto a compreensão dos fenômenos estudados quanto o reconhecimento consensual de seus indicadores de mensuração. Os atributos definidores constituem o alicerce dessa análise, representando unidades discursivas regularmente associadas à aplicação do conceito, o que possibilita tanto sua compreensão integral (Walker; Avant, 2019) quanto sua distinção frente a constructos similares (Fernandes et al., 2011). Paralelamente, os antecedentes e consequentes demarcam os contextos de manifestação conceitual, servindo como referenciais para a delimitação dos atributos. Nessa perspectiva, entende-se por antecedentes os fenômenos precedentes à ocorrência do conceito, enquanto os consequentes referem-se aos desdobramentos oriundos de sua materialização (Walker; Avant, 2019).

Para consecução desta pesquisa, adotou-se integralmente o protocolo de oito etapas proposto por Walker e Avant (2019): (1) seleção do conceito "Territórios saudáveis e sustentáveis"; (2) definição do objetivo de estruturar, refinar e elucidar seus elementos constitutivos; (3) identificação de usos conceituais mediante revisão de escopo; (4) determinação dos atributos descritos na literatura; (5) elaboração de caso-modelo ilustrativo; (6) construção de casos adicionais para demarcação de limites conceituais; (7) identificação de antecedentes e consequentes via revisão de escopo; e (8) estabelecimento de referências empíricas.

A revisão de escopo foi conduzida conforme as diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) (Peters et al., 2024) e do protocolo PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), com registro prévio no Open Science Framework (DOI: 10.17605/OSF.IO/A75HQ). A questão norteadora, formulada mediante o mnemônico PCC (População, Conceito, Contexto), focalizou exclusivamente o constructo "território saudável e/ou sustentável", resultando na interrogação: "Quais as evidências disponíveis sobre territórios saudáveis e/ou sustentáveis?".

Adotaram-se critérios inclusivos amplos, contemplando produções acadêmicas independentemente de idioma, país ou período de publicação, desde que relacionadas ao tema investigado. A estratégia de busca, realizada em novembro de 2024 através do Portal de Periódicos CAPES via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), abrangeu as bases MEDLINE/PubMed, SciELO, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para literatura cinzenta, consideraram-se os 200 primeiros registros do Banco de Teses e Dissertações da CAPES e do Google Scholar, visando maximizar a abrangência documental.

A equação de busca foi formulada a partir de termos sensíveis à pesquisa, incluindo palavras-chave ou descritores, de acordo com cada plataforma de busca, sejam eles referentes aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou ao Medical Subject Headings (MeSH). Foram utilizados operadores booleanos: “OR”, entre os termos similares, e “AND”, entre os diferentes acrônimos. A versão final das estratégias de busca encontra-se consolidada no Quadro 1.

Quadro 1. Estratégia de busca por base consultada. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
BVS	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
MEDLINE/PUBMED	("Sociocultural territory") OR ("Popular healthsurveillance") OR ("Healthy Territories") OR ("healthy city") OR ("healthy cities")
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("Sociocultural territory") OR TITLE-ABS-KEY ("Popular health surveillance") OR TITLE-ABS-KEY ("Healthy Territories") OR TITLE-ABS-KEY ("healthy city") OR TITLE-ABS-KEY ("healthy cities")

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudávelse sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
SCIELO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudávelse sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
GOOGLE ACADÊMICO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudávelse sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")

Fonte: elaboração própria.

A organização das informações baseou-se na leitura dos artigos na íntegra, identificando o uso dos conceitos "território saudável", "território sustentável" e sua intersecção, além da classificação de atributos, antecedentes e consequentes.

Dois pesquisadores independentes organizaram os dados no Microsoft Word®, catalogando: título, ano, autores, país/região, objetivo, tipo de estudo, nível de evidência (segundo Stillwell et al., 2010), antecedentes, atributos e consequentes. Os níveis de evidência seguiram a seguinte classificação: Nível I- evidências de revisões sistemáticas e/ou metanálises de ensaios clínicos randomizados; Nível II- evidências de um ensaio clínico com aleatorização, controlado e bem delineado; Nível III- evidências de estudos bem delineados, controlados e sem aleatorização; Nível IV- evidências de estudos de coorte ou caso controle; Nível V- evidências de revisões sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível VI- evidências de estudo descritivo e/ou qualitativo; e Nível VII- evidências de opiniões de autoridades ou relatórios de comitês de especialistas (Stillwell et al., 2010).

Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva quanto a frequência absoluta e relativa e sumarizados em infográfico informativo, considerando as características dos estudos, e tabelas, contemplando os atributos, antecedentes e consequentes. Ao fim, elaborou-se um modelo conceitual que representa visualmente as relações entre os elementos essenciais do conceito Territórios Saudáveis e Sustentáveis.

Ao passo, foram construídos casos-modelo, casos-límitrofes e caso-contrários, que visam propiciar comparações e contrastes do conceito analisados, elucidando o que o conceito é, o que não é e a aplicação de seus elementos constitutivos. Respectivamente, o caso-modelo demonstra uma situação de aplicação do conceito, com a totalidade de seus atributos; o caso-límitrofe apresenta uma situação em que há elementos característicos e confundidores do conceito, ou seja, que não pertencem a esse; e, por fim, o caso-contrário ilustra um contexto que não corresponde ao conceito em questão, opondo-se a esse.

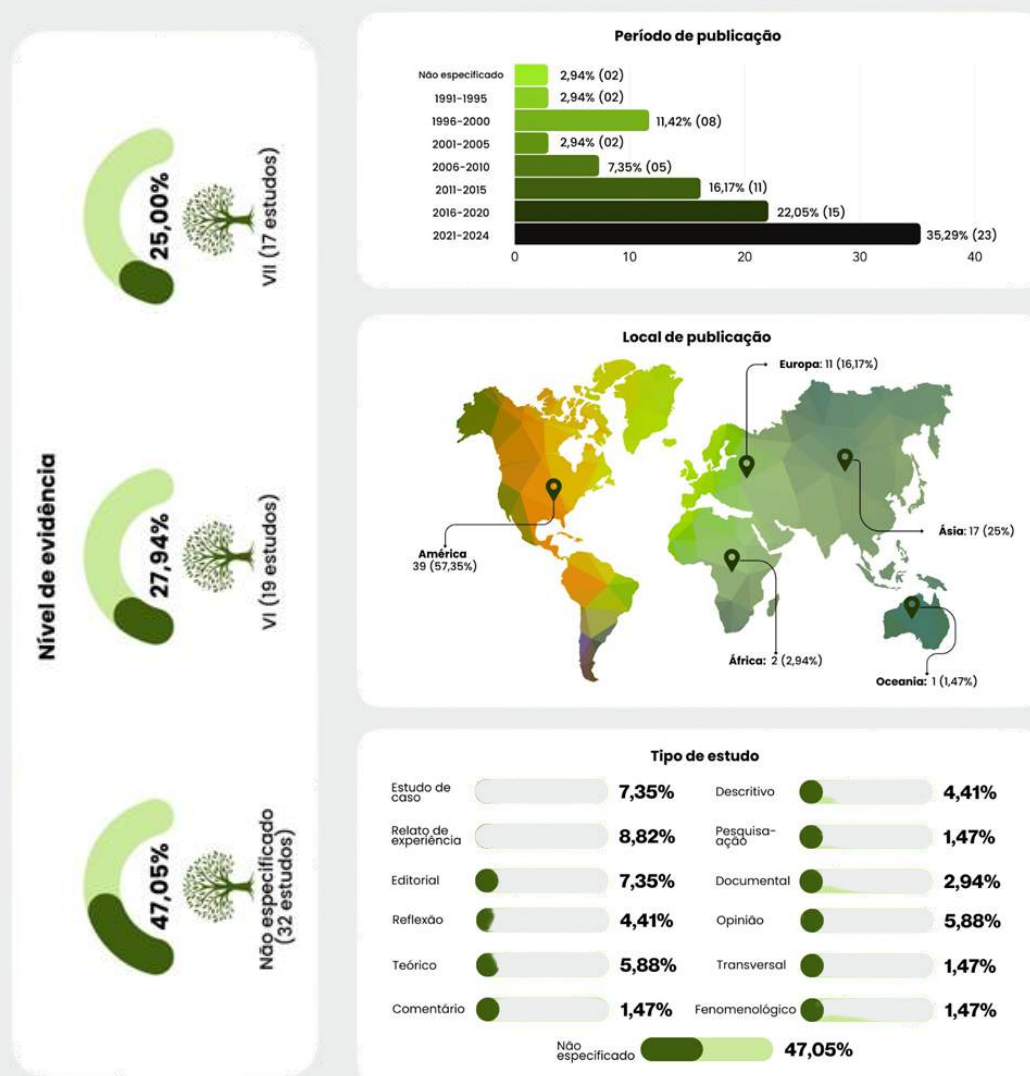
No que diz respeito à formulação das referências empíricas, foram considerados os atributos do conceito, sendo estabelecidos, com base na literatura, indicadores operacionais que exemplificam sua manifestação.

Por tratar-se de estudo com base em artigos científicos publicizados, os direitos autorais foram preservados mediante citação adequada em documento suplementar, não sendo necessária avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

3. RESULTADOS

O conceito de Territórios Saudáveis tem se manifestado na literatura científica ao longo dos últimos quarenta anos, acompanhado por um crescimento expressivo na produção acadêmica. A maioria dos estudos apresentou delineamento metodológico claro (52,95%; n=36). Dentre as pesquisas que especificam suas abordagens metodológicas, predominam os estudos qualitativos, especialmente do tipo relato de experiência (8,82%; n=6), seguidos de editorial (7,35%; n=5) e estudo de caso (7,35%; n=5), classificados sem nível de evidência (47,05%; n=32). Do ponto de vista geográfico, observa-se uma concentração mais acentuada de publicações no continente americano (57,35%; n = 39), sendo o Brasil o principal contribuinte, com 45,58% (n = 31) dos estudos analisados. A caracterização detalhada dessas pesquisas, considerando período de publicação, nível de evidência, local de origem e tipo de estudo, encontra-se sintetizada na Figura 2 e Anexo 1.

Figura 2. Infográfico de caracterização dos estudos incluídos na análise do conceito Territórios Saudáveis e Sustentáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025 (n=68)



Fonte: elaboração própria.

A investigação do conceito de territórios saudáveis enfrenta a polissemia e a complexidade inerentes à sua composição, sendo frequentemente abordado na literatura científica pertinente sob a forma de cidades saudáveis ou comunidades saudáveis. A partir desse reconhecimento, e considerando o território como uma expressão da vivência no mundo em um espaço geográfico específico — marcado pela produção, apropriação e experiências —, é possível delinear os elementos fundamentais que constituem o conceito de territórios saudáveis, analisando seus antecedentes, atributos e consequentes.

O refinamento desse conceito ancora-se, ainda, em sua aplicação em diversas áreas do conhecimento, como administração e planejamento, arquitetura e urbanismo, ciências sociais, ecologia e saúde. No entanto, faz-se necessário um maior alinhamento entre esses campos, a fim de consolidar uma abordagem teórica e metodológica mais coerente e integrada.

ANTECEDENTES DO CONCEITO

Os antecedentes do conceito territórios saudáveis referem-se aos elementos que, quando mobilizados fundamentam a organização e efetivação desses territórios. Eles precedem e sustentam os atributos que definem o conceito.

No contexto dos territórios saudáveis, esses antecedentes abrangem dimensões teóricas, políticas e práticas essenciais para estimular e articular a mobilização social em defesa desses espaços como âmbitos de construção da vida e da saúde. A partir da literatura analisada, identificaram-se 18 antecedentes, agrupados em cinco domínios com base em similaridades objetivas ou contextuais (Quadro 2).

Quadro 2. Domínios e antecedentes do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

DOMÍNIO	ANTECEDENTES CONSTITUINTES
Bases teóricas e influências conceituais	Medicina social e saúde coletiva Promoção da saúde e saúde em todas as políticas Determinação Social da Saúde
Fundamentos político-institucionais	Liderança política local Governança intersetorial Marco legal e políticas públicas saudáveis Investimento governamental Fortalecimento institucional

DOMÍNIO	ANTECEDENTES CONSTITUINTES
Inclusão e mobilização da sociedade civil	Participação cidadã Empoderamento comunitário Mobilização de saberes locais Associações e redes colaborativas
Diagnóstico e planejamento baseado em evidências	Análise situacional da saúde Desenho de cidades inclusivas Adoção de indicadores para monitoramento
Cooperação multinível e redes	Parcerias nacionais e internacionais Apoio acadêmico e técnico Integração entre níveis de governo

Fonte: elaboração própria.

Os antecedentes configuram-se como pré-condições fundamentais para a constituição de territórios saudáveis, manifestando-se através de quatro dimensões interdependentes: a articulação de ações políticas e sociais mediante a efetiva inclusão e mobilização da sociedade civil; a garantia de um engajamento comunitário com caráter decisório, superando abordagens meramente consultivas; a identificação sistemática de prioridades, necessidades e iniquidades mediante diagnósticos territoriais rigorosos; e a alocação adequada de recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros como condição *sine qua non* para a efetividade das políticas públicas.

No que concerne às bases teóricas e influências conceituais, observa-se a convergência de três paradigmas fundamentais: a medicina social e saúde coletiva, a promoção da saúde e a determinação social da saúde. A medicina social e saúde coletiva, enquanto campos epistemológicos engajados, fundamentam-se na crítica aos modelos biomédicos hegemônicos, propondo uma abordagem transformadora centrada nos determinantes sociais e na luta pela equidade em saúde (Istúriz, 2024; Harvey, Piñones-Rivera; Holmes, 2023). Estas correntes analisam os processos coletivos de produção da vida e suas implicações na saúde populacional, defendendo reformas sanitárias de caráter universalista. A saúde coletiva, em particular, incorpora contribuições interdisciplinares das ciências sociais para compreender a complexidade dos sistemas de cuidado (Silva, 2021).

A promoção da saúde emerge como marco teórico-prático que potencializa a ação comunitária mediante estratégias intersetoriais, transcendendo perspectivas biologicistas ao integrar as dimensões políticas, culturais e econômicas que conformam o processo saúde-doença (Ihlebaek, Ånestad; Nordbø, 2023). Por sua vez, a determinação social da saúde oferece um arcabouço analítico transversal, examinando como as condições históricas e estruturais - como renda, educação, acesso a transporte e segurança - determinam inequivocamente os perfis de saúde das populações (Lara et al., 2024; Abadía-Barrero; Martínez-Parra, 2017).

Esta tríade conceitual compartilha um compromisso ontológico com a transformação das realidades territoriais, privilegiando abordagens críticas que confrontam as iniquidades em saúde.

Estas perspectivas teóricas constituem os alicerces fundamentais para o desenvolvimento de territórios saudáveis, convergindo em três eixos estruturantes: a promoção da equidade em saúde, a abordagem interdisciplinar e a defesa intransigente de políticas públicas participativas e territorializadas. Tal convergência representa um movimento contra-hegemônico com significativo potencial transformador das realidades sociais.

Os fundamentos político-institucionais operacionalizam esses pressupostos teóricos, materializando-os em ações concretas para a construção de territórios saudáveis que promovam a melhoria da qualidade de vida, do trabalho e da organização social. Esta dimensão abarca cinco componentes essenciais: (1) a liderança política local comprometida com a implementação de políticas promotoras de saúde e a criação de ambientes favoráveis ao desenvolvimento socioeconômico (Burgos, Quintero; Gracia-Soriano, 2019); (2) a governança intersetorial, que potencializa o desenvolvimento social e econômico mediante a articulação inclusiva e inovadora entre diferentes setores (Dansou; Carrier, 2023); (3) a adoção de marcos legais e diretrizes para políticas públicas saudáveis, como demonstrado pela experiência russa de integração entre reformas institucionais e econômicas para redução de disparidades territoriais (Strielkowski et al., 2024); (4) o investimento governamental em infraestrutura e serviços públicos que criem condições concretas para o enfrentamento das iniquidades em saúde; e (5) o fortalecimento institucional, que promove a confiança e cooperação entre comunidade e gestores, conforme evidenciado pelas iniciativas internacionais na Tunísia (Marzo, 2019).

A efetivação desses fundamentos político-institucionais requer necessariamente a inclusão e mobilização da sociedade civil através de quatro mecanismos complementares: (a) a participação cidadã ativa nos processos decisórios; (b) o protagonismo comunitário na identificação e enfrentamento dos problemas locais; (c) a valorização dos saberes locais como insumos para políticas públicas; e (d) a formação de redes colaborativas estáveis.

Como demonstram Blandón-Lotero e Jaramillo-Mejía (2020), a participação comunitária qualificada amplia o diálogo social e produz respostas mais assertivas às demandas populacionais. Esta abordagem encontra respaldo na capacidade das comunidades mobilizarem seus saberes e desenvolverem competências para a ação em saúde, adaptando as intervenções às particularidades territoriais (Machado, Maciel; Thiollent, 2021). As redes colaborativas, por sua vez, materializam-se em espaços deliberativos diversos - conselhos, conferências, mobilizações sociais - que fortalecem simultaneamente a governança local e a coesão social (Pylypenko et al., 2024; Nilsson; Svensson, 2023).

O diagnóstico e planejamento baseado em evidências configuram-se como elementos imprescindíveis para a efetividade das intervenções em territórios saudáveis. A análise situacional de saúde, enquanto metodologia abrangente de avaliação dos determinantes sociais da saúde através de indicadores multidimensionais (sociais, demográficos, econômicos, ambientais e epidemiológicos), permite identificar prioridades e orientar políticas públicas contextualizadas (Pereira et al., 2023). Este diagnóstico fundamenta o planejamento urbano inclusivo, que deve incorporar as perspectivas do curso de vida e promover desenhos urbanos favoráveis ao envelhecimento saudável e ao bem-estar integral (Yuezhong; Theng, 2020; Caicedo et al., 2024).

O monitoramento contínuo de indicadores constitui elemento fundamental para a avaliação de impacto das políticas e intervenções em territórios saudáveis, permitindo o necessário ajuste estratégico com base em evidências (Pereira et al., 2023). Este processo requer a construção de sistemas de informação robustos, capazes de gerar registros de saúde adequadamente processados - com estrito respeito à privacidade dos dados - que sirvam de subsídio para o planejamento territorializado e a avaliação sistemática de resultados (Yuezhong; Theng, 2020). A efetividade desses mecanismos está intrinsecamente vinculada à sua capacidade de captar e responder às particularidades locais, garantindo que as intervenções mantenham consonância com as necessidades específicas de cada território.

O domínio da cooperação multinível e em rede emerge como componente essencial para a consolidação de territórios saudáveis, viabilizando a integração sinérgica de recursos e competências dos diversos setores, instituições e esferas governamentais. Neste contexto, as parcerias nacionais e internacionais desempenham papel estratégico ao fomentar a adoção de abordagens inovadoras e contextualmente adequadas, particularmente no que concerne à mensuração e intervenção sobre os determinantes sociais da saúde mediante avaliações cooperativas (Delgadillo, Reyes; Baumgartner, 2021). Paralelamente, o apoio acadêmico e técnico consolida a tríade ensino-serviço-comunidade, gerando conhecimentos e inovações cruciais para o desenvolvimento territorial sustentável. A integração estratégica entre tecnologias e recursos locais, conforme demonstrado por Sumane et al. (2024), potencializa tanto o crescimento econômico endógeno quanto a participação social ativa, criando valor compartilhado por meio de redes territoriais colaborativas.

Em síntese, a construção de territórios saudáveis configura-se como processo dinâmico e multifacetado que demanda: base política comprometida com a equidade em saúde; mecanismos de gestão participativa que garantam efetiva de liberação comunitária; intervenções concretas sobre os determinantes sociais da saúde; e articulação em redes multiníveis.

Esta abordagem integrada, fundamentada em evidências e sensível às particularidades locais, representa o caminho mais promissor para a transformação sustentável dos territórios em direção ao bem-estar coletivo.

ATRIBUTOS DO CONCEITO

Os atributos conceituais constituem elementos qualificadores fundamentais que caracterizam a essência e a estruturação do conceito de territórios saudáveis. Sua identificação e delimitação decorrem de análise sistemática da literatura especializada, mediante o reconhecimento de padrões recorrentes na descrição teórica e empírica desses territórios. O processo de investigação permitiu a categorização desses elementos em dez domínios distintos, conforme apresentado no Quadro 3.

Quadro 3. Domínios e atributos do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

DOMÍNIO	ATRIBUTOS CONSTITUINTES
Qualidade do espaço urbano	Ambiente físico seguro, limpo e de alta qualidade (habitação, mobilidade, áreas verdes).
Equidade e acesso universal	Garantia de necessidades básicas (alimentação, água, moradia, renda, segurança, trabalho). Serviços públicos acessíveis (saúde, educação, transporte, lazer). Justiça social e redução de desigualdades (econômicas, territoriais, de gênero, raça etc.).
Governança participativa	Participação ativa da comunidade nas decisões políticas. Colaboração entre governo, setor privado e sociedade civil.
Intersectorialidade	Políticas públicas integradas (saúde, urbanismo, economia, cultura).
Promoção da saúde	Saúde como prioridade política, além da ausência de doenças. Enfoque nos determinantes sociais da saúde (educação, emprego, saneamento). Ações preventivas e promoção de estilos de vida saudáveis. Capacitação comunitária para atuar por melhores condições de vida e saúde.
Economia inclusiva e diversificada	Economia local dinâmica, inovadora e geradora de oportunidades. Trabalho digno e geração de renda.
Pertencimento e coesão social	Comunidades solidárias, com redes de apoio mútuo. Respeito à diversidade cultural e valorização de saberes locais. Preservação do patrimônio histórico e identidade territorial.
Planejamento urbano inclusivo	Infraestrutura que favoreça mobilidade segura e acessível. Espaços públicos que incentivem interação social e atividades físicas. Adaptação a crises (climáticas, epidemias) e resiliência urbana.

DOMÍNIO	ATRIBUTOS CONSTITUINTES
Inovação e monitoramento contínuo	Avaliação sistemática de políticas (ex.: indicadores de saúde, sustentabilidade). Uso de tecnologias e dados para tomada de decisão. Flexibilidade para adaptar-se a mudanças e demandas emergentes.
Qualidade de vida e bem-estar integral	Ambientes que favoreçam saúde mental e convívio social. Acesso à cultura, lazer e atividades recreativas. Enfoque no ciclo de vida (crianças, idosos, pessoas com deficiência).

Fonte: elaboração própria.

Sob esta perspectiva teórica, o território saudável constitui-se como um espaço urbano que integra qualidade ambiental, equidade no acesso a serviços essenciais de saúde e governança participativa. Este conceito abrange ainda a articulação intersetorial, uma economia diversificada e inclusiva, planejamento urbano inclusivo, sistemas contínuos de inovação e monitoramento, fortalecimento do pertencimento comunitário e coesão social, além do direcionamento estratégico para a promoção da saúde e do bem-estar integral da população.

A qualidade do espaço urbano preocupa-se primordialmente com a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado e resiliente, voltado à preservação dos ecossistemas e seus componentes fundamentais - ar, solos e água. Este atributo implica no combate sistemático a fatores externos que possam comprometer sua segurança ambiental, particularmente os diversos tipos de poluição. Envolve igualmente uma estrutura urbana planejada de forma harmônica com a utilização dos espaços naturais, prevenindo sua degradação, ao mesmo tempo que cria oportunidades para a prática de exercícios físicos, atividades de lazer e redução das emissões de poluentes, mediante a implantação de parques e ciclovias.

A qualificação do espaço urbano inclui necessariamente a expansão e melhoria da qualidade das áreas verdes e azuis, cuja presença demonstra associação estatisticamente significativa com melhores indicadores de saúde, particularmente no que diz respeito ao fortalecimento da saúde mental. Desta forma, o território configura-se como mais saudável quando se dedica à melhoria contínua do ambiente físico (Yang et al., 2023), assegurando padrões adequados de limpeza, segurança, conforto (Firty et al., 2020) e condições habitacionais (Leeuw et al., 2015).

Esta dimensão ambiental transcende a estrutura física, abarcando a universalização do saneamento básico em todas as regiões, incluindo áreas carentes e periféricas, além da gestão adequada de resíduos sólidos e manutenção da qualidade do ar (Ferraz, 1993).

Investe-se igualmente em modelos de desenvolvimento urbano que considerem a proteção ambiental, prevenindo a degradação dos ecossistemas e promovendo padrões sustentáveis de produção e consumo (Hancock, 2021). Exige-se que o processo de urbanização se alinhe de modo equilibrado com os determinantes sociais que impactam diretamente no processo saúde-doença-cuidado, os quais incluem emprego, renda, acesso a serviços essenciais, infraestrutura social e sistemas de transporte (Santos et al., 2022).

Para além da dimensão física, esta abordagem amplia seu escopo para os ambientes sociais, mediante a implementação de medidas criativas pelo governo local em conjunto com a sociedade civil. Compreende-se assim espaços onde a vida em sociedade é viabilizada, fortalecida e permanentemente incentivada (Wen et al., 2024; Huang et al., 2024). Desta forma, o planejamento urbano orientado pela saúde reconhece a intrincada inter-relação entre diversos setores e serviços (Lee, Park; Yoon, 2019), propondo ambientes urbanos que integrem espaços de vida, práticas cotidianas e serviços essenciais saudáveis.

É fundamental ressaltar que a mera criação de espaços fisicamente adequados não garante por si só a promoção da saúde. Tais ambientes necessitam ser mantidos e fortalecidos continuamente mediante a mobilização de recursos comunitários, possibilitando assim a expressão plena das capacidades individuais e coletivas (Huang et al., 2024; Salas-Zapata, 2016). Neste sentido, o planejamento urbano de caráter interfederativo e comunitário (Gadelha; Ameixa, 2024) estabelece relações simbióticas entre indivíduos, coletivos e meio ambiente (Zhao et al., 2023), considerando de forma integrada os ambientes naturais, construído e social (Salas-Zapata, 2016).

O território saudável favorece ainda a ecologia urbana, a gestão ambiental e a valorização da cultura local, promovendo a redução dos impactos ambientais (Botchway et al., 2023), o incentivo a alternativas sustentáveis de transporte e a construção sistemática de espaços verdes (Portney; Sansom, 2017). No contexto do desenvolvimento urbano, os espaços verdes caracterizam-se como áreas geograficamente demarcadas, quantificáveis pela densidade de vegetação em zonas urbanas e proximidade com residências. Sua delimitação frequentemente considera parâmetros políticos, como divisões administrativas e códigos postais, sendo mensurados através de técnicas como o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) em imagens de satélite.

Revisão sistemática da literatura, analisando estudos experimentais, quase-experimentais e longitudinais, demonstrou associação positiva entre espaços verdes urbanos e melhoria na capacidade de atenção, humor e prática de atividade física. Paralelamente, evidenciou correlação negativa com indicadores de mortalidade, marcadores cardiovasculares e ocorrência de violência, reforçando a importância de sua preservação e inclusão nas agendas de gestão urbana (Kondo et al., 2018).

A adoção de critérios qualitativos na avaliação desses espaços mostra-se fundamental para compreender inconsistências nos estudos sobre sua relação com atividade física e obesidade, particularmente quando análises exclusivamente quantitativas não consideram aspectos como acessibilidade e qualidade real dos espaços (Knobel et al., 2021).

Paralelamente ao enfoque nos espaços verdes, observa-se crescente reconhecimento da importância dos espaços azuis nas pesquisas e políticas urbanas globais. Estes compreendem ambientes relacionados a corpos d'água e sua integração com a saúde pública, incluindo a prática de atividades sociais e físicas, além de experiências sensoriais enriquecedoras. Enquadram-se nesta categoria tanto ambientes naturais quanto artificiais com presença proeminente de água e acessíveis à população, como lagos, lagoas, rios, açudes e áreas costeiras (Zhang et al., 2024).

Reafirma-se assim a relação direta entre qualidade do espaço urbano e a constituição de territórios saudáveis, demandando sua incorporação nos processos de planejamento mediante a compreensão dos impactos dos ambientes construídos na saúde e equidade social (Concessão et al., 2022). A discussão sobre a conjuntura urbana e a qualidade de seus espaços relaciona-se intrinsecamente com os princípios de equidade e acesso universal, uma vez que a promoção da saúde através da melhoria ambiental enfrenta constantemente determinantes sociais como emprego, educação, moradia e pobreza.

Por equidade e acesso universal compreende-se a garantia das necessidades básicas para uma vida digna, a oferta de serviços públicos acessíveis, a promoção da justiça social e a redução sistemática das desigualdades. Estes atributos constituem fundamentos essenciais para a proposição e implementação eficaz de territórios saudáveis, os quais demandam a identificação e superação dos obstáculos que limitam o acesso equitativo a serviços de qualidade. Esta perspectiva deve considerar tanto o setor saúde quanto os demais setores afins, necessários ao enfrentamento dos determinantes sociais e econômicos e à implementação de políticas verdadeiramente inclusivas e universais.

No que concerne às necessidades básicas, é fundamental destacar o acesso universal a alimentos, água, moradia digna, renda adequada, segurança e oportunidades de trabalho para todos os indivíduos no território. A garantia desses elementos constitui base essencial para a obtenção de melhores condições de saúde. Nesta perspectiva, o objetivo transcende a mera redução de índices de morbidade, almejando a promoção de elevados padrões de saúde populacional (Leeuw et al., 2015).

A concepção de territórios saudáveis, sob a ótica da equidade e acesso universal, fundamenta-se no respeito às particularidades históricas e geográficas, nas relações sociais estabelecidas e nas experiências cotidianas de vida e trabalho (Silva et al., 2024).

Considerando a complexidade inerente à avaliação dos estados de saúde em sua concepção ampliada, tais territórios mobilizam recursos diversos para fomentar interações sociais, comunicação e experiências coletivas que fortaleçam os indivíduos na busca por melhores condições de vida (Leeuw et al., 2015). Esta abordagem exige a superação de visões reducionistas centradas exclusivamente no setor saúde e nos aspectos biológicos, incorporando determinantes psicológicos, sociais, econômicos e ambientais em suas intervenções (Iamtrakul, 2023).

A dimensão do acesso engloba a oferta de serviços de saúde multiprofissionais e assistência médica universal, respeitando as singularidades individuais e coletivas sob os princípios da justiça social e equidade (Luo et al., 2022). Reconhece-se que, embora o setor saúde não deva arcar isoladamente com a satisfação de todos os determinantes, cabe-lhe o papel estratégico de articular políticas, programas e ações intersetoriais, funcionando como eixo norteador na construção de territórios saudáveis.

Antes de abordar especificamente o acesso equitativo, impõe-se uma reflexão sobre a cobertura universal de saúde - meta ainda não alcançada em diversas realidades globais. A concretização do direito à saúde como mecanismo de proteção individual e coletiva tem sido prioridade da Organização Mundial da Saúde (OMS), especialmente considerando que, em 2017, metade da população mundial não tinha acesso a serviços essenciais de saúde (Gostin, 2021).

A discussão sobre acesso à saúde envolve necessariamente debates políticos, estratégicos e conceituais que demandam alinhamento de perspectivas. As discrepâncias entre organismos internacionais tornam-se evidentes quando se contrasta a abordagem abrangente da OMS - que inclui ações promocionais, preventivas, curativas, reabilitadoras e paliativas - com a visão mais restrita dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, focada principalmente em cuidados médicos e de enfermagem. Outra contradição manifesta-se na posição do Banco Mundial, que alerta para o risco de custos com saúde aprofundarem situações de pobreza - aspecto frequentemente negligenciado em outros fóruns de discussão (Gostin, 2021).

O monitoramento predominante baseado em indicadores quantitativos revela-se insuficiente para captar as nuances qualitativas exigidas pela equidade em saúde. Esta limitação pode inadvertidamente acentuar disparidades e até mesmo validar situações de "equidade inversa", onde populações privilegiadas acessam primeiro os serviços, relegando grupos economicamente vulneráveis e periféricos a um segundo plano (Rodney; Colina, 2014).

O enfrentamento das desigualdades sociais nos territórios saudáveis exige a identificação e transformação dos determinantes que restringem o acesso de grupos específicos. Este processo demanda a participação ativa desses grupos na identificação de sistemas excludentes e na proposição de estratégias inclusivas. O acesso universal configura-se como consenso mínimo, devendo abranger um rol essencial de bens e serviços sem qualquer forma de exclusão (Allotey et al., 2012).

O cenário global atual caracteriza-se por uma sindemia de problemas interconectados - incluindo crises ambientais, conflitos armados, deterioração socioeconômica e pandemias - que exacerbam desigualdades estruturais em saúde (Mead, Pickin; Popay, 2022). As políticas sociais universais, embora necessárias, mostram-se limitadas ao não contemplar necessidades específicas de grupos populacionais, comprometendo sua eficácia na redução de desigualdades (Fisher et al., 2022).

O terceiro domínio de atributos - a governança participativa - envolve o fortalecimento da atuação comunitária nas políticas públicas mediante colaboração entre governo, setor privado e sociedade civil (Leeuw et al., 2015). Esta abordagem favorece a integração social, a adoção de valores como equidade e autonomia, e o fortalecimento da comunicação colaborativa.

Urge desenvolver modelos de governança capazes de incluir múltiplos atores no diagnóstico de necessidades, planejamento, implementação e avaliação de ações em saúde, ampliando os espaços de participação social na tomada de decisões (Setti et al., 2016). A governança em territórios saudáveis caracteriza-se por práticas deliberativas fundamentadas na justiça social, que ampliam a criatividade, liberdade e capacidades dos indivíduos e coletivos (Setti et al., 2016).

A participação comunitária efetiva traduz-se em contribuições substantivas para governos locais visando melhores condições de saúde, bem-estar (Hancock, 2021) e estrutura urbana favorável (Lee, Park; Yoon, 2019). Busca-se um desenvolvimento humano, integral e diverso, com coparticipação de autoridades, comunidade e todos os segmentos sociais (Chavez, 2009; Laureano-Eugenio, 2021).

Este modelo envolve: representatividade étnica; respeito às vulnerabilidades e culturas diversas; combate à exclusão social; abordagem integral considerando multidimensionalidade humana; fortalecimento de vínculos territoriais; e inclusão de minorias nos processos decisórios (Setti et al., 2016; Tavares, 2014). Contudo, persistem desafios significativos, incluindo assimetrias de conhecimento, questões epistêmicas e desequilíbrios de poder, particularmente na inclusão de populações historicamente marginalizadas (Fritar, Clifford-Holmes; Palmer, 2024).

Ainda assim os territórios saudáveis demandam essa participação e o incentivo ao reconhecimento da pluralidade de conhecimentos, a ampliação de mecanismos de produção desse conhecimento alinhado a libertação e opressão e a valorização de saberes populares (Setti et al., 2016).

O interculturalismo associado aos diferentes tipos de conhecimento potencializa a capacidade de agir das comunidades na resolução de crises, na organização de respostas as demandas e no usufruto do desenvolvimento para o bem-estar próprio e da coletividade (Westphal; Mendes, 2000).

A lógica da governança participativa parte da apropriação do território por meio de técnicas e estratégias de territorialização, enquanto produção social, econômica, política e cultural que possibilita aproximação com as necessidades e prioridades que emanam de um território (Setti et al., 2016). Parte-se do pressuposto de que políticas públicas com e para participação da sociedade local contribuem para construção de territórios saudáveis, uma vez que desvela um interesse real do governo na saúde de seus moradores, com melhorias nas condições e estados de saúde (Lee; Park; Yoon, 2019).

Além de assegurar a participação, faz-se relevante promover a igualdade na ocupação dos espaços (Sperandio; Francisco Filho; Mattos, 2016), fomentar espaços de governança local, diálogo e contato com outros setores (Ly et al., 1998), engajar-se nos planos de desenvolvimento com foco na saúde territorial e estruturação de redes para ambientes saudáveis (Onez, 2024).

Posto isso, integrar as políticas públicas de saúde, urbanismo, economia, cultura, dentre outras, caracterizam a intersetorialidade, quarto atributo do conceito analisado.

A ação intersetorial envolve o exercício de superação da fragmentação ainda empregada na produção do cuidado, materializada especialmente por especializações excessivas e dicotomia entre os setores e áreas do saber. O esforço empreendido reconhece a complexidade sanitárias e heterogeneidades territoriais que não podem estar dissociadas em ações isoladas e descontextualizadas, com pouco ou nenhum efeito sobre a saúde e qualidade de vida dos indivíduos (Dias et al., 2014).

Trabalhar sob o alinhamento intersetorial consiste na mobilização de ações, projetos, programas e políticas que transcendam o setor saúde, manifestando-se transversalmente em outras proposições. Assim, considerando a múltipla determinação social, promove-se a inserção da saúde no debate sobre habitação, emprego, renda, desenvolvimento econômico, planejamento urbano, mobilidade urbana, lixo, educação, lazer e acesso a bens e serviços essenciais (Petersen et al., 2020; Lima; Lima, 2020).

A combinação de diferentes setores para desenvolvimento de territórios saudáveis encontra justificativa e respaldo frente as diversas condições de vida e saúde socialmente determinadas por decisões políticas, sociais e ambientais. Esse processo deve ser contínuo e é influenciado por aspectos como liderança, objetivos comuns, definição efetiva de papéis e responsabilidades, determinação de recursos, confiança, resolução de conflitos e compreensão da saúde como eixo conectivo e objetivo a ser alcançado (Bilodeau et al., 2023).

Esse domínio articula-se fortemente a governança participativa, uma vez que exige a mobilização e interação entre indivíduos representantes de seguimentos e setores distintos. Dentre os desafios manifestos à intersetorialidade relacionados a governança e participação social pode-se pontuar a sustentação de processos democráticos, a integração de contribuições da sociedade civil e/ou de seus representantes na tomada de decisões e o desequilíbrio de poder (Bilodeau et al., 2023).

A resistência à perda de autonomia organizacional também se manifesta como um dos desafios a intersetorialidade, o que pode ser enfrentando a partir da tratativa da liderança entre os diferentes setores relevantes e articulados, não depositando o protagonismo no setor saúde. As propostas podem partir do setor saúde ou mesmo ser estimuladas por esse, mas não se sustentam unicamente nesse, demandando articulação com os demais setores (Lima; Lima, 2020).

Outras medidas recomendadas são o incentivo a cooperação, a partilha de responsabilidades e distribuindo a efetivação das ações; contemplação de eixos de desigualdade social, como pobreza, gênero e raça/etnia; e promoção da descentralização do poder e tomada de decisões em substituição de processos hierárquicos descendentes e impositivos (Gallardo, 2019).

Esses desafios precisam ser trabalhados e superados no âmbito das representações do Estado, capacitando os setores instituídos para compartilhar o poder decisório (Setti et al., 2016). Assim, avança-se no sentido da intrasetorialidade, necessária previamente a uma intersetorialidade efetiva (Westphal, 2000).

Uma outra realidade a ser considerada é a organização das práticas colaborativas de cunho multisetorial, por vezes classificadas como intersetoriais. A atuação multisetorial, embora envolva diferentes setores, trata da soma de esforços sem que exista sinergia entre esses. Logo, não se identifica uma coparticipação efetiva que perpassasse todas as etapas de operacionalização de uma proposta, incluindo o desfrute dos seus resultados, como é característico da intersetorialidade (Dias et al., 2014).

Por fim, é relevante destacar a valorização dos saberes produzidos na comunidade a partir da associação entre indivíduos, setores e propostas diversas, aproximando-se cada vez mais de onde a saúde é produzida e experienciada. Pode-se citar a formação de redes comunitárias colaborativas a partir da mobilização de práticas populares do território, como ervateiros, parteiras, curandeiros, cuidadores informais e comunicadores comunitários, dentre outros (Monken, 2024).

Reitera-se que a consecução de objetivos em saúde pública mostra-se inatingível por um único setor isoladamente, sendo necessária a cooperação sinérgica entre departamentos governamentais, sociedade civil e setor privado para produzir resultados eficientes, eficazes e sustentáveis (Mondal, Belle; Maioni, 2021). A intersectorialidade configura-se como elemento fundamental para a promoção da saúde, quinto domínio constitutivo dos territórios saudáveis.

No contexto da conformação de territórios saudáveis, a promoção da saúde assume papel estratégico ao posicionar a saúde como prioridade política, transcendendo a mera ausência de doenças; focalizar nos determinantes sociais da saúde; implementar

ações preventivas e de estilos de vida saudáveis; e capacitar as comunidades para atuarem ativamente na melhoria de suas condições de vida. Esta abordagem alinha-se ao conceito ampliado de saúde proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1986), compreendendo-a como processo de empoderamento populacional que preserva a autonomia e garante participação social.

A saúde é concebida como recurso para a vida cotidiana, não como objetivo final em si mesma (OMS, 1986). Esta perspectiva multifacetada, que considera os aspectos positivos que conferem qualidade à existência humana (Bittencourt, 2017), mostra-se essencial nos territórios saudáveis, onde a promoção da saúde mobiliza e articula os demais atributos do conceito, orientando-se pelos objetivos de saúde definidos coletivamente (Freire, Salles; Sá, 2016; Intrakul; Chayphong, 2023; Westphal, 2000).

A promoção da saúde atua sobre determinantes não diretamente controláveis - sociais, culturais, políticos e econômicos (Waynsztok, Rossi; Chiara, 2011) - mediante estratégias nas dimensões individual, organizacional e comunitária (Graciano et al., 2019). Sua abordagem holística fundamenta-se nos princípios de equidade, direitos humanos e desenvolvimento sustentável (Fortune et al., 2018).

O marco conceitual contemporâneo, estabelecido pela Carta de Ottawa (OMS, 1986), supera visões culpabilizantes ao reconhecer o papel do Estado na produção de condições saudáveis; fortalecer o protagonismo comunitário;

propor políticas públicas saudáveis; criar ambientes favoráveis; reforçar a ação comunitária; e desenvolver competências pessoais (O'Hara, Taylor; Barnes, 2018). Para alcançar o bem-estar integral, os indivíduos necessitam autoconhecimento de suas aspirações, capacidade de satisfazer necessidades básicas e habilidade para modificar responsavelmente seu ambiente (OMS, 1986).

Essa abordagem demanda informação acessível para fortalecer o letramento em saúde (Dooris; Heritage, 2011); e conscientização cidadã sobre saúde e civilização (Wang, Wang; Guan, 2017). O desenvolvimento de competências em promoção da saúde - entendido como processo de aquisição e aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes (Machado, 2023) - mostra-se fundamental para mobilizar recursos favoráveis à qualidade de vida.

Estudo brasileiro (Machado, 2023) identificou treze domínios essenciais de competências em promoção da saúde, incluindo: valores éticos, trabalho intersetorial, liderança estratégica, advocacia em saúde, comunicação eficaz, capacidade de mudança, educação permanente, diagnóstico situacional, planejamento, implementação, avaliação, pesquisa e gestão. Estas competências não são exclusivas aos profissionais de saúde, devendo ser estendidas à comunidade, com especial atenção aos saberes locais e projetos comunitários ao longo do ciclo vital (Botchway et al., 2023; Rudolph et al., 2008).

A educação popular em saúde emerge como estratégia convergente, fundamentada nos pressupostos freireanos e caracterizada por: diálogo construtivo; interdisciplinaridade; intersetorialidade; pedagogias decoloniais; e respeito às pluralidades territoriais (Gomes; Beretta, 2024; Alves et al., 2022). Durante a pandemia de COVID-19, estas práticas ganharam relevância como resposta à necropolítica e negligência institucional, demonstrando o potencial dos movimentos sociais na implementação de ações contextualizadas (Alves et al., 2022).

Assim, a promoção da saúde consolida sua agenda de compromissos por meio do engajamento de profissionais da saúde, setores administrativos, representações políticas, autoridades públicas, organizações populares e do setor privado, discutindo e atuando sobre as repercussões das políticas nas condições de vida e saúde em um território (Buss et al., 2020).

Enquanto determinantes sociais, é fundamental assegurar trabalho digno e geração de renda sob a lógica de uma economia inclusiva e diversificada, sexto domínio de atributos do conceito.

A literatura indica que esse modelo econômico contribui para territórios saudáveis ao promover equidade e inclusão, fortalecendo uma economia local dinâmica e inovadora, capaz de gerar oportunidades, estimular a resiliência econômica e social e adotar práticas sustentáveis que respeitem os limites ambientais.

Condições econômicas adversas, como baixa renda, desemprego, subemprego, ocupações precárias ou perigosas, impactam diretamente a saúde, associando-se a piores desfechos em morbimortalidade. Ademais, as desigualdades em saúde, estruturadas pela concentração de renda, e a crise climática representavam os principais desafios da saúde pública antes da pandemia de COVID-19 (Shipton et al., 2021).

Uma economia inclusiva pressupõe organização, governança e objetivos equitativos, abrangendo a distribuição de bens e serviços essenciais, participação econômica, acesso a ativos e valorização justa (Shipton et al., 2021).

Por sua vez, a diversificação produtiva de bens e serviços necessária à economia pode derivar da inovação. Recomenda-se, portanto, a descentralização dos processos produtivos e a construção de relações mais participativas e inclusivas entre as partes interessadas. Essa abordagem pode fortalecer a atratividade dos territórios, mobilizar recursos conforme as demandas locais e estimular o desenvolvimento. As inovações podem ser tecnológicas, organizacionais, sociais ou institucionais, implementadas de forma unitária, sequencial ou paralela, conforme o contexto e os objetivos estabelecidos (Dansou; Carrier, 2023).

Entre as estratégias para uma economia inclusiva e diversificada, destacam-se: a adoção de perspectivas feministas, a valorização do propósito social do capital, a regulamentação do mercado de trabalho, a integração de objetivos sociais e sustentabilidade ambiental no sistema tributário, o aprimoramento da economia fundamental e a definição de metas econômicas mais abrangentes (Shipton et al., 2021; Leeuw et al., 2015).

A articulação entre indivíduos e setores para a promoção de atividades econômicas social e politicamente inclusivas reforça o domínio de atributos como pertencimento e coesão social, dada a natureza solidária das comunidades, com redes de apoio mútuo, valorização da diversidade cultural, saberes locais, identidade territorial e preservação do patrimônio histórico e dos recursos naturais. Tais atributos contribuem para o bem-estar subjetivo, a resiliência comunitária, a proteção de grupos vulneráveis e o controle coletivo, associando-se a melhores indicadores de saúde mental e física.

A coesão social refere-se ao grau de conexão e solidariedade entre os membros de uma comunidade, englobando confiança, relações sociais, senso de pertencimento e orientação para o bem comum (Adetunji et al., 2023).

Um território saudável é valorizado por seus habitantes, que desenvolvem um senso de pertencimento e, conseqüentemente, de responsabilidade e cuidado, inclusive na escolha de seus representantes (Sperandio et al., 2016).

A coesão social e o sentimento de pertencimento elevam a satisfação com a residência, melhoram a percepção de segurança e reduzem o isolamento social, promovendo o bem-estar e a saúde psicológica. Também impactam positivamente a saúde física, ao minimizar estressores ambientais e incentivar o uso de recursos locais, como opções de lazer e prática de atividades físicas (Zahnow, 2024).

O contato social e a familiaridade com os indivíduos do território, facilitados por atividades cotidianas como frequentar espaços públicos, mercados e bibliotecas, são elementos associados a maior atividade física e senso de comunidade (Zahnow, 2024). Além disso, a coesão social e o pertencimento estão ligados a habitação de qualidade, infraestrutura de transporte eficiente, acesso a serviços de saúde e assistência, segurança e baixos índices de criminalidade (Davis; Davies, 2025).

O pertencimento também abrange o orgulho e a identidade cultural compartilhados pelos cidadãos (Grant, 2015), a participação em discussões e decisões que afetam a vida, a saúde e o bem-estar coletivo (Leeuw et al., 2015), a construção de espaços relacionais (Gadelha; Ameixa, 2024) e a conexão com a história local, o patrimônio cultural e biológico (Pilon, 1993).

Esses atributos funcionam como recursos para a capacidade comunitária, potencializando a ação individual e coletiva na criação de oportunidades para melhorar o bem-estar no território. Somam-se a isso a capacidade coletiva, a confiança no potencial de ação, a resolução de conflitos e a liderança competente (Adetunji et al., 2023).

Em seguida, aborda-se o planejamento urbano inclusivo, sétimo domínio de atributos de territórios saudáveis. Trata-se de uma infraestrutura que favoreça mobilidade segura e acessível, espaços públicos que incentivem interação social e atividades físicas, e adaptação a crises, promovendo resiliência urbana. O planejamento urbano inclusivo contribui para territórios saudáveis ao fomentar ambientes sustentáveis, equitativos e acessíveis, melhorando a saúde e o bem-estar por meio de mobilidade eficiente, espaços públicos qualificados e redução de desigualdades socioespaciais.

O planejamento urbano pode catalisar o desenvolvimento saudável ao incentivar a prática de exercícios, fortalecer a coesão social, garantir acesso equitativo a alimentação adequada, promover interação social e segurança, além de viabilizar relacionamentos saudáveis, lazer, experiências afetivas e acesso a bens e serviços essenciais (Mouratidis, 2021).

Especificamente, áreas urbanas planejadas para a saúde geram impactos positivos em cascata. Por exemplo, políticas de incentivo ao transporte público reduzem poluição sonora e atmosférica, aumentam a atividade física e diminuem o fluxo de veículos (Soni; Soni, 2016). Da mesma forma, a incorporação de espaços verdes no planejamento urbano auxilia na redução de ruídos, poluição e estresse térmico, além de estarem associados a maior satisfação com a vida, melhor saúde mental e bem-estar psicológico (Kondo et al., 2018).

No entanto, a intersecção com políticas, setores e interesses diversos impõe desafios ao seu reconhecimento e implementação. Entre esses desafios, destacam-se a falta de conhecimento sobre territórios saudáveis entre profissionais de diferentes áreas, com priorização de decisões diretamente ligadas à saúde (como espaços para atividade física) em detrimento de determinantes sociais (como habitação e geração de empregos). Outros debates relevantes incluem a expansão urbana acelerada, perda de biodiversidade, mudanças climáticas, iniquidades, envelhecimento populacional e o aumento de doenças não transmissíveis (Pineo, 2020).

Todos os processos mencionados exigem acompanhamento sistemático, alinhado ao monitoramento contínuo e à inovação em avaliações e suporte à tomada de decisão. O nono domínio, inovação e monitoramento contínuo, envolve a avaliação sistemática de políticas por meio de indicadores de saúde, o uso de tecnologias e dados para decisões informadas e a adaptabilidade a mudanças e demandas emergentes.

O paradigma da inovação consiste em um conjunto de políticas que visam à competitividade entre territórios – regiões, nações, cidades e comunidades – sob a ótica da globalização. Atualmente, tem sido ressignificado para subsidiar transformações institucionais, ambientais e sociais, indo além de mudanças meramente tecnológicas e econômicas (Jeannerat; Crevoisier, 2022).

A inovação permite ampliar a ação produtiva, incorporando criatividade e possibilitando o surgimento de novos métodos, produtos e práticas, alinhados a diferentes formas de pensar e agir. Quando aplicada à lógica territorial, deve considerar a governança do território, reconhecer os múltiplos atores e suas contribuições para o desenvolvimento, além de priorizar a produção de tecnologias adaptadas ao contexto local (Torre, 2025).

No âmbito do monitoramento em saúde, é essencial estimular o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias da informação inovadoras, capazes de integrar dados de fontes diversas e auxiliar na gestão eficiente de recursos. Sua relevância para territórios saudáveis sustenta-se na necessidade de resiliência e adaptação às rápidas e dinâmicas mudanças socioeconômicas, especialmente em situações de crise, como guerras e pandemias (Lipianina-Honcharenko, 2024).

As tecnologias da informação contribuem nesse sentido de três maneiras principais considerando a heterogeneidade dos dados, provenientes de fontes distintas e passíveis de diferentes formas de organização, análise e apresentação; utilizando métodos analíticos avançados, como inteligência artificial, modelos preditivos, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, que agregam precisão e relevância, otimizando processos; e fornecendo suporte à tomada de decisão, com base em evidências robustas (Lipianina-Honcharenko, 2024).

Por sua vez, a avaliação sistemática de políticas envolve o monitoramento contínuo de processos relevantes ao território (Lee; Park; Yoon, 2019), abrangendo programas (Waynsztok; Rossi; Chiara, 2011), perfis de saúde territorial (Cetin, 2024) e impactos na saúde (Tsouros; Green, 2013).

As ações de monitoramento têm como objetivos prevenir riscos e orientar medidas que reduzam a exposição de indivíduos a situações que comprometem o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde. Essas ações estão associadas à vigilância em saúde, em suas dimensões ambiental, ocupacional, nutricional, epidemiológica e sanitária. São aplicáveis aos territórios por adotá-los como unidades espaciais predefinidas, nas quais se realizam diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de ações em saúde (Cardoso; Costa; Silva, 2020).

Entretanto, reconhecendo sua importância, é necessário transcender os modelos tradicionais de vigilância. Dessa forma, é possível ampliar a abordagem para incluir outros aspectos da vida relacionados à saúde e sua promoção, como análise de construtos de felicidade, senso de pertencimento territorial, participação popular, comportamentos de saúde e percepção geral de bem-estar (Liu, 2024). Outras estratégias, como a vigilância popular em saúde, também podem ser empregadas para monitorar determinantes sociais da saúde, alcançando grupos vulneráveis e considerando singularidades territoriais (Meneses et al., 2023).

Ainda não há um consenso global sobre indicadores capazes de mensurar integralmente territórios saudáveis. Observam-se iniciativas alinhadas a contextos específicos, considerando a disponibilidade de dados locais, o que impede a padronização completa de informações para todos os territórios.

No Brasil, o Índice de Território Saudável e Sustentável (ITSS) surge como uma proposta para o planejamento de ações e serviços de saúde alinhados à promoção da saúde e articulados com políticas públicas (Petersen et al., 2020).

O ITSS reúne sete indicadores com dados disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Petersen et al., 2023).

Embora seja uma iniciativa relevante, assim como outras, o ITSS não abrange todos os atributos que constituem territórios saudáveis. Portanto, o desenvolvimento de instrumentos de mensuração mais abrangentes configura-se como uma necessidade para a estruturação e avaliação desses territórios.

Por fim, o último atributo dos territórios saudáveis consiste na qualidade de vida e bem-estar integral, elementos fundamentais para o desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental e a participação comunitária. Assim, busca-se que os territórios favoreçam a saúde mental e o convívio social, o acesso à cultura, ao lazer e a atividades recreativas, além de adotar abordagens assertivas para todas as fases do ciclo de vida (crianças, adolescentes e idosos, por exemplo) e para as especificidades de grupos como pessoas com deficiência.

Sob essa perspectiva, o território desenvolve-se para melhorar os parâmetros e comportamentos de seus habitantes (Leeuw et al., 2015), ampliando seus recursos para apoiar a vida, o bem-estar e a realização do potencial individual e coletivo (Wen et al., 2024).

A intersecção dos atributos aqui descritos transcende fronteiras disciplinares, promovendo um diálogo entre saúde, meio ambiente, planejamento urbano, economia, política, direitos humanos e participação social. Nesse contexto, reforça-se a complexidade de desenvolver territórios saudáveis, exigindo o envolvimento de múltiplos atores de forma responsável e comprometida com o bem-estar coletivo presente e futuro. Embora os esforços sejam diversos e a concepção de territórios saudáveis possa ser vista como utópica, todo avanço em direção a esses atributos é relevante para a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da população, merecendo valorização e estímulos contínuos.

CONSEQUENTES DO CONCEITO

O desenvolvimento de territórios saudáveis visa impactar positivamente a qualidade de vida, as condições de saúde e a harmonia ecossistêmica no contexto do processo de urbanização. Sua fundamentação contribui para a articulação entre a saúde urbana e a complexidade do processo saúde-doença-cuidado, com base no enfrentamento dos determinantes e condicionantes sociais (Domingues; Silva; Ravera, 2024).

A efetivação desses espaços resulta em melhoria da saúde e da qualidade de vida, redução das desigualdades e promoção da inclusão social, desenvolvimento ambiental sustentável, fortalecimento da governança e das políticas públicas, engajamento coletivo e autonomia comunitária e benefícios econômicos e aumento da eficiência (Quadro 4).

Quadro 4. Domínios e consequentes do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

DOMÍNIO	CONSEQUENTES CONSTITUINTES
Melhoria da saúde e qualidade de vida	Redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida Melhoria do bem-estar físico, mental, social e ambiental Promoção de hábitos saudáveis Prevenção e gestão de doenças urbanas
Redução de desigualdades e inclusão social	Redução das desigualdades em saúde (socioeconômicas, de gênero, acesso a serviços) Priorização de grupos vulneráveis Promoção de políticas públicas e inclusivas
Desenvolvimento ambiental	Redução de impactos ambientais negativos Criação de espaços urbanos saudáveis (áreas verdes, transporte sustentável, habitação digna) Integração entre saúde, economia e ecologia
Fortalecimento da governança e políticas públicas	Implementação de políticas intersetoriais Planejamento urbano com foco em saúde coletiva Fortalecimento da gestão municipal e respostas locais a emergências
Engajamento coletivo e autonomia comunitária	Envolvimento ativo da população nas decisões de saúde Fortalecimento da coesão social e redes de apoio Promoção da autonomia e emancipação dos cidadãos
Benefícios econômicos e eficiência	Redução de custos com serviços de saúde Aumento da produtividade local Otimização de recursos por meio de parcerias
Promoção de estilos de vida saudáveis	Aumento no conhecimento sobre saúde física e mental Incentivo a hábitos sustentáveis e seguros Criação de ambientes que facilitem escolhas saudáveis
Resiliência e preparação para crises	Melhoria da capacidade de resposta a emergências sanitárias Redução de vulnerabilidades sociais e ambientais

Fonte: elaboração própria.

A melhoria da saúde e da qualidade de vida em territórios saudáveis reflete-se na redução da mortalidade e no aumento da expectativa de vida, resultados alcançados por meio de processos promotores de saúde e da diminuição das vulnerabilidades sociais e ambientais. Esses avanços são viabilizados mediante ações comunitárias e pela efetivação de políticas públicas em suas múltiplas dimensões – ambiental, cultural, econômica, política e social. Envolvem ainda o enfrentamento dos problemas territoriais, a atenção às populações expostas a esses desafios e a priorização de ações em saúde (Petersen et al., 2020).

Por outro lado, a melhoria do bem-estar físico, mental, social e ambiental decorre principalmente da estruturação de ambientes favoráveis à saúde e sua promoção, o que inclui a qualificação do espaço habitacional, especialmente em áreas de vulnerabilidade (Domingues; Silva; Ravera, 2024), e a regeneração física, econômica e social que influenciam os modos e condições de trabalho e vida dos indivíduos (Burgos; Quintero; Gracia-Soriano, 2019). A promoção da saúde, mobilizada para esses fins, contribui ainda para a adoção de hábitos saudáveis pela população, fruto da implementação de agendas estratégicas e participativas que ampliam o acesso à informação em saúde, sua aplicação prática e aos recursos territoriais que os viabilizam (Portela; Webber; Bowles, 2023; Gallo; Setti, 2012).

Embora seja reconhecido o potencial dos territórios saudáveis para melhorar as condições de vida da população, destaca-se a necessidade de superação do modelo hegemônico de produção vigente, valorizando experiências alternativas de organização econômica e social, alinhadas aos princípios de solidariedade e eficiência (Gallo; Setti, 2012). Dessa forma, coopera-se para uma gestão eficaz de medidas preventivas e de enfrentamento às doenças urbanas, antecipando-se aos eventos sob uma lógica ecossistêmica e comunicativa, que inclui propostas integradas de saúde, economia e seguridade social voltadas à superação dos desafios demográficos, nutricionais, epidemiológicos, econômicos e tecnológicos que impactam o bem-estar coletivo (Gallo; Setti, 2012).

A redução das desigualdades, entendidas como diferenças nos níveis de saúde entre indivíduos e comunidades (Garzón-Orjuela et al., 2020), e a promoção da inclusão social emergem como consequências fundamentais dos territórios saudáveis, caracterizadas pela priorização de grupos vulneráveis e pela implementação de políticas públicas inclusivas. Essa redução está intrinsecamente ligada à proposição de intervenções comunitárias, à governança inclusiva e ao acesso universal. As intervenções baseadas na comunidade podem ser classificadas segundo sua capacidade de reduzir desigualdades, ampliá-las ou gerar benefícios gerais sem impactar a equidade em saúde. É essencial que tais intervenções sejam fundamentadas em processos metodológicos bem delineados, produzindo evidências que permitam sua avaliação e replicação em outros contextos (Nickel; Knesebeck, 2020).

Paralelamente, a governança inclusiva mostra-se crucial para abordar as desigualdades, especialmente em contextos globalizados onde estas se acentuam, como durante a pandemia de COVID-19 ou em conflitos armados que reduzem o acesso à saúde de mulheres, crianças e idosos (Eliakimu; Mans, 2022). O enfrentamento das desigualdades em saúde pode exigir tanto ações de acesso universal quanto respostas específicas para diferentes grupos populacionais, como pessoas em situação de rua ou imigrantes. Embora o acesso universal busque solucionar demandas decorrentes de gradientes socioeconômicos e ambientais, argumenta-se que ele, isoladamente, é insuficiente para atender às necessidades daqueles em piores condições de saúde, demandando ações direcionadas para mitigar desvantagens, discriminações e promover inclusão efetiva (Campos-Matos et al., 2019).

O processo de inclusão social, por sua vez, depara-se com as injustiças espaciais, manifestas principalmente de duas formas: o confinamento involuntário de indivíduos em espaços limitados, como favelas em expansão, e a distribuição desigual de recursos nos territórios (Madanipour; Shucksmith; Brooks, 2021). Diante disso, são necessárias abordagens territoriais capazes de enfrentar os determinantes sociais a partir do desenvolvimento econômico, social e ambiental, discutindo as desigualdades em todos os espaços de governança (FAO, 2021).

Os territórios saudáveis articulam-se de forma mutualística, estabelecendo uma relação harmônica entre indivíduos e ecossistemas. Nessa perspectiva, preservam-se, criam-se e expandem-se espaços urbanos saudáveis, como áreas verdes e azuis, moradias dignas e sistemas de transporte sustentável. Destaca-se a importância de projetos de desenvolvimento territorial que promovam a recuperação de áreas degradadas, transformando-as em espaços ecológicos e socialmente autossuficientes, como o projeto Porto di Mare em Milão, que restaurou a biodiversidade e melhorou a qualidade de vida (Serohin et al., 2023). Outro exemplo relevante é a gestão ambiental e o planejamento territorial no Reino Unido e Alemanha, que converteram áreas industriais em espaços habitáveis e recreativos, impactando positivamente a qualidade de vida urbana (Pupentsova et al., 2020).

Adicionalmente, as práticas de gestão territorial de povos originários, como indígenas, oferecem contribuições valiosas para a redução de impactos ambientais, combinando saberes tradicionais com medidas de conservação e sustentabilidade (Zanjani et al., 2023). A avaliação ambiental contínua dos territórios também é crucial para minimizar impactos negativos em diferentes estágios (Louiseau et al., 2012).

A resiliência e sustentabilidade ambiental relacionam-se à integração entre saúde, economia e ecologia. Nesse contexto, destacam-se sistemas alimentares territorializados, que fortalecem mercados locais e práticas agrícolas familiares (Kato; Delgado; Romano, 2022), e cadeias de abastecimento alimentar sustentáveis, que geram empregos e promovem a agricultura responsável (Mundler; Laughrea, 2016).

Territórios saudáveis desempenham papel fundamental no fortalecimento da governança e das políticas públicas, especialmente através da implementação de políticas intersetoriais, do planejamento urbano centrado na saúde e do aprimoramento da gestão municipal para respostas locais a emergências. A atuação intersetorial, baseada em redes colaborativas entre diferentes atores e níveis de governo, promove coesão e sustentabilidade (Chamusca, 2023; Antunes; Borsatto; Souza-Esquerdo, 2021). Essa abordagem é exemplificada pelo projeto brasileiro Bocaína, que elevou os padrões de governança por meio de gestão integrada e participativa (Setti et al., 2016), e pelo desenvolvimento de índices para monitoramento de territórios saudáveis (Petersen et al., 2020).

A gestão municipal eficaz requer planejamento estratégico que considere as necessidades da população e fomente a interação entre atores sociais, setores públicos e privados (Santinha; Soares; Forte, 2023; Martini; Serluca, 2024). Por fim, o engajamento coletivo e a autonomia comunitária emergem como pilares dos territórios saudáveis, envolvendo ativamente a população nas decisões de saúde, fortalecendo a coesão social e promovendo a emancipação cidadã.

As iniciativas de participação coletiva nas discussões e decisões em saúde são fomentadas visando ao estabelecimento de parcerias sustentáveis e mudanças políticas capazes de refletir as necessidades comunitárias. Nesse contexto, destaca-se a relevância da Pesquisa Baseada na Comunidade como estratégia eficaz para o engajamento comunitário na melhoria das condições de saúde pública (Wallerstein et al., 2020), bem como experiências como a do Collective Actionwith Communities (CAwC), desenvolvido na Nova Zelândia, que envolveu ativamente a população na elaboração de planos de saúde, garantindo que suas demandas fossem incorporadas nos documentos orientadores e subsequentemente implementadas (Maxwell; Mahuika; Edmonds, 2023).

No que concerne à coesão social, esta tem se materializado por meio de coletivos comunitários organizados de forma prefigurativa, caracterizados por iniciativas locais fundamentadas nos princípios da solidariedade e autogovernança. A constituição de espaços discursivos de organização social alternativa, concretizados nas práticas cotidianas, tem fortalecido significativamente a coesão social e as redes de apoio mútuo (Bhatt et al., 2023).

Ações de impacto coletivo, que envolvem múltiplos setores sociais, demonstram eficácia na promoção da saúde e na sustentação de redes de apoio robustas, as quais influenciam positivamente o bem-estar comunitário (Black; Hyer, 2020; Hayes et al., 2021).

O desenvolvimento de territórios saudáveis pode ainda potencializar a eficiência produtiva e a preservação de recursos naturais, resultando na redução da necessidade de intervenções em saúde de alto custo, uma vez que a conservação ambiental contribui para a criação de ambientes mais favoráveis à saúde (Blieva, 2023). Ademais, a melhoria da qualidade de vida e a redução dos índices de morbidade podem ser observadas mediante a implementação de práticas ecológicas na gestão territorial, que diminuem as pressões sobre os sistemas e serviços de saúde (Bezrukova; Gyiazov; Kuksova, 2020).

Paralelamente, a eficiência produtiva estimula o desenvolvimento econômico local, particularmente através da implementação de estratégias territoriais que incluam clusters industriais, inovação tecnológica e aumento da competitividade regional (Ananicheva; Paytaeva; Goloschchapova, 2024). A delimitação de territórios de desenvolvimento prioritário pode ser eficaz ao fomentar investimentos, geração de empregos e melhoria dos padrões de vida, desde que não perpetuem injustiças espaciais. A integração entre serviços públicos e privados também se mostra relevante nesse cenário, ao otimizar a gestão de recursos e promover sinergias para o desenvolvimento econômico sustentável (Oleksandrivna, 2022).

A articulação entre setores público, privado e comunitário impulsiona a criação de infraestruturas que favorecem estilos de vida saudáveis, essenciais para a melhoria do sistema de saúde e a promoção do conhecimento em saúde (Travinikova; Dvoryadkina, 2021). Nesse aspecto, a inovação em saúde pode contribuir para o aumento da literacia sanitária, por meio de abordagens educativas adaptadas às potencialidades e limitações de cada público-alvo, como a gamificação aplicada à promoção de hábitos saudáveis entre crianças (Ramírez et al., 2024).

A promoção de estilos de vida saudáveis está intrinsecamente relacionada a práticas sustentáveis e seguras, como as fomentadas pela agroecologia e por programas de gestão territorial comprometidos com a saúde, justiça ambiental, educação e protagonismo comunitário (Palm et al., 2024; Pérez, 2018). A gestão territorial deve ainda contemplar o planejamento urbano voltado para a criação de ambientes equitativos e promotores de saúde (Grant et al., 2022), considerando aspectos físicos, econômicos e sociais. Além de favorecer a saúde populacional, os territórios devem ser estruturados para promover a regeneração ambiental (Burgos; Peñaloza; Gracia-Soriano, 2019).

Por fim, territórios saudáveis demonstram maior resiliência e capacidade de enfrentamento de crises econômicas e sanitárias. Para tanto, é fundamental fomentar a inovação, a colaboração intersetorial, as parcerias estratégicas e a educação continuada. A colaboração entre instituições de pesquisa, empresas e universidades fortalece a capacidade de resistência e recuperação de comunidades em crise, como evidenciado durante a pandemia de COVID-19, que destacou a importância da educação e da diversificação do mercado de trabalho local (Sargento; Lopes, 2024). Parcerias efetivas e acesso a recursos são elementos-chave para a resiliência comunitária, especialmente entre populações vulneráveis (Kieffer, 2024).

Em contextos de crise, a (re)conexão com o ambiente natural proporciona benefícios materiais, como segurança alimentar, e imateriais, como bem-estar psicológico, ambos essenciais para a saúde integral (Benessaiah; Chan, 2023). A resiliência territorial é fortalecida mediante a manutenção do equilíbrio socioeconômico, a proteção de infraestruturas críticas e o enfrentamento de ameaças internas e externas (Kulyk, 2024). Tais prerrogativas são fundamentais para a identificação de vulnerabilidades e a transformação dos sistemas socioecológicos e tecnológicos, viabilizando um planejamento eficaz para crises e desastres (Brunetta et al., 2019).

Sob esta perspectiva, os territórios saudáveis mostram-se mais alinhados com a promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar coletivo, estruturando-se a partir de um planejamento integrado e ações coletivas que fortalecem indivíduos, comunidades e governanças locais.

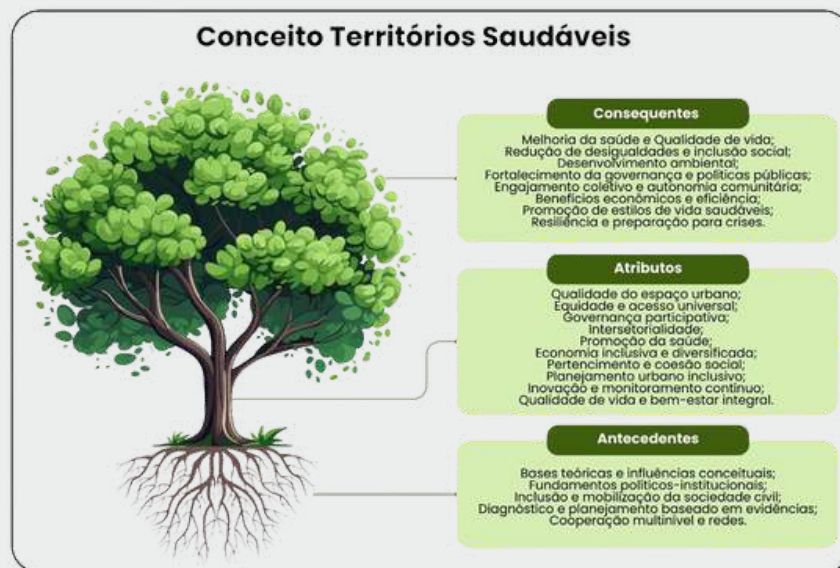
MODELO CONCEITUAL DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS

O construto territórios saudáveis articula-se em três dimensões fundamentais: antecedentes, definidos como condições estruturais e contextuais indispensáveis à constituição de territórios orientados para a saúde; atributos, entendidos como elementos distintivos e critérios normativos que os caracterizam; e consequentes, correspondentes aos desfechos derivados da implementação e consolidação desses territórios, mensurados por indicadores de efetividade.

Nessa perspectiva, territórios saudáveis configuram-se como espaços geográficos e sociais nos quais a produção da vida emerge da interação dialética entre sociedade e natureza, mediada por uma abordagem integral da saúde como eixo estruturante da qualidade de vida e bem-estar coletivo. Essa concepção exige a transversalidade da saúde nas políticas públicas e na organização de serviços, bem como a sinergia intersetorial para garantir sustentabilidade.

Tais territórios pressupõem planejamento urbano participativo, alinhado a critérios de equidade e justiça socioambiental; governança colaborativa, com engajamento comunitário e corresponsabilização; diversificação econômica inclusiva, capaz de reduzir disparidades; e fortalecimento do capital social, expresso em coesão comunitária e sentido de pertencimento. Seu escopo primordial é promover saúde como direito universal, mediante ações intersetoriais que integrem determinantes sociais, ambientais e econômicos, assegurando acesso equânime a serviços e tecnologias. Ademais, sua sustentabilidade depende de sistemas de monitoramento contínuo e de inovação na gestão pública, fundamentados em evidências científicas e avaliação crítica de impactos.

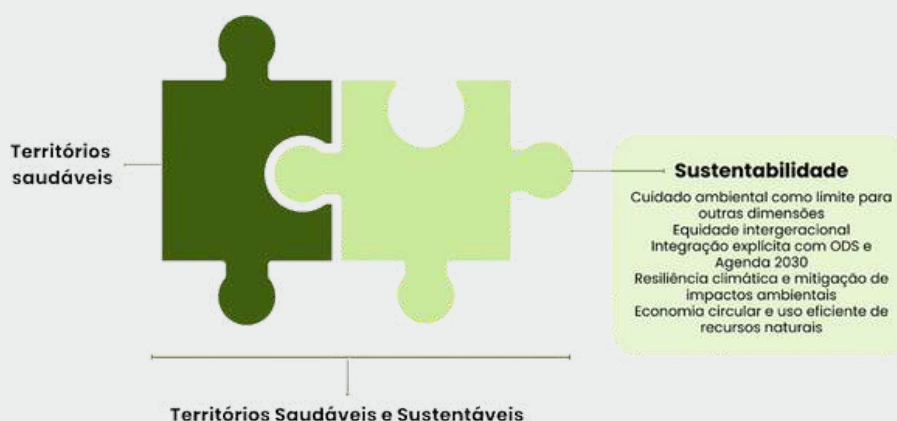
Figura 3. Modelo conceitual de territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025



Fonte: elaboração própria.

Para além de seus atributos fundamentais, os territórios saudáveis incorporam a sustentabilidade como uma característica complementar essencial, configurando-se, assim, como territórios saudáveis e sustentáveis. Essa conformação integra o cuidado ambiental como um limite estruturante para as demais dimensões, além de abranger a equidade intergeracional, a articulação explícita com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, a resiliência climática e a mitigação de impactos ambientais, a economia circular e o uso eficiente de recursos naturais (Figura 4).

Figura 4. Intersecção entre territórios saudáveis e sustentabilidade. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.



Fonte: elaboração própria.

A sustentabilidade contribui para os territórios saudáveis ao fomentar a continuidade do desenvolvimento humano e social, com reflexos diretos na redução de iniquidades em saúde e na integração de práticas estratégicas regionais às políticas públicas. Essa atuação está alicerçada no fortalecimento contínuo da promoção da saúde como via para a melhoria da qualidade de vida das populações (Petersenet al., 2020), na conservação da biodiversidade e no uso sustentável dos recursos naturais, os quais se configuram como requisitos fundamentais para a autodeterminação e o fortalecimento comunitário (Zanjani et al., 2023).

O cuidado ambiental ocupa um espaço prioritário na agenda sustentável, constituindo-se em uma estrutura tridimensional que engloba o autocuidado, o cuidado com o outro e com o planeta. Essa conjunção estabelece um ambiente mais sustentável para todos os atores sociais (Corral-Verdugo; Pato; Torres-Soto, 2021). Esse cuidado abrange práticas de Green Care, desenvolvimento humano e sustentabilidade corporativa. As práticas de Green Care incluem a interação com a natureza para a promoção do bem-estar comunitário e dos ecossistemas, além de envolver processos de aprendizagem, práticas relacionais e a potencialização da sustentabilidade (Moriggi et al., 2020).

O desenvolvimento humano está intrinsecamente associado ao cuidado ecológico, uma vez que contribui para a redução da emissão de gases poluentes e da exposição à poluição atmosférica (Opaku; Dogah; Aluko, 2022). Paralelamente, a sustentabilidade ambiental relaciona-se à sustentabilidade corporativa, na medida em que potencializa o desempenho empresarial nos âmbitos financeiro, organizacional e de crescimento (Gupta; Gupta, 2020).

Em áreas rurais, a sustentabilidade deve articular as dimensões ecológica, social e econômica para superar os desafios da pobreza e das desigualdades na concentração de meios de produção e renda (Roldan; Méndez; Santana, 2023).

A equidade intergeracional visa assegurar a proteção das necessidades das gerações futuras, sem comprometer os recursos e as capacidades ecológicas e econômicas para as gerações subsequentes. Assume, portanto, um compromisso ético com o futuro (Padilla, 2022; Roemer; Suzumura, 2007), promovendo o uso responsável dos recursos ambientais (Spijkers, 2018).

A integração explícita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda 2030 alinha-se à sustentabilidade ao fomentar uma abordagem holística e integrada no enfrentamento dos desafios globais, harmonizando esforços sociais, ambientais e econômicos (Weiland et al., 2021).

Esses compromissos abordam de maneira integrá-los determinantes sociais da saúde, reconhecendo que pobreza, saúde, educação e degradação ambiental estão interligados e, consequentemente, demandam intervenções conjuntas (Bornemann; Weiland, 2021). Sua implementação exige novos modelos de organização, com governança propositiva de transformações sistêmicas, mediante a cooperação entre atores de todos os níveis políticos e da sociedade (Birner; Bornemann; Biermann, 2024).

Dentre as parcerias estratégicas, as universidades e os centros de pesquisa desempenham um papel vital ao promover a formação profissional e a integração ensino-serviço-comunidade, fortalecendo os aspectos econômicos, sociais e o senso de pertencimento (Gallardo-Vásquez; Folgado-Fernández, 2020). Em sua função social, operacionalizam os ODS no ensino, na pesquisa e na extensão, fomentando práticas ambientais sistemáticas e processos qualificados em prol do desenvolvimento sustentável, além de aproximar debates contemporâneos e relevantes entre entidades estatais, não estatais e a comunidade (Fuchs et al., 2023; Oleaga; Fernández; Castillo-Eguskitza, 2020).

Apesar da ampla divulgação, persistem desafios à efetivação dos ODS, tais como a falta de orientações bem delimitadas e direcionadas aos serviços e setores, bem como a necessidade de priorizar uma agenda ambiental de forma transitória e equitativa (Nunes; Lee; O’Riordan, 2016; Elder, 2024).

A resiliência climática e a mitigação de impactos ambientais convergem para a redução das emissões de carbono, a promoção do crescimento verde e o aumento da capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Entre as iniciativas nesse sentido, destacam-se: o financiamento climático para a redução de emissões e o crescimento verde (Lee et al., 2022); construções sustentáveis com soluções energéticas eficientes e infraestruturas resilientes (Behsoodi; Safi; Shirzad, 2024); e práticas agrícolas inovadoras, como os sistemas agroflorestais (Xing et al., 2025).

O uso eficiente dos recursos naturais contribui para a organização do capital natural de um território, consolidando sua resistência a forças externas e impulsionando o desenvolvimento regional (Tolstykh et al., 2020). Trata-se da articulação de políticas de coesão local que direcionem recursos financeiros para a redução de disparidades territoriais e a melhoria do bem-estar econômico coletivo (Romão; Neuts, 2017).

A economia circular desempenha um papel relevante nesse contexto ao reduzir a extração de recursos naturais (Bianchi; Cordella, 2023), minimizar resíduos, emissões poluentes e o consumo de materiais nos processos produtivos (Piscicelli, 2023), além de fomentar a redução, a reutilização e a reciclagem (Khajuria et al., 2022).

Portanto, a sustentabilidade amplia o escopo dos territórios saudáveis, influenciando diretamente sua manutenção e perpetuidade.

CASOS-MODELOS DO CONCEITO “TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS”

Os casos-modelo consistem em descrições fictícias de realidades possíveis que incorporam integralmente os atributos do conceito em estudo. As situações relatadas a seguir articulam qualidade urbana, equidade e participação social a partir de uma perspectiva integrada que conecta mobilidade, saúde, economia e meio ambiente, além de fomentar a participação comunitária, a governança inclusiva e o monitoramento contínuo. Desse modo, evidencia-se que os territórios saudáveis, longe de constituírem meras utopias, representam resultados concretos de escolhas estratégicas e de articulações intersetoriais e comunitárias (Quadro 5).

Quadro 5. Casos-modelo do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

CASO 01 - VILA HARMONIA (SC)

Na serra catarinense, a pequena Vila Harmonia surgiu como resposta à crise habitacional da região. Planejada coletivamente por moradores, arquitetos e o poder público municipal, tornou-se referência nacional em urbanismo participativo. Seu traçado prioriza pedestres e ciclistas, com ruas arborizadas que conectam praças, hortas comunitárias e ecopontos de reciclagem. A mistura de habitações populares e residências de classe média evitou a segregação comum em conjuntos habitacionais. O projeto foi financiado por um sistema cooperativado: famílias de baixa renda contribuíram com mutirões, enquanto a prefeitura forneceu infraestrutura básica. Em Vila Harmonia todas as casas possuem placas solares e sistema de captação de água da chuva. Assembleias mensais decidem sobre manutenção e novos investimentos e feiras de troca e oficinas de reciclagem reduziram o desperdício em torno de 45%.

CASO 02 - SOL NASCENTE (CE)

Na periferia de Fortaleza, o bairro Sol Nascente era sinônimo de abandono com esgoto a céu aberto, escolas depredadas, casas com fachadas pichadas e altos índices de criminalidade. A virada começou com o programa "Meu Bairro Seguro", que uniu moradores, artistas locais e agentes públicos numa transformação radical. As ações do programa incluíram a modificação de antigos pontos de tráfico que deram lugar a praças vivas com quadras, bibliotecas ao ar livre, espaços para prática de exercícios físicos e iluminação em LED. Os postos de saúde do bairro foram integrados a centros de profissionalização juvenil, escolas de ensino integral como espaço de suas práticas e Centros de Referência em Assistência Social para atuação colaborativa. Os grafiteiros transformaram muros pichados em galerias a céu aberto que contavam a história da comunidade e homenageava atores sociais que contribuíram para a mudança do território. As mudanças fomentaram a redução da criminalidade, o aumento do número de crianças participando de atividades extracurriculares e com acesso ao lazer e o surgimento de micro-empresendimentos locais.

CASO 03 - NOVA AURORA (PR)

No Paraná interiorano, Nova Aurora reinventou a relação urbano-rural. Projetada como "cidade-agroecológica", seu zoneamento inovador reserva 30% do território para agricultura familiar, conectada ao centro urbano por corredores verdes. Em Nova Aurora verifica-se inovações na realização de feiras diretas, onde os produtores vendem sem intermediários em mercados municipais; na integração de escolas públicas a ciclos agrícolas, com alimentação estudantil advinda de produções locais; e estabelecimento de uma moeda social para transações locais. Observou-se no território a melhoria da segurança alimentar e a geração de empregos relacionados ao artesanato e ecoturismo.

Fonte: elaboração própria.

CASOS-LIMÍTROFES DO CONCEITO "TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS"

Os casos limítrofes apresentam elementos característicos do construto de territórios saudáveis, embora não consigam reunir todos os seus atributos definidores, representando assim a fronteira conceitual entre o que pode ser considerado como pertencente ao conceito e o que dele se distancia. As situações apresentadas, igualmente fictícias, ilustram realidades que incorporam alguns dos atributos do conceito, porém sem estabelecer entre eles uma articulação harmônica e sistêmica. Essa análise demonstra que a mera existência de proposições isoladas - como governança participativa, intersetorialidade ou economia diversificada - não é suficiente quando tais elementos não interagem de forma sinérgica e complementar (Quadro 6).

Quadro 6. Casos-limítrofes do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025

CASO 01 - HORIZONTES (MT)

Horizontes foi planejada como um modelo de eficiência no coração do Mato Grosso. Financiada por grandes corporações do agronegócio, a cidade oferece infraestrutura impecável: ruas pavimentadas, rede internet sem fio de acesso público, e um sistema de monitoramento por drones que controla tudo, desde a iluminação até a segurança. No entanto, sua governança é totalmente verticalizada – as decisões são tomadas por um conselho de empresários, sem participação popular. A qualidade do espaço urbano é alta para quem vive nos condomínios fechados, mas os trabalhadores rurais moram em assentamentos precários na periferia, sem acesso a transporte digno ou lazer. A economia é hiper-especializada (soja e gado), sem espaço para diversificação. Apesar dos índices de crescimento econômico, a coesão social é frágil – não há praças públicas movimentadas, apenas shoppings cercados por seguranças privados. Horizontes é um exemplo de como inovação tecnológica sem equidade gera exclusão.

CASO 02 - BELOS CAMPOS (SP)

Construído às pressas para reduzir o déficit habitacional, Belos Campos, em São Paulo, é um mar de prédios idênticos, erguidos longe do centro urbano. O programa teve acesso universal – milhares de famílias saíram de favelas para ali –, mas o planejamento foi puramente quantitativo. As ruas são estreitas e mal iluminadas, os postos de saúde ficam a quilômetros de distância, e o único espaço de lazer é um campo de futebol sem grama. A intersetorialidade falhou: as escolas foram construídas anos depois das casas, e não há linhas de ônibus suficientes. Apesar disso, os moradores criaram redes de apoio informal, como feiras comunitárias e um sistema de trocas solidárias, mostrando resiliência. Mas a falta de pertencimento é clara pois muitos ainda se referem ao local como "o canteiro de obras que nunca acabou". Belos Campos é o retrato de como políticas habitacionais massivas podem negligenciar a vida comunitária.

CASO 03 - CANTEIROS (RS)

Projetada nos anos 1970 por um arquiteto modernista, Canteiros, no Rio Grande do Sul, é admirada por suas linhas futuristas e amplas praças. Seus prédios públicos são obras de arte, e o espaço urbano foi pensado para ser esteticamente perfeito. No entanto, a cidade sofre de um mal crônico: não foi feita para pessoas, e sim para fotos de revista. As largas avenidas são ótimas para carros, mas inviáveis para pedestres. O centro administrativo é imponente, mas as zonas residenciais foram relegadas a áreas distantes, criando uma segregação espacial. A economia local estagnou – não há incentivo a pequenos negócios, apenas repartições públicas. Apesar de bela, Canteiros tem baixíssima vitalidade urbana: as praças estão sempre vazias, e os poucos moradores reclamam que a cidade "parece um museu". Aqui, o planejamento estético superou a funcionalidade, gerando uma cidade que é mais cenário que comunidade.

Fonte: elaboração própria.

CASOS-CONTRÁRIOS DO CONCEITO "TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS"

os casos-contrários representam situações diametralmente opostas ao conceito de territórios saudáveis, caracterizando-se pela ausência total de seus atributos fundamentais. As narrativas fictícias aqui apresentadas ilustram configurações sociais que não apenas divergem do referido conceito, mas incorporam padrões antagônicos, tais como: a primazia absoluta do lucro sobre o bem-estar coletivo, estruturas de governança autoritárias, completa fragmentação setorial e a institucionalização de desigualdades sociais por meio de projetos políticos deliberados (Quadro 7).

Quadro 7. Casos-contrários do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025

CASO 01 - CRETÓPOLIS (RJ)
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, Concretópolis é o retrato do urbanismo que privilegia o automóvel em detrimento da vida humana. Projetada ao final de 1980 para ser uma cidade moderna, seu traçado é um labirinto de vias expressas, viadutos e condomínios fechados. Aqui, a qualidade do espaço urbano é medida em metros de asfalto – as poucas áreas verdes são cercadas e vigiadas, inacessíveis à maioria da população. Enquanto os bairros nobres têm ruas pavimentadas e coleta seletiva, as periferias sofrem com esgoto a céu aberto e iluminação pública precária. A governança é centralizada nas mãos de um cartel de empreiteiras e políticos, sem qualquer mecanismo de participação popular. A secretaria de transporte não dialoga com a de meio ambiente, resultando em obras que pioram enchentes e congestionamentos. A saúde é negligenciada – não há ciclovias, quadras ou parques, e os postos de saúde estão sempre lotados. A economia depende de um único polo industrial, que demite em massa em crises. O pertencimento é inexistente; ninguém se identifica com a cidade, apenas com seu condomínio. O planejamento urbano é excludente com favelas ignoradas até serem removidas à força para dar lugar a shoppings. O único monitoramento é feito por câmeras de vigilância. O resultado é uma cidade hostil, onde o bem-estar é privilégio de poucos.
CASO 02 - VALE SECO (BA)
No sertão baiano, Vale Seco foi erguida às pressas para abrigar trabalhadores de um projeto de mineração que faliu. A qualidade urbana é pífia com ruas sem calçamento, praças abandonadas e um centro comercial fantasma. Os executivos da mineradora viviam em um enclave com piscina e heliporto, enquanto os operários se amontoavam em barracos de madeira. As decisões são tomadas em gabinetes fechados, com licitações fraudadas. A intersetorialidade é sabotada por disputas políticas. A secretaria de educação culpa a de infraestrutura pelas escolas alagadas, e nada muda. O hospital mais próximo fica a 80 km, e a única UBS não tem médicos. A economia entrou em colapso com o fim da mineração. Não há políticas de diversificação – apenas subempregos no comércio precário. O pertencimento se resume à nostalgia dos tempos em que a mineração dava lucros. O planejamento foi tão ausente que a cidade cresceu sem saneamento, e hoje sofre com epidemias de dengue. Inovação é uma palavra desconhecida; até o Wi-Fi público é bloqueado para evitar protestos.
CASO 03 - VILA ELITE (PE)
Vila Elite é o paraíso artificial dos 1%. Planejada para ser uma referência no turismo, sua beleza esconde uma divisão socioespacial. A qualidade urbana existe apenas nos cartões-postais. Orlas impecáveis, enquanto o morro ao fundo não tem água encanada. Os trabalhadores do setor hoteleiro moram em favelas sem transporte digno. As leis urbanas são alteradas para beneficiar resorts e empreendimentos de luxo, sem consulta pública. A secretaria de turismo ignora os impactos ambientais da especulação imobiliária. Hospitais privados para ricos, e postos de saúde sem remédios para os pobres. A economia gira em torno do turismo predatório, com empregos informais e sem direitos trabalhistas. Os ricos se veem como cidadãos do mundo, os pobres como invasores. O planejamento é deliberadamente excludente – as favelas são consideradas manchas visuais a serem removidas. A única inovação são os drones de segurança que patrulham as praias particulares.

Fonte: elaboração própria.

REFERÊNCIAS EMPÍRICAS DO CONCEITO “TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS”

As referências empíricas constituem elementos fundamentais para a verificação concreta dos atributos de um conceito teórico. Nessa perspectiva, tais referências podem ser operacionalizadas como indicadores mensuráveis, os quais permitem não apenas constatar a presença desses atributos, mas também viabilizar seu monitoramento sistemático e a realização de comparações válidas entre diferentes contextos geográficos e temporais.

Quadro 8. Referências empíricas do conceito territórios saudáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025

ATRIBUTOS	REFERÊNCIAS EMPÍRICAS
Qualidade do espaço urbano	• Percentual de áreas verdes por habitante (OMS recomenda $\geq 12\text{m}^2/\text{hab.}$) • Existência de calçadas acessíveis, ciclovias e mobilidade urbana adequada • Níveis de poluição do ar (média anual de partículas poluentes no ar com menos de 2,5 micrômetros de diâmetro abaixo de $10\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$) • Proporção de ruas com arborização $\geq 50\%$
Equidade e acesso universal	• Índice de Gini territorial (desigualdade socioespacial) • Cobertura universal de água potável e saneamento • Acessibilidade a serviços de saúde e educação em raio de 1 km • Índice de Acessibilidade a Transporte Público
Governança participativa	• Existência de conselhos locais com poder deliberativo • Taxa de participação em consultas públicas • Número de audiências públicas por ano para debate de políticas locais propostas por cidadãos
Intersetorialidade	• Número de políticas públicas com ações integradas • Existência de comitês intersetoriais com metas compartilhadas • % do orçamento municipal alocado a projetos multi-setoriais
Promoção da saúde	• Redução de doenças crônicas ligadas ao ambiente • Número de ações de prevenção desenvolvidas no território • Proporção de ações de atenção à saúde por ciclo de vida • Cobertura da Estratégia Saúde da Família
Economia inclusiva e diversificada	• Percentual de emprego formal e informal em setores diversificados (agricultura, tecnologia, serviços) • Número de cooperativas e negócios locais por 1.000 habitantes • % da população em economia solidária
Pertencimento e coesão social	• Taxa de voluntariado em projetos comunitários • Nível de confiança nos vizinhos

ATRIBUTOS	REFERÊNCIAS EMPÍRICAS
Planejamento urbano inclusivo	• Percentual de moradias acessíveis para pessoas com necessidades específicas e idosos. • Existência de planos diretor com metas para populações vulneráveis. • % de calçadas adaptadas
Inovação e monitoramento contínuo	• Existência de planos diretor com metas para populações vulneráveis. • Existência de planos diretor com metas para populações vulneráveis. • Frequência de atualização de indicadores
Qualidade de vida e bem-estar integral	• Índice de Felicidade Local • Expectativa de vida livre de incapacidades • Nível de satisfação com a vida da população

Fonte: elaboração própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise conceitual permitiu delimitar territórios saudáveis como espaços geográficos e sociais nos quais a produção da vida emerge da interação dialética entre sociedade e natureza, mediada por uma abordagem integral da saúde como eixo estruturante da qualidade de vida e do bem-estar coletivo. Nesse sentido, foram elucidados cinco domínios de antecedentes que fundamentam o desenvolvimento de territórios saudáveis, dez domínios de atributos que caracterizam o conceito — contemplando a qualidade do espaço urbano, a equidade e o acesso universal, a governança participativa, a intersetorialidade, a promoção da saúde, a economia inclusiva e diversificada, o pertencimento e a coesão social, o planejamento urbano inclusivo, a inovação e o monitoramento contínuo, e a qualidade de vida e o bem-estar integral —, além de oito domínios de consequentes, que materializam os resultados e impactos desses territórios, apresentando-se como produtos comuns a eles.

A elucidação dos constituintes dos territórios saudáveis aponta para uma padronização de seu uso como fundamento de políticas públicas, ações, projetos e programas voltados à instituição de melhores condições de vida e saúde para a população. Considerando sua polissemia, complexidade e influências históricas, econômicas, políticas e sociais, recomenda-se a escuta de atores sociais de diferentes áreas para agregar evidências de validade à sua proposição, assim como sua aplicação em proposições e documentos oficiais regulamentadores, de modo a impulsionar sua adoção padronizada. Além disso, destaca-se a relevância de operacionalizar outros estudos que ampliem a produção de evidências científicas sobre o tema, incluindo o desenvolvimento de instrumentos de medida do construto e seus domínios, propostas andragógicas de educação permanente em saúde para fortalecer sua aplicação por profissionais e a interlocução com políticas públicas de outros setores com forte determinação social, como assistência social e educação.

Embora este estudo ofereça subsídios importantes para ampliar o debate sobre territórios saudáveis e reconheça as potencialidades dessa análise, é preciso considerar suas limitações, mesmo diante dos esforços metodológicos mobilizados. Entre elas, destacam-se a análise exclusiva de documentos disponíveis online, o que pode ter excluído iniciativas locais não publicizadas ou documentadas apenas em meios físicos, e a ausência de um recorte temporal, que limita a focalização em tendências contemporâneas e a abrangência do panorama traçado. Por fim, por se tratar de uma revisão de escopo, os achados contribuem principalmente para instigar reflexões, debates e a elaboração de hipóteses para a prática profissional, sem oferecer recomendações específicas sobre eficiência, eficácia, efetividade, custo-benefício ou qualidade das possibilidades apresentadas.

REFERÊNCIAS

- ABADÍA-BARRERO, C.E.; MARTÍNEZ-PARRA, A.G. Care and consumption: A Latin Americansocial medicine’s conceptual framework to comprehend oral health inequalities. *Global Public Health*. v.12, n.10, p.1228-1241, 2017.
- ADETUNJI, A.; SILVA, M.; TULSIANI, N.J.;ADEDIRA, M. “Like a broom tied together”: A qualitative exploration of social cohesion and its role in community capacity strengthening to support integrated health in Nigeria.*PLOS Glob Public Health*. v.3, n.10, 2023.
- ADRIANO, J.R.; WERNECK, G.A.F.;SANTOS, M.A.; SOUZA,R.C. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida? *Cien. Saúde Coletiva*. v.5, n.1, 53-62, 2000.
- ALLOTEY, P.; VERGHIS, S.; ALVAREZ-CASTILLO, F.; REIDPATH, D.D. Vulnerability, equity and universal coverage – a concept note. *BMC Public Health*. v.12, 2012.
- ALVES, H.; SOARES, M.R.P.;COSTA, R.R.S.; CRUZ, S.S.; SCHOTTZ,V. Territórios rurais contra a Covid-19:saberes, fazeres e reflexões por meio da Educação Popular em Saúde. *Interface (Botucatu)*. 26:e210724, 2022.
- ANANICHEVA, E.P.; PAYTAEVA, K.; GOLOSHCHAPOVA, L.V. The impact of regional economic policy on the development and growth of territories. *Ekonomika – Upravlenie problemy resheniya*. v.12, n.153, p.65-70, 2024.
- ANTUNES JUNIOR, W.F.; BORSATTO, R.S.; SOUZA-ESQUERDO, V.F. Why is it so difficult to promote territorial development through public policies? The obstacles faced by a Brazilian experience. *World Development Perspectives*. v.24, 100367, 2021.
- AWOFESO, N. The Healthy Cities approach - reflections on a framework for improving global health.*Bull World Health Organ*. v.81, n.3, p.222-3,2003.
- BEHSOODI, M.M.;SAFI, H.U.; SHIRZAD,W. Sustainable Construction Practices for Climate Change Mitigation and Adaptation: A Review. *Nangarhar University International Journalof Biosciences*. 2024:ICC(Special Issue), 2024.
- BENESSAIAH, K.; CHAN, K.M. Why reconnect to nature in times of crisis? Ecosystem contributions to the resilience and well-being of people going back to the land in Greece. *People and Nature*. v.5, n.6, p.2026-47, 2023.

BEZRUKOVA,T.L.; GYIAZOV,A.T.; KUKSOVA,I.V. Socio-ecologicaland economic efficiency of the territories of forestry. IOP Conf.Ser.: Earth Environ.Sci. 595, 2020.

BHATT, B.; QURESHI, I.; SHUKLA, D.M.; HOTA, P.K. Prefiguring Alternative Organizing: Confronting marginalization through projective culturaladjustment and tempered autonomy. Organization Studies. v.45, n.1, 2023.

BIANCHI, M.; CORDELLA, M. Does circular economy mitigate the extraction of natural resources? Empiricalevidence based on analysis of 28 Europeaneconomies over the past decade. Ecological Economics. v.203, 2023.

BIRNER, J.; NORNEMANN, B.; BIERMANN, F. Policy integration through the Sustainable Development Goals? The case of the German Federal Government. Sustainable Development. v.32, n.4, 2024.

BITTENCOURT, M.S. Health promotion: A step beyond prevention in cardiology. American Heart Journal. v.198,p.178-179, 2018.

BLACK, K.; HYER, K. Evaluating collective impact for healthy aging at the intersection of public health and age-friendly communities. Innovationin aging. v.4, Sup.1, p.698-699, 2020.

BLANDÓN-LOTERO, L.C.; JARAMILLO-MEJÍA, M.C. Communities on the move: community participation in health in rural territories of Buenaventura District in Colombia. International Journal for Equity in Health. v.19, n.129, 2020.

BLIEVA, A.K. The impact of sustainable development of territories on the economyof agriculture and the agro-industrial complex. Research of economic and financial problems. n.4, 2023.

BORNEMANN, B.; WEILAND, S. The UN 2030 Agendaand the Questfor Policy Integration: A Literature Review. Politics and Governance. v.9, n.1, 2021.

BOTCHWAY, E.A.; AGYEKUM, K.; KOTEI-MARTIN,J.N.; PITTRI, H.; DOMPEY, A.M.A.; AFRAM, S.O.; ASARE, N.E. Achieving Healthy City Development in Ghana: Referencing Sustainable Development Goal 11. Sustainability. v.15, n.19, 2023.

BRITO, P.N.A.; SANTANA, E.L.P.; MORAES, O.A.; SILVA, J.C.; CRUZ, P.J.S. O que se tem discutido sobre Educação Popularem Saúde nos últimos anos: uma revisão narrativa da literatura. Cien Saude Colet. 29:e12542023, 2024.

BRUNETTA, G.; CERAVALLO, R.; BARBIERI, C.A.; BORGHINI, A.; CARLO, F.; ELA, A. et al. Territorial Resilience: Toward a Proactive Meaning for Spatial Planning. *Sustainability*, v.11, n.8, 2019.

BURGOS, C.A.P.;QUINTERO, R.E.P.; GRACIA-SORIANO, P. Exploring the (re)construction of healthy destinations in the Mediterranean. In: *Health, Wellbeing and Sustainability in the Mediterranean City*. 1ª ed., Routledge, 2019.

BUSS, P.M.; HARTZ, Z.M.A.;PINTO, L.F.; ROCHA,C.M.F. Promoção da saúde e qualidade de vida: uma perspectiva histórica ao longo dos últimos 40 anos (1980-2020). *Cien. Saude Coletiva*. v.25, n.12, p.4723-35, 2020.

CAICEDO, Y.L.;SANTAMARIA, R.O.M.; Villanueva, G.A.; Gonzáles, L.N.Z.;Díaz, W.D.L.; Gonzales, I.B.P.et al. Urban planning effective ness and citizen satisfaction. A systematic literature review. *F1000Research*. 2024.

CAMPOS-MATOS, I.; STANNARD, J.; SOUSA, E.; O’CONNOR, R.; NEWTON, J.N. From health for all to leaving no-onebehind: public healtha gencies, inclusion health, and health inequalities. *The Lancet Public Health*. v.4, n.12, 2019.

CARDOSO, A.F.; COSTA, V.A.M.; SILVA, C.A. A importância do território em ações de vigilância em saúde. *Revista Cerrados*. v.18, n.2, 2020.

ÇETIN, Z.O. Healthycities and municipaladministrations in Türkiye:the case of Denizli Metropolitan Municipality. *Humanities and Social Sciences Communications*. v11, 2024.

CHAMUSCA, P. Public policiesfor territorial cohesionand sustainability in Europe: an overview. *Sustainability*. v.15, 2023.

CHÁVEZ, B.M. Limitantes de la estrategia de municipios saludables como política pública en Antioquia. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*. v.27, n.3, p.264-270, 2009.

COLE, H.; SHOKRY, G.; CONNOLLY, J.J.T.; PÉREZ-DEL-PUGAR, C.; ALONSO, J.; ANGUELOVSKI,I. Can Healthy Cities be made really healthy? *Lancet Public Health*. v.2, n.9, e394-e395, 2017.

CORRAL-VERDUGO, V.; PATO, C.; TORRES-SOTO, N. Testing a tridimensional model of sustainable behavior: self-care, caring for others,and caring for the planet. *Environment, Development and Sustainability*. v.23, p.12867-92, 2021.

DANSOU, H.D.; CARRIER, M. Decentralization, institutional innovation and governance of inter-territorial relations: A view from Benin. *Cities*. v.133, 2023.

DAVIS, S.F.; DAVIES, M. Understanding the Effects of Social Cohesion on Social Wellbeing: A Scoping Review. *Int J Public Health*. v.70, 2025.

DELGADILLO, E.; REYES, T.; BAUMGARTNER, R.J. Towards territorial product-service systems: A framework linking resources, networks and value creation. *Sustainable Production and Consumption*. v.28, p.1297-1313, 2021.

DIAS, M.S.A.; PARENTE, J.R.F.; VASCONCELOS, M.I.O.; DIAS, F.A.C. Intersetorialidade e Estratégia Saúde da Família: tudo ou quase nada a ver? *Cien. Saúde Coletiva*. v.19, n.11, p.4371-82, 2014.

DOMINGUES, L.C.S.M.; SILVA, G.A.; RAVERA, C.B. Promoção de territórios saudáveis: assessoria técnica à habitação social no Setor 1 da Colônia Juliano Moreira. *Saúde em debate*. v.48, n. esp. 1, 2024.

DOORIS, M.; HERITAGE, Z. Healthy Cities: facilitating the active participation and empowerment of local people. *J Urban Health*. v.90, supl.1, p.74-91, 2013.

ELDER, M. Integration versus prioritization in the Sustainable Development Goals: An argument to prioritize environmental sustainability and a just transition. *Sustainable Development*. v.33, n.1, p.465-477, 2024.

ELIAKIMU, E.S.; MANS, L. Addressing Inequalities Toward Inclusive Governance for Achieving One Health: A Rapid Review. *Front. Public Health*. v.9, 2022.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Territorial approaches and community development to drive local change and prevent all forms of malnutrition. 2021.

FERNANDO, M.L.C.; LI, Y.; SYN, J.C.K.; MEDAAN, H.M.A.A.; ISHIMINE, A.; TUDEV, B. et al. AFHC Report 2008. The Alliance For Healthy Cities. 2008

FERRAZ, S.T. A pertinência da adoção da filosofia de cidades saudáveis no Brasil. *Saúde em Debate*. Nº 41, 1993.

FISHER, M.; HARRIS, P.; FREEMAN, T.; MACKEAN, T.; GEOGRE, E.; FRIEL, S.; BAUM, F. Implementing Universal and Targeted Policies for Health Equity: Lessons From Australia. *Int J Health Policy Manag*. v.11, n.10, 2022.

FITRY, I.N.;PALUTTURI, S.; THAHA,R.M.; SYAM, A. Impact Evaluation of Healthy City Implementation in Makassar City.Open Access Maced J Med Sci.v.8, T2, pag. 12-5, 2020.

FORTUNE, K.; BECERRA-POSADA, F.; BUSS, P.; GALVÃO, L.A.C.; CONTRERAS, A.; MURPHY, M. et al. Health promotion and the agenda for sustainable development, WHO Region of the Americas. Bull World Health Organ. v.96, p.621-6, 2018.

FREIRE, M.S.M.; SALLES, R.P.S.; SÁ, R.M.P.F. Mapeando iniciativas territoriais saudáveis, suas características e evidências de efetividade. Cienc. Saude Coletiva. v.21, n.6, p.1757-66, 2016.

FRY, A.; CLIFFORD-HOLMES, J.; PALMER, C. A systemic analysis of participatory land and water governance in the TsitsaRiver Catchment, South Africa. Syst Res Behav Sci. v.41, p.771-87, 2024.

FUCHS, P.G.;FINATTO, C.P.; BIRCH,R.S.; DUTRA, A.R.A.;GUERRA, J.B.S.O.A. Sustainable Development Goals (SDGs) in Latin-American Universities. Sustainability. v.15, 8556, 2023.

GADELHA, P.; AMEIXA, V. Territórios Sustentáveis e Saudáveis no SUS: a relação intrínseca com a Agenda 2030. Saúde debate. v.48, Esp.1., 2024.

GALINDO, E.F.; FURTADO, M.F.R.G. A intersectorialidade como requisito para construção de uma cidade saudável: política de saneamento e de saúde no Recife (gestão 2001/2004) : estudo de caso. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

GALLARDO, M.P.S. Intersetorialidade, a chave para enfrentar as Desigualdades Sociais em Saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 27:e3124, 2019.

GALLARDO-VÁSQUEZ, D.; FOLGADO-FERNÁNDEZ, J.A. Regional Economic Sustainability: Universities' Role in Their Territories. Land. v.9, n.4, 2020.

GALLO, E.; SETTI, A.F.F. Abordagens ecossistêmica e comunicativa na implantação de Agendas territorializadas de desenvolvimento sustentável e promoção da saúde. Cien. Saúde Coletiva, v.17, n.6, p.1433-46, 2012.

GARZÓN-ORJUELA, N.; SAMACÁ-SAMACÁ, D.F.; ÂNGULO, S.C.L.; ABDALA, C.V.M.; REVEIZ, L.; ESLAVA-SCHMALBACH, J. An overview of reviews on strategies to reduce healthinequalities. International Journal for Equityin Health. 2020.

GRANT, M. European HealthyCity Network Phase V: patternsemerging for healthy urban planning. *Health Promot Int.* Sup.1, p.54-70, 2015.

GRANT, M.; SIRI, J.; GATZWEILER, F.; DORA, C.; AERTS, J.; NADUDU, S. et al. Supporting a Healthy Planet, Healthy People and Health Equitythrough Urban and Territorial Planning. *Planning Practice & Research.* v.37, n.1, 2022.

GOMES, G.M.R.B.; BERETTA, R.C.S. A educação popular em saúde na articulação com a promoção da saúde: revisão integrativa. *Psicologia e saúde em debate.* v.10, n.1, 2024.

GOSTIN, L.O. The Legal Determinants of Health: How Can We Achieve Universal Health Coverageand What Does it Mean? *Int J Health Policy Manag.* v.10, n.1, p.1-4, 2021.

GRACIANO, A.M.C.;CARDOSO, N.M.M.; TEIXEIRA,S.A.; MATTOS, F.F.; GOMES, V.E.;BORGES-OLIVEIRA, A.C. Healthpromotion in Brazil: qualitative survey with primary school teachers. *Health Promot Int.* v.34, n.5, p.28-35, 2019.

GUPTA, A.K.; GUPTA, N. Effect of corporate environmental sustainability on dimensions of firm performance – Towards sustainable development: Evidence from India. *Journal of Cleaner Production.* v.253, 2020.

HANCOCK, T. Towards healthyOne Planet citiesand communities: planetary health promotion at the local level. *Health Promot Int.* v.36, n. Sup.1, p.i53-i63, 2021.

HARVEY, M.; PIÑONES-RIVERA, C.; HOLMES, S.M. Structural competency, Latin American social medicine, and collective health: Exploring shared lessons through the work of Jaime Breilh. *Glob Public Health.* v.18, n.1, 2023.

HAYES, A.; FREESTONE, M.; DAY, J.; DALTON, H.; PERKINS, D. Collective Impact Approaches to Promoting Community Health and Wellbeing in a Regional Township: Learnings for Integrated Care.*International Journalof Integrated Care.* v.21, n.2, 1-4, 2021.

HUANG, H.; HUANG, S.; HE, S.; LU, Y.; DENG, S. Healthy city evaluation based on factor analysis-Taking citiesin the Guangxi Zhuang Autonomous Region as an example. *Plos One.* 2024.

IAMTRAKUL, P.; CHAYPHONG, S. Factors affecting the development of a healthy city in Suburban areas,Thailand. Factors affecting the development of a healthycity in Suburban areas, Thailand. *Journal of Urban Management.* v.12, n.3, 2023.

IHLEBÆK, C.; ÅNESTAD, R.; NORDBØ, E.C.A. Bridging discourses on health promotion and social sustainability towards healthy community development. *Scandinavian Journal of Public Health*. v.53, Sup.1, p.16-23, 2025.

ISTÚRIZ, O.F. *Social Medicine and Collective Health. Monthly review*. v.75, n.8, 2024.

JEANNERAT, H.; CREVOISIER, O. From competitiveness to territorial value: transformative territorial innovation policies and anchoring milieus. *European Planning Studies*. v.30, n.11, 2022.

KAMPER-JORGENSEN, F. Editorial: the healthy city. *Scand J Public Health*. v.38, n.2, p.113-4, 2010.

KATO, K.Y.M.; DELGADO, N.G.; ROMANO, J.O. Territorial Approach and Rural Development Challenges: Governance, State and Territorial Markets. *Sustainability*. v.14, n.12, 2022.

KEGLER, M.; NORTON, B.L.; ARONSON, R. Achieving organizational change: findings from case studies of 20 California healthy cities and communities coalitions. *Health Promot Int*. v.32, n.2, p.109-18, 2008.

KEINERT, T.M.M. Planejamento governamental e políticas públicas: a estratégia “cidades saudáveis”. *Saúde Sociedade*. v.6, n.2, p.55-64, 1997.

KHAJURIA, A.; ATIENZA, V.A.; CHAVANICH, S.; HENNING, W.; ISLAM, I.; KRAL, U. et al. Accelerating circular economy solutions to achieve the 2030 agenda for sustainable development goals. *Circular Economy*. v.1, n.1, 2022.

KIEFFER, E. The strength of partnerships in emergency response and resilience: findings from the voices of new yorkers. *Innovation in Aging*. v.8, Sup.1, 2024.

KLEDGER, M.C.; NORTON, B.L.; ARONSON, R.E. Strengthening Community Leadership: Evaluation Findings from the California Healthy Cities and Communities Program. *Health Promotion Practice*. v.9, n.2, p.170-179, 2008.

KNOBEL, P.; MANEHA, R.; BARTOLL, X.; ALONSO, L.; BAUWELINCK, M.; VALENTIN, A. et al. Quality of urban green spaces influences residents' use of these spaces, physical activity, and overweight/obesity. *Environmental Pollution*. v.271, 2021.

KONDO, M.C.; FLUEHR, J.M.; MCKEON, T.; BRANAS, C.C. Urban Green Space and Its Impact on Human Health. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. v.15, n.3, 2018.

KULYK, A. Resilience of territorial communities as a factor in strengthening national security. *Dnipro Academy of Continuing Education Herald*, Series: "Public Management and Administration". v.2, n.2, 2024.

LARA, J.E.H.; LEÓN, A.D.; DASER, D.; DOERING-WHITE, J.; FRANK-VITALE, A. Towards a social determination of health framework for understanding climate disruption and health-disease processes. *Med. Antropol. Q.* v.38, p.313–327, 2024.

LAUREANO-EUGENIO, J.; GÓMEZ-RODRÍGUEZ, R.O.; TASEJO-CORZANTES, J.; RAMÍREZ, A.S.; AGUILAR, R.M.P.; ALCALDE-RABANAL, J.E. Sustainability of the Healthy Municipalities Strategy in Guatemala. *Rev Panam Salud Publica*. v.45, 2021.

LEE, C.; LI, X.; YU, C.; ZHAO, J. The contribution of climate finance toward environmental sustainability: New global evidence. *Energy Economics*. v.111, 2022.

LEE, M.; PARK, S.; YOON, K. Does Health Promotion Program Affect Local Resident's Emotions? *Int J Environ Res Public Health*. v.16, n.4, 2019.

LEE, P.R.; FUCCILLO, R.; WOLFF, T.J. Key components of a statewide Healthy Communities effort. *Public Health Rep.* v.115, n.2-3, p.134-8, 2000.

LEEuw, E.; GREEN, G.; SPANSWICK, L.; PALMER, N. Policymaking in European healthy cities. *Health Promot Int.* sup. 1, p.i18-i31, 2015.

LEEuw, E.; KICKBUSCH, I.; PALMER, N.; SPANSWICK, L. European Healthy Cities come to terms with health network Governance. *Health Promot Int.* v.30, Suppl 1, p.32-44, 2015.

LI, H.; GUO, J.; PAN, C.; WU, J.; LIU, X. The EWM-Based Evaluation of Healthy City Construction Levels in East China under the Concept of "Making Improvements Is More Important Than Reaching Standards". *Sustainability*. v.16, n.10, 2024.

LIM, N.H.H.; HASNAN, L.; ABIDIN, N.Z.; CHOWDHURY, S.; JALIL, N.A.S.A.; HASSAN, L.S. Exploring the relationship between the perceived importance of healthy city indicators and satisfaction levels towards the local government in shaping a healthy city. *Planning Malaysia*. v.21, n.29, 2023.

LIMA, F.A.;LIMA, S.C. Construindo cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do Planejamento Estratégico Situacional. Saúde Soc. v.29, n.2, 2020.

LIPIANINA-HONCHARENKO, K. Methods for analyzing socio-economic data of territorial communities for adaptive resource management. International Scientific Journal Computer Systems and Information Technologies. n.3, 2024.

LIU, X. Countermeasures to promote sustainable construction and coordinated development of healthy cities:a case study of DandongCity. Energy Informatics. v.7, n.60, 2024.

LIU, Y.; THENG, Y.L. Development of Synthetic HealthRecords to SupportUrban Planning for Healthy Aging. Innovation in Aging. v.4, sup.1, 2020.

LLORCA, E.; AMOR, M.T.; MERINO, B.; MÁRQUEZ, F.J.; GÓMEZ, F.; RAMÍREZ, R. Ciudades saludables: una estrategia de referencia en las políticaslocales de salud pública. Gac Sanit. v.24, n.6, 435-436, 2010.

LOUISEAU, E.; JUNQUA, G.; ROUX, P.; BELLON-MAUREL, V.B. Environmental assessmentof a territory: An overviewof existing tools and methods.Journal of Environmental Management. v.112, p.213-225, 2012.

LUO J.; CHAN, E.; DU, J.; FENG, L.; JIANG, P.; XU, Y.Developing a Health-Spatial Indicator System for a HealthyCity in Small and MidsizedCities. Int. J. Environ.Res. Public Health. v.19, n.6, 2022.

LV, Z.; GUO, H.; ZHANG, L.; LIANG, D. Comparative Study on the Evaluation of HealthyCity Construction in Typical ChineseCities Based on Statistical Data and Land Use Data. Sustainability, v.14, n.5, 2022.

LY, E.H.;SMARD, P.; O'NEILL,M. Research into the applicability of the healthycities movement in Dakar district (Senegal): Methodology and results. Environment & Urbanization. v.10, n.2, 1998.

MACHADO, G.C.X.M.P.; MACIEL,T.M.F.B.; THIOLLENT,M. Uma abordagem Integral para Saneamento Ecológico em Comunidades Tradicionais e Rurais. Cien. Saude Colet. v.26, n.4, p.1333-1344, 2021.

MACHADO, J.M.H.; MARTINS, W.J.; SOUZA, M.S.; FENNER, A.L.; MACHADO, A.A. Territórios saudáveis e sustentáveis: contribuição para saúde coletiva, desenvolvimento sustentável e governança territorial. *Com. Ciências Saúde*. v.28, n.2, p.243-249, 2017.

MACHADO, L.D.S. Competências em promoção da saúde: desenvolvimento e análise das evidências de validade de um instrumento de mensuração. Tese (doutorado acadêmico) – Universidade estadual do Ceará, Programa de Pós-graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde – Doutorado, Fortaleza, 2023.

MANDANIPOUR, A.; SHUCKSMITH, M.; BROOKS, E. The concept of spatial justice and the European Union's territorial cohesion. *European Planning Studies*. v.30, 2022.

MARTINI, E.; SERLUCA, M.C. Possible trajectories of institutional policy for local development. *Economy and sociology*. n.1, 2024.

MARTYNOVYCH, N. O. From result to efficiency: socio-economic context of development of territories of priority development. *Ekohomika*. n.4, 2022.

MARZO, P. Supporting political debate while building patterns of trust: the role of the German political foundations in Tunisia (1989–2017). *Middle Eastern Studies*. v.55, n.4, p.621-637, 2019.

MATIAS, J.L.N.; JEREISSATI, L.C. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. *Rev. Dir. Cid.* v.14, n.1, p.643-672, 2022.

MAXWELL, A.; MAHUIKA, I.; EDMONDS, E. Collective Action with Communities - Elevating whānau (family) voice within localities as part of the Pae Ora (Healthy Futures) reforms. *International Journal of Integrated Care*. v.23, Sup.1:698, 2023.

MEAD, R.; PICKIN, C.; POPAY, J. Policies for Social and Health Equity: The Case for Equity Sensitive Universalism. *Int J Health Policy Manag.* v.11, n.12, 2022.

MENESES, M.N.; QUADROS, J.D.; MARQUES, G.P.; NORA, C.R.D.; CARNEIRO, F.F.; ROCHA, C.M.F. Práticas de vigilância popular em saúde no Brasil: revisão de escopo. *Cien. Saude Coletiva*. v.28, n.9, p.2553-2564, 2023.

MONDAL, S.; BELLE, S.V.; MAIONI, A. Learning from intersectoral action beyond health: a meta-narrative review. *Health Policy Plan.* V.36, n.4, p.552-571, 2021.

MONKEN, M. Território e saúde: apontamentos conceituais para a proposta de territórios sustentáveis e saudáveis. *Saúde em Debate*. v. 48, n. 1, e8721, 2024.

MORATIDIS, K. Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective well-being. *Cities*. v.115, 2021.

MORIGGI, A.; SOINI, K.; BOCK, B.B.; ROEP, D. Caring in, for, and with Nature: An Integrative Framework to Understand Green Care Practices. *Sustainability*, v.12, n.8, 2020.

MOURA, R.A.; FERREIRA, K.P.M. Cidadesaudável: o diagnóstico do território urbano por meio dos determinantes sociais de saúde: o caso Maracanaú. *Saúde e Pesquisa*. v.14, n.1, p.201-211. 2021.

MUNDLER, P.; LAUGHREA, S. The contributions of short food supply chains to territorial development: A study of three Quebec territories. *Journal of Rural Studies*. v.45, p.218-229, 2016.

NASCIMENTO, P.R.; WESTPHAL, M.F.; MOREIRA, R.S.; BALTAR, V.T.; MOYSÉS, S.T.; ZIONI, F. et al. Impact of the Social Agendas – Agenda 21 and Healthy Cities – upon Social Determinants of Health in Brazilian municipalities: measuring the effects of diffuse social policies through the dimensions of the Millennium Development Goals. *Rev. Bras Epidemiol. Suppl DSS*, p.1-14, 2014.

NIEMEYER, C.B.; LARA, P.C.; XAVIER, J.B.; AZEVEDO, L.O. 'O povo cuidando do povo': Agentes Populares na promoção de territórios mais sustentáveis e saudáveis. *Saúde debate*. v.48, n. esp.1, e8739, 2024.

NILSSON, D.; SVENSSON, I. Pushing the doors open: Nonviolent action and inclusion in peace negotiations. *Journal of Peace Research*. v.60, n.1, 2023.

NICKEL, S.; KNESEBECK, O. Do multiple community-based interventions on health promotion tackle health inequalities? *International Journal for Equity in Health*. v.19, 2020.

NUNES, A.R.; LEE, K.; O'RIORDAN, T. The importance of an integrating framework for achieving the Sustainable Development Goals: the example of health and well-being. *BMJ Global Health*. v.1, n.3, 2016.

O'HARA, L.; TAYLOR, J.; BARNES, M. The invisibilization of health promotion in Australian public health initiatives. *Health Promotion International*. v.33, n.1, 2018.

- OLEAGA, E.S.C.; FERNANDEZ, I.F.; CASTILLO-EGUSKITZA, N. A Holistic Approach to Integrate and Evaluate Sustainable Development in Higher Education. The case study of the University of the Basque Country. [Preprint]. 2020. Doi: 10.20944/preprints202012.0417.v1
- OPOKU, E.E.O.; DOGAH, K.E.; ALUKO, O.A. The contribution of human development towards environmental Sustainability. *Energy Economics*. v.106, 2022.
- PADILLA, E. Intergenerational equity and Sustainability. *Ecological Economics*. v.41, n.1, p.69-83, 2002.
- PALM, J.L.; PORTO, M.F.; FASANELLO, M.T.; ROCHA, D.F.; SOUZA, J.; SANTOS, A.P.C.; SANTOS, R.C.F. Agroecology and food sovereignty: Struggles for justice and healthy food in urban peripheral territories. *Saúde Debate*. v.48, n. especial 1, e8576, 2024.
- PENAFORTE, T.R. A abordagem territorial nos Territórios Sustentáveis e Saudáveis: um alargamento conceitual a partir da antropologia. *Saúde debate*. v.48, n. esp.1, e8726, 2024.
- PEREIRA, S.C.; SIMÕES, D.G.; DURÃO, J.; MARTINHO, J.; ALHO, M.; FERREIRA, P.P. et al. Health and quality of life development plan: from theory to practice. *European Journal of Public Health*. v.33, Sup.2, 2023.
- PÉREZ, Y.B.F.; PERALTA, C.A.B. Modelo de comunidad saludable en el sector Vista Alegre, La Libertad. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Social. Universidad Nacional de Trujillo. p.204, 2018.
- PETERSEN, R.S.; SILVEIRA, M.; FENNER, A.L.D.; CAMPOS, A.S.; MARTINS, W.J.; MACHADO, J.M.H. Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro. *Cad. Saúde Pública*. v.36, n.11, 2020.
- PILON, A.F. Twenty steps for developing a healthy cities project. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen, 1992. *Rev. Saúde Pública*. v.27, n.4, p.308-10, 1993.
- PINEO, H. Towards healthy urbanism: inclusive, equitable and sustainable (THRIVES) – an urban design and planning framework from theory to praxis. *Cities & health*. v.6, n.5, 2022.
- PISCICELLI, L. The sustainability impact of a digital circular economy. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. v.61, 2023.

PORTELA, D.S.; WEBBER, T.; BOWLES, J. Using Technology to Enhance Community Health and Territorial Resources Access. In: Mantas, J. Healthcare Transformation with Informatics and Artificial Intelligence. 2023.

PORTNEY, K.E.; SANSOM, G.T. Sustainable cities and healthy cities: Are they the same? Urban Planning. v.2, n.3, 2017.

PUPENTSOVA, S.V.; ALEKSEEVA, N.S.; STROGANOVA, O.A. Foreign and Domestic Experience in Environmental Planning and Territory Management. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. v.753, n.2, 2020.

PYLYPENKO, V.; PYLYPENKO, N.; SLOBOZHAN, O.; NAHORNA, O.; TKACHENKO, B. Social Inclusion in Driving Sustainable Growth within United Territorial Communities. Grassroots Journal of Natural Resources. v.7, n.3, p.420-457, 2024.

RIBEIRO, R.C. A construção de um município saudável: descentralização e intersetorialidade – experiência de Fortaleza. Saúde Sociedade. v.6, n.2, p.47-54, 1997.

RODNEY, A.M.; HILL, P.S. Achieving equity within universal health coverage: a narrative review of progress and resources for measuring success. International Journal for Equity in Health. 2014.

ROEMER, J.; SUZUMURA, K. Intergenerational Equity and Sustainability. Palgrave macmillan. 2007.

ROLDAN, C.S.; GIRALDO, G.A.M.; SANTANA, E.L. Sustainable Development in Rural Territories within the Last Decade: A Review of the State of the Art. Heliyon. v.9, n.7, e17555, 2023.

ROMÃO, J.; NEUTS, B. Territorial capital, smart tourism specialization and sustainable regional development: Experiences from Europe. Habitat International. v.68, p.64-74, 2017.

SALAS-ZAPATA, L.; LÓPEZ-RÍOS, J.M.; GÓMEZ-MOLINA, S.; FRANCO-MORENO, D.; MARTÍNEZ-HERRERA, E. Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias para qualidade de vida. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. v.34, n.1, p.96-104, 2016.

SANTINHA, G.; SOARES, C.; FORTE, T. Strategic planning as the core of active and healthy ageing governance: a case study. Sustainability. v.15, 1959, 2023.

SANTOS, E.L.; FRANZ, N.M.; SIMÃO, A.G.; TERNOSKI, S.; SILVA, C.L.; SANTOS, GD. Cidades inteligentes e sustentáveis: percepções sobre a cidade de Curitiba/PR a partir dos planos plurianuais de 2014 a 2021. *urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana*. v14, 2022.

SARGENTO, A.; LOPES, A.S. Territorial resilience on the aftermaths of COVID-19 crisis—An exploratory analysis on the role of innovation. *Regional Science Policy & Practice*. v.16, n.1, 2024.

SELLERA, P.E.; MORO, M.F.S.A.; ALBUQUERQUE, R.H.; BRAGA, L.I.; SOUZA, M.S.; LIMA, A.S.; MARTINS, W.J. A ativação de redes sociotécnicas na cidade estrutural/DF, Brasil: construindo um território saudável sustentável. *Cien. Saúde Coletiva*. v.24, n.6, p.2185-91, 2019.

SEROHIN, V.; SEROHINA, S.; BODROVA, I.; HRYTSENKO, H.; OMELIANENKO, O. The Potential of Territorial Communities as a Factor of Socio-Environmental Development of Territories. *Wseas transactions on environment and development*. V.19, 2023.

SETTI, A.F.; RIBEIRO, H.; AZEITEIRO, U.M.; GALLO, E. Governance and the promotion of sustainable and healthy territories: the experience of Bocaina, Brazil. *Journal of Integrated Coastal Zone Management*. v.16, n.1, p.57-69, 2016.

SHIPTON, D.; SARICA, S.; CRAIG, N.; MCCARTNEY, G.; KATIKIREDDI, S.V.; ROY, G. et al. Knowing the goal: an inclusive economy that can address the public health challenges of our time. *J Epidemiol Community Health*. v.75, p.1129-32, 2021.

SILVA, C.V.P.; ALBUQUERQUE, P.C.; MELLO, L.M.B.D.; TAVARES, M.S. Agentes populares no contexto da pandemia de Covid-19: educação popular em saúde na construção de territórios saudáveis sustentáveis. *Interface (Botucatu)*. v.28: e230142, 2024.

SILVA, L.M.V. Collective Health: Theory and Practice. Innovations From Latin America. In D. MCQUEEN (Ed.), *Oxford research encyclopedia of global public health*. Oxford University Press. 2021.

SONI, N.; SONI, N. Benefits of pedestrianization and warrants to pedestrianize an area. *Land use policy*. v.57, 2016.

SPERANDIO, A.M.; CORREA, C.R.S.; SERRANO, M.M.; RANGEL, H.A. Caminho para a construção coletiva de ambientes saudáveis – São Paulo, Brasil. *Cien. Saude Coletiva*. v.9, n.3, p.643-654, 2004.

SPERANDIO, A.M.G.;FRANCISCO FILHO, L.L.;MATTOS, T.P. Política de promoção da saúde e planejamento urbano: articulações para o desenvolvimento da cidade saudável. Cien. Saúde Coletiva. v.21, n.6, p.1931-37, 2016.

SPIJKERS, O. Intergenerational Equity and the Sustainable Development Goals. Sustainability. v.10. n.11, 2018.

STRIELKOWSKI, W.; KALYUGINA, S.; GRUZINOVA, I.; PYANOV, A. Regional Sustainable Economic Development, Territorial Asymmetry, and the Role of Institutions: a Case of Russia. Journal of Institutional Studies. n.4, 2024.

ŠŪMANE, S.; ĀDAMSONE-FISKOVIČA, A.; CĪRULE, L., GRĪVIŅŠ, M., KĪLIS, E.; SKUDRA, M.S. et al. Knowledge and innovation partnerships for smart and sustainable territorial development. 2021: Rural Development. Challenges for Sustainable Bioeconomy and ClimateChange. 2024.

TAVARES, R.C. O sentimento de pertencimento social como um direito universal. Caderno Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. v.15, n.106, p.179-201, 2014.

TOLSTYKH, T.; GAMIDULLAEVA, L.; SHMELEVA, N.; LAPYGIN, Y. Regional Development in Russia: An Ecosystem Approach to Territorial Sustainability Assessment. Sustainability. v.12, n.16, 2020.

TORRE, A. Contribution to the theory of territorial development: a territorial innovations approach. Regional Studies. v.59, n.1, 2025.

TRAVNIKOVA, D.; DVORYADKINA, E. Formation of regional conditions for the development of healthy lifestyle infrastructure using public and private partnership mechanisms. E3S Web of Conferences. 296, 04010, 2021.

TSOUROS, A.; GREEN, G. Healthy cities in Europe: editorial. J Urban Health. v.90, sup. 1, p.1-3, 2013.

TSOUROS, A.D. Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: a sustainable movement for change and innovation at the local level. Health Promotion International. v. 30, sup.1, p.3-7, 2015.

WALLERSTEIN, N.; OETZEL, J.G.; SANCHEZ-YOUNGMAN, S.; BOURSAW, B.; DICKSON, E., KASTELIC, S. et al. Engage for Equity: A Long-Term Study of Community-Based Participatory Research and Community-Engaged Research Practices and Outcomes. *Health Education & Behavior*. v.47, n.3, 2020.

WANG, Y.; WANG, X.; GUAN, F. The Beneficial Evaluation of the Healthy City Construction in China. *Iran J Public Health*. v.46, n.6, p.843-847, 2017.

WAYNSZTOK, L.; ROSSI, P.; CHIARA, M. Los espacios virtuales de asistencia técnica del programa nacional de municipios y comunidades saludables. *Revista Argentina de Salud Pública*. v.2, n.9, 2011.

WEBSTER, P.; SANDERSON, D. Healthy Cities indicators--a suitable instrument to measure health? *J Urban Health*. v.90, Sup.1, p.52-61, 2013.

WEILAND, S.; HICKMANN, T.; LEDERER, M.; MARQUARDT, J.; SCHWINDENHAMMER, S. The 2030 Agenda for Sustainable Development: Transformative Change through the Sustainable Development Goals? *Politics and Governance*. V.9, n.1, 2021.

WEN, Y.; LI, Y.; ZHANG, Y.; LIU, B. Comprehensive evaluation of global health cities development levels. *Front. Public Health*. v.12, 2024.

WESTPHAL, M.F. O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a qualidade de vida. *Cien. Saude Coletiva*. v.5, n.1; 2000.

WESTPHAL, M.F.; MENDES, R. Cidade saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e intersetorialidade. *RAP*. v.34, n.6, p.47-61, 2000.

WESTPHAL, M.F. O modelo de atenção na perspectiva de saúde integral: a promoção da saúde e a estratégia de "municípios saudáveis". *SANARE – Revista de Políticas Públicas*. v.2, n.3, 2013.

WHO. World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO; 1986.

XING, C.C.; SERGIENKO, A.; FROLOVA, A.; RYKOV, A. Climate-resilient agriculture: Strategies for mitigating environmental impacts in rural economies. *E3S Web of Conferences*. 614, 2025.

YANG, J.; LUO, X.; XIAO, Y.; SHEN, S.; SU, M.; BAI, Y.; GONG, P. Comparing the Use of Spatially Explicit Indicators and Conventional Indicators in the Evaluation of Healthy Cities: A Case Study in Shenzhen, China. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. v.17, n.20, 2020.

YANG, L.; HE, B.; CHENG, L.; WANG, R.; AO, Y. Editorial: The physical environment and health: implications for the planning and management of healthy cities. *Front Public Health*. v.11, 1245561, 2023.

YOSHIZAWA, K. WHO Healthy City Initiative in Japan. *Jpn. J. Hyg.* v.68, n.2, 2013.

ZAHNOW, R. Social infrastructure, social cohesion and subjective wellbeing. *Wellbeing, Space and Society*. v.7, 2024.

ZANJANI, L.V.; GOVAN, H.; JONAS, H.C.; KARFAKIS, T.; MWAMIDI, D.M.; STEWART, J. et al. Territories of life as key to global environmental Sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. v.63, 2023.

ZHANG, H.; NIJHUIS, S.; NEWTON, C.; TAO, Y. Healthy urban blue space design: Exploring the associations of blue space quality with recreational running and cycling using crowdsourced data. *Sustainable Cities and Society*. v.117, 2024.

ZHAO, M.; QIN, W.; ZHANG, S.; QI, F.; LI, X.; LAN, X. Assessing the construction of a Healthy City in China: a conceptual framework and evaluation index system. *Public Health*. v.220, p.88-95, 2023.



PRODUTOS 03

DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO O MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO SOBRE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS COM FOCO NOS INDICADORES, VISANDO GERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS, VISUAIS E MAPEAMENTO NECESSÁRIO VISANDO CONTRIBUIÇÃO ÀS DISCUSSÕES DO MARCO 3, DO COMPROMISSO 8 LIGADOS AO 6º PLANO DE AÇÃO BRASILEIRO.

Autor: Marcos Aguiar Ribeiro

1. INTRODUÇÃO

Os territórios em saúde vêm se consolidando como objeto de estudo e intervenção intersetorial, abrangendo campos como saúde coletiva, geografia, planejamento urbano, ciências sociais e ambientais. Longe de serem compreendidos apenas como espaços físicos delimitados por fronteiras administrativas, os territórios em saúde são concebidos como construções vivas, dinâmicas e simbólicas, continuamente moldadas pelas relações sociais, pelos modos de vida e pelas interações com o ambiente (Santos, 1996; Monken, 2024). Essa concepção amplia a compreensão tradicional de espaço, incorporando elementos subjetivos, históricos e culturais que se materializam na experiência cotidiana das populações.

A emergência de novas formas de adoecimento associadas à urbanização acelerada, à desigualdade social e à degradação ambiental tem impulsionado iniciativas que buscam reorganizar os territórios sob perspectivas mais equitativas e sustentáveis. Nesse contexto, surgem propostas que associam a promoção da saúde à transformação dos espaços de vida, promovendo o engajamento das comunidades na busca por soluções contextualizadas e emancipatórias (Tsouros, 2015; Kickbusch; Nutbeam; Aronson, 2008). A ideia de que os territórios podem ser agentes na produção da saúde – e não apenas cenários de intervenção – vem ganhando força nas políticas públicas e na literatura científica.

O conceito de cidade saudável, neste sentido, representa um desdobramento relevante. Ele propõe um modelo de desenvolvimento urbano centrado na qualidade de vida, na equidade e na participação social, integrando dimensões como habitação, mobilidade, segurança, meio ambiente e redes de apoio comunitário (Ma et al., 2022; Duhl; Hancock, 1988). Ao adotar esse modelo, reconhece-se que os determinantes sociais e ambientais da saúde exigem uma abordagem integrada, participativa e comprometida com o bem viver coletivo.

O conceito contemporâneo de “cidades saudáveis” foi sistematizado no final do século XX pelos estudiosos Trevor Hancock, do Canadá, e Leonard Duhl, dos Estados Unidos, durante o Workshop on Healthy Toronto 2000, realizado em 1984. Na ocasião, os autores propuseram um modelo de cidade comprometida com o desenvolvimento humano integral, a equidade social e a promoção da saúde em todas as políticas, em diálogo com a urbanização sustentável e a participação comunitária (Duhl; Hancock, 1988).

Embora inovadora em sua formulação institucional, essa proposta se insere em uma tradição histórica de pensamento sanitário, como reconhecido pelos próprios autores, ao fazerem referência à obra do inglês Edwin Chadwick, notório por seu Relatório sobre as Condições Sanitárias da População Trabalhadora (1842), e à utopia urbana de seu seguidor

Benjamin Ward Richardson, editor da revista *The Sanitarian*, que imaginou *Hygeia: A City of Health* como um ideal decida de planejada com base em princípios de higiene, salubridade e bem-estar coletivo (Richardson, 1876; Tsouros; Green, 2013; Kickbusch; Nutbeam; Aronson, 2008).

Desde a Declaração de Alma-Ata (1978), a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem reiterado que a saúde é um direito humano fundamental, cuja garantia depende de fatores que transcendem o setor saúde (WHO, 1986). A criação do Projeto Cidades Saudáveis, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1986, representou um marco na institucionalização da promoção da saúde como estratégia urbana, ao propor intervenções intersetoriais orientadas pelos princípios da equidade, justiça social e participação cidadã. O documento inaugural do projeto destaca que “uma cidade saudável é aquela que está comprometida com a melhoria contínua de seu ambiente físico e social e com o fortalecimento dos recursos comunitários que apoiam a vida” (WHO, 1986). A partir desse referencial, a OMS passou a influenciar políticas públicas em diversas regiões, reconhecendo os territórios como construções sociais, atravessadas por disputas simbólicas, políticas e materiais.

A promoção de territórios saudáveis e sustentáveis está intrinsecamente alinhada à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles que tratam de saúde, equidade, urbanização, meio ambiente e governança (ONU, 2015). Ao considerar o território como unidade estratégica de planejamento e intervenção, essa abordagem permite reconhecer e enfrentar desigualdades estruturais, promover o bem-estar coletivo e fortalecer os vínculos entre população, ambiente e políticas públicas (BARCELLOS; PEREIRA, 2021; BUSS; FILIPE, 2021). Assim, investir na consolidação de territórios saudáveis e sustentáveis não apenas reforça o compromisso com os ODS, mas também opera como estratégia transversal e catalisadora para sua efetiva concretização (PAHO, 2022; WHO, 2016).

No Brasil, políticas como a Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2017), a Política Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2018) e a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (Brasil, 2013) incorporam a noção de territórios saudáveis. Contudo, a ausência de definições operacionais claras e a superposição de terminologias indicam a necessidade de revisão e alinhamento conceitual entre os marcos normativos, os projetos em curso e as práticas de planejamento local. Essa lacuna também revela a urgência de se avançar na sistematização de indicadores capazes de subsidiar o reconhecimento, o monitoramento, a avaliação e o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis, de modo a orientar intervenções qualificadas e promover maior coerência entre diretrizes políticas e realidades territoriais.

A construção de indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis constitui etapa fundamental para o planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à sustentabilidade socioambiental. Indicadores bem definidos permitem não apenas mensurar avanços e identificar desigualdades territoriais, mas também orientar a tomada de decisão com base em evidências e fortalecer o controle social. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), os indicadores devem refletir dimensões interdependentes como qualidade ambiental, infraestrutura urbana, acesso a serviços essenciais, participação social e coesão comunitária. No entanto, a definição de um conjunto de indicadores sensíveis à diversidade territorial e cultural dos contextos locais ainda representa um desafio, exigindo abordagens participativas e interdisciplinares que articulem dados quantitativos e qualitativos.

O mapeamento de indicadores com o apoio de ferramentas de georreferenciamento constitui uma estratégia robusta para a caracterização de territórios, o monitoramento de dinâmicas locais e a geração de evidências qualificadas para subsidiar o planejamento e a gestão de políticas públicas em diferentes setores. Como destaca Barcellos (2008), o uso de sistemas de informação geográfica (SIG) amplia a capacidade analítica dos gestores e pesquisadores, facilitando a compreensão da relação entre condições territoriais e perfis de saúde da população. A incorporação de tecnologias geoespaciais favorece, ainda, o monitoramento contínuo de indicadores, o que é essencial para a avaliação de políticas intersetoriais.

Nesse sentido, este produto técnico se justifica pela necessidade de consolidar referenciais teóricos e técnicos que orientem a identificação e o uso de indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis. Ao propor o mapeamento georreferenciado de indicadores, busca-se subsidiar políticas públicas com base em evidências contextualizadas. Diante disso, questiona-se: Quais são os indicadores utilizados para a caracterização de territórios saudáveis e sustentáveis na literatura científica? Como a apresentação espacial dos indicadores pode contribuir para a promoção e o desenvolvimento de territórios saudáveis e sustentáveis?

Nesse sentido, o objetivo geral deste produto técnico foi sistematizar evidências acerca de indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis, com vistas a realizar um mapeamento georreferenciado.

2. METODOLOGIA

O itinerário metodológico deste produto técnico foi estruturado em três etapas principais: (1) revisão de escopo; (2) síntese e seleção preliminar de indicadores; (3) avaliação de critérios de qualidade dos indicadores; e (4) georreferenciamento dos indicadores selecionados.

2.1 PRIMEIRA ETAPA: REVISÃO DE ESCOPO, SÍNTESE E SELEÇÃO PRELIMINAR DE INDICADORES

2.1.1 REVISÃO DE ESCOPO

A Etapa 1 tem início com a realização de uma revisão de escopo, que foi conduzida a partir das orientações contidas no manual do *Joana Briggs Institute* (Aromataris et al., 2024) e pelo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses - Extension for Scoping Review* (PRISMA-ScR) (Tricco et al., 2018). O registro deste protocolo está contido na plataforma *Open Science Framework* (<https://osf.io/external-login/email>) sob o DOI 10.17605/OSF.IO/A75HQ.

As buscas foram realizadas na *National Library of Medicine and National Institutes of Health* (MEDLINE/PubMed), na Scielo, na Scopus e na Biblioteca Virtual da Saúde. Como literatura cinzenta buscou-se no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e no Google Scholar, considerando os 200 primeiros resultados da busca. A estratégia complementar consistiu na consulta às referências dos estudos incluídos. As buscas foram realizadas em novembro de 2024.

A estratégia foi formulada a partir de termos sensíveis à pesquisa, incluindo palavras-chave ou descritores, de acordo com cada plataforma de busca (Quadro 1). Foram utilizados operadores booleanos: “OR”, entre os termos similares, e “AND” entre as formulações dos acrônimos.

Quadro 1. Equações de busca. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
MEDLINE / PUBMED	((("Sociocultural territory") OR ("Popular healthsurveillance")) OR ("Healthy Territories")) OR ("healthy city")) OR ("healthy cities")
SCOPUS	TITLE-ABS-KEY ("Sociocultural territory") OR TITLE-ABS-KEY ("Popular health surveillance") OR TITLE-ABS-KEY ("Healthy Territories") OR TITLE-ABS-KEY ("healthy city") OR TITLE-ABS-KEY ("healthy cities")

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
BVS	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
BDTD	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")
SCIELO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")

BASE DE DADOS	EQUAÇÃO DE BUSCA
GOOGLE ACADÊMICO	("território saudável") OR ("território sustentável") OR ("ambiente saudável") OR ("ambientes saudáveis") OR ("ambiente sustentável") OR ("ambientes sustentáveis") OR ("terriórios sustentáveis") OR ("territórios saudáveis") OR ("territórios sustentáveis e saudáveis") OR ("territórios saudáveis e sustentáveis") OR ("território saudável e sustentável") OR ("território sustentável e saudável") OR ("território saudáveis e sustentáveis") OR ("território sustentáveis e saudáveis") OR ("territorio saudavel") OR ("territorio sustentavel") OR ("territorios sustentaveis") OR ("territorios saudaveis") OR ("território e saúde") OR ("promoção à saúde no território") OR ("desigualdade territorial e saúde") OR ("iniquidade territorial e saúde") OR ("territórios e saúde") OR ("abordagem de saúde territorial") OR ("saúde e território") OR ("desigualdades territoriais e saúde") OR ("iniquidades territoriais e saúde") OR ("cidade saudável") OR ("cidades saudáveis") OR ("cidade sustentável") OR ("cidades sustentáveis") OR ("cidade saudável e sustentável") OR ("cidades saudáveis e sustentáveis") OR ("cidade sustentável e saudável") OR ("cidades sustentáveis e saudáveis")

Fonte: elaboração própria.

Salienta-se que dois pesquisadores de forma interdependente realizaram as buscas para validação da equação assim como para a seleção. A seleção dos estudos foi feita a partir da análise dos títulos e resumos; seguida pela leitura na íntegra, em ambas as etapas foram considerados os critérios de elegibilidade elencados nesta revisão.

Os resultados das buscas foram salvos em formato.csv ou .ris e transferidos para o software Rayyan, em sua versão de acesso público, para organização dos estudos identificados e para garantia da blindagem dos estudos na etapa de seleção pelos avaliadores de forma independente. Além disso, nesse mesmo software foi feita a remoção das duplicatas.

O protocolo desta revisão de escopo foi baseado na seguinte pergunta norteadora: Quais as evidências sobre territórios saudáveis e/ou sustentáveis? Para o delineamento da questão de pesquisa foi utilizado uma adaptação do acrônimo PCC, onde delimitaram-se dois conceitos “território saudável” e “território sustentável”. Para este produto técnico, delimitou-se uma subquestão específica: **“Quais as evidências científicas que utilizam, contêm, sintetizam ou incorporam indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis?”**.

Foram selecionados os documentos independente do idioma de publicação, país, período de publicação, e que possuam ênfase sobre o problema desta revisão.

Neste sentido, não foram utilizados filtros a fim de tornar a busca mais abrangente, de fosse possível a identificação de estudos que possam responder à pergunta desta revisão.

Os critérios de inclusão foram divididos em três dimensões, a saber: 1. Conteúdo e termos abordados: Estudos que contemplem em seu título, resumo e/ou texto na íntegra os termos territórios saudáveis e/ou sustentáveis. Demarca-se como termos correspondentes/similares a territórios: espaços geográficos, ambientes, cidades, localidades, entre outros; 2. Tipos de estudo: Uma perspectiva teórico-conceitual ou reflexiva dos conceitos de territórios saudáveis e sustentáveis; A aplicação prática do conceito, incluindo o uso do termo no desenvolvimento e construção de territórios saudáveis; Análises ou avaliações de experiências ou estudos sobre territórios saudáveis e sustentáveis; e 3. Abordagem ampliada de saúde: Estudos que tratam os territórios saudáveis sob a perspectiva do conceito ampliado de saúde, considerando suas múltiplas dimensões.

Já os critérios de exclusão foram: estudos de revisão, como revisões sistemáticas, revisões integrativas, revisões de escopo ou outros formatos similares; estudos que abordem os territórios exclusivamente por uma visão epidemiológica, limitando-se a analisar o comportamento de doenças no território, sem considerar a perspectiva ampliada de saúde ou os aspectos relacionados à sustentabilidade; estudos que se limitaram a descrever uma experiência específica de território saudável e/ou sustentável. Ressalta-se que em caso de estudos similares, mas de formatos diferentes, como por exemplo, dissertação e artigo que apresentassem os resultados do mesmo estudo, optou-se pelo formato de artigo, devido a avaliação por pares às cegas.

Foi construído um instrumento de extração de dados (APÊNDICE A) pelos autores a fim de alinhar esse processo. O instrumento teve como finalidade sistematizar e analisar informações relacionadas à produção científica e técnica sobre indicadores utilizados na avaliação de territórios sob a perspectiva da saúde e sustentabilidade. Estruturado em seis blocos, o instrumento permitiu a caracterização detalhada dos estudos selecionados quanto à identificação básica (título, autores, ano, local e tipo de estudo), descrição geral (objetivo, população, método e abrangência dos indicadores), indicadores relatados (quantitativos e qualitativos, fontes e escalas), classificação por dimensões temáticas, nível de operacionalização e potencial de síntese.

A ferramenta possibilitou a coleta padronizada de dados, favorecendo a análise comparativa e o agrupamento dos indicadores por categorias analíticas, como qualidade do espaço urbano, governança, equidade, intersetorialidade e bem-estar integral. Além disso, considerou aspectos metodológicos relevantes, como a definição de cálculo, validação e aplicabilidade prática dos indicadores, contribuindo para a consolidação de um referencial crítico voltado a iniciativas de monitoramento e planejamento em territórios comprometidos com o desenvolvimento saudável e sustentável.

2.1.2 SÍNTESE E SELEÇÃO PRELIMINAR DE INDICADORES

A etapa de síntese e seleção preliminar de indicadores foi conduzida com base nos princípios metodológicos da revisão de escopo, seguindo as diretrizes do instrumento *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* (PRISMA). As etapas de identificação, triagem e inclusão dos estudos foram representadas por meio do fluxograma PRISMA, garantindo transparência e reprodutibilidade do processo.

Vale salientar, que os dados referentes aos estudos excluídos, após a retirada das duplicatas, juntamente com os motivos específicos para cada exclusão, bem como os dados dos estudos incluídos, contendo a caracterização detalhada de cada um (como local do estudo, tipo de pesquisa, população analisada, objetivos e método utilizado), estão sistematizados e demonstrados no Produto Técnico 02.

Neste sentido, a partir dos estudos selecionados na revisão de escopo, foi realizada uma segunda seleção específica para este produto técnico, considerando aqueles que apresentaram indicadores relacionados a territórios saudáveis e sustentáveis. Assim, os estudos que serão detalhados neste documento correspondem àqueles que abordam, de forma direta ou indireta, indicadores voltados à análise, monitoramento ou avaliação de territórios saudáveis e sustentáveis.

A síntese dos indicadores foi realizada por meio da extração sistemática de dados dos textos selecionados, considerando a presença explícita de indicadores ou de descritores mensuráveis relacionados à avaliação de territórios. A partir dessa extração, os indicadores foram organizados segundo seu tipo (quantitativo ou qualitativo), fonte de dados (primária, secundária ou mista) e escala de aplicação (individual, comunitária, territorial/ambiental). Em seguida, foram agrupados em dimensões analíticas e subdimensões temáticas, conforme emergiram do conteúdo dos estudos, permitindo uma visão estruturada e interpretativa dos elementos avaliativos utilizados nos diferentes contextos territoriais.

A seleção preliminar dos indicadores considerou critérios como clareza conceitual, aplicabilidade prática e aderência à proposta de avaliação de territórios saudáveis e sustentáveis. Indicadores repetidos ou genéricos foram revisados à luz da literatura analisada, sendo consolidados apenas aqueles com maior recorrência, robustez metodológica ou relevância temática. Esse processo permitiu construir uma base inicial de indicadores que será posteriormente aprofundada nas etapas metodológicas seguintes, contribuindo para a consolidação de um referencial avaliativo consistente e situado.

2.1.3 AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS INDICADORES

A avaliação dos critérios de qualidade dos indicadores foi realizada com base na síntese obtida a partir da revisão de escopo desenvolvida na Etapa 1 deste produto técnico. Inicialmente, foram identificados e extraídos os indicadores apresentados nos estudos selecionados, tanto quantitativos quanto qualitativos, relacionados à construção de territórios saudáveis e sustentáveis. Em seguida, procedeu-se à análise crítica desses indicadores considerando critérios de validade, relevância, factibilidade, sensibilidade e aplicabilidade, conforme parâmetros adotados por instituições como a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2016).

A análise foi fundamentada em pressupostos metodológicos da avaliação em saúde, que indicam que bons indicadores devem possuir definição clara, base conceitual sólida, possibilidade de mensuração, disponibilidade de dados e potencial para informar decisões em contextos diversos (CECÍLIO, 2011; CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). A avaliação permitiu verificar o grau de alinhamento dos indicadores com os objetivos avaliativos dos estudos, sua capacidade de captar as dinâmicas territoriais e sua pertinência às dimensões sociais, ambientais e de saúde coletiva.

O processo resultou na sistematização de um conjunto de indicadores considerados de alta qualidade, os quais apresentam potencial para subsidiar propostas metodológicas e práticas de monitoramento e avaliação de políticas intersetoriais voltadas à promoção da saúde nos territórios, em consonância com os princípios da equidade, da integralidade e da sustentabilidade (SILVA; BERTOLLI FILHO, 2020).

2.1.4 GEORREFERENCIAMENTO DOS INDICADORES SELECIONADOS

O georreferenciamento dos indicadores selecionados constituiu uma etapa estratégica deste produto técnico, possibilitando a visualização espacial dos dados e sua análise territorializada. A partir da síntese dos estudos incluídos na revisão de escopo, foram escolhidos indicadores cuja disponibilidade em bases públicas permitisse a associação com unidades territoriais brasileiras, especialmente no nível municipal. Os critérios para essa seleção incluíram: a presença de dados atualizados, a relevância para as dimensões temáticas previamente categorizadas, e a possibilidade de associação a códigos territoriais padronizados.

Com o objetivo de garantir rigor metodológico, o processo de georreferenciamento foi conduzido utilizando o software Quantum GIS (QGIS), versão 3.3, uma das plataformas de código aberto mais robustas para análises em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), reconhecida por sua flexibilidade, ampla gama de ferramentas analíticas e compatibilidade com diversos formatos de dados espaciais (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2022).

A base geográfica utilizada foi o *shapefile* dos municípios brasileiros, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), versão atualizada em 2023. Esta base é reconhecida nacionalmente pela sua precisão cartográfica e pela padronização dos códigos territoriais (códigos IBGE), elemento fundamental para a associação entre dados tabulares e camadas espaciais (IBGE, 2023).

O processo de georreferenciamento foi dividido em cinco etapas principais:

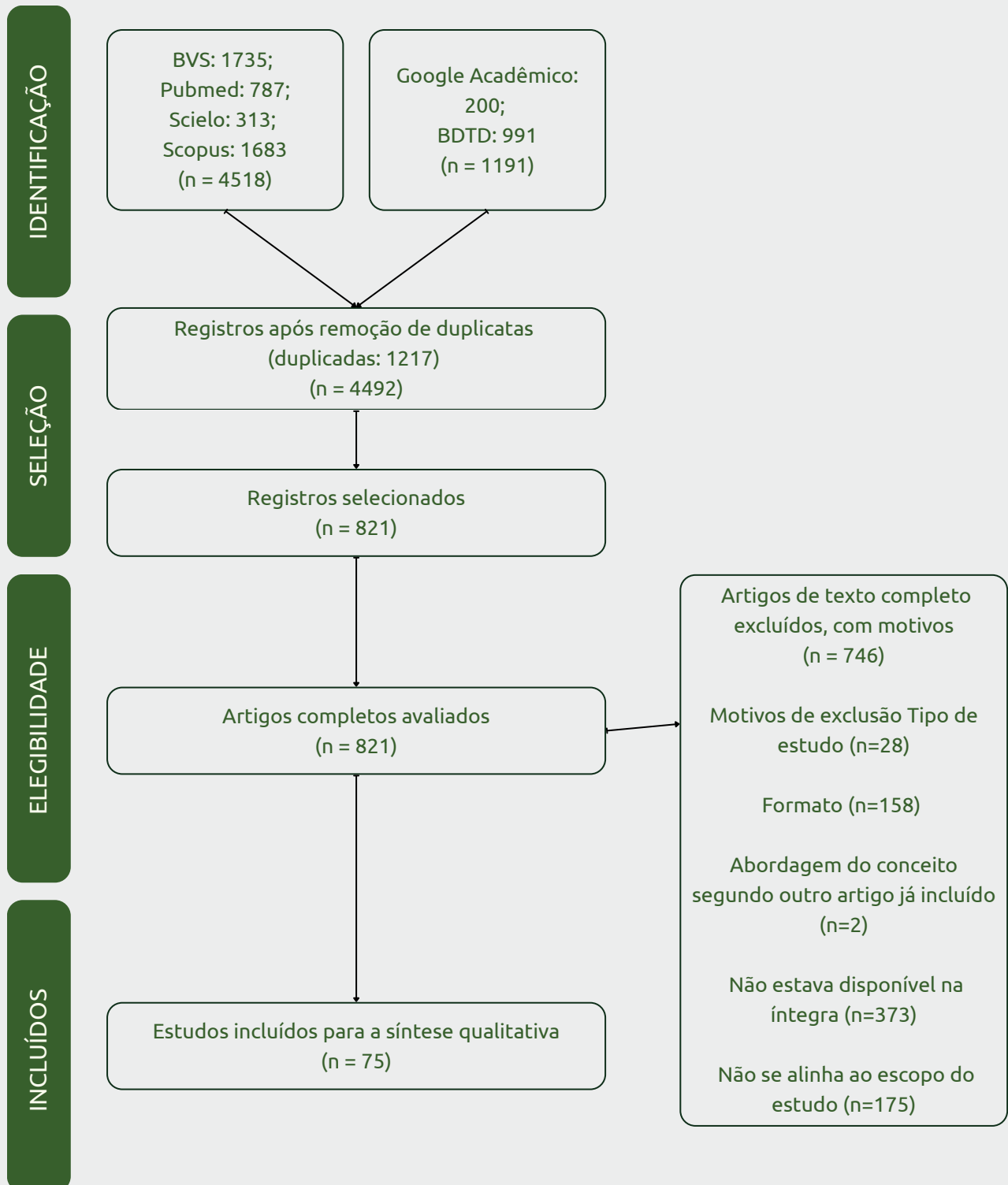
- Importação e preparação da base geográfica: os arquivos *shapefile* dos municípios foram importados para o ambiente QGIS, garantindo a integridade topológica e a projeção cartográfica adequada (SIRGAS 2000, fusos correspondentes).
- Integração dos dados tabulares: os indicadores selecionados, previamente organizados em planilhas, foram vinculados às unidades territoriais por meio do campo "Código do Município (IBGE)", assegurando correspondência exata entre as bases de dados.
- Criação de mapas temáticos: foram gerados mapas temáticos utilizando simbologia graduada (por cores) e classificação por quartis ou intervalos naturais (*Jenks*), com o intuito de evidenciar padrões espaciais e contrastes regionais relevantes. Cada indicador foi representado em mapa próprio, com legenda descritiva, escala gráfica e norteador.
- Análise de consistência e refinamento visual: os mapas foram revisados quanto à coerência visual e qualidade gráfica, com ajustes de paleta de cores, rótulos e limites territoriais. Também foram avaliadas eventuais lacunas ou inconsistências nos dados, sinalizando a necessidade de complementação ou tratamento estatístico.
- Exportação e organização cartográfica: os produtos cartográficos finais foram exportados em alta resolução (formato .png e .pdf), organizados em conjuntos temáticos por dimensão analítica, permitindo sua utilização em relatórios, painéis e apresentações estratégicas.

A escolha pela utilização de mapas temáticos justifica-se pela capacidade que esses instrumentos possuem de traduzir evidências quantitativas em representações visuais compreensíveis e comparáveis, fortalecendo o planejamento territorial baseado em dados. Essa abordagem permite não apenas identificar disparidades intra e intermunicipais, mas também reconhecer áreas prioritárias de intervenção, subsidiar políticas intersetoriais e fomentar o diálogo entre diferentes setores e atores sociais (MONKEN et al., 2008; SANTOS, 1996)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da utilização dos critérios de elegibilidade elencados nesta revisão, foram encontrados $n = 4492$ nas seis bases de dados ou repositórios utilizados na busca deste estudo. Após as etapas da triagem resultaram em 75 documentos selecionados para análise desta revisão, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. PRISMA adaptado para a síntese de indicadores. Brasil, 2024.



Fonte: elaboração própria.

O quadro 2 apresenta uma síntese da caracterização dos estudos selecionados (n = 32) que apresentaram indicadores para territórios saudáveis e sustentáveis, conforme título, autor(es), ano de publicação, local e objetivo.

Quadro 2. Síntese dos estudos que apresentaram indicadores relacionados aos territórios saudáveis e sustentáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2024.

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A4	Does Health Promotion Program Affect Local Resident' Emotions?	Lee et al.	2019	Coreia	Definir qualitativamente a correlação entre o desempenho de um programa de cidade saudável e as emoções dos moradores locais usando o índice de felicidade pessoal como parâmetro.
A7	Healthy Cities indicators--a suitable instrument to measure health?	Webster; Sanderson	2013	Reino Unido	Propor e analisar uma versão simplificada de indicadores para avaliação de cidades saudáveis.
A8	Comprehensive evaluation of global health cities development levels	Wen et al.	2024	Amsterdã, Boston, Buenos Aires, Dubai, Joanesburgo, Londres, Los Angeles, Melbourne, Nova York, Paris, Santiago, Xangai, Cingapura, Tóquio e Toronto	Identificar e analisar as diferenças nos níveis de desenvolvimento de saúde entre cidades globais, auxiliar os departamentos de gestão urbana a identificarem com precisão os pontos fortes e os problemas e avaliar e diagnosticar razoavelmente os níveis gerais de saúde e as deficiências das cidades da amostra.
A10	Cidade saudável: o diagnóstico do território urbano por meio dos determinantes sociais de saúde: o caso Maracanaú	Moura et al.	2021	Brasil	Compreender o território urbano através da análise dos Determinantes Sociais da Saúde como pressuposto para a estruturação de uma agenda de cidade saudável.
A11	Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro	Petersen et al.	2020	Brasil	Desenvolver o Índice de Território Saudável e Sustentável, com indicadores de dados secundários de 2010, para classificação territorial em prioridade de ação em território saudável e sustentável

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A17	Sustainability of the Healthy Municipalities Strategy in Guatemala	Laureano-Eugenio et al.	2021	Guatemala	Avaliar a sustentabilidade da estratégia de Municípios Saudáveis na Guatemala para ter evidências sólidas para apoiar a tomada de decisões.
A18	Healthy city evaluation based on factor analysis- Taking cities in the Guangxi Zhuang Autonomous Region as an example	Huang et al.	2024	China	Medir os níveis de saúde das cidades de Nanning e Chongzuo na Região Autônoma de Guangxi Zhuang para preencher as lacunas e deficiências na pesquisa nesta área. Além disso, ao construir um índice de cidade saudável (HCI) e avaliar de forma abrangente o nível de construção de cidade saudável na Região Autônoma de Guangxi Zhuang.
A24	Movimento "São Paulo - cidade saudável"	Secretaria Municipal de São Paulo	1990	Brasil	Não especificado
A26	O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional	Matias; Campos	2022	Brasil	Contribuir para o debate acerca das cidades sustentáveis, procurando definir com maior precisão as balizas de sua conceituação, à luz da ordem jurídica nacional e a da doutrina, o que ensejará a melhor compreensão do direito a cidades sustentáveis.
A27	Construindo cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do Planejamento Estratégico Situacional	Lima; Lima	2020	Brasil	Apresentar a evolução histórica do conceito de cidade saudável e as concepções paradigmáticas que lhe deram corpo no âmbito da saúde pública e, por fim, apresentar uma proposta de um enquadramento do conceito cidade saudável a partir de ideias do Planejamento Estratégico Situacional.

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A28	Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro	Petersen et al.	2020	Brasil	Desenvolver o ITSS, com indicadores de dados secundários de 2010, para classificação territorial em prioridade de ação em território saudável e sustentável.
A35	The EWM-Based Evaluation of Healthy City Construction Levels in East China under the Concept of "Making Improvements Is More Important Than Reaching Standards"	Li et al.	2024	China	Não especificado.
A36	Exploring the relationship between the perceived importance of healthy city indicators and satisfaction levels towards the local government in shaping a healthy city	Lim et al.	2023	Malásia	Explorar a correlação entre a importância percebida dos indicadores de cidade saudável e seus níveis de satisfação em relação à eficácia do governo na criação de um ambiente de cidade saudável; e oferecer uma oportunidade única para entender o que constitui uma "cidade saudável" conforme percebido pelo público.
A37	Countermeasures to promote sustainable construction and coordinated development of healthy cities: a case study of Dandong City	Liu	2024	China	Analisar a meta geral da construção de cidades saudáveis em Dandong usando o processo de hierarquia analítica.
A39	A set of 99 healthy city indicators for application in urban planning and design	Ziafati; Cheshmehzangi; Ankowska	2023	Reino Unido	Desenvolver 99 indicadores para uma cidade saudável

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A41	How to Make Future Cities Smart in the Realm of Environmentally Friendly Healthy Cities? Looking from the Perspective of Ease of Living Index	Gupta; Sethi	2024	Índia	Desenvolver uma ferramenta integrada para avaliação baseada em dados do programa de cidades saudáveis proposto pela Índia, criando uma lista abrangente de indicadores abrangendo ambas as estruturas.
A42	Comparative Study on the Evaluation of Healthy City Construction in Typical Chinese Cities Based on Statistical Data and Land Use Data	Lv et al.	2022	China	Introduz o conceito de desenvolvimento sustentável na avaliação de cidades saudáveis e constrói um conjunto de sistemas de índices de avaliação para cidades saudáveis que leva em conta tendências de desenvolvimento urbano e desenvolvimento sustentável, e seleciona uma série de diferentes escalas e tipos de cidade típica, coletando dados estatísticos e dados de uso do solo, e usando o método de polígono de matriz inteira (EAP) para avaliar e comparar o nível de desenvolvimento saudável de cada cidade típica.
A43	Updating Healthy City Variables for the Post-pandemic Era Using Delphi Method	Cacique et al.	2022	México	Atualizar as variáveis usadas para medir a Cidade Saudável usando o Método Delphi, uma vez que a atual Pandemia tornou necessário repensar e reavaliar toda a complexa noção de Cidade Saudável
A47	Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index	Pineo et al.	2018	Inglaterra	Apresentar o desenvolvimento de um índice global para ajudar os líderes e profissionais da cidade a entender seu papel na entrega de resultados de saúde por meio de políticas e programas de ambiente urbano

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A54	Assessing the construction of a Healthy City in China: a conceptual framework and evaluation index system	Zhao et al.	2023	China	Explorar os padrões espaciais e temporais da construção da Cidade Saudável em 341 cidades chinesas.
A58	Comparing the Use of Spatially Explicit Indicators and Conventional Indicators in the Evaluation of Healthy Cities: A Case Study in Shenzhen, China	Yang et al.	2020	China	Comparar a diferença entre os resultados de avaliação gerados usando indicadores convencionais e indicadores derivados pela abordagem espacialmente explícita.
A59	Impact of the Social Agendas – Agenda 21 and Healthy Cities – upon Social Determinants of Health in Brazilian municipalities: measuring the effects of diffuse social policies through the dimensions of the Millennium Development Goals	Nascimento et al.	2014	Brasil	Relatar, sobre a temática dos DSS, uma abordagem metodológica quantitativa, como parte de um estudo multicêntrico usando “métodos mistos”.
A64	The development and application of a two-step surveillance process for Healthy China Initiative based on wide coverage interagency data	Liu et al.	2023	China	Desenvolver e aplicar um processo de vigilância em duas etapas para a Iniciativa China Saudável com base em dados interinstitucionais de ampla cobertura.
A65	A abordagem territorial nos Territórios Sustentáveis e Saudáveis: um alargamento conceitual a partir da antropologia	Penaforte	2024	Brasil	Expandir o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis a partir da antropologia.

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A66	A ativação de redes sociotécnicas na cidade estrutural/DF, Brasil: construindo um território saudável e sustentável	Sellera et al.	2019	Brasil	Descrever iniciativas para a ativação de redes sociotécnicas na Cidade Estrutural como estratégia para implementar a Agenda 2030, visando tornar o território saudável e sustentável por meio de um novo processo de produção local.
A67	Healthy Cities in Europe: Editorial	Tsouros; Green	2013	Europa	Avaliar a evolução do trabalho realizado na fase IV (2003– 2008) da Rede Europeia de Cidades saudáveis (WHO- EHCN), contextualizando os avanços na fase V (2009– 2013) e os objetivos para a fase VI (2014–2018), alinhados à política Health 2020 da OMS.
A68	Achieving Healthy City Development in Ghana: Referencing Sustainable Development Goal 11	Botchway et al.	2023	Gana	Avaliar a percepção dos profissionais das Assembleias Distritais sobre o desenvolvimento de cidades saudáveis em Gana, com foco no alcance do ODS 11.
A69	A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida?	Adriano et al.	2000	Brasil	Discutir a importância do Movimento Cidades Saudáveis como estratégia para melhorar a qualidade de vida e apresentar uma experiência piloto desenvolvida nos municípios mineiros de Dionísio e São José do Goiabal entre 1996 e 1998.
A71	Achieving organizational change: Findings from case studies of 20 California Healthy Cities and Communities coalitions	Kegler; Norton; Aronson	2008	Estados Unidos	Avaliar até que ponto as coalizões participantes do programa CHCC demonstraram capacidade de alavancar recursos financeiros, expandir programas comunitários e influenciar políticas organizacionais, promovendo a saúde e a qualidade de vida nos territórios.

ID	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	ANO	LOCAL	OBJETIVO (adaptado ao idioma português)
A72	City environmental conditions are associated with health outcomes in people living there: Insights from the Alliance for Healthy Cities (AFHC) Japan	Yoshizawa	2013	Japão	Explorar como as cidades membros da AFHC promovem iniciativas de Cidades Saudáveis, investigando os fatores que influenciam o sucesso dessas iniciativas, como a participação comunitária, o financiamento e as redes colaborativas
A73	Editorial: The Healthy Cities	Kamper-Jorgensen	2010	Dinamarca	Avaliar o desenvolvimento de políticas em, com e para Cidades Saudáveis na Região Europeia da OMS, destacando saúde, equidade, justiça social e sustentabilidade urbana
A74	Developing a Health-Spatial Indicator System for a Healthy City in Small and Midsized Cities	Luo et al.	2022	China	Desenvolver um sistema de indicadores espaciais de saúde para avaliar e orientar iniciativas de Cidades Saudáveis em cidades pequenas e médias, conectando o design urbano e a saúde pública.

Observação: Os ID's são codificados conforme a numeração atribuída à totalidade de artigos incluídos na revisão de escopo, sendo todos detalhados integralmente no produto 02.

Fonte: elaboração própria.

Dos 75 estudos selecionados para esta revisão, 41 estudos não mencionaram indicadores para análise, dois não especificaram com detalhes indicadores e 32 estudos descreveram indicadores que foram agrupados e sintetizados em 10 dimensões e 44 subdimensões em ordem decrescente pelo quantitativo de indicadores, conforme verifica-se no Quadro 03 a seguir.

Quadro 3. Síntese das dimensões e subdimensões dos indicadores de territórios saudáveis e sustentáveis. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
ECONOMIA (N=46)	Emprego, benefícios e desemprego	19
	Gastos, investimentos e outros	18
	Economia saudável e sustentável	09

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (N=168)	Transporte/Mobilidade urbana	35
	Espaços verdes	34
	Infraestrutura	29
	Outros relativos a sustentabilidade	21
	Energia	13
	Qualidade da água	12
	Qualidade /Poluição do ar	11
	Qualidade do som	06
	Qualidade do solo	04
	Aquecimento global	03
SOCIOECONÔMICO (N=113)	Habitação	26
	Saneamento básico	24
	Segurança alimentar	17
	Esporte e lazer	16
	Educação	15
	Renda	05
	Acesso a internet	02
	Outros	08
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (N=49)	Serviços de saúde	24
	Profissionais de saúde	11
	Materno-infantil	07
	Promoção à Saúde e prevenção de doenças	04
	Saúde do idoso	02
	Saúde mental	01

DIMENSÕES	SUBDIMENSÕES	QUANTIDADE DE INDICADORES
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA LOCAL (N=25)	Democracia	12
	Solidariedade	09
	Engajamento/Liderança	04
SAÚDE (N=40)	Doenças/Agravos e outros	20
	Mortalidade	17
	Longevidade	03
EQUIDADE (N=18)	Acessibilidade	09
	Diversidades das populações	07
	Situações de calamidade pública	02
GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO (N=17)	Gestão	07
	Planejamento	06
	Monitoramento	04
POPULAÇÃO (N=11)	Geral	07
	Individual	04
FALTA DE SEGURANÇA (N=06)	Ocorrência de crimes	06
ESPECÍFICOS (N=05)	Índices	05
DADOS/INOVAÇÃO (N=03)	Pesquisa	03

Fonte: elaboração própria.

3.1 DIMENSÃO: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A dimensão Sustentabilidade Ambiental configura-se como a mais abrangente da matriz analítica, reunindo 10 subdimensões e um total de 168 indicadores, o que evidencia a centralidade do componente ambiental na construção do conceito de território saudável e sustentável. Esta dimensão expressa, de forma intersetorial e territorializada, a importância do ambiente urbano e natural na promoção da saúde coletiva, da equidade e da resiliência frente às mudanças climáticas e aos impactos ambientais.

Os indicadores dessa dimensão abarcam desde os aspectos físicos e ecológicos do território, até os elementos de infraestrutura urbana que moldam os modos de viver e de se deslocar nas cidades. A seguir, detalham-se as principais subdimensões e exemplos de indicadores, com base nas fontes públicas nacionais de dados disponíveis para agregação e análise no nível municipal.

A dimensão de Sustentabilidade Ambiental, pela sua amplitude e densidade, fornece uma base empírica essencial para a avaliação integrada da saúde dos territórios. Os indicadores aqui sistematizados não apenas fornecem um retrato da situação ambiental local, mas também funcionam como ferramentas operacionais para: Diagnosticar desigualdades ambientais e urbanas, priorizar investimentos em infraestrutura verde e saneamento, acompanhar metas municipais de sustentabilidade e clima e promover justiça ambiental e saúde coletiva.

3.1.1 TRANSPORTE / MOBILIDADE URBANA

A subdimensão Transporte/Mobilidade Urbana representa um componente essencial na avaliação de territórios saudáveis e sustentáveis, ao refletir a capacidade de deslocamento seguro, equitativo, acessível e ambientalmente responsável da população. O modo como o transporte é organizado impacta diretamente na qualidade do ar, nos níveis de sedentarismo, no acesso aos serviços essenciais, na coesão social e na sustentabilidade ambiental (YOSHIZAWA, 2013; BOTCHWAY et al., 2023).

Abrange indicadores relacionados ao acesso a meios de transporte seguros, sustentáveis e acessíveis, incluindo condições para o deslocamento a pé e por bicicleta.

Os indicadores internacionais refletem um padrão comparativo e analítico adotado em estudos sobre mobilidade urbana em cidades como Londres, Seul, Paris, Pequim e Nova York, sendo úteis para diagnóstico e planejamento urbano sustentável:

- Pedestrianização(WEBSTER; SANDERSON, 2013);
- Número de ruas exclusivas para pedestres (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Rotas de ciclismo mapeadas (WEBSTER; SANDERSON, 2013);
- Alcance e qualidade do transporte público(WEN et al., 2024; LIM et al., 2023);
- Densidade ferroviária (km/km²)(LV et al., 2022);

- Densidade de estradas (km/km²) (ZIAFATI et al., 2023);
- Redução da velocidade e volume do tráfego (LIM et al., 2023);
- Projetos de cidade para pedestres (CACIQUE et al., 2022);
- Transporte público e segurança (CACIQUE et al., 2022);
- % de passageiros que utilizam meios alternativos ao carro para trabalhar (PINEO et al., 2018);
- Número de ônibus por 10.000 habitantes (ZHAO et al., 2023);
- Número de paradas/estações de transporte por 10.000 hab. (YANG et al., 2020);
- Conectividade entre bairros e floresta urbana por transporte público (ZIAFATI et al., 2023);
- Compartilhamento de transporte ferroviário (HUANG et al., 2024);
- Forma urbana e transporte (LUO et al., 2022).

Esses indicadores são úteis para compor diagnósticos comparativos entre cidades globais e estabelecer parâmetros de desempenho sustentável.

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro de transporte e mobilidade urbana, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Percentual da população que reside a até 500 metros de um ponto de transporte público.**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e Pesquisa Nacional de Saúde Urbana (PNSU).
 - Aplicabilidade: Permite avaliar a proximidade física da população ao sistema de transporte público, fundamental para o planejamento da cobertura e inclusão territorial.

- **Extensão de ciclovias (quilômetros) por 100 mil habitantes.**
 - Fonte: Planos de Mobilidade Urbana (PlanMob), Secretarias Municipais de Transporte e Trânsito.
 - Aplicabilidade: Indicador da infraestrutura voltada ao transporte ativo, como bicicletas e patinetes, contribuindo para cidades mais sustentáveis.
- **Proporção de viagens feitas a pé ou por bicicleta.**
 - Fonte: Pesquisa de Origem e Destino (OD), IBGE – Módulo de Mobilidade Urbana.
 - Aplicabilidade: Mede o comportamento modal da população e auxilia na formulação de políticas de incentivo à mobilidade ativa.
- **Velocidade média do trânsito em áreas urbanas**
 - Fonte: INRIX Global Traffic Scorecard, Companhias de Engenharia de Tráfego (CETs) municipais.
 - Aplicabilidade: Indica a fluidez da circulação urbana, com impactos sobre tempo de deslocamento, poluição e qualidade de vida.
- **Percentual de vias com calçadas em boas condições**
 - Fonte: IBGE – Censo Demográfico, Prefeituras Municipais.
 - Aplicabilidade: Indicador essencial para avaliação da acessibilidade e segurança dos pedestres, com impacto na caminhabilidade urbana.
- **Proporção da população com acesso a transporte público, por sexo, idade e deficiência**
 - Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022 e Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).
 - Aplicabilidade: Permite avaliar desigualdades no acesso ao transporte, com ênfase em grupos populacionais vulneráveis.
- **Densidade de tráfego (número de veículos por quilômetro de via urbana)**
 - Fonte: Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) / Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), secretarias municipais de transporte.
 - Aplicabilidade: Permite estimar a sobrecarga do sistema viário, útil para planejamento de intervenções e mitigação de congestionamentos.
- **Número total de viagens por automóvel particular e por transporte coletivo, com respectivas durações médias**
 - Fonte: IBGE – Módulo de Mobilidade Urbana, pesquisas de Origem e Destino (OD) regionais.
 - Aplicabilidade: Indicador da eficiência e preferência modal da população, orientando investimentos em transporte público.

- **Cobertura da rede de transporte público (em quilômetros ou área de abrangência)**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Mobilidade Urbana (SNIS - Mobilidade), PlanMob.
 - Aplicabilidade: Mede o alcance territorial da malha de transporte público e sua capacidade de atendimento à população.
- **Percentual de bairros com paradas de transporte público em seu centro geográfico**
 - Fonte: Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) municipais, IBGE – Perfil dos Municípios.
 - Aplicabilidade: Indica vazios urbanos de cobertura e contribui para planejamento baseado em justiça territorial.
- **Quilometragem de sistemas de transporte público de alta capacidade por 100 mil habitantes.**
 - Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), São Paulo Transporte S/A (SPTrans), empresas metro ferroviárias regionais.
 - Aplicabilidade: Mede o investimento em infraestrutura de transporte coletivo de massa, como metrô, VLT e BRT.
- **Uso de bicicletas como meio de transporte sustentável**
 - Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), PNS, Observatórios de Mobilidade Urbana.
 - Aplicabilidade: Permite acompanhar a adesão ao transporte ciclovitário, refletindo mudanças de comportamento e estrutura urbana.
- **Existência de projetos e infraestrutura voltados à caminhabilidade e acessibilidade de pedestres**
 - Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios Brasileiros, Ministério das Cidades.
 - Aplicabilidade: Indica ações municipais que promovem cidades mais inclusivas, saudáveis e centradas nas pessoas.

3.1.2 ESPAÇOS VERDES

Os espaços verdes configuram um componente central para a promoção da saúde, bem-estar e sustentabilidade dos territórios. Esta subdimensão articula elementos relacionados à infraestrutura ecológica urbana, acesso equitativo à natureza, mitigação das mudanças climáticas, preservação da biodiversidade e qualidade ambiental percebida e objetiva (GALINDO; FURTADO, 2004; LIM et al., 2023). A presença e a distribuição adequada de áreas verdes contribuem para o controle da temperatura urbana, melhoria da qualidade do ar, redução de ruídos e estímulo à convivência comunitária.

Essa categoria é composta por indicadores que abordam desde a quantidade e distribuição de vegetação até padrões de certificação ambiental de edifícios, refletindo a crescente importância da sustentabilidade urbana no planejamento territorial.

Os indicadores internacionais refletem padrões de avaliação utilizados em diversos contextos urbanos ao redor do mundo. Esses indicadores oferecem parâmetros comparativos internacionais e são fundamentais para o alinhamento das cidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação contra a mudança global do clima) e 15 (Vida terrestre). Entre eles, destacam-se:

- Infraestrutura/Espaço verde (WEBSTER; SANDERSON, 2013; WEN et al., 2024);
- Taxa de cobertura florestal (HUANG et al., 2024; LV et al., 2022);
- Área de reflorestamento e área verde em parques e jardins urbanos (HUANG et al., 2024);
- Espaço verde per capita (m²/pessoa) (LI et al., 2024; YANG et al., 2020);
- % de bairros com parques ou faixas naturais (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023)
- Número de áreas verdes urbanas ≥ 20 hectares (ZIAFATI et al., 2023);
- % da área urbana coberta por árvores (PINEO et al., 2018);
- % de edifícios com telhados verdes ou certificados com padrões sustentáveis (LEED, BREEAM) (PINEO et al., 2018);
- Hectares de área verde por 100 mil habitantes (PINEO et al., 2018);
- % de habitações a menos de 300m de áreas verdes ≥ 1 hectare (PINEO et al., 2018);
- Proporção de áreas verdes e espaços abertos (LIU et al., 2023; LUO et al., 2022);
- Salubridade ambiental e governança urbana (GALINDO; FURTADO, 2004; LUO et al., 2022)
- Variação na biodiversidade (ex: espécies nativas) (PINEO et al., 2018).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro relacionados aos espaços verdes, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **m² de área verde por habitante**

- Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios, MapBiomas (Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil)
- Aplicabilidade: Mede a disponibilidade média de áreas verdes por pessoa no município; pode ser usado como referência para metas urbanísticas.

- **Proporção da população com acesso a áreas verdes a menos de 300 metros da residência**

- Fonte: Planos Diretores Municipais, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) locais.
- Aplicabilidade: Permite avaliar a equidade territorial no acesso a espaços verdes, especialmente relevante em zonas densamente urbanizadas.

- **Percentual da área urbana com cobertura vegetal contínua**

- Fonte: MapBiomas, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
- Aplicabilidade: Indica a proporção da malha urbana ocupada por vegetação nativa ou regenerada, sendo essencial para o monitoramento ambiental.

- **Número de praças e parques por bairro ou distrito**

- Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios, bases de dados municipais.
- Aplicabilidade: Avalia a distribuição geográfica de equipamentos públicos de lazer e sua contribuição para o verde urbano.

- **% de escolas e unidades de saúde com áreas verdes acessíveis**

- Fonte: Bases de dados locais, Relatórios de Gestão, Planos Diretores Municipais, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) locais.
- Aplicabilidade: Aponta a integração entre áreas verdes e equipamentos públicos estratégicos.

- **Incremento anual de desmatamento na Amazônia Legal**

- Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Plataforma TerraBrasilis / Projeto PRODES (Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite). Link de acesso: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>.
- Aplicabilidade: Este indicador mensura a área total desmatada anualmente na Amazônia Legal brasileira, expressa em km². Permite identificar a tendência de avanço do desmatamento ao longo do tempo, avaliar a eficácia de políticas ambientais e direcionar ações de fiscalização, conservação e mitigação da degradação ambiental.

Os dados estão disponíveis com abrangência municipal, estadual e por Unidade da Federação (UF), possibilitando análises territoriais específicas e comparações interregionais. Pode ser usado como marcador da sustentabilidade ambiental e da integridade ecológica dos territórios amazônicos.

- **Áreas protegidas em zona urbana ou periurbana (ex: APPs urbanas, RPPNs municipais)**
 - Fonte: Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), IBGE – Mapas Municipais.
 - Aplicabilidade: Garante a conservação de ecossistemas relevantes dentro da malha urbana ou em sua borda, com benefícios ambientais e sociais.
- **Presença de telhados verdes ou infraestrutura urbana com soluções baseadas na natureza (SbN)**
 - Fonte: Planos Diretores, legislações ambientais locais.
 - Aplicabilidade: Pode ser levantado via registros municipais e promove práticas de resiliência urbana.

3.1.3 INFRAESTRUTURA

A subdimensão Infraestrutura trata dos elementos estruturantes e funcionais que compõem o tecido urbano e que são indispensáveis para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis. Engloba indicadores relacionados à morfologia urbana, uso do solo, mobilidade multimodal, infraestrutura sanitária, conectividade digital, preservação do patrimônio histórico e cultural, e qualidade do ambiente construído.

Esta categoria é transversal e intersetorial, conectando temas como acessibilidade universal, equidade espacial, resiliência urbana, eficiência energética, resposta a emergências (como pandemias) e função social das cidades.

Os indicadores internacionais refletem padrões de avaliação utilizados em diversos contextos urbanos ao redor do mundo relacionados à infraestrutura:

- Número médio de tipos de uso do solo por bairro (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de bairros que incluem atividades diurnas e noturnas (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Número de grandes quarteirões com acesso restrito ou corte limitado (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);

- Número de grandes espaços públicos dentro da malha urbana (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Número de ruas completas (com infraestrutura para todos os modais de mobilidade) (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de terreno urbano destinado a espaço público aberto (excluindo ruas) (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023)
- Percentual da população com acesso à banda larga de alta velocidade (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de edifícios localizados em zonas de risco de inundação (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de locais de trabalho noturnos sem disponibilidade de estacionamento (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Número de ruas sem calçadas (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual da população que vive e trabalha no mesmo bairro (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de bairros com centro comunitário (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de locais históricos utilizados ou visitados no cotidiano (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de unidades educacionais instaladas em edifícios de valor histórico (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Percentual de edifícios altos com lojas no térreo e espaços comunitários integrados (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Circularidade da forma urbana (relação entre área urbana e círculo de contorno) (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Fragmentação da forma urbana (relação entre áreas dispersas e total urbano) (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);

- Percentual da área urbana abandonada (ZIAFATI;CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Número de edifícios históricos demolidos anualmente (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Número total de marcos históricos registrados (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023)
- Percentual de bairros com composição social mista (ZIAFATI; CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Ventilação adequada em edifícios urbanos (CACIQUE et al., 2022);
- Adaptações estruturais urbanas para resposta a pandemias (CACIQUE et al., 2022);
- Metros quadrados de espaço público (interno e externo) per capita (CACIQUE et al., 2022);
- Índice de controle de qualidade da construção urbana (CACIQUE et al., 2022);
- Percentual da população a menos de 500 metros de rodovia ou via principal (PINEO et al., 2018);
- Número de registros nacionais de proteção do patrimônio cultural imaterial (ZHAO et al., 2023);
- Taxa de urbanização (relação entre população urbana e total) (ZHAO et al., 2023; LIU et al., 2023);
- Existência de mecanismos legais de proteção ao patrimônio cultural e natural (BOTCHWAY et al., 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro relacionados à infraestrutura, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Proporção de domicílios com acesso à rede geral de esgotamento sanitário**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
 - Aplicabilidade: Indicador essencial para monitorar a universalização do saneamento e as desigualdades intraurbanas.

- **Índice de tratamento de esgoto**

- Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).
- Aplicabilidade: Permite avaliar a efetividade da coleta e tratamento de efluentes, com impactos diretos na saúde ambiental e pública.

- **Proporção de domicílios com destinação adequada de resíduos sólidos**

- Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) / SNIS.
- Aplicabilidade: Indica o grau de organização da gestão de resíduos no município e sua conformidade com as normas ambientais.

- **Metros quadrados de espaço público interno e externo per capita**

- Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios / Planos Diretores Municipais.
- Aplicabilidade: Permite aferir o acesso equitativo a espaços de convivência urbana e lazer.

- **Percentual de área urbana destinada a espaços públicos abertos (excluindo ruas)**

- Fonte: Sistemas de Informação Geográfica Municipais (SIG), Planos Diretores.
- Aplicabilidade: Essencial para avaliar a qualidade do ambiente urbano e o cumprimento da função social da cidade.

- **Número de edifícios em zonas de risco (ex: áreas de inundação ou escorregamento)**

- Fonte: IBGE – Mapas de Risco / Defesa Civil / SIG municipais.
- Aplicabilidade: Indica a vulnerabilidade urbana a desastres ambientais e subsidia ações de mitigação.

- **Número de marcos históricos e áreas tombadas**

- Fonte: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), legislações municipais.
- Aplicabilidade: Fundamenta políticas de preservação do patrimônio cultural e incentiva a identidade urbana.

- **Taxa de urbanização municipal**

- Fonte: IBGE – Censo Demográfico.
- Aplicabilidade: Expressa a proporção da população em áreas urbanas e é usada no planejamento territorial e ambiental.

- **Percentual de domicílios com acesso à internet de banda larga**

- Fonte: IBGE – PNAD TIC, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
- Aplicabilidade: Reflete a conectividade digital, essencial para educação, trabalho remoto e serviços públicos.

- **Percentual de ruas com calçadas acessíveis e seguras**

- Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios, auditorias urbanas locais.
- Aplicabilidade: Mede a caminhabilidade urbana e a inclusão de pessoas com deficiência.

3.1.4 OUTROS INDICADORES RELATIVOS À SUSTENTABILIDADE

Esta subdimensão contempla um conjunto heterogêneo de indicadores que tangenciam aspectos menos explorados nas categorias tradicionais da sustentabilidade urbana, mas que são igualmente fundamentais para a construção de territórios saudáveis, resilientes e sustentáveis.

Reúnem-se aqui dimensões como resiliência urbana, infraestrutura verde e cinza, governança sustentável, acesso a serviços básicos, reciclagem, controle de incômodos ambientais, entre outros fatores de ordem política, jurídica, econômica, ecológica e socioterritorial.

Os principais indicadores internacionais identificados na literatura são:

- Relação entre taxa de consumo de terra e taxa de crescimento populacional (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Número de sítios industriais abandonados (WEBSTER; SANDERSON, 2013);
- Qualidade e área do espaço de vida urbano (WEBSTER; SANDERSON, 2013);
- Capacidade de resiliência urbana frente a crises (WEN et al., 2024);
- Disponibilidade de utilidades e serviços urbanos essenciais (WEN et al., 2024);
- Incômodos ambientais: poluição sonora, visual e por odor (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Sustentabilidade político jurídica: acordos, legislações, planos e diretrizes locais (PETERSEN et al., 2020);
- Sustentabilidade econômica: recursos para saúde, água, saneamento e avaliação de políticas (LAUREANO-EUGENIO et al., 2021);
- Taxa de penetração do gás urbano (residencial e industrial) (HUANG et al., 2024);

- Comprimento da rede de drenagem urbana (HUANG et al., 2024);
- Área de terrenos destinados à construção urbana (HUANG et al., 2024);
- Volume de fornecimento de gás natural urbano (HUANG et al., 2024);
- Grau de urbanização por município ou região (HUANG et al., 2024);
- Proporção de cidades com planos de desenvolvimento urbano sustentáveis e integrados (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Proporção de áreas verdes e patrimônio cultural em situação de abandono ou sem manutenção (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Construção do conceito de “sustentabilidade única” para cada cidade (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Indicadores de mudanças climáticas, desastres naturais, congestionamentos e poluição atmosférica (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Taxa de reciclagem urbana e infraestrutura associada (CACIQUE et al., 2023);
- Disponibilidade de serviços de saúde ambiental (água, ar, ruído, solo) (CACIQUE et al., 2023);
- Capacidade institucional de redução de impactos de desastres naturais (BOTCHWAY et al., 2023);
- Capacidade de mitigação dos impactos ambientais urbanos (BOTCHWAY et al., 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Índice de Vulnerabilidade Social – Infraestrutura Urbana (IVS-Infraestrutura)**
 - Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – Atlas da Vulnerabilidade Social;
 - Aplicabilidade: Avalia as condições de acesso da população de baixa renda a saneamento, mobilidade e serviços públicos essenciais.

- **Percentual de municípios com plano diretor que incorpora diretrizes de sustentabilidade urbana**

- Fonte: IBGE – Perfil dos Municípios Brasileiros (MUNIC);
- Aplicabilidade: Avalia o grau de institucionalização da sustentabilidade nos instrumentos legais de ordenamento territorial.

3.1.5 ENERGIA

Esta subdimensão abrange tanto o acesso à energia quanto a sustentabilidade da matriz energética utilizada. O uso de fontes renováveis é essencial para mitigação das mudanças climáticas.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- Consumo de energia (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- % da população com serviço de eletricidade autorizado (CACIQUE et al., 2022; PINEO et al., 2018);
- % de energia derivada de fontes renováveis (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Proporção da matriz energética municipal composta por fontes renováveis**
 - Fonte: ANEEL / Empresa de Pesquisa Energética (EPE);
 - Aplicabilidade: Compreender a matriz energética municipal composta por fontes renováveis.
- **Emissão per capita de CO2 equivalente**
 - Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) / Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA);
 - Aplicabilidade: Compreender as emissão do CO2.
- **Consumo médio de energia elétrica residencial**
 - Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
 - Aplicabilidade: Disponível por concessionária com recorte municipal.

3.1.6 QUALIDADE DE ÁGUA

Os indicadores que avaliam a potabilidade, distribuição e acesso à água tratada são fundamentais para a saúde pública.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- Qualidade dos rios (CACIQUE et al., 2022);
- %de edifícios com abastecimento de água potável(CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Taxa de penetração de água urbana (HUANG et al., 2024).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Percentual da população atendida por rede geral de água**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);
 - Aplicabilidade: Disponível para todos os municípios brasileiros.
- **Índice de perdas na distribuição de água tratada**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);
 - Aplicabilidade: Importante para avaliar a eficiência do serviço de abastecimento local.
- **Proporção de amostras fora do padrão microbiológico**
 - Fonte: Sistema de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA / Ministério da Saúde);
 - Aplicabilidade: Indicador de qualidade da água potável disponível nos municípios.

3.1.7 QUALIDADE / POLUIÇÃO DO AR

A qualidade do ar é um dos aspectos mais críticos para a saúde humana e para a sustentabilidade ambiental urbana. A exposição prolongada a poluentes atmosféricos é associada a doenças respiratórias, cardiovasculares e à mortalidade precoce.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- Concentração de PM2.5 (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023; LV et al., 2022; PINEO et al., 2018);

- Concentração de NO₂ (µg/m³) (PINEO et al., 2018);
- Concentração de PM₁₀ (µg/m³) (PINEO et al., 2018);
- Proporção de dias com boa qualidade do ar (LI et al., 2024);
- Número de dias com poluição severa (LI et al., 2024).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Concentração média anual de PM_{2.5} e PM₁₀**

- Fonte: Sistema Nacional de Qualidade do Ar (MonitorAr/IBAMA);
- Aplicabilidade: Dados disponíveis por estados e grandes centros urbanos, permitindo comparações intermunicipais.

- **Número de dias com qualidade do ar "inadequada"**

- Fonte: CETESB e órgãos ambientais estaduais;
- Aplicabilidade: Aplicável especialmente em áreas urbanas com estações de monitoramento.

- **Mortalidade por doenças respiratórias**

- Fonte: DATASUS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM);
- Aplicabilidade: Disponível por município; permite correlação com dados ambientais.

3.1.8 QUALIDADE DO SOM

A exposição a ruídos intensos afeta a qualidade de vida e pode causar danos à saúde auditiva e mental.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- % da população exposta a ruído acima de 55dB (PINEO et al., 2018);
- % de moradores com incômodo relatado por ruído (PINEO et al., 2018).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **% da população exposta a níveis superiores a 55dB**
 - Fonte: Pesquisa de Percepção Urbana
 - Aplicabilidade: Aplicação em grandes centros urbanos com dados de monitoramento.
- **Queixas sobre ruído**
 - Fonte: Ouvidorias municipais, registros policiais;
 - Aplicabilidade: Indicador de percepção da população sobre o incômodo acústico.

3.1.9 QUALIDADE DO SOLO

A qualidade do solo está diretamente ligada à sustentabilidade do uso da terra e à segurança ambiental.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- Acidificação do solo (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Poluição do solo (CACIQUE et al., 2022);
- Mistura de uso do solo (PINEO et al., 2018).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Percentual de área urbana com solo impermeabilizado**
 - Fonte: MapBiomas;
 - Aplicabilidade: Monitoramento anual com recorte municipal.
- **Existência de áreas contaminadas por resíduos**
 - Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) / Órgãos Estaduais;
 - Aplicabilidade: Dados disponíveis por região e, em alguns casos, por município.
- **Proporção de domicílios em áreas de risco geológico**
 - Fonte: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) / Defesa Civil;
 - Aplicabilidade: Baseado em mapeamentos de risco municipais.

3.1.10 AQUECIMENTO GLOBAL

Esta subdimensão foca nos efeitos das emissões de gases de efeito estufa e suas consequências locais e globais.

Os principais indicadores internacionais identificados na revisão de escopo são:

- Emissão de gases de efeito estufa per capita (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Índice de calor urbano (PINEO et al., 2018).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Emissões de CO2 per capita**
 - Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) / Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA);
 - Aplicabilidade: Dados comparáveis em nível municipal para monitoramento de metas climáticas.
- **Número de eventos climáticos extremos registrados**
 - Fonte: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) / Defesa Civil;
 - Aplicabilidade: Permite rastrear impactos e tendências associadas às mudanças climáticas.
- **Existência de plano municipal de adaptação climática**
 - Fonte: Plataforma ClimaAdapt / Ministério do Meio Ambiente (MMA);
 - Aplicabilidade: Avaliação qualitativa da resiliência climática municipal.
- **Índice de vulnerabilidade socioambiental**
 - Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) / MapBiomass;
 - Aplicabilidade: Disponível com dados georreferenciados; importante para análise territorial integrada.

3.2 DIMENSÃO: SOCIO-ECONÔMICA

A dimensão “Socioeconômica” (Webster; Sanderson, 2013) evidencia o papel estruturante das determinações sociais na conformação de territórios saudáveis e sustentáveis, agregando um conjunto de 113 indicadores.

Tais indicadores abrangem dimensões fundamentais da justiça social e do desenvolvimento humano, incluindo variáveis relacionadas a habitação e saneamento básico, segurança alimentar e nutricional (3.1.2), oferta de equipamentos e oportunidades de esporte e lazer (3.1.3), acesso e permanência na educação (3.1.4), renda e condições econômicas (3.1.5), bem como acesso a tecnologias de informação e comunicação, especialmente à internet (3.1.6).

Esses elementos são expressivos do grau de equidade territorial e do atendimento às necessidades humanas básicas, constituindo-se como determinantes críticos para a promoção da saúde e a redução das iniquidades sociais.

3.2.1 HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO

A subdimensão "Habitação e Saneamento Básico" compreende dimensões essenciais para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis, refletindo diretamente nas condições de vida, bem-estar e equidade em saúde. A habitação adequada e o acesso a saneamento básico seguro são determinantes sociais críticos para a saúde e estão fortemente associados a indicadores de morbidade, mortalidade e qualidade de vida. Essa categoria integra um conjunto de indicadores que visam mensurar tanto as condições estruturais das moradias quanto o acesso da população aos serviços essenciais de água, esgoto, coleta de resíduos e drenagem urbana.

Os indicadores internacionais, conforme a literatura científica sistematizada, abrangem múltiplas dimensões, permitindo uma avaliação ampla da adequação da moradia e dos serviços básicos. Destacam-se:

- Proporção da população urbana vivendo em favelas ou habitações inadequadas (Matias; Campos, 2022; Pineo et al., 2018);
- Número de pessoas sem-abrigo por 10.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Pineo et al., 2018);
- Qualidade da moradia e eficiência energética (Wen et al., 2024; Lim et al., 2023);
- Acesso à água potável e esgotamento sanitário adequado (Matias; Campos, 2022; Webster; Sanderson, 2013);
- Porcentagem da população com coleta de resíduos sólidos (Pineo et al., 2018);
- Reciclagem de resíduos e esgoto (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);

- Manejo inofensivo de resíduos (Lv et al.,2022; Zhao et al., 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Proporção de domicílios em aglomerados subnormais**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Demográfico (<https://censo2022.ibge.gov.br>);
- Aplicabilidade: Identificação de áreas vulneráveis para políticas habitacionais e de reurbanização.

- **Déficit habitacional absoluto e relativo**

- Fonte: Fundação João Pinheiro (<http://www.fjp.mg.gov.br>);
- Aplicabilidade: Apoio ao planejamento de programas de habitação social e subsídios.

- **Condição de moradia (tipo de material, densidade de moradores por cômodo, precariedade)**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Demográfico e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua;
- Aplicabilidade: Avaliação das condições estruturais da habitação, relacionadas ao risco sanitário.

- **Percentual de domicílios com banheiro exclusivo e água canalizada**

- Fonte: Sistema de Informação sobre Qualidade da Água para Consumo Humano – SISAGUA (<https://sisagua.saude.gov.br>);
- Aplicabilidade: Monitoramento do acesso mínimo à infraestrutura sanitária domiciliar.

- **Índice de Vulnerabilidade Habitacional Municipal (IVHM)**

- Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) / Observatório das Metrópoles;
- Aplicabilidade: Mapeamento de áreas críticas para intervenções prioritárias em habitação.

- **Percentual de domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água**

- Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (<https://www.snis.gov.br>);
- Aplicabilidade: Planejamento de universalização do acesso à água potável.

- **Percentual de domicílios com acesso à rede de esgotamento sanitário**

- Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- Aplicabilidade: Monitoramento de metas do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB.

- **Taxa de tratamento de esgoto**

- Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
- Aplicabilidade: Indicador de eficiência da rede de saneamento em áreas urbanas.

- **Percentual da população com coleta regular de resíduos sólidos**

- Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- Aplicabilidade: Monitoramento da cobertura da coleta domiciliar e gestão de resíduos.

- **Proporção de resíduos sólidos urbanos dispostos adequadamente**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE / Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
- Aplicabilidade: Avaliação da sustentabilidade ambiental da gestão municipal de resíduos.

- **Cobertura de serviços de drenagem urbana**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE / Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
- Aplicabilidade: Diagnóstico de risco de inundações e impactos urbanos relacionados.

- **Incidência de doenças de veiculação hídrica associadas à ausência de saneamento**

- Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN;
- Aplicabilidade: Identificação de correlação entre saúde ambiental e agravos como hepatite A e diarreia.

3.2.2 SEGURANÇA ALIMENTAR

A segurança alimentar é definida como a garantia de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Trata-se de uma dimensão fundamental para territórios saudáveis e sustentáveis, uma vez que envolve desde a disponibilidade de alimentos até sua acessibilidade econômica, física, nutricional e cultural.

A insegurança alimentar, por outro lado, expressa privações alimentares que podem acarretar desnutrição, doenças crônicas e agravos psicossociais.

A literatura internacional destaca indicadores que permitem avaliara qualidade, a acessibilidade e a distribuição equitativa dos alimentos nos territórios. Destacam-se:

- Acesso a alimentos (Wen et al., 2024);
- Segurança alimentar baseada em inspeção alimentar por amostragem/lote por mil habitantes (Li et al., 2024);
- Desenvolvimento de infraestrutura pública para acesso a alimentos (Lim et al.,2023);
- % de escolas alimentadoras (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de bairros com lojas de alimentos frescos(Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de bairros com hortas comunitárias (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de bairros com restaurantes acessíveis (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Higiene alimentar e condições de comercialização de alimentos (Cacique et al., 2022);
- Nutrição e educação alimentar (Cacique et al., 2022);
- Assinatura do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão (Pineo et al., 2018);
- Acessibilidade alimentar– distância de caminhada até estabelecimentos com frutas e vegetais (Pineo et al., 2018)
- % de domicílios sem veículo a mais de 1,5 km de supermercados (Pineo et al., 2018)
- Número de pontos de venda de alimentos fresco sem raio de 500 metros de residências (Pineo et al., 2018);
- % de moradores que percebem disponibilidade de alimentos saudáveis no bairro (Pineo et al., 2018)
- Porcentagem de crianças menores de 2 anos com subnutrição proteico-calórica (Nascimento et al., 2014)

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Percentual de domicílios em insegurança alimentar leve, moderada ou grave**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa de Orçamentos Familiares;
 - Aplicabilidade: Avaliação do acesso aos alimentos por grupos populacionais; subsídio para políticas de assistência social e segurança alimentar.
- **Percentual da população com fome (insegurança alimentar grave)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa de Orçamentos Familiares / Inquéritos com base na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar;
 - Aplicabilidade: Planejamento de ações emergenciais e programas de transferência de renda.
- **Prevalência de subnutrição proteico-calórica em crianças menores de 5 anos**
 - Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) – Ministério da Saúde;
 - Aplicabilidade: Monitoramento da situação nutricional por município; base para ações intersetoriais.
- **Prevalência de excesso de peso em escolares de 5 a 9 anos**
 - Fonte: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) / Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL);
 - Aplicabilidade: Planejamento de políticas de promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil.
- **Número de feiras livres, hortas comunitárias e mercados públicos cadastrados no município**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Entidades e Equipamentos da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional / Companhia Nacional de Abastecimento;
 - Aplicabilidade: Diagnóstico da infraestrutura alimentar local; subsídio para políticas de abastecimento e circuitos curtos de comercialização.
- **Percentual de escolas públicas com alimentação escolar adequada e saudável**
 - Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Programa Nacional de Alimentação Escolar;
 - Aplicabilidade: Monitoramento da alimentação escolar como estratégia de segurança alimentar e educação nutricional.

- **Número de beneficiários do Programa Bolsa Família ou do Programa Auxílio Brasil**
 - Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
 - Aplicabilidade: Identificação de grupos em situação de vulnerabilidade alimentar e social.
- **Existência de Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional**
 - Fonte: Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional / Sistema de Convênios do Governo Federal;
 - Aplicabilidade: Avaliação da capacidade de gestão intersetorial da política pública de segurança alimentar em nível local.

3.2.3 ESPORTE E LAZER

A subdimensão esporte e lazer refere-se ao conjunto de condições, estruturas e oportunidades que garantem às pessoas o direito de viver para além do trabalho, promovendo bem-estar, saúde física e mental, inclusão social e desenvolvimento comunitário. O acesso equitativo a atividades esportivas e espaços de lazer representa um componente essencial de territórios saudáveis e sustentáveis.

A literatura internacional tem evidenciado a relevância da infraestrutura e da prática regular de atividades físicas como marcadores de qualidade de vida e saúde pública. Destacam-se:

- Instalações desportivas e de lazer disponíveis (Webster; Sanderson, 2013; Wen et al., 2024; Moura et al., 2021);
- Área de estádios por habitante (X10 per capita)(Li et al., 2024);
- Proporção de instrutores de esportes sociais por 1.000 habitantes (Li et al., 2024);
- Proporção da população que atingiu os padrões nacionais de aptidão física(Li et al., 2024);
- Proporção da população que pratica regularmente atividade física (Li et al., 2024);
- Disponibilidade de instalações públicas próximas a áreas residenciais e de trabalho (Lim et al., 2023);
- Área de recreação interna per capita (m²) (Cheshmehzangi; Ankowska,2023; Pineo et al., 2018);

- Área de recreação ao ar livre per capita (m²) (Pineo et al., 2018);
- Acesso a instalações de lazer dentro de 600 metros por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018);
- Equipamentos para parques infantis pré-escolares (Pineo et al., 2018);
- Número de centros de fitness por 100.000 habitantes (Pineo et al., 2018);
- Instalações esportivas por 10.000 habitantes (Yang et al., 2020; Zhao et al., 2023);
- Área de campos esportivos per capita (Zhao et al., 2023);
- População que pratica exercícios regularmente (Cacique et al., 2022).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Número de equipamentos públicos de esporte e lazer (quadras, ginásios, pistas de caminhada, praças ativas, etc.)**
 - Fonte: Plano Diretor Municipal e registro em sites oficiais das Prefeituras;
 - Aplicabilidade: Diagnóstico da presença e distribuição de equipamentos de esporte e lazer no território municipal.
- **Presença de equipamentos de lazer adaptados para pessoas com deficiência**
 - Fonte: Plano Diretor Municipal;
 - Aplicabilidade: Avaliação da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência em espaços públicos de lazer.
- **Área de parques e praças públicas por habitante (m²/hab)**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – Indicadores Urbanos / Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal;
 - Aplicabilidade: Planejamento urbano e monitoramento da provisão equitativa de áreas verdes recreativas.
- **Proporção de estudantes com prática de atividade física regular**
 - Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PENSE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Ministério da Saúde);
 - Aplicabilidade: Monitoramento de hábitos saudáveis entre adolescentes e apoio a políticas escolares de promoção da saúde.

- **Presença de secretarias ou coordenações municipais específicas para esporte e lazer**
 - Fonte: Plano Diretor Municipal
 - Aplicabilidade: Avaliação da capacidade institucional de gestão e formulação de políticas públicas setoriais.

3.2.4 EDUCAÇÃO

A subdimensão Educação é um componente central para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis. Ela compreende o acesso equitativo e contínuo à educação formal em diferentes etapas da vida, abrangendo desde a educação básica até o ensino superior, e incorpora aspectos como qualidade do ensino, permanência escolar, equidade de gênero e alfabetização em saúde. A educação qualificada é uma das principais determinantes sociais da saúde e tem impacto direto sobre oportunidades de vida, renda, cidadania e bem-estar.

A literatura internacional sistematizada tem evidenciado alguns indicadores. Destacam-se:

- Número de estudantes universitários por 10.000 habitantes (Zhao et al., 2023);
- Volume de livros em bibliotecas públicas por 10.000 habitantes (Zhao et al., 2023; Lv et al., 2022);
- Percentual de bairros com escolas públicas (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Nível de alfabetização em saúde da população (Li et al., 2024);
- Percentual da população com formação acadêmica em ciências (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Idade média de conclusão do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014);
- Porcentagem de crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental (Nascimento et al., 2014);
- Taxa de abandono escolar no 1º ano do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014);
- Distorção idade-série no 4º e 8º ano do ensino fundamental (Nascimento et al., 2014);

- Proporção de gênero nas matrículas do ensino fundamental, médio e superior (Nascimento et al., 2014);
- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – componente educação (Petersen et al., 2020)

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Taxa de matrícula líquida no ensino fundamental (crianças de 6 a 14 anos)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) / Censo Escolar – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP);
 - Aplicabilidade: Avaliação da universalização do acesso à educação obrigatória em idade adequada.
- **Taxa de matrícula líquida no ensino médio (jovens de 15 a 17 anos)**
 - Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP / Censo Escolar;
 - Aplicabilidade: Diagnóstico do acesso ao ensino médio em tempo oportuno; base para políticas de permanência.
- **Número de estabelecimentos escolares públicos por 10.000 habitantes**
 - Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica;
 - Aplicabilidade: Avaliação da distribuição espacial das escolas no território municipal.
- **Taxa de distorção idade-série (4º e 8º ano do ensino fundamental)**
 - Fonte: INEP – Censo Escolar
 - Aplicabilidade: Indicador de fluxo escolar adequado; sinaliza reprovação, abandono ou atraso escolar.
- **Taxa de abandono escolar no ensino fundamental e médio**
 - Fonte: INEP – Censo Escolar / Painel de Indicadores da Educação Básica;
 - Aplicabilidade: Monitoramento da permanência dos estudantes; subsídio para ações de busca ativa escolar.
- **Média de desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**
 - Fonte: INEP – IDEB;
 - Aplicabilidade: Avaliação da qualidade da educação básica, combinando proficiência em língua portuguesa e matemática com taxa de aprovação.

- **Percentual da população com ensino fundamental completo (≥ 18 anos)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Demográfico;
 - Aplicabilidade: Indicador de capital humano local; correlaciona-se com emprego, renda e saúde.
- **Percentual da população com ensino médio e superior completo**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – PNAD Contínua / Censo;
 - Aplicabilidade: Subsídio para políticas de qualificação profissional e redução de desigualdades educacionais.
- **Média de anos de estudo da população de 25 anos ou mais**
 - Fonte: Programadas Nações Unidas para o Desenvolvimento – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM – Educação);
 - Aplicabilidade: Medida consolidada de escolaridade da população adulta; indicador estratégico de desenvolvimento social.
- **Proporção de gênero nas matrículas da educação básica e superior**
 - Fonte: INEP – Censo Escolar e Censo da Educação Superior;
 - Aplicabilidade: Monitoramento da equidade de gênero no acesso à educação em diferentes níveis.
- **Percentual de estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família (ou Auxílio Brasil) matriculados na rede pública**
 - Fonte: Ministério da Educação / Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
 - Aplicabilidade: Identificação de estudantes em vulnerabilidade social para ações intersetoriais.
- **Número de bibliotecas públicas por 10.000 habitantes**
 - Fonte: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – Ministério da Cultura;
 - Aplicabilidade: Avaliação do acesso à leitura e ao material informacional em território municipal.
- **Volume de livros disponíveis em bibliotecas públicas municipais por habitante**
 - Fonte: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas / Cadastro Nacional de Bibliotecas Públicas/ Banco de dados local;
 - Aplicabilidade: Indicador de acesso a recursos educativos e culturais.

3.2.5 RENDA

A subdimensão renda é significativa para a análise das desigualdades sociais e econômicas nos territórios. Reflete não apenas o acesso a recursos financeiros, mas também as oportunidades de inserção produtiva, formalização do trabalho e superação da pobreza. É também um fator determinante para o acesso a direitos sociais como alimentação, moradia, educação e saúde. Essa dimensão está diretamente relacionada à estrutura econômica local, às políticas públicas de proteção social e aos arranjos de produção e trabalho vigentes.

Os principais indicadores sistematizados internacionalmente para mensurar as condições de renda e trabalho incluem:

- Condições econômicas gerais da população (Moura et al., 2021);
- Emprego e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho (Webster; Sanderson, 2013);
- Índice de Vulnerabilidade Social (dimensão renda e trabalho): desocupação de adultos, informalidade, dependência de renda de idosos e trabalho infantil (Petersen et al., 2020);
- Percentual de pessoas abaixo da média de renda per capita (Cacique et al., 2022);
- Componente de renda do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM Renda (Petersen et al., 2020)

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Renda média domiciliar per capita (em reais)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censo Demográfico / Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua);
 - Aplicabilidade: Avaliação do padrão médio de renda das famílias; permite identificar desigualdades entre regiões e grupos populacionais.
- **Percentual da população com renda inferior a 1/2 salário mínimo per capita**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – PNAD Contínua/ Censo;
 - Aplicabilidade: Identificação da população em situação de pobreza e extrema pobreza e extrema pobreza; subsídio para programas de transferência de renda.

- **Índice de Gini da renda domiciliar per capita**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – PNAD Contínua;
- Aplicabilidade: Medida da desigualdade na distribuição de renda em cada município; quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade.

- **Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – componente Renda (IDHM-Renda)**

- Fonte: Programadas Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/ Fundação João Pinheiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
- Aplicabilidade: Mede a renda per capita ajustada, permitindo comparações entre municípios e regiões; integra o IDHM com as dimensões Educação e Longevidade.

- **Índice de Vulnerabilidade Social – dimensão Renda e Trabalho**

- Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – Atlas da Vulnerabilidade Social;
- Aplicabilidade: Indicador sintético que considera informalidade, desemprego, dependência de benefícios e presença de trabalho infantil; essencial para planejamento intersetorial.

3.2.6 ACESSO À INTERNET

O acesso à internet é um elemento central para a inclusão digital e para o exercício pleno da cidadania na contemporaneidade. Mais do que uma questão tecnológica, trata-se de um determinante social da equidade no acesso à informação, educação, saúde digital, participação social, oportunidades econômicas e serviços públicos. A ausência de conexão ou sua má qualidade amplia desigualdades e compromete o desenvolvimento de territórios sustentáveis, especialmente em populações vulneráveis, zonas rurais e periferias urbanas.

Os indicadores internacionais sistematizados para mensurar o acesso e a conectividade digital incluem:

- Taxa de penetração da internet – proporção da população com acesso à internet fixa ou móvel (Zhao et al., 2023);
- Taxa de penetração da internet entre residentes – incluindo frequência de uso, tipo de conexão e distribuição geográfica (Lv et al., 2022);
- Proporção de domicílios com computador e acesso à internet de alta velocidade (OCDE, 2022; ITU, 2023);

- Número de pontos públicos de acesso gratuito à internet (wi-fi comunitário, bibliotecas, centros digitais, escolas)
- Disparidades de acesso à internet entre áreas urbanas e rurais (UN-Habitat, 2022)
- Índice de Desenvolvimento da Banda Larga– avalia infraestrutura, cobertura, acessibilidade e políticas públicas (ITU, 2023)

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Percentual de domicílios com acesso à internet (qualquer tipo de conexão)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: módulo de Tecnologias da Informação e Comunicação;
 - Aplicabilidade: Mede o grau de inclusão digital em domicílios, com possibilidade de desagregação por zona urbana/rural, tipo de conexão e renda.
- **Percentual de domicílios com acesso à internet exclusivamente por celular**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua;
 - Aplicabilidade: Indica o tipo de conectividade predominante e limitações na qualidade e estabilidade do acesso.
- **Percentual de escolas públicas com acesso à internet**
 - Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Censo Escolar da Educação Básica;
 - Aplicabilidade: Mede a infraestrutura digital das escolas públicas, com desagregação por etapa de ensino e localização. Subsidia programas como o Programa Educação Conectada.
- **Existência de equipamentos públicos com internet gratuita (telecentros, praças digitais, bibliotecas públicas)**
 - Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Pesquisa de Informações Básicas Municipais;
 - Aplicabilidade: Indica a presença de infraestrutura digital comunitária e espaços de acesso público à internet no território.

- **Existência de legislação municipal sobre inclusão digital e conectividade**

- Fonte: Base de dados legislativa municipal / Instituto Brasileiro de Administração Municipal;
- Aplicabilidade: Indica o nível de institucionalização da política de acesso à internet no âmbito local.

3.3 SAÚDE

A dimensão "Saúde", composta por 89 indicadores, abrange o acesso aos serviços de saúde com foco nas singularidades dos indivíduos e na centralidade da pessoa no cuidado. Inclui também a quantidade e diversidade de profissionais de saúde, com destaque para o número de médicos, o que evidencia a persistência de um modelo medicalocêntrico. Integram essa dimensão indicadores sobre saúde materno-infantil, promoção da saúde e prevenção de doenças, incluindo ações de educação em saúde e cobertura vacinal, bem como aspectos relacionados à saúde da pessoa idosa e à saúde mental.

Além disso, a literatura especializada aponta a presença de diversos indicadores relacionados a doenças e agravos, nos quais a "ausência de doença" ainda é comumente utilizada como marcador de saúde. Também compõem essa dimensão os indicadores de mortalidade por diferentes causas, com ênfase para a mortalidade infantil, e os indicadores de longevidade, como a expectativa de vida ao nascer, que sinalizam o nível de desenvolvimento e bem-estar de uma população.

3.3.1 SERVIÇOS DE SAÚDE

Os serviços de saúde representam um componente fundamental para a materialização do direito à saúde, devendo ser organizados com base no acesso universal, na equidade e na integralidade do cuidado. Além do acesso em si, são essenciais a qualidade, a adequação cultural, a resolubilidade e a distribuição territorial dos serviços. As barreiras geográficas, financeiras, linguísticas e institucionais impactam diretamente na efetividade do sistema de saúde e na sua capacidade de resposta às necessidades da população, especialmente em territórios vulnerabilizados.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Porcentagem da população coberta por seguro de saúde (Webster; Sanderson, 2013);
- Disponibilidade de serviços em línguas estrangeiras (Webster; Sanderson, 2013);
- Debates sobre saúde na Câmara Municipal (Webster; Sanderson, 2013);

- Número de leitos em unidades de saúde por 1.000 pessoas (Li et al., 2024; Lv et al., 2022);
- % da população que se sente com boa saúde (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % da população que percebe estresse na vida diária (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de bairros que possuem um centro de saúde primário (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Número de farmácias por 1.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de hospitais públicos em áreas de baixa renda e vulneráveis (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- % de centros de saúde que oferecem assistência médica virtual (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Cobertura por seguro de saúde (Cacique et al., 2022);
- Hospitais e instalações de saúde comunitárias, escolas, centros comunitários (Cacique et al., 2022);
- Taxa de cobertura do seguro médico básico para residentes urbanos e rurais (Zhao et al., 2023);
- Número de instituições médicas (Liu et al., 2023);
- Serviço amigável de saúde (Luo et al., 2022).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde**

- Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
- Aplicabilidade: Mede o grau de cobertura dos serviços básicos no território, com possibilidade de desagregação municipal, por região de saúde e porte populacional.

- **Quantidade de Estabelecimentos de Saúde por município**

- Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/DATASUS ;
- Aplicabilidade: Indica a oferta de serviços por tipo (UBS, hospital, pronto-atendimento), porte e gestão, subsidiando análises sobre a capacidade instalada.

- **Cobertura de serviços especializados por tipo (CAPS, CER, SAE, CEO, Hospitais)**

- Fonte: CNES – DATASUS;
- Aplicabilidade: Permite avaliar a presença e distribuição dos pontos de atenção especializados, especialmente em saúde mental, reabilitação, doenças crônicas e atenção odontológica especializada.

3.3.2 PROFISSIONAIS DA SAÚDE

A força de trabalho em saúde constitui um eixo estratégico para a consolidação de territórios saudáveis e sustentáveis. O mapeamento e monitoramento da distribuição, qualificação, densidade e vínculo dos profissionais de saúde permitem compreender como se organiza a oferta de cuidado nos diferentes espaços do território, revelando desigualdades, vazios assistenciais e fragilidades na resposta institucional às necessidades da população.

Indicadores relacionados aos profissionais de saúde são fundamentais para o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas públicas. Eles subsidiam decisões sobre provimento e retenção de profissionais em áreas vulneráveis, alocação de recursos, reorganização das redes de atenção e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde como ordenadora do cuidado. Além disso, refletem a capacidade local de produzir cuidado integral, humanizado e culturalmente adequado, a partir da presença qualificada de equipes multiprofissionais em todos os pontos do território.

Nesse sentido, avaliar a presença e o desempenho da força de trabalho em saúde é essencial para o avanço de territórios que promovam o bem-estar, a equidade, a coesão social e a sustentabilidade no longo prazo.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Habitantes por profissional de saúde primário (Webster; Sanderson, 2013);
- Habitantes por enfermeiro (Webster; Sanderson, 2013);
- Número de médicos por 1.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023; Lv et al., 2022; Zhao et al., 2023)

- Número de médicos generalistas por 10.000 habitantes (Li et al., 2024);
- Número de profissionais de saúde pública por 10.000 habitantes (Li et al., 2024);
- Número de profissionais de psiquiatria (por 1.000 habitantes) (Liu et al., 2023);
- Número de enfermeiros registrados (por 1.000 habitantes) (Liu et al., 2023);
- Distribuição de médicos e enfermeiros por território (Huang et al., 2024).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Médicos por 1.000 habitantes**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Permite a mensuração da densidade médica no município, com desagregação por especialidade, vínculo empregatício (efetivo, contratado, cooperado, terceirizado) e tipo de estabelecimento (público, privado, filantrópico).
- **Número de enfermeiros por 1.000 habitantes**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Mede a oferta da categoria da enfermagem, fundamental para a atenção primária, vigilância em saúde, saúde hospitalar e rede de atenção psicossocial.
- **Proporção de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por população coberta**
 - Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB);
 - Aplicabilidade: Expressa o grau de capilaridade da Estratégia Saúde da Família, representando o vínculo entre serviços de saúde e território. Permite identificar lacunas de cobertura em áreas periféricas e rurais.
- **Número de equipes completas da Estratégia Saúde da Família implantadas por município**
 - Fonte: e-Gestor AB / CNES;
 - Aplicabilidade: Avalia a cobertura populacional por equipes multiprofissionais (com médico, enfermeiro, técnico/auxiliar e ACS), sendo um dos principais indicadores da organização da APS no Brasil.

- **Cobertura populacional por equipe de Consultório na Rua (eCR)**

- Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / e-Gestor AB;
- Aplicabilidade: Avalia a presença de políticas de saúde voltadas para a população em situação de rua, com foco em vulnerabilidades urbanas.

- **Cobertura do Programa Mais Médicos por município**

- Fonte: Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) – Ministério da Saúde;
- Aplicabilidade: Indica a presença de médicos alocados via Programa Mais Médicos (PMM) nos territórios municipais, evidenciando estratégias federais de provimento em áreas com escassez de profissionais. Possibilita análise da vulnerabilidade dos territórios com base na dependência do programa, bem como a distribuição dos médicos por tipo de gestão (federal, municipal, cooperação internacional). Dados disponíveis por município, com recorte de tipo de unidade e população coberta.

- **Número de Equipes Multiprofissionais cadastradas na Atenção Básica**

- Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / e-Gestor AB;
- Aplicabilidade: Permite mensurar a estrutura multiprofissional vinculada às ações de saúde da família, incluindo NASF, consultórios na rua, equipes de atenção domiciliar, saúde bucal, saúde prisional, entre outros. Contribui para a avaliação da integralidade do cuidado, da transversalidade entre áreas técnicas e da capacidade do município em compor redes ampliadas de atenção. Disponível por município, com detalhamento por tipo de equipe e componentes profissionais.

3.3.3 SAÚDE MATERNO-INFANTIL

A subdimensão "saúde materno-infantil" contempla indicadores que avaliam as condições de atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal e da criança na primeira infância.

Em geral, os indicadores internacionais e nacionais estão mais centrados na mulher como genitora, restringindo a análise ao período gestacional e perinatal, com menor ênfase em aspectos ampliados de cuidado à saúde reprodutiva, planejamento familiar ou saúde das mulheres em outras fases da vida.

A saúde materno-infantil é considerada um marcador estratégico da qualidade e equidade dos sistemas de saúde, sendo utilizada por organismos internacionais e nacionais como referência para o monitoramento de direitos e de desenvolvimento humano sustentável.

A adequada cobertura de pré-natal, o parto seguro, a atenção qualificada ao recém-nascido e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil são componentes essenciais dessa subdimensão.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Serviços de saúde materno-infantil (Li et al., 2024);
- Taxa de gestão da saúde infantil (Li et al., 2024);
- Taxas de gestão materna sistemática (Li et al., 2024);
- Porcentagem de partos institucionais (Nascimento et al., 2014);
- Proporção de cobertura de gestações com 7 ou mais consultas pré-natais (Nascimento et al., 2014);
- Disponibilidade de cuidados infantis (Webster; Sanderson, 2013);
- Idade das mães no momento do parto (Webster; Sanderson, 2013).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Proporção de gestantes com início do pré-natal até a 12ª semana de gestação**
 - Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) – Ministério da Saúde;
 - Aplicabilidade: Avalia a precocidade do início do acompanhamento pré-natal, indicador sensível à organização da rede de atenção primária.
- **Taxa de Mortalidade Infantil (TMI)**
 - Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – Ministério da Saúde / DATASUS;
 - Aplicabilidade: A Taxa de Mortalidade Infantil expressa o número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade por mil nascidos vivos, sendo um dos principais indicadores sintéticos da qualidade de vida, desenvolvimento socioeconômico e efetividade do sistema de saúde. Sua análise permite avaliar as condições de acesso, cobertura e qualidade da atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, refletindo desigualdades regionais e sociais. Possui ampla disponibilidade em nível municipal, com dados desagregáveis por faixa etária, sexo, cor/raça e causas básicas de óbito. O indicador é utilizado em políticas públicas, no monitoramento de metas como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e na avaliação de territórios saudáveis e sustentáveis.

- **Percentual de gestações com 7 ou mais consultas de pré-natal**
 - Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – DATASUS;
 - Aplicabilidade: Indica a continuidade do cuidado pré-natal, com possibilidade de desagregação municipal e por faixa etária materna.
- **Taxa de partos cesáreos por município**
 - Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – DATASUS;
 - Aplicabilidade: Permite avaliar a prevalência de cesarianas em relação aos partos vaginais, evidenciando padrões de medicalização do parto.
- **Cobertura de partos realizados em estabelecimentos de saúde**
 - Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – DATASUS;
 - Aplicabilidade: Indica o acesso institucional ao parto, importante para a segurança da mulher e do recém-nascido.
- **Percentual de recém-nascidos com peso adequado ao nascer**
 - Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – DATASUS;
 - Aplicabilidade: Representa um indicador indireto da qualidade da atenção pré-natal e das condições de saúde gestacional.
- **Taxa de vacinação em crianças menores de 1 ano**
 - Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI);
 - Aplicabilidade: Indica a cobertura vacinal infantil, fundamental para a prevenção de doenças evitáveis e para a vigilância epidemiológica.
- **Proporção de crianças com acompanhamento do crescimento e desenvolvimento**
 - Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) – Ministério da Saúde;
 - Aplicabilidade: Mede a efetividade do seguimento da criança na atenção primária à saúde, com possibilidade de análise por faixa etária e território.
- **Proporção de municípios com presença de Centros de Parto Normal ou Casas de Parto**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
 - Aplicabilidade: Avalia a existência de serviços alternativos e humanizados para atenção ao parto e nascimento.
- **Existência de serviços de atenção especializada à mulher (pré-natal de alto risco, planejamento reprodutivo)**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - SISAB;

- **Aplicabilidade:** Permite identificar a oferta de serviços integrados voltados ao cuidado ampliado da mulher durante e após o ciclo gestacional.

3.3.4 PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

A subdimensão "Promoção à saúde e prevenção de doenças" contempla ações intersetoriais e estratégias educativas que visam a ampliação da autonomia das pessoas e coletividades frente ao processo saúde-doença. Envolve a implementação de políticas públicas que promovam modos de vida saudáveis e previnam o surgimento de doenças, com foco em imunização, educação em saúde e ações de vigilância em saúde. Trata-se de uma dimensão essencial para territórios saudáveis e sustentáveis, pois impacta diretamente na qualidade de vida e na redução de iniquidades em saúde.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Taxa de vacinação do programa de imunização para crianças em idade escolar por município (%) (Liu et al., 2023);
- Taxas de imunização (Webster; Sanderson, 2013; Cacique et al., 2022);
- Programas de educação em saúde da cidade (Webster; Sanderson, 2013);
- Existência de programa de educação para a saúde (Cacique et al., 2022).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal.

- **Cobertura vacinal por tipo de vacina (BCG, Pentavalente, Tríplice Viral, Poliomielite, etc.)**
 - Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI);
 - Aplicabilidade: Permite monitorar a efetividade das ações de imunização em nível municipal, com dados desagregados por vacina, faixa etária e período. É um dos principais indicadores de prevenção de doenças imunopreveníveis.
- **Proporção de municípios com salas de vacina ativas**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - DATASUS;
 - Aplicabilidade: Avalia a capacidade instalada dos municípios para executar ações regulares de vacinação. Pode indicar fragilidades na cobertura territorial de imunização.

- **Existência de programas ou ações regulares de Educação em Saúde nas escolas**
 - Fonte: Programa Saúde na Escola (PSE) – Ministério da Saúde / MEC;
 - Aplicabilidade: Expressão grau de articulação intersetorial entre saúde e educação, com foco em ações preventivas, promoção de hábitos saudáveis e envolvimento comunitário. Disponível por município participante.

- **Número de atividades de Educação em Saúde registradas na Atenção Básica**
 - Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) – Ministério da Saúde / e-SUS AB;
 - Aplicabilidade: Quantifica a realização de ações educativas pelas equipes de saúde da família. Pode ser desagregado por tipo de atividade (individual, coletiva, visitas domiciliares).

- **Existência de comitês municipais de promoção da saúde**
 - Fonte: Pesquisa Nacional de Práticas de Promoção da Saúde (PNPPS) – Ministério da Saúde, Relatório Anual de Gestão, Bases locais;
 - Aplicabilidade: Indica a presença de instâncias locais de governança voltadas à promoção da saúde, com potencial para mobilização comunitária e controle social.

3.3.5 SAÚDE DO IDOSO E LONGEVIDADE

A subdimensão "Saúde do idoso e Longevidade" abrange indicadores que evidenciam tanto a qualidade dos serviços voltados à população idosa quanto os determinantes de expectativa de vida. A transição demográfica no Brasil e em outros países implica desafios significativos para os sistemas de saúde, exigindo políticas públicas que promovam o envelhecimento ativo, saudável e com qualidade de vida. Os indicadores organizados nesta subdimensão auxiliam no monitoramento da efetividade das ações em saúde voltadas à população idosa, bem como na compreensão das condições que favorecem a longevidade nos territórios.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Número de leitos de assistência a idosos por 1.000 idosos (Li et al., 2024);

- Existência de políticas públicas de envelhecimento saudável (Tsouros; Green, 2013);

- Expectativa de vida per capita (Li et al., 2024; Lv et al., 2022; Zhao et al., 2023; Liu et al., 2023);

- Taxa de natalidade (Huang et al., 2024).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Expectativa de vida ao nascer**

- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- Aplicabilidade: Reflete as condições de saúde e qualidade de vida da população. Pode ser analisada por estados e estimativas municipais indiretas, sendo essencial para o planejamento de políticas de envelhecimento e ações intersetoriais.

- **Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM - Componente Longevidade)**

- Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano / Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
- Aplicabilidade: Reflete a esperança de vida ao nascer, associando-se às condições de saúde, segurança alimentar, habitação e acesso a serviços. Disponível para todos os municípios brasileiros.

- **Proporção da população com 60 anos ou mais**

- Fonte: Censos Demográficos e Estimativas Populacionais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
- Aplicabilidade: Indica o processo de envelhecimento populacional e serve como base para o dimensionamento das políticas e serviços voltados à população idosa.

- **Número de Centros de Referência em Saúde do Idoso por município**

- Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / DATASUS;
- Aplicabilidade: Informa a existência de unidades de atenção especializada ao idoso no território, importantes para o cuidado integral da população idosa com alta vulnerabilidade clínica e social.

- **Existência de serviços de atenção domiciliar para idosos**

- Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / e-Gestor AB;
- Aplicabilidade: Avalia a presença de serviços de atenção domiciliar estruturados no município, importantes para manter a autonomia e reduzir hospitalizações desnecessárias.

- **Proporção de idosos com acompanhamento regular na Atenção Primária**

- Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) – Ministério da Saúde;
- Aplicabilidade: Permite avaliar a longitudinalidade e continuidade do cuidado à população idosa nos serviços de saúde da família.

- **Cobertura de vacinação contra influenza em idosos**

- Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI);
- Aplicabilidade: Indicador de prevenção de doenças imunopreveníveis, associado à redução da morbimortalidade em idosos.

3.3.6 SAÚDE MENTAL

A saúde mental tem se consolidado como dimensão essencial da Saúde Coletiva e da promoção de territórios saudáveis e sustentáveis. Apesar de historicamente menos visibilizada nos indicadores, vem ganhando centralidade diante do aumento dos transtornos mentais, especialmente após a pandemia de COVID-19. A mensuração da atenção à saúde mental permite avaliar a presença de serviços especializados, o acesso a tratamentos contínuos e a integração das ações com a atenção primária e a rede psicossocial.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Taxa de tratamento padronizada de pacientes com transtornos mentais graves (Li et al., 2024);
- Existência de programas de atenção psicossocial comunitária (Webster; Sanderson, 2013);
- Número de profissionais de psiquiatria por 1.000 habitantes (Liu et al., 2023);
- Taxa de internação psiquiátrica (Lv et al., 2022);
- Número de centros comunitários de saúde mental (Zhao et al., 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100.000 habitantes**
 - Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Avalia a cobertura de serviços substitutivos à internação psiquiátrica, integrados à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

- **Taxa de óbitos por suicídio por 100.000 habitantes**

- Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – DATASUS / Ministério da Saúde;
- Aplicabilidade: Permite avaliar a magnitude do suicídio como problema de saúde pública nos municípios, sendo fundamental para a vigilância em saúde mental e para o planejamento de estratégias de prevenção, especialmente em populações vulneráveis. A análise pode ser feita por sexo, faixa etária, região e evolução temporal. Dados disponíveis em nível municipal, com séries históricas acessíveis por meio da plataforma TABNET.

- **Índice de Bem-Estar Subjetivo (felicidade autodeclarada)**

- Fonte: Dados de inquéritos internacionais adaptados ao Brasil, como o Gallup World Poll;
- Aplicabilidade: Esse indicador expressa a autopercepção da população sobre a própria felicidade ou satisfação com a vida, geralmente medida por escalas de 0 a 10. Pode ser desagregado por faixa etária, sexo, escolaridade, renda e local de residência, permitindo avaliar desigualdades no bem-estar subjetivo. Ainda que não disponível sistematicamente para todos os municípios, pode ser utilizado em estudos populacionais, comparações regionais e como subsídio para políticas intersetoriais de promoção da saúde e qualidade de vida.

3.3.7 DOENÇAS / AGRAVOS, OUTROS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E MORTALIDADE

A subdimensão "Doenças/Agravos, outros aspectos epidemiológicos e mortalidade" é relevante, uma vez que decorre da capacidade de refletir a carga de doenças evitáveis, os padrões epidemiológicos do território e os efeitos da ausência ou fragilidade dos determinantes sociais de saúde. Inclui tanto condições crônicas quanto doenças infecciosas, aspectos de violência, acidentes e causas externas, além de indicadores de mortalidade geral e específica.

Essa dimensão dialoga diretamente com as estratégias de vigilância em saúde, atenção primária, promoção da saúde, prevenção de agravos e organização da rede assistencial.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Baixo peso ao nascer (Webster; Sanderson, 2013);
- Investigação epidemiológica (Moura et al., 2021);
- Razão de dependência (Petersen et al., 2020);

- Proporção de pessoas vítimas de violência sexual ou física, por sexo, idade e deficiência, nos últimos 12 meses (Matias; Campos, 2022);
- Segurança urbana – percentagem da população afetada seriamente por crimes e acidentes de trânsito (Matias; Campos, 2022);
- Incidência de doenças infecciosas de classe A e B (Li et al., 2024; Lv et al., 2022);
- Prevalência de hipertensão em pessoas de 18 a 50 anos (Li et al., 2024);
- Taxa de tabagismo em pessoas com mais de 15 anos (Li et al., 2024);
- Número de feridos em acidentes de trânsito por 10.000 habitantes (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Consumo de álcool e outras drogas (Cacique et al., 2022);
- Fontes de estresse social (Cacique et al., 2022);
- Prevalência da malária (Nascimento et al., 2014);
- Incidência e prevalência de tuberculose (Liu et al., 2023; Nascimento et al., 2014);
- Taxa de pneumoconiose em trabalhadores expostos à poeira (Liu et al., 2023);
- Diagnóstico precoce de câncer em áreas críticas (Liu et al., 2023);
- Hospitalizações evitáveis por hipertensão e diabetes tipo 2 (Liu et al., 2023);
- Casos de intoxicação alimentar (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023);
- Prevalência de obesidade, diabetes e doenças respiratórias (Cheshmehzangi; Ankowska, 2023).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Taxa de incidência de tuberculose por 100 mil habitantes**
 - Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);

- Aplicabilidade: Permite avaliar o desempenho da vigilância e da atenção à saúde em territórios com maior vulnerabilidade social e sanitária.
- **Taxa de internações por condições sensíveis à atenção primária**
 - Fonte: Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Indica fragilidades na prevenção e monitoramento de doenças crônicas evitáveis, sendo um dos principais indicadores indiretos da efetividade da APS.
- **Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano)**
 - Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Reflete a qualidade do cuidado pré-natal, do parto e do primeiro ano de vida. Pode ser desagregado por município, região e ano.
- **Taxa de mortalidade materna**
 - Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Indicador-chave da atenção obstétrica e da vigilância em saúde da mulher, relevante para monitorar a segurança do parto.
- **Mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)**
 - Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Permite o monitoramento da carga de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Importante para análise por faixa etária e sexo.
- **Taxa de mortalidade por causas externas (acidentes e violências)**
 - Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Expressa a exposição a fatores de risco ambientais e sociais, como violência urbana e acidentes de transporte.
- **Prevalência de hipertensão e diabetes autorreferida**
 - Fonte: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) / Ministério da Saúde
 - Aplicabilidade: Permite a vigilância de fatores de risco e doenças crônicas nos grandes centros urbanos.
- **Número de óbitos por arboviroses**
 - Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / Ministério da Saúde;

- Aplicabilidade: Indicador sentinela da vigilância em saúde ambiental e controle vetorial, especialmente para dengue, zika e chikungunya.
- **Taxa de detecção de casos novos de hanseníase por 100 mil habitantes**
 - Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) / DATASUS;
 - Aplicabilidade: Mede a capacidade do município em identificar precocemente e tratar doenças negligenciadas.
- **Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por DCNT**
 - Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) / Ministério da Saúde;
 - Aplicabilidade: Indicador utilizado globalmente pela OMS e ONU nos ODS. Mede o sucesso das políticas preventivas e de diagnóstico precoce.

3.4 PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

A dimensão "Participação Comunitária" compreende elementos essenciais para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis, articulando democracia participativa, solidariedade social e engajamento cidadão como fundamentos de uma governança inclusiva. A literatura internacional destaca a importância da participação da comunidade nas decisões locais, como meio de garantir a responsividade das políticas públicas, fortalecer o tecido social e promover a justiça social e ambiental (LEE et al., 2019; YOSHIZAWA, 2013; GALINDO; FURTADO, 2004). Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

3.4.1 DEMOCRACIA

- Percentagem da população que participa das eleições locais ou de associações comunitárias (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Participação comunitária nas decisões locais e urbanas (KEGLER; NORTON; ARONSON, 2008; ADRIANO et al., 2000);
- Porcentagem de vereadoras e deputadas eleitas (NASCIMENTO et al., 2014);
- Garantia da participação cidadã em decisões que afetam territórios (LIMA; LIMA, 2020);
- Estrutura democrática para participação cidadã no planejamento urbano (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- % de consultas públicas urbanas (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);

- Descentralização e fortalecimento das autoridades locais (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Indicadores sobre crenças políticas (LEE et al., 2019).

3.4.2 SOLIDARIEDADE

- % de voluntários da comunidade e número de organizações voluntárias (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Participação cidadã, direitos humanos e segurança urbana (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Cooperação intermunicipal para a Agenda 2030 (LIMA; LIMA, 2020);
- Proporção de voluntários registrados (LI et al., 2024);
- Sustentabilidade social e envolvimento ativo da população (LAUREANO- EUGENIO et al., 2021);
- Desenvolvimento de capacidades locais e programas comunitários (ADRIANO et al., 2000; KEGLER; NORTON; ARONSON, 2008).

3.4.3 ENGAJAMENTO / LIDERANÇA:

- % da população com facilidade de orientação (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Liderança cidadã para reconstrução e bem comum (CACIQUE et al., 2022);
- Engajamento como pilar do sucesso comunitário (YOSHIZAWA, 2013).

Esta subdimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Proporção de conselhos locais de saúde ou participação em conferências municipais**
 - Fonte: Sistema de Apoio às Conferências e Conselhos de Saúde (SARGSUS / CNS / DATASUS);
 - Aplicabilidade: Mede a institucionalização da participação cidadã nos espaços do SUS, com desagregação por município.

- **Taxa de associação a grupos comunitários locais (ONGs, associações de bairro, grupos religiosos etc.)**
 - Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE);
 - Aplicabilidade: Permite aferir a organização da sociedade civil e sua capacidade de mobilização social.
- **Presença de Programa Nacional de Educação Fiscal e Orçamento Participativo**
 - Fonte: Ministério da Fazenda / Portais de Transparência Municipais;
 - Aplicabilidade: Reflete a promoção da cidadania fiscal, com enfoque na educação para a gestão pública local.
- **Proporção de mulheres eleitas no poder legislativo municipal**
 - Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
 - Aplicabilidade: Indica o grau de representação de grupos historicamente sub-representados na política local.
- **Proporção de municípios com plano diretor elaborado com participação cidadã**
 - Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente Urbano (SINIMA / MMA);
 - Aplicabilidade: Mede a inserção social nos processos de planejamento territorial e urbano.

3.5 EQUIDADE

A equidade em saúde constitui um princípio estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo essencial para a formulação de políticas que visem à justiça social e à superação das iniquidades (TRAVASSOS; CASTRO, 2012). No contexto de territórios saudáveis e sustentáveis, a equidade assume papel central ao reconhecer as desigualdades sociais, econômicas e territoriais que impactam diretamente nos determinantes sociais da saúde.

Machado et al. (2017) reforçam que a construção de territórios saudáveis e sustentáveis exige planejamento intersetorial e ação coletiva, com foco na justiça territorial e na inclusão de populações historicamente marginalizadas. Nesse sentido, políticas públicas devem ser orientadas por diagnósticos que incorporem indicadores de vulnerabilidade social e de acesso aos serviços de saúde, educação, saneamento e segurança. Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

3.5.1 ACESSIBILIDADE

- Desenvolvimento social com investimento em equidade e inclusão (LIMA; LIMA, 2020);

- Proporção média de áreas construídas que são espaços abertos de uso público, por sexo, idade e deficiência (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- % de bairros com serviço de reabilitação de deficientes (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- % de bairros com ruas adaptadas para deficientes (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Estabelecimento de ambientes sociais, físicos e culturais alinhados para inclusão e bem-estar de todos (LIMA; LIMA, 2020);
- Promoção da paz por meio de sociedades inclusivas centradas nas pessoas (LIMA; LIMA, 2020).

3.5.2 INCLUSÃO SOCIAL E DIVERSIDADE

- Inclusão social como estratégia para saúde pública (KEGLER; NORTON; ARONSON, 2008);
- Acesso a espaços públicos seguros e inclusivos (BOTCHWAY et al., 2023);
- Implementação de políticas de inclusão e redução de desastres (BOTCHWAY et al., 2023);
- Questões demográficas: gênero, juventude, envelhecimento e relação urbano- rural (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Ação intersetorial pelo bem-estar de todos nos territórios (LIMA; LIMA, 2020);
- % de centros de saúde com serviços em línguas estrangeiras (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Inclusão de populações vulneráveis no planejamento urbano (YOSHIZAWA, 2013);
- Apoio ao desenvolvimento sustentável nas comunidades menos desenvolvidas (BOTCHWAY et al., 2023);
- Promoção da equidade em saúde, justiça social e sustentabilidade urbana (KAMPER-JORGENSEN, 2010);

- Saúde em todas as políticas (KAMPER-JORGENSEN, 2010).

3.5.3 SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA

- Proporção de governos locais com estratégias de redução de risco de desastres alinhadas ao Marco de Sendai (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Número de países com estratégias nacionais e locais para redução de risco de desastres (MATIAS; CAMPOS, 2022).

Esta dimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Índice de Equidade e Dimensionamento (IED)**

- Fonte: Portaria GM/MS N° 3.493 (10/04/2024); Nota Técnica nº 122/2024 – CGFAP/SAPS/MS; Ministério da Saúde;
- Aplicabilidade: O IED combina o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do Ipea, ponderado em 30%, com o porte populacional (IBGE), ponderado em 20%, classificando municípios em 4 estratos. Essa classificação define o valor per capita de cofinanciamento federal para equipes de APS (Estratégia Saúde da Família e Atenção Primária), reforçando a equidade vertical. Os Municípios mais vulneráveis e de menor porte (Estrato 1) recebem maior repasse per capita, apoiando o fortalecimento e ampliação da APS.

- **Cobertura de populações vulneráveis (ex: indígenas, quilombolas, ribeirinhos) por políticas de saúde**

- Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB) / Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
- Aplicabilidade: Mede a equidade no acesso à Atenção Primária em populações específicas.

- **Proporção de população com acesso à renda, saneamento e educação**

- Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua / IBGE);
- Aplicabilidade: Avaliação multidimensional da exclusão social no território.

3.6 GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO

A dimensão "Governança, Planejamento e Monitoramento" é significativa para a consolidação de territórios saudáveis e sustentáveis, uma vez que estrutura a capacidade institucional e a inteligência técnica dos governos locais para conduzir políticas públicas intersetoriais. Trata-se de um componente transversal, que viabiliza o ciclo do planejamento em saúde e outras áreas, articulando a formulação de políticas, a implementação territorializada, o monitoramento e a avaliação. Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

3.6.1 GOVERNANÇA

Envolve a gestão de políticas com foco na articulação intersetorial, na sustentabilidade institucional e na legislação urbana.

- Sustentabilidade operacional (LAUREANO-EUGENIO et al., 2021);
- Gestão de desastres e pandemias (CACIQUE et al., 2022);
- Governança intersetorial (TSOUROS; GREEN, 2013);
- Fortalecimento da intersetorialidade nas políticas públicas (ADRIANO et al., 2000);
- Influência em políticas organizacionais (KEGLER; NORTON; ARONSON, 2008);
- Integração intersetorial (GALINDO; FURTADO, 2004);
- Governança pública e legislação urbana (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Proteção ambiental em políticas municipais (LIMA; LIMA, 2020).

3.6.2 PLANEJAMENTO

Abrange a capacidade institucional para desenvolver planos inclusivos, sustentáveis e integradores, com base em diagnósticos situacionais e com participação social.

- Elaboração de planos de ação em saúde (LIMA; LIMA, 2020);
- Planejamento nacional e regional com integração à sustentabilidade (BOTCHWAY et al., 2023);

- Planejamento e gestão urbana, mobilidade, gestão da terra, agricultura urbana (MATIAS; CAMPOS, 2022);
- Planejamento institucional e para populações específicas (CACIQUE et al., 2022);
- Planejamento urbano inclusivo (BOTCHWAY et al., 2023).

3.6.3 MONITORAMENTO

Constitui o pilar técnico que permite acompanhar resultados e retroalimentar o ciclo de gestão.

- Análise da situação de saúde (LIMA; LIMA, 2020);
- Criação de salas de situação (LIMA; LIMA, 2020);
- Padrão de fiscalização e transparência (CACIQUE et al., 2022);
- Monitoramento da saúde urbana, equidade e sustentabilidade (KAMPER- JORGENSEN, 2010).

Esta dimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Existência de Sala de Situação de Saúde ativa no município**
 - Fonte: Relatórios de monitoramento municipal;
 - Aplicabilidade: Permite mensurar a capacidade de análise técnica e vigilância em saúde, com potencial para monitorar indicadores epidemiológicos e operacionais.
- **Elaboração de Plano Municipal de Saúde vigente e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde**
 - Fonte: Sistema DigiSUS / Relatórios da Programação Anual de Saúde (PAS);
 - Aplicabilidade: Mede a institucionalização do planejamento em saúde e o controle social no nível local.
- **Existência de Comitê Municipal de Enfrentamento a Emergências em Saúde Pública**
 - Fonte: Relatórios de gestão / CNES
 - Aplicabilidade: Avalia a governança intersetorial para resposta a desastres e pandemias.

- **Proporção de investimentos intersetoriais em saúde nos últimos dois anos**
 - Fonte: SIOPS / Planejamento municipal
 - Aplicabilidade: Reflete a articulação entre saúde, assistência social, educação e meio ambiente nas políticas locais.
- **Existência de legislação municipal de planejamento urbano com diretrizes para sustentabilidade e inclusão social**
 - Fonte: Planos Diretores Municipais;
 - Aplicabilidade: Indica o alinhamento das cidades aos princípios de territórios sustentáveis, com base legal estruturada.

3.7 POPULAÇÃO

A dimensão "População" contempla características demográficas dos indivíduos, incluindo elementos estruturais como total populacional, distribuição por idade e sexo, densidade demográfica e envelhecimento, assim como fatores individuais associados à felicidade, bem-estar e capacidade de interação com a diversidade cultural e social.

Trata-se de uma dimensão importante para o planejamento de políticas saudáveis e sustentáveis, ao permitir compreender o perfil da população e suas necessidades em diferentes estágios do ciclo de vida, bem como avaliar condições subjetivas que impactam a qualidade de vida.

Os indicadores sistematizados na revisão incluem:

- População total (CACIQUE et al., 2022);
- Repartição por idade e por sexo (CACIQUE et al., 2022);
- Densidade populacional (população por km²) (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023; LV et al., 2022; CACIQUE et al., 2022; PINEO et al., 2018);
- Porcentagem da população (CACIQUE et al., 2022);
- Distribuição étnica (CACIQUE et al., 2022);
- Taxa de crescimento populacional natural (ZHAO et al., 2023);
- Proporção de idosos nas cidades (YOSHIZAWA, 2013).

3.8 SEGURANÇA

A dimensão “Segurança” é essencial para a construção de territórios saudáveis e sustentáveis, pois a sensação de segurança influencia diretamente o bem-estar, a saúde mental, a mobilidade urbana e a vida em comunidade. A insegurança e a violência são determinantes sociais que afetam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis, comprometendo o direito à cidade e à saúde.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- % de crimes contra a propriedade (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- % da população que se sente segura andando sozinha na área onde vive (CHESHMEHZANGI; ANKOWSKA, 2023);
- Taxa de ocorrência de violência doméstica (CACIQUE et al., 2022);
- Taxa de ocorrência de crimes gerais (CACIQUE et al., 2022);
- Crimes contra a propriedade por 100.000 habitantes (PINEO et al., 2018);
- % de moradores que relatam presença de indícios ambientais de crime e vandalismo (PINEO et al., 2018).

Esta dimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Taxa de homicídios por 100.000 habitantes**
 - Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM / DATASUS);
 - Aplicabilidade: Indica a incidência de mortes violentas intencionais, sendo um dos principais indicadores de segurança pública. Pode ser desagregado por sexo, faixa etária e região, com potencial de análise de tendências e desigualdades.
- **Notificações de violência interpessoal e autoprovocada por 100.000 habitantes**
 - Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS);
 - Aplicabilidade: Engloba notificações de violência física, psicológica, sexual e negligência, sendo útil para identificar grupos vulneráveis e planejar ações intersetoriais de enfrentamento.

- **Proporção de mulheres vítimas de violência doméstica com registro em serviços de saúde**
 - Fonte: Notificação de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
 - Aplicabilidade: Permite identificar a capacidade dos serviços de acolher e notificar casos de violência contra mulheres, contribuindo para ações integradas com as redes de proteção social.
- **Índice de percepção de segurança urbana**
 - Fonte: Pesquisas do IBGE (como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua – suplemento de segurança, quando disponível);
 - Aplicabilidade: Mede a sensação subjetiva de segurança da população, importante para análises qualitativas de políticas públicas e estratégias de vigilância em saúde.
- **Presença de políticas públicas de prevenção à violência nos municípios**
 - Fonte: Sistema de Monitoramento de Políticas Intersectoriais / SNPM
 - Aplicabilidade: Informa se o município possui iniciativas de prevenção à violência, como centros de referência, programas escolares de mediação de conflitos, iluminação pública, urbanismo social, entre outros.

3.9 ESPECÍFICOS

A dimensão “Específicos” foi composta por índices que são a junção de indicadores para medir o nível de territórios saudáveis e sustentáveis.

Os indicadores internacionais sistematizados incluem:

- Índice de Gini – que mede a desigualdade na distribuição de renda (PETERSEN et al., 2020);
- Índice de Território Saudável e Sustentável (PETERSEN et al., 2020);
- Índice básico da cidade saudável de Dandong (LIU, 2024);
- Índice de Desempenho Municipal – MPI (GUPTA; SETHI, 2024);
- Índice de Gini (PETERSEN et al., 2020);
- Índice de Desempenho Municipal – MPI, que visa aprimorar a governança urbana e a infraestrutura a partir da avaliação do desempenho dos municípios nas áreas de Governança, Tecnologia, Planejamento, Serviços e Finanças (GUPTA; SETHI, 2024);

- Índice de Território Saudável e Sustentável – ITSS (PETERSEN et al., 2020), que é Formado pela vulnerabilidade social (ausência ou insuficiência de políticas públicas para infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, que repercutem nas condições de bem-estar das populações); e pelo desenvolvimento humano (aumento da liberdade de escolhas das pessoas, para uma vida longa e saudável, na aquisição de conhecimentos e do padrão de vida decente) (PETERSEN et al., 2020);
- Índice básico de avaliação da construção da cidade saudável de Dandong (LIU, 2024).

Esta dimensão reúne ainda os principais indicadores aplicáveis ao contexto brasileiro, considerando dados de acesso público, provenientes de fontes oficiais com abrangência nacional e/ou possíveis fontes locais, com potencial de análise em nível municipal:

- **Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM**

- Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Fundação João Pinheiro (FJP);
- Aplicabilidade: Reflete as condições de vida da população, considerando longevidade, educação e renda. Está disponível por município, permitindo análises territoriais de bem-estar e desigualdades.

- **Índice de Vulnerabilidade Social – IVS**

- Fonte: IPEA/Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios;
- Aplicabilidade: Avalia a fragilidade social dos territórios a partir de aspectos urbanos, de capital humano e de renda. É utilizado como insumo para políticas públicas focalizadas.

- **Índice de Equidade e Dimensionamento – IED**

- Fonte: Ministério da Saúde – Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024;
- Aplicabilidade: Aponta os municípios que devem receber maior apoio federal na Atenção Primária, considerando vulnerabilidade e porte populacional. Instrumento de gestão da equidade no SUS.

- **Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR)**

- Fonte: Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com a *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), com apoio institucional da Caixa Econômica Federal, da União Europeia e do Ministério do Meio Ambiente (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2024);

- Aplicabilidade: monitorar o avanço de cada município em direção aos ODS; identificar fragilidades temáticas e territoriais; auxiliar a formulação de políticas públicas com base em evidências; subsidiar relatórios locais de sustentabilidade (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2024).

- **Coeficiente de Gini (por município)**

- Fonte: Censos e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Aplicabilidade: Mede a desigualdade de renda. Permite monitoramento de justiça social em nível municipal.

Dentre os índices específicos, destaca-se Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC BR). O IDSC-BR é um índice que avalia o desempenho dos 5.570 municípios brasileiros em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Foi desenvolvido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com a *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), com apoio institucional da Caixa Econômica Federal, da União Europeia e do Ministério do Meio Ambiente (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2024).

A metodologia baseia-se em cerca de 100 indicadores oficiais, normalizados em uma escala de 0 a 100, onde 100 representa o desempenho ideal. A normalização considera metas globais, médias nacionais ou ausência total do problema avaliado. Posteriormente, os dados são agregados por média aritmética em cada ODS e sintetizados em uma pontuação final única (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2024).

Os resultados são apresentados em classificação semafórica: Verde: desempenho adequado; Amarelo e Laranja: desempenho médio; Vermelho: desempenho crítico (INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2024).

Os 100 indicadores são organizados de acordo com os ODS, a saber:

ODS 1 – Erradicação da pobreza

- Famílias inscritas no Cadastro Único (%);
- Percentual de inscritos no Cadastro Único que recebem Bolsa Família (%);
- Percentual de inscritos no Cadastro-Único abaixo da linha da pobreza pós-Bolsa Família (%);
- Pessoas com renda de até ¼ do salário mínimo (%).

ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável

- Obesidade infantil (%);
- Baixo peso ao nascer (%);
- Desnutrição infantil (%);
- Produtores de agricultura familiar com apoio do PRONAF (%);
- Estabelecimentos de agricultura orgânica (%).

ODS 3 – Saúde e bem-estar

- Cobertura vacinal (%);
- Mortalidade por suicídio (por 100 000 habitantes);
- Mortalidade infantil (< 1 ano por mil nascidas vivas);
- Mortalidade materna (por mil nascidas vivas);
- Mortalidade na infância (< 5 anos por mil nascidas vivas);
- Mortalidade neonatal (< 28 dias por mil nascidas vivas);
- Mortalidade por AIDS (por 100 000 habitantes);
- Incidência de dengue (por 100 000 habitantes);
- Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (por 100 000 habitantes);
- Orçamento municipal per capita para saúde (R\$);
- População atendida por equipes de Saúde da Família (%);
- Detecção de hepatite (por 100 000 habitantes);
- Pré-natal insuficiente (%);
- Unidades Básicas de Saúde por mil habitantes;

- Idade média ao morrer (anos);
- Gravidez na adolescência (%);
- Incidência de tuberculose (por 100 000 habitantes).

ODS 4 – Educação de qualidade

- Acesso à internet nas escolas públicas (%);
- Crianças de 0–3 anos matriculadas em creches (%);
- Escolas com acessibilidade física (%);
- Escolas com Atendimento Educacional Especializado (por mil matrículas);
- IDEB anos iniciais;
- IDEB anos finais;
- Jovens com ensino médio concluído até 19 anos (%);
- Professores com formação superior na Educação Infantil (%);
- Professores com formação superior no Ensino Fundamental (%);
- Relação aluno/professor na pré-escola;
- Relação aluno/professor no Ensino Fundamental;
- Distorção idade–série no Ensino Fundamental (%);
- Analfabetismo (≥ 15 anos) (%);
- Centros culturais por 100 000 habitantes;
- Crianças e jovens de 4–17 anos na escola (%).

ODS 5 – Igualdade de gênero

- Mulheres de 15–24 anos que não estudam nem trabalham (%);

- Porcentagem de vereadoras (%);
- Razão salarial (mulheres/homens);
- Diferença percentual no NEET (“nem estudam nem trabalham”) entre jovens;
- Taxa de feminicídio (por 100 000 mulheres).

ODS 6 – Água potável e saneamento

- Doenças por saneamento inadequado (por 100 000 habitantes);
- Perda de água tratada (%);
- População com esgotamento sanitário (%);
- Índice de tratamento de esgoto (%);
- População com abastecimento de água (%).

ODS 7 – Energia acessível e limpa

- Domicílios com energia elétrica (%);
- Vulnerabilidade energética (índice).

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico

- População ocupada entre 10–17 anos (%);
- PIB per capita (R\$);
- Taxa de desemprego (%);
- Taxa de desemprego juvenil (%);
- Jovens NEET (%);
- Ocupação formal ≥ 16 anos (%).

ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura

- Investimento público em infraestrutura urbana per capita (R\$);

- Empregos formais em setores intensivos em tecnologia (%).

ODS 10 – Redução das desigualdades

- Renda apropriada pelos 20% mais pobres (%);
- Coeficiente de Gini;
- Diferença em indicadores educacionais entre pretos/pardos e brancos;
- Diferença nas taxas de mortalidade infantil, gravidez adolescente, distorção idade-série, homicídios e feminicídios entre pretos/pardos e brancos;
- Razão de rendimento médio (pretos/pardos ÷ brancos);
- População LGBTQIA+ vítima de violência (por 100 000);
- Percentual de vereadores pretos/pardos (%).

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis

- População de baixa renda que leva ≥ 1 h para ir ao trabalho (%);
- Mortes no trânsito (por 100 000 habitantes);
- População em aglomerados subnormais (%);
- Domicílios em favelas (%);
- Equipamentos esportivos por 100 000 habitantes;
- População negra em assentamentos subnormais (%).

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis

- Resíduos sólidos domiciliares coletados per capita (kg/dia);
- Resíduos reciclados selecionadamente (%);
- População atendida com coleta seletiva (%).

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima

- Emissões CO₂e per capita (ton);

- Focos de queimadas (mil);
- Municípios com políticas para risco e desastres (%);
- Proporção de domicílios em áreas de risco (%);
- Percentual do município desflorestado (%).

ODS 14 – Vida na água

- Esgoto tratado antes de chegar a corpos d'água (%).

ODS 15 – Vida terrestre

- Hectares de área florestal por habitante (ha);
- Unidades de conservação (%);
- Maturidade de financiamentos ambientais (%).

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes

- Homicídio juvenil (por 100 000 habitantes);
- Taxa de homicídio (por 100 000 habitantes);
- Mortes por arma de fogo (por 100 000 habitantes);
- Estruturação de políticas de controle da corrupção (%);
- Estruturação de políticas de direitos humanos (%);
- Estruturação de políticas de transparência (%).

ODS 17 – Parcerias e meios de implementação

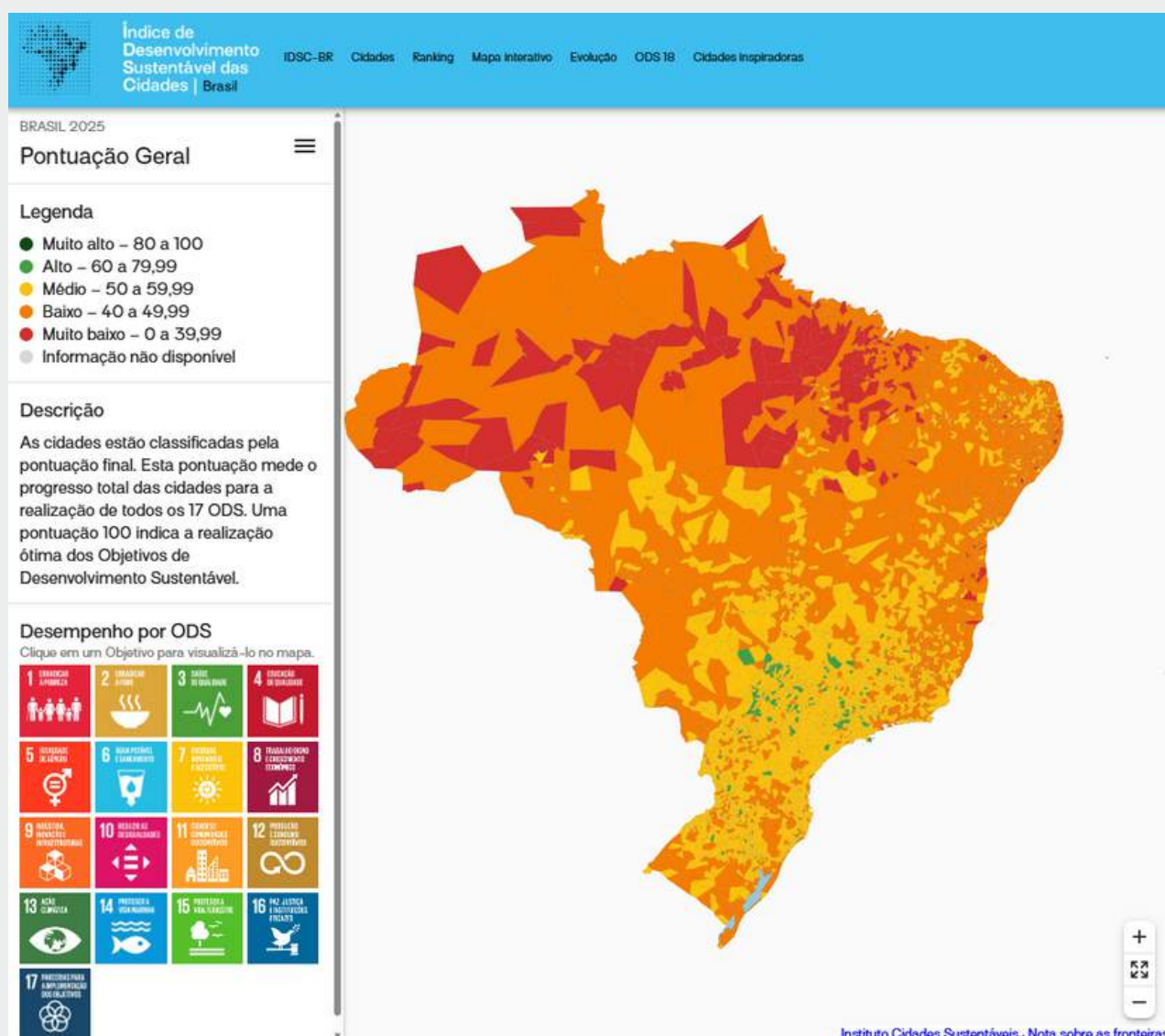
- Investimento público per capita (R\$);
- Receita própria (%).

A Figura 2 apresenta o mapa interativo do IDSC-BR – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, disponível de forma dinâmica no endereço eletrônico: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/map/>.

A plataforma permite a visualização georreferenciada dos resultados do índice para todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, possibilitando análises comparativas entre os territórios a partir dos 100 indicadores organizados segundo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

A ferramenta oferece ainda filtros por dimensão, município e região, contribuindo para o monitoramento e avaliação de políticas públicas locais voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável.

Figura 02. Pontuação Geral do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR). Brasil, 2025.



Fonte: O (IDSC - BR) Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Sustainable Development Solutions Network (SDSN), consultoria do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebap) e co-financiado pela Caixa, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela União Européia.

DADOS / INOVAÇÃO

A dimensão “Dados/Inovação” (LEE et al., 2019) é composta por três indicadores de pesquisa que ajudam a entender a satisfação do usuário e a avaliação de impactos da economia na saúde.

Os indicadores sistematizados na revisão incluem:

- Pesquisa de Percepção do Cidadão (GUPTA; SETHI, 2024);
- Percepção sobre saúde e bem-estar (CACIQUE et al., 2022);
- Avaliação do impacto da economia na saúde (CACIQUE et al., 2022).

3.10 MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO

A partir da análise dos indicadores nacionais e internacionais relacionados aos territórios saudáveis e sustentáveis, foram selecionadas variáveis capazes de representar a distribuição desses aspectos, no âmbito municipal, para os 5.570 municípios brasileiros. A escolha dos indicadores considerou a diversidade de domínios (demográficos, ambientais, socioeconômicos, de saúde e de sustentabilidade), e os dados foram sistematizados em planilhas Excel e posteriormente georreferenciados por meio do software QGIS, permitindo a construção de representações espaciais dinâmicas e integradas.

Os indicadores selecionados foram os seguintes:

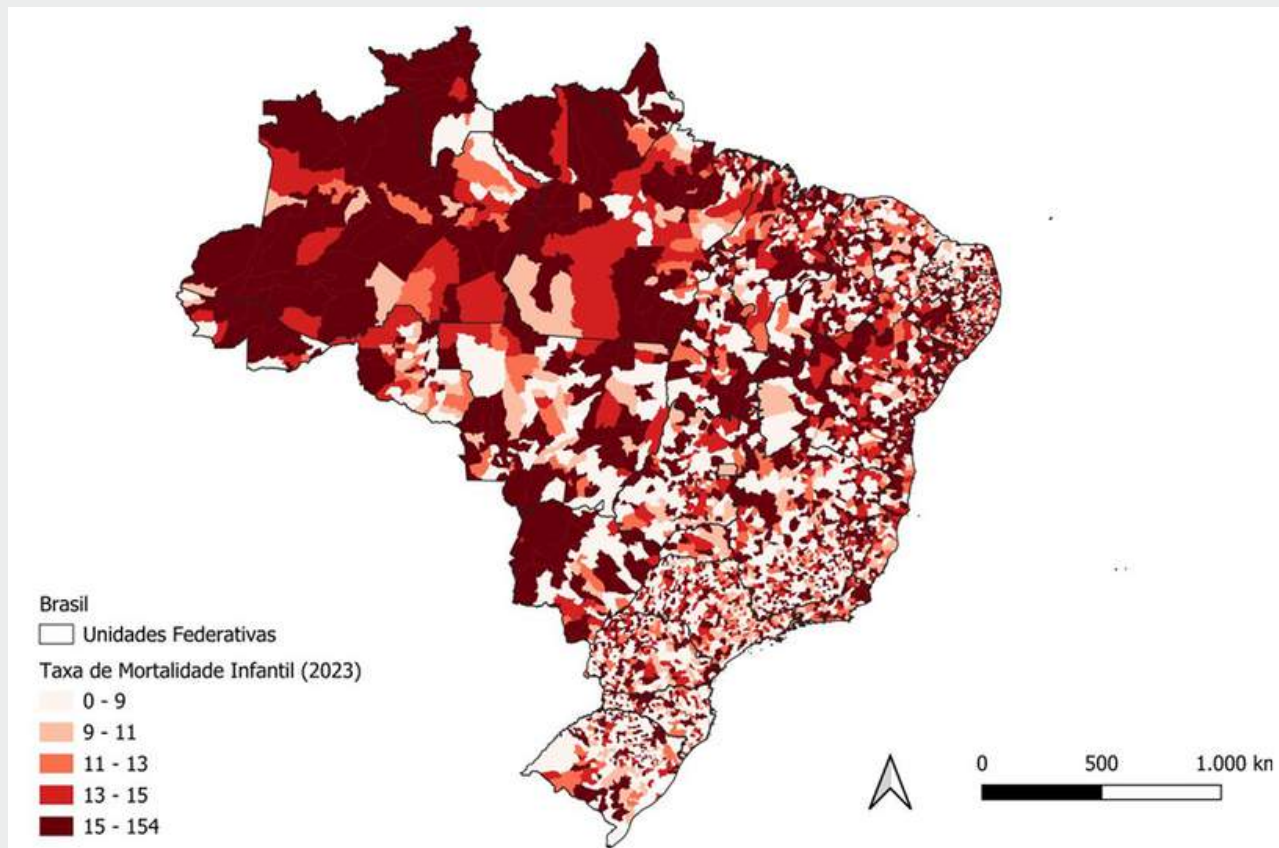
3.10.1 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (2023)

A taxa de mortalidade infantil, expressa como o número de óbitos de crianças menores de um ano de idade por mil nascidos vivos, é amplamente reconhecida como um dos principais indicadores do nível de desenvolvimento humano e das condições de vida de uma população. Sua análise permite inferir sobre a efetividade das políticas públicas em saúde, sobretudo no que tange ao cuidado pré-natal, parto e puerpério (SZWARCOWALD et al., 2021).

Em contextos de alta mortalidade infantil, observam-se geralmente deficiências na cobertura da atenção primária, falta de acesso a serviços de saúde de qualidade e ausência de infraestrutura básica como saneamento e água potável. Estudos apontam que municípios com maior vulnerabilidade socioeconômica apresentam maiores taxas de mortalidade infantil, refletindo desigualdades históricas (BARROS; VICTORA, 2019).

No Brasil, os dados sobre este indicador são provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), que coleta registros administrativos de óbitos. Em 2023, o Brasil apresentou uma taxa média nacional em torno de 11,3 por mil nascidos vivos, com marcadas disparidades entre as regiões Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste (BRASIL, 2023).

Figura 3. Mapeamento georreferenciado da Taxa de mortalidade infantil. Brasil, 2023.



Fonte: Dados extraídos da plataforma DATASUS/SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade. Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), ano de referência: 2023. Mapeamento realizado por Ribeiro (2025) exclusivamente para este produto técnico. Elaboração própria com geoprocessamento em QGIS.

3.10.2 PERCENTUAL DE COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (2023)

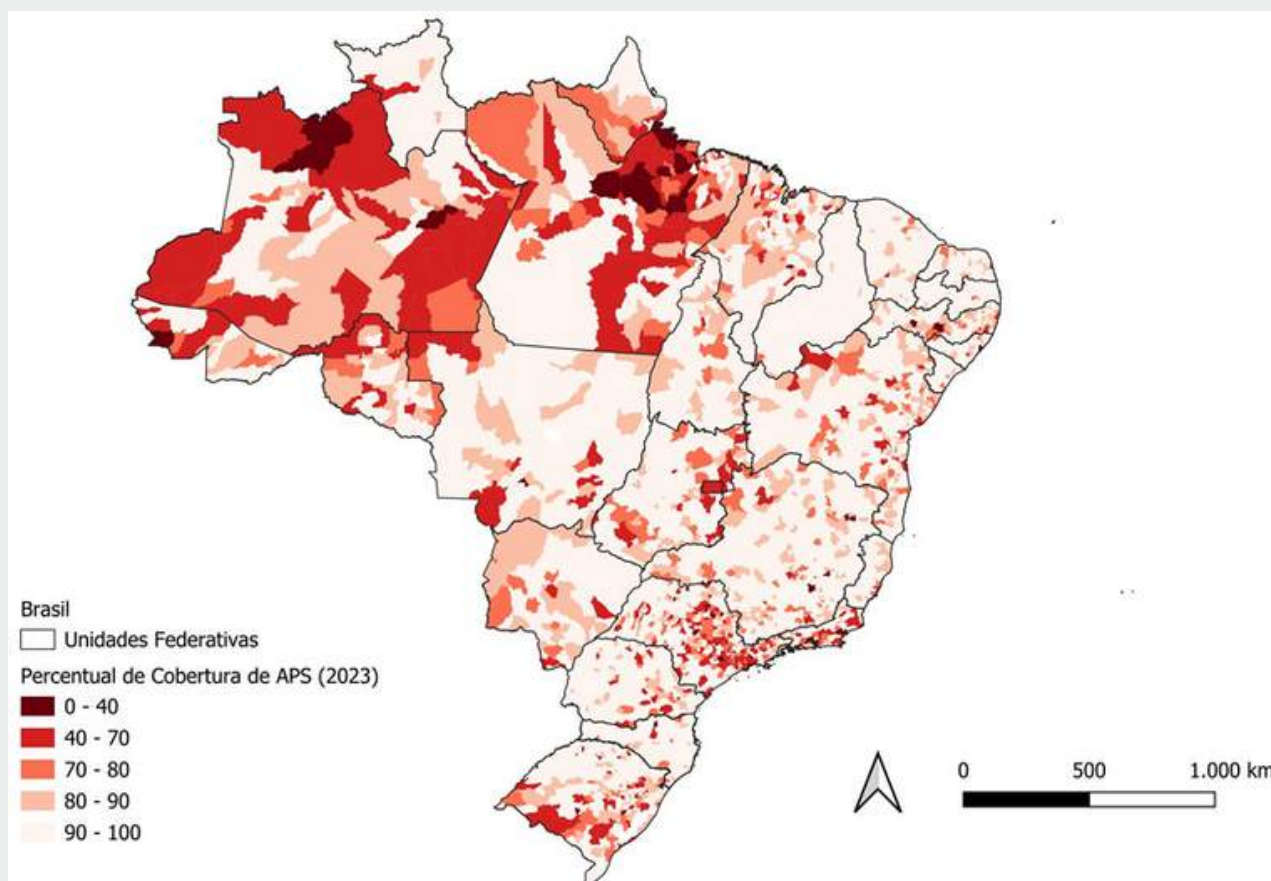
Este indicador representa a proporção da população teoricamente coberta pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) em cada município. A APS é considerada a porta de entrada preferencial do SUS, fundamental para o cuidado longitudinal e coordenado (STARFIELD, 2002).

A ampliação da cobertura da APS está associada a uma redução significativa de hospitalizações por causas evitáveis, como diabetes e hipertensão, além de impacto positivo na saúde infantil e materna (MACINKO; GUERRA, 2015). O indicador permite identificar áreas desassistidas e subsidiar políticas de expansão territorial da saúde básica.

Os dados são extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e, em 2023, indicaram cobertura média nacional de 76%, com variações importantes entre estados, o que reforça a necessidade de estratégias regionalizadas de financiamento e estruturação (BRASIL, 2023).

A Figura 4 apresenta o mapeamento georrefenciado do Percentual de cobertura da Atenção Primária à Saúde (2023).

Figura 4. Mapeamento georrefenciado do Percentual de cobertura da Atenção Primária à Saúde. Brasil, 2023.



Fonte: Dados extraídos do Departamento de Atenção Primária à Saúde (DAPS/SAPS/MS), com base na estimativa populacional IBGE e nas equipes cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). Percentual de cobertura da Atenção Primária à Saúde, ano de referência: 2023. Mapeamento realizado por Ribeiro (2025) exclusivamente para este produto técnico. Elaboração própria com geoprocessamento em QGIS.

3.10.3 ÍNDICE DE EQUIDADE E DIMENSIONAMENTO - IED (2024)

Previsto na Portaria GM/MS nº 3.493/2024, o IED foi desenvolvido para operacionalizar a alocação de recursos federais do Piso da Atenção Primária à Saúde (PAP) com base em critérios de equidade. O índice integra duas dimensões: a vulnerabilidade social (a partir do IVS) e o porte populacional (BRASIL, 2024).

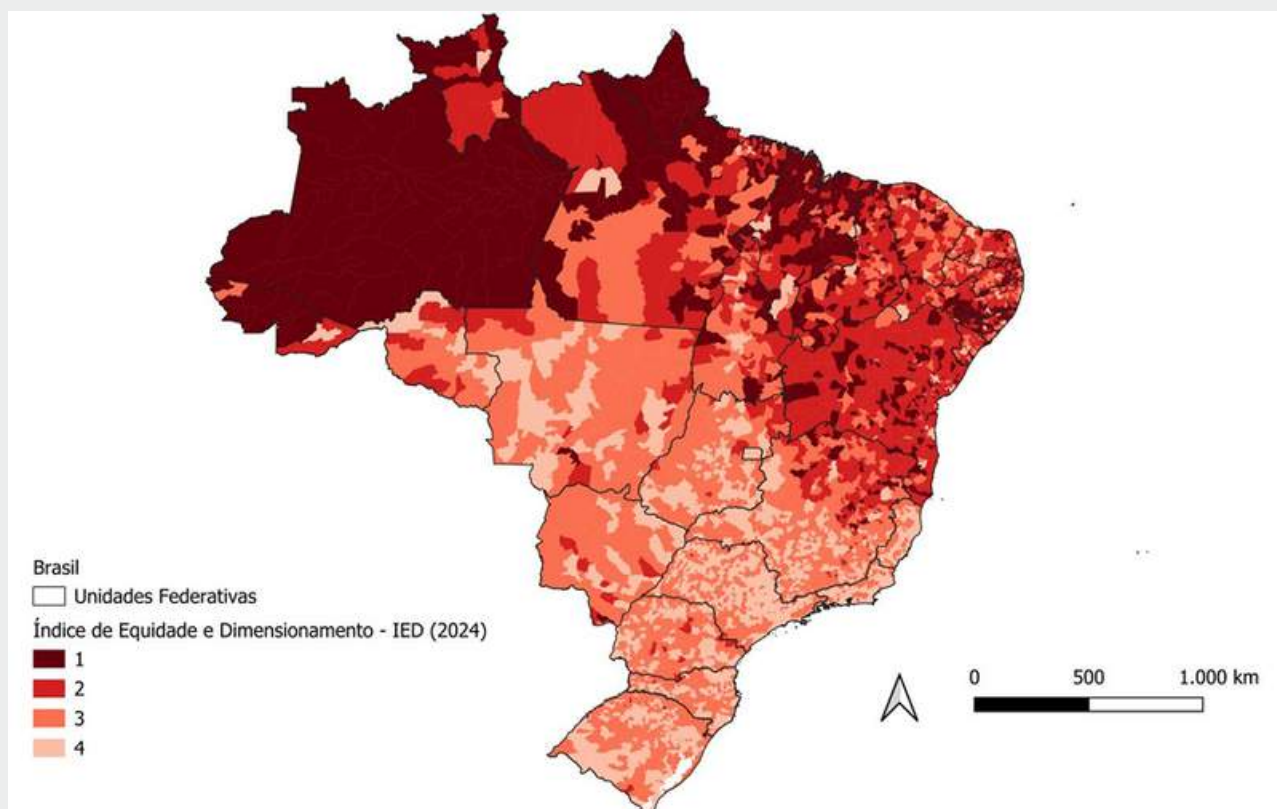
A proposta está alinhada com o princípio constitucional da equidade no SUS, buscando corrigir desigualdades históricas no acesso aos serviços de saúde.

Municípios com maior grau de vulnerabilidade social e menor capacidade instalada são priorizados na distribuição de recursos (PEREIRA et al., 2024).

A implementação do IED contribui para a redistribuição solidária de recursos, respeitando diferenças territoriais e populacionais. Além disso, permite comparações intermunicipais e monitoramento da efetividade do cofinanciamento federal no fortalecimento da atenção primária. Assim, a metodologia de cálculo do IED para o cofinanciamento federal do Piso da Atenção Primária à Saúde reforça o princípio da equidade do SUS, compreendendo a vulnerabilidade social e o porte populacional como importante medida de quais territórios demandam mais recursos de cofinanciamento para apoio na ampliação, fortalecimento e organização do acesso na APS.

A Figura 5 apresenta o mapeamento georrefenciado do Índice de Equidade e Dimensionamento (IED) – 2024.

Figura 5. Mapeamento georrefenciado do Índice de Equidade e Dimensionamento (IED). Brasil, 2024.



Fonte: Índice de Equidade e Dimensionamento (IED) – ano de referência: 2024, conforme Portaria GM/MS nº 3.493, de 2024. Mapeamento realizado por Ribeiro (2025) exclusivamente para este produto técnico. Elaboração própria com geoprocessamento em QGIS.

3.10.4 INCREMENTO ANUAL DE DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL (2008 - 2023)

O desmatamento é uma das principais ameaças à sustentabilidade ambiental, impactando diretamente os serviços ecossistêmicos essenciais à vida e à saúde. O incremento anual de desmatamento representa a quantidade de área desmatada, por ano, na Amazônia Legal, medida em quilômetros quadrados (INPE, 2024).

O desmatamento afeta o equilíbrio climático, a disponibilidade hídrica e a qualidade do ar, além de aumentar o risco de doenças como malária e leishmaniose, frequentemente associadas a áreas de fronteira agrícola e devastação florestal (FUNASA, 2021). Portanto, o indicador é relevante não apenas sob o aspecto ambiental, mas também sob a ótica da saúde pública.

Os dados são disponibilizados pelo sistema TerraBrasilis/PRODES, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com atualizações anuais que permitem o monitoramento por município. A análise espacial do incremento de desmatamento permite identificar pressões ambientais e orientar estratégias de preservação, especialmente em territórios indígenas e unidades de conservação.

3.10.5 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (2023)

As unidades de conservação (UCs) são territórios legalmente instituídos com o objetivo de preservar a biodiversidade e os recursos naturais. A presença de UCs em um município reflete o grau de comprometimento com a proteção ambiental e com os objetivos do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2000).

Além de protegerem ecossistemas frágeis, as UCs contribuem para a manutenção dos serviços ambientais, como regulação climática, produção de água e proteção do solo. Estudos indicam que áreas próximas a UCs apresentam maior estabilidade ambiental e menor incidência de desmatamento e queimadas (MMA, 2021).

Os dados das UCs federais, estaduais e municipais são disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). Sua análise geoespacial permite avaliar a cobertura territorial da proteção ambiental e sua correlação com outros indicadores de saúde e qualidade de vida. A análise espacial do incremento anual de desmatamento da Amazônia Legal no período de 2008 a 2023, aliada à identificação das Unidades de Conservação Ambiental no ano de 2023, foi realizada com a incorporação de camadas geográficas adicionais em formato shapefile, que contemplam os territórios indígenas, territórios quilombolas e áreas de assentamento rural.

Essa abordagem visa ampliar a compreensão sobre os padrões territoriais de pressão e conservação ambiental, permitindo uma leitura mais complexa das dinâmicas socioambientais da região amazônica. As camadas foram integradas por meio de geoprocessamento no software QGIS, proporcionando uma visualização crítica da sobreposição entre as áreas protegidas e as pressões de desmatamento (ALMEIDA et al., 2016; MAPBIOMAS, 2024).

Os territórios indígenas, reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro, desempenham papel crucial na preservação ambiental, sendo historicamente associados a menores índices de desmatamento. Estudos apontam que áreas sob domínio indígena registram menores taxas de conversão de vegetação nativa quando comparadas a outras categorias fundiárias (RAZERA; ARAÚJO; VIEIRA, 2020). A inclusão dessas áreas na análise permite compreender não apenas o impacto do desmatamento sobre os direitos territoriais dos povos originários, mas também reconhecer o protagonismo dessas populações na manutenção de ecossistemas florestais e da biodiversidade (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2022). A proteção legal dos territórios indígenas constitui, portanto, um componente estratégico na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis, alinhando-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015).

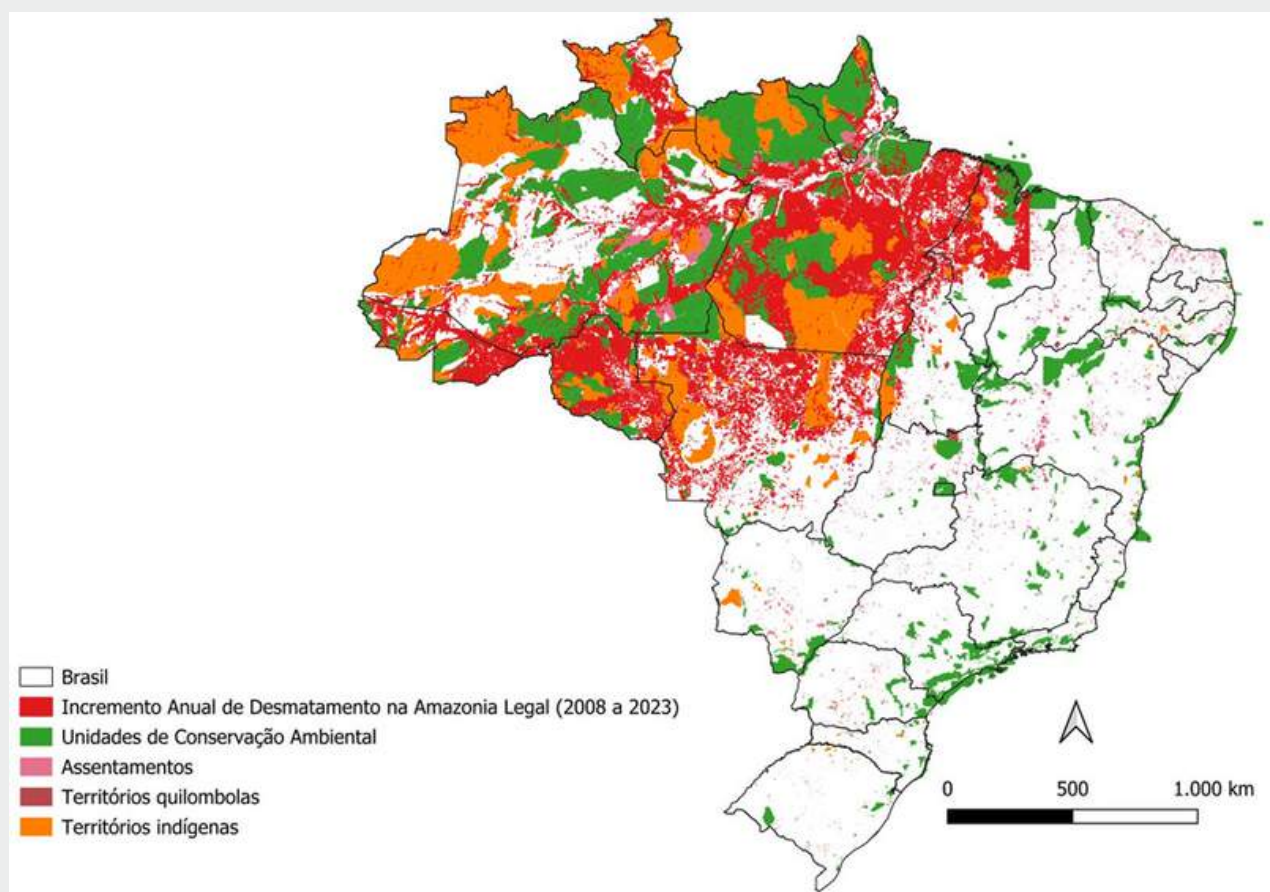
Os territórios quilombolas também foram integrados como camada geográfica, permitindo refletir sobre os impactos ambientais e sociais que incidem sobre esses espaços historicamente marginalizados. A visibilização espacial desses territórios é fundamental para a formulação de políticas públicas intersetoriais que promovam equidade territorial e justiça ambiental (SILVA; RIBEIRO, 2021). A relação entre desmatamento, vulnerabilidade social e ausência de políticas efetivas nesses territórios evidencia a necessidade de estratégias que reconheçam as especificidades étnico-culturais e garantam condições para o pleno exercício dos direitos territoriais e ambientais dessas comunidades (MARTINS; BRASIL, 2019).

Por fim, os assentamentos rurais foram considerados por sua relevância nas dinâmicas agrárias e socioeconômicas da Amazônia Legal. Muitos desses assentamentos, oriundos de processos de reforma agrária, apresentam diferentes padrões de uso do solo e, em diversos casos, estão associados ao avanço do desmatamento em função da ausência de apoio técnico, políticas de fomento agroecológico e infraestrutura básica (INCRA, 2023; IMAZON, 2022). A incorporação dessas camadas ao mapeamento espacial contribui para a análise crítica das políticas de ordenamento territorial e do papel do Estado na promoção de um desenvolvimento rural sustentável. Os dados utilizados foram obtidos nas plataformas públicas do MapBiomas (<https://brasil.mapbiomas.org/tabela-de-camadas/>) e TerraBrasilis/INPE (<https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/citacoes-e-licenca-de-uso/>), assegurando transparência, reprodutibilidade e base científica às análises.

Essa abordagem revela a importância de uma leitura integrada entre preservação ambiental e justiça social na construção de territórios verdadeiramente saudáveis e sustentáveis.

A Figura 6 apresenta o mapeamento georreferenciado do incremento anual do desmatamento na Amazônia Legal (2008–2023), sobreposto às Unidades de Conservação Ambiental, territórios indígenas, quilombolas e assentamentos rurais.

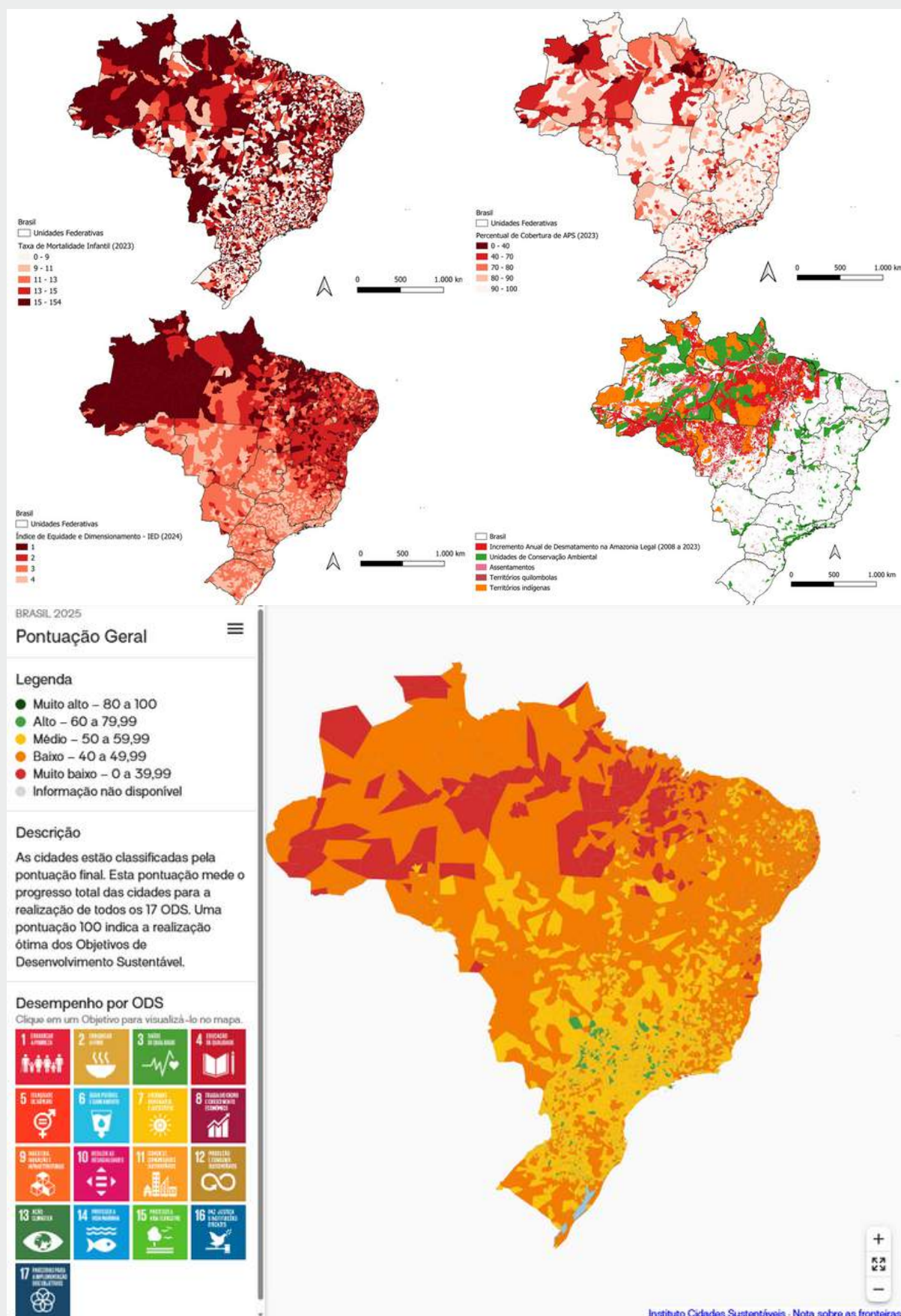
Figura 6. Mapeamento georreferenciado do incremento anual do desmatamento na Amazônia Legal, sobreposto às Unidades de Conservação Ambiental, territórios indígenas, quilombolas e assentamentos rurais. Brasil, 2008 – 2023.



Fonte: Dados extraídos das plataformas MapBiomas (<https://brasil.mapbiomas.org/tabela-de-camadas/>) e TerraBrasilis/INPE (<https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/citacoes-e-licenca-de-uso/>), referentes ao desmatamento anual na Amazônia Legal (2008–2023), Unidades de Conservação Ambiental (2023), territórios indígenas, quilombolas e assentamentos rurais. Mapeamento realizado por Ribeiro (2025) exclusivamente para este produto técnico. Elaboração própria com geoprocessamento em QGIS.

A Figura 7 apresenta, de forma visual integrada, a distribuição espacial dos seguintes indicadores: taxa de mortalidade infantil (2023), percentual de cobertura da Atenção Primária à Saúde (2023), Índice de Equidade e Dimensionamento – IED (2024), incremento anual do desmatamento na Amazônia Legal (2008–2023) e a localização das Unidades de Conservação Ambiental (2023), territórios indígenas, quilombolas e assentamentos rurais.

Figura 7. Painel comparativo geoespacial de indicadores selecionados. Brasil, 2025.



Fonte: Agregado dos mapas anteriores, cujas respectivas fontes estão descritas detalhadamente nas legendas e notas de cada figura. Elaboração própria com base na consolidação geoespacial das camadas apresentadas. Especificamente o mapeamento do IDSC-BR – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, foi elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis

Essa composição cartográfica apresentada na Figura 6 permite uma análise integrada e comparativa de múltiplos indicadores socioambientais e de saúde, oferecendo uma visualização detalhada dos padrões territoriais em nível nacional. Ao sobrepor dados como taxa de mortalidade infantil, cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS), Índice de Equidade e Dimensionamento (IED), incremento do desmatamento na Amazônia Legal e a distribuição das Unidades de Conservação Ambiental, é possível estabelecer relações entre dimensões críticas da sustentabilidade e da equidade. Essa abordagem favorece uma leitura multiescalar do território, essencial para a formulação de políticas públicas mais coerentes com as realidades locais (CASTRO; ALMEIDA, 2020; RIGOTTO et al., 2021).

Observa-se, a partir da análise espacial, uma significativa convergência de padrões territoriais críticos nas regiões Norte e Nordeste do país, onde se concentram os piores indicadores de saúde e maior pressão ambiental. Municípios com elevadas taxas de mortalidade infantil tendem a apresentar também baixas coberturas da APS e baixos escores de equidade no IED (BRASIL, 2024a; DATASUS, 2024). Paralelamente, essas regiões coincidem com áreas de maior avanço do desmatamento e menor densidade de Unidades de Conservação Ambiental, o que evidencia a sobreposição de vulnerabilidades sociais, sanitárias e ecológicas (ALMEIDA et al., 2016; MAPBIOMAS, 2024). A espacialização desses dados reforça o entendimento de que a desigualdade regional no Brasil se expressa de forma multifacetada e persistente (IPEA, 2022).

A integração entre os indicadores de saúde e de sustentabilidade ambiental aponta para a urgência de ações intersetoriais e territorializadas que superem abordagens setoriais fragmentadas. As políticas públicas devem considerar simultaneamente os determinantes sociais da saúde, os riscos ambientais e as capacidades institucionais locais (BUSS; FILIPE, 2021). Essa perspectiva reforça o papel das redes de atenção à saúde, articuladas a estratégias de desenvolvimento territorial sustentável, como eixos centrais de intervenção. Nesse sentido, a territorialização das ações em saúde deve dialogar com instrumentos de planejamento ambiental, uso do solo e justiça social (MONKEN; BARROSO, 2023).

A configuração espacial dos indicadores apresentados justifica a priorização de políticas públicas compensatórias e estruturantes para o Norte e o Nordeste do país. Essas políticas devem ir além da lógica de financiamento per capita e incorporar critérios de equidade regional e vulnerabilidade social (BRASIL, 2023). A expansão da cobertura da APS, a consolidação de equipes de saúde da família, o fortalecimento de práticas agroecológicas nos assentamentos e a valorização dos territórios tradicionais são caminhos estratégicos para a promoção da saúde e da sustentabilidade (FAO; OPAS; WHO, 2019).

Nesse contexto, é essencial o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais, participativas e territorializadas voltadas ao reconhecimento, à proteção e ao desenvolvimento dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis.

Essas políticas devem articular ações nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, agricultura familiar, segurança alimentar, infraestrutura e regularização fundiária, respeitando os modos de vida e os saberes tradicionais das populações que habitam esses territórios. A efetivação dessas iniciativas exige a atuação conjunta de diferentes esferas governamentais, com financiamento adequado, mecanismos de participação social qualificados e sistemas de informação integrados que permitam o monitoramento contínuo dos indicadores de equidade e sustentabilidade nos territórios. Dessa forma, o fortalecimento dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis se constitui como eixo estratégico na construção de um modelo de desenvolvimento baseado na justiça socioambiental, na diversidade cultural e na promoção do bem viver.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este produto técnico teve como objetivo contribuir para a compreensão dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis a partir da identificação, sistematização e análise de indicadores disponíveis na literatura científica e em documentos institucionais, de modo a permitir o mapeamento georreferenciado de alguns indicadores. A partir de critérios de elegibilidade previamente definidos, foram identificados indicadores pertinentes ao tema. Esses indicadores foram organizados em dimensões e subdimensões, refletindo a complexidade e a transversalidade dos fatores que compõem a noção de sustentabilidade territorial.

Os indicadores foram distribuídos entre temas relacionados à sustentabilidade ambiental, condições socioeconômicas, saúde, participação comunitária, equidade, governança, planejamento e monitoramento, população, segurança, indicadores específicos e inovação e dados. Essa diversidade evidencia a multiplicidade de aspectos que devem ser considerados na formulação de políticas públicas comprometidas com o fortalecimento de territórios mais justos, resilientes e sustentáveis. A etapa de síntese e seleção preliminar permitiu destacar os indicadores mais relevantes, considerando não apenas sua frequência na literatura, mas também sua aplicabilidade ao contexto brasileiro e a disponibilidade de dados em bases públicas.

Vale salientar, que o IDSC-BR – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, foi identificado neste estudo como a ferramenta mais robusta e completa entre os indicadores analisados. Trata-se de um índice já sistematizado, com ampla base de dados disponível para os 5.570 municípios brasileiros, apresentado de forma acessível por meio de mapas temáticos interativos. Um de seus principais diferenciais é a organização dos indicadores em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que permite uma análise integrada e alinhada às agendas internacionais. Sua estrutura facilita a visualização comparativa entre municípios e regiões, contribuindo para o diagnóstico de desigualdades e a definição de prioridades locais.

No entanto, apesar de seu potencial analítico e estratégico, o IDSC-BR ainda é pouco conhecido e subutilizado por gestores públicos, planejadores e formuladores de políticas. É urgente que essa ferramenta seja mais amplamente divulgada e incorporada aos processos de tomada de decisão, planejamento territorial e monitoramento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à equidade.

Como avanço metodológico, os indicadores selecionados foram espacializados por meio de georreferenciamento, possibilitando a visualização integrada dos territórios a partir das evidências sistematizadas.

Essa abordagem cartográfica permitiu observar padrões territoriais e sobreposições críticas, revelando, por exemplo, a concentração de piores indicadores de saúde e sustentabilidade nas regiões Norte e Nordeste do país. O mapeamento tornou possível a análise comparativa entre indicadores como mortalidade infantil, cobertura da APS, índice de equidade e incremento do desmatamento, evidenciando desigualdades estruturais e a necessidade de ações direcionadas a esses territórios.

Apesar dos avanços, é importante reconhecer as limitações do estudo, especialmente relacionadas à escassez de informações metodológicas em parte dos documentos analisados — muitos não especificavam o tipo de estudo ou o método utilizado. Ainda assim, a sistematização realizada representa um passo significativo na consolidação de uma base conceitual e empírica sobre os Territórios Saudáveis e Sustentáveis no Brasil, contribuindo para o aprimoramento do planejamento público e da governança territorial em saúde, meio ambiente e desenvolvimento.

Dentre as limitações deste produto técnico, destaca-se o elevado grau de complexidade envolvido na construção dos mapas temáticos, que exigiu um trabalho minucioso e criterioso. A manipulação de dados referentes aos 5.570 municípios brasileiros demandou a criação de bancos de dados robustos, sua limpeza e padronização, além da compatibilização de diferentes fontes públicas. Somente após essas etapas foi possível realizar o georreferenciamento das informações utilizando o software QGIS, assegurando a consistência espacial dos resultados. Esse processo, embora tecnicamente exigente, é fundamental para garantir a precisão das análises territoriais e a qualidade das evidências produzidas, mas representa um desafio significativo em termos de tempo, recursos e capacidade técnica.

Em suma, o fortalecimento dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis deve ser reconhecido como um eixo estratégico para a promoção do bem viver, exigindo o envolvimento articulado de diferentes esferas de governo, academia, sociedade civil e comunidades locais. São necessárias mais pesquisas/produtos técnicos que aprofundem o entendimento sobre a adequação dos indicadores ao contexto brasileiro e que ampliem a produção de dados acessíveis, transparentes e territorializados. Essa agenda é indispensável para a construção de um futuro mais equitativo e sustentável, capaz de garantir qualidade de vida e justiça para todas as populações, em todos os territórios.

REFERÊNCIAS

ADRIANO, J. R.; WERNECK, G. A. F.; SANTOS, M. A. dos; SOUZA, R. de C. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida? *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 53–62, 2000. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100006>.

ADRIANO, J.R.; WERNECK, G.A.F.; SANTOS, M.A.; SOUZA, R.C. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a melhoria da qualidade de vida? *Cien. Saúde Coletiva*. v.5, n.1, 53-62, 2000.

ALMEIDA, C. A. de et al. Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia Legal: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 68, n. 1, p. 103-120, 2016.

AROMATARIS, E. et al. JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI; 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>. Acesso em: 01 mar. 2025.

AROMATARIS, E. et al. JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI; 2024. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-24-09>. Acesso em: 01 mar. 2025.

AWOFESO, N. The Healthy Cities approach: Reflections on a framework for improving global health. *Bulletin of the World Health Organization*, v. 81, p. 222 223, 2003.

BANWELL, N.; LAW, R.; MACKEY, B.; RUTHERFORD, S. Implementation of national health adaptation policy: a case study of policy principles and implementation barriers in the Philippines. *Regional Environmental Change*. v.21, n.93, 2021.

BARCELLOS, Christovam; PEREIRA, Francisco N. Vulnerabilidade socioambiental, território e saúde: uma abordagem integrada. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 4, p. 1295–1304, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.00472021>

BARCELLOS, Christovam. A geografia e o contexto dos problemas de saúde. In: BARATA, Rita de Cássia Barradas (Org.). *Condicionantes e determinantes da saúde nas cidades*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 49–62.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70 Brasil; [1977] 2016.

BARROS, F. C.; VICTORA, C. G. Mortalidade infantil no Brasil: tendências, causas e estratégias de prevenção. *Revista de Saúde Pública*, v. 53, n. 8, 2019.

BICK, N. Citizen involvement in local sustainability policymaking: an in-depth analysis of staff activities and motivations. *Sustain Sci*. v. 19, p.1865–1880, 2024.

BONAB, M.R.; RAJABI, F.; VEDADHIR, A.; MAJDZADEH, R. Sustainable political commitment is necessary for institutionalizing community participation in health policy-making: Insights from Iran. *Health Res Policy Syst*. v.22, n.1, 2024.

BOTCHWAY, E.A.; AGYEKUM, K.; KOTEI-MARTIN, J.N.; PITTRI, H.; DOMPEY, A.M.A.; AFRAM, S.O.; ASARE, N.E. Achieving Healthy City Development in Ghana: Referencing Sustainable Development Goal 11. *Sustainability*. v.15, n.19, 2023.

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. *Diário Oficial da União*, 19 jul. 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: MS, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024. Institui o Índice de Equidade e Dimensionamento (IED). Brasília: MS, 2024a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024. Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso da Atenção Primária à Saúde. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2761, de 19 de novembro de 2013, que institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Brasília: DATASUS, 2023.

BRYAN, B.A.; RAYMOND, C.M.; CROSSMAN, N.D.; MACDONALD, D.H. Targeting the management of ecosystem services based on social values: Where, what, and how? *Landscape and Urban Planning*. v.97, n.2, p.111-122, 2010.

BUSS, P. M.; FILIPE, L. M. A saúde e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Agenda 2030 e seus determinantes sociais. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 8, e00141020, 2021.

BUSS, P.M.; HARTZ, Z.M.A.; PINTO, L.F.; ROCHA, C.M.F. Health promotion and quality of life: a historical perspective of the last two 40 years (1980-2020). *Cien. Saúde Coletiva*. v.25, n12, p.4723-4735, 2020.

BUSS, Paulo M.; FILIPE, Ana Paula S. Territórios saudáveis e sustentáveis: uma proposta para implementação da Agenda 2030 da ONU em nível local. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 10, p. 4207–4216, 2021. <https://doi.org/10.1590/1413 812320212610.10062021>

CACIQUE, M. et al. Updating Healthy City Variables for the Post-pandemic Era Using Delphi Method. In: *Proceedings of 2021 4th International Conference on Civil Engineering and Architecture*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. p. 455 466.

CASTRO, J. L.; ALMEIDA, M. P. Vulnerabilidades territoriais e saúde no Brasil: uma análise baseada em dados geoespaciais. *Saúde em Debate*, v. 44, n. 126, p. 344–359, 2020.

CECÍLIO, L. C. O. Apontamentos teórico-conceituais sobre processos avaliativos considerando as múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 15, n. 37, p. 589–99, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832011000200021>.

CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE SAÚDE. Territórios Saudáveis e Sustentáveis – Número Especial, *Saúde em debate*, v.48, n. esp. 1, Rio de Janeiro, 2024.

ÇETIN, Z.O. Healthy cities and municipal administrations in Türkiye: the case of Denizli Metropolitan Municipality. *Humanities and Social Sciences Communications*. v11, 2024.

CHÁVEZ, B.M. Limitantes de la estrategia de municipios saludables como política pública en Antioquia. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*. v.27, n.3, p.264-270, 2009.

CHIANG, C. A systematic literature network analysis of green information technology for sustainability: Toward smart and sustainable livelihoods. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 199, p. 123053, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123053>.

CHO, H-J.; Kim, J-H.; Lee, E-A. A Study on the Advancement of Spatial Maps and the Improvement of the Legal System as a Key Tool for Sustainable National Landscape Planning: Case Study of South Korea. *Land*. v.12, n.5, 2023.

CHU, E.; ANGUELOVSKI, I.; CARMIN, J. Inclusive approaches to urban climate adaptation planning and implementation in the Global South. *Climate Policy*. v.16, n.3, 2016.

COLE, H.; SHOKRY, G.; CONNOLLY, J.J.T.; PÉREZ-DEL-PUGAR, C.; ALONSO, J.; ANGUELOVSKI, I. Can Healthy Cities be made really healthy? *Lancet Public Health*. v.2, n.9, e394-e395, 2017.

CONTANDRIOPOULOS, A. P. et al. Avaliação em saúde: aspectos conceituais e operacionais. In: HARTZ, Z. M. A. (org.). *Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. p. 29–47.

CRANE, M.; LLOYD, S.; HAINES, A.; DING, D.; HUTCHINSON, E.; BELESOVA, K.; DAVIES, M.; OSRIN, D.; ZIMMERMANN, N.; CAPON, A.; WILKINSON, P.; TURCU, C. Transforming cities for sustainability: A health perspective. *Environment International*, v. 147, p. 106366, fev. 2021. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106366>

CRUZ, P. J. S. C. et al. Educação popular em saúde: princípios, desafios e perspectivas na reconstrução crítica do país. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 28, p. e230550, 2024.

DATASUS. Departamento de Informática do SUS. Taxa de Mortalidade Infantil por Município, 2023. Brasília: MS, 2024. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

DE LEEUW, E. et al. Policymaking in European healthy cities. *Health promotion international*, v. 30, n. suppl_1, p. i18-i31, 2015.

DEPRIEST, K.; GLASGOW, L.; BAYER, E.M.; WEISS, S.; HACKER, K. Building healthy, equitable, and resilient communities: lessons learned from multisector community partnerships addressing the social determinants of health. *J Public Health Manag Pract*. v.31, n.1, p.83-89, 2025.

DEPRIEST, K.; HAMILTON, R.; BARNES, J. The Conceptual Foundations of Healthy and Sustainable Territories: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 22, n. 1, p. 145-163, 2025.

DHL, Len; HANCOCK, Trevor. *Healthy cities: promoting health in the urban context*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1988.

DOMINGUES, L.C.S.M.; SILVA, G.A.; RAVERA, C.B. Promoção de territórios saudáveis: assessoria técnica à habitação social no Setor 1 da Colônia Juliano Moreira. *Saúde em debate*. v.48, n. esp. 1, 2024.

Saúde em debate. v.48, n. esp. 1, 2024. DOORIS, M.; HERITAGE, Z. Healthy Cities: facilitating the active participation and empowerment of local people. *J Urban Health*. v.90, suppl.1, p.74-91, 2013.

DUHL, Leonard J.; HANCOCK, Trevor. *Healthy cities: promoting health in the urban context*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1988.

ESFANDI, S.; TAYEBI, S.; BYRNE, J.; TAMINIAU, J.; GIYAHCHI, G.; ALAVI, S. A. Smart cities and urban energy planning: An advanced review of promises and challenges. *Smart Cities*, v. 7, n. 1, p. 414–444, 2024. <https://doi.org/10.3390/smartcities7010016>.

EVANS, D.; KAZARIAN, S.S. Health Promotion, Disease Prevention, and Quality of Life. *Handbook of Cultural Health Psychology*. p. 85-112, 2001.

FAO; OPAS; WHO. Sistemas alimentares sustentáveis para dietas saudáveis. Brasília: FAO, 2019.

FERRAZ, S. F. A pertinência da adoção da filosofia de cidades saudáveis no Brasil. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, n. 41, p. 45-49, dez. 1993.

FITRY, I.N.; PALUTTURI, S.; THAHA, R.M.; SYAM, A. Impact Evaluation of Healthy City Implementation in Makassar City. Open Access Maced J Med Sci. v.8, T2, pag. 12-5, 2020.

FOLKVORD, F.; ROEL C. J. Hermans Food Marketing in an Obesogenic Environment: a Narrative Overview of the Potential of Healthy Food Promotion to Children and Adults. Current Addiction Reports. v.7, p.431-436, 2020.

FREIRE, M.S.M.; SALLES, R.P.S.; SÁ, R.M.P.F. Mapeando iniciativas territoriais saudáveis, suas características e evidências de efetividade. Cienc. Saude Coletiva. v.21, n.6, p.1757-66, 2016.

FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Doenças relacionadas ao desmatamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

GADELHA, P.; AMEIXA, V. Territórios Sustentáveis e Saudáveis no SUS: a relação intrínseca com a Agenda 2030. Saúde debate. v.48, Esp.1., 2024.

GALINDO, E.F.; FURTADO, M.F.R.G. A intersetorialidade como requisito para construção de uma cidade saudável: política de saneamento e de saúde no Recife (gestão 2001/2004) : estudo de caso. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós- Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

GALLO, E.; SETTI, A.F.F. Território, intersetorialidade e escalas: requisitos para a efetividade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 4383-4396, 2014.

GILMORE, A.B.; FABBRI, A.; BAUM, F.; BERTSCHER, A.; BONDY, K.; CHANG, H. Defining and conceptualising the commercial determinants of health. The Lancet. v.401, n.10383, p.1194-1213, 2023.

GRANT, M. European Healthy City Network Phase V: patterns emerging for healthy urban planning. Health Promot Int. Sup.1, p.54-70, 2015.

GUPTA, S.; SETHI, N.L. How to Make Future Cities Smart in the Realm of Environmentally Friendly Healthy Cities? Looking from the Perspective of Ease of Living Index. Journal of Environmental & Earth Sciences, v. 6 , n.2, 2024.

HANCOCK, T. Towards healthy One Planet cities and communities: planetary health promotion at the local level. *Health Promot Int.* v.36, n. Sup.1, p.i53-i63, 2021.

HASDELL, R. The Space in Between: Healthy Public Policy Development in Canada's Provincial North. Tese de doutorado [Programa de pós-graduação em Filosofia - Dalla Lana School of Public Health]. University of Toront. 240 p., 2019.

HUANG, H. et al. Healthy city evaluation based on factor analysis—Taking cities in the Guangxi Zhuang Autonomous Region as an example. *Plos one*, v. 19, n. 7, p. e0306344, 2024.

IAMTRAKUL, P.; CHAYPHONG, S. Factors affecting the development of a healthy city in Suburban areas, Thailand. *Journal of Urban Management.* v.12, n.3, 2023.

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. TerraBrasilis – PRODES. São José dos Campos, 2024. Disponível em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Malhas territoriais digitais do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>

INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS. IDSC-BR – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil. São Paulo: Instituto Cidades Sustentáveis, 2024. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

INSTITUTO CIDADES SUSTENTÁVEIS. IDSC-BR – Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil, 2025. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. COORDENAÇÃO-GERAL DE CIÊNCIAS DA TERRA. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS BIOMAS BRASILEIROS. Deter – Monitoramento Diário da Supressão e Degradação da Vegetação Nativa – Alertas – Amazônia/Cerrado/Pantanal – Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/>. Acesso em: 10 fev. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. COORDENAÇÃO-GERAL DE CIÊNCIAS DA TERRA. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS BIOMAS BRASILEIROS. Prodes – Monitoramento Anual da Supressão da Vegetação Nativa – Amazônia/Cerrado/Pantanal/Caatinga/Mata Atlântica/Pampa – Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/downloads/>. Acesso em: 15 fev. 2025.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros. Brasília: IPEA, 2022.

JONGEN, C.S.; McCALMAN, J.; BAINBRIDGE, R.G. The Implementation and Evaluation of Health Promotion Services and Programs to Improve Cultural Competency: A Systematic Scoping Review. *Front Public Health*. v.5, n.24, 2017.

KAMPER-JØRGENSEN, F. Editorial: The Healthy Cities. *Scandinavian journal of public health*, v. 38, n. 2, p. 113-4, 2010.

KEGLER, M.; NORTON, B.L.; ARONSON, R. Achieving organizational change: findings from case studies of 20 California healthy cities and communities coalitions. *Health Promot Int*. v.32, n.2, p.109-18, 2008.

KEINERT, T.M.M. Planejamento governamental e políticas públicas: a estratégia “cidades saudáveis”. *Saúde Sociedade*. v.6, n.2, p.55-64, 1997.

KICKBUSCH, Ilona; NUTBEAM, Don; ARONSON, Bruce. Governance for health in the 21st century. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008.

KICKBUSCH, Ilona; NUTBEAM, Don; ARONSON, Bruce. Governance for health in the 21st century. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008.

KLEDGER, M.C.; NORTON, B.L.; ARONSON, R.E. Strengthening Community Leadership: Evaluation Findings from the California Healthy Cities and Communities Program. *Health Promotion Practice*. v.9, n.2, p.170-179, 2008.

KLINGBERG, S.; ADHIKARI, B.; DRAPER, C.E.; BOSIRE, E.; NYIRENDA, D.; TIIGAH, P.; MUKUMBANG, F. Enhanced or hindered research benefits? A realist review of community engagement and participatory research practices for non communicable disease prevention in low- and middle-income countries. *BMJ Glob Health*. v.9, n.2, 2024.

LAUREANO-EUGENIO, J.; GÓMEZ-RODRÍGUEZ, R.O.; TASEJO-CORZANTES, J.; RAMÍREZ, A.S.; AGUILAR, R.M.P.; ALCALDE-RABANAL, J.E. Sustainability of the Healthy Municipalities Strategy in Guatemala. *Rev Panam Salud Publica*. v.45, 2021. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.70>

LAZARO, L. L. B.; SOARES, R. S. The energy quadrilemma challenges – Insights from the decentralized energy transition in Brazil. *Energy Research & Social Science*, [S.l.], v. 113, p. 103533, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103533>

LEE, M.; PARK, S.; YOON, K. Does Health Promotion Program Affect Local Resident' Emotions? *Int J Environ Res Public Health*. v.16, n.4, 2019. <https://doi.org/10.3390/ijerph16040549>.

LEE, P.R.; FUCCILLO, R.; WOLFF, T. J. Key components of a statewide healthy communities effort. *Public Health Reports*, v. 115, n. 2-3, p. 134, 2000.

LEEuw, E.; KICKBUSCH, I.; PALMER, N.; SPANSWICK, L. European Healthy Cities come to terms with health network Governance. *Health Promot Int*. v.30, Suppl 1, p.32-44, 2015.

LI, H.; GUO, J.; PAN, C.; WU, J.; LIU, X. The EWM-Based Evaluation of Healthy City Construction Levels in East China under the Concept of "Making Improvements Is More Important Than Reaching Standards". *Sustainability*. v.16, n.10, 2024.

LIM, N.H.H.; HASNAN, L.; ABIDIN, N.Z.; CHOWDHURY, S.; JALIL, N.A.S.A.; HASSAN, L.S. Exploring the relationship between the perceived importance of healthy city indicators and satisfaction levels towards the local government in shaping a healthy city. *Planning Malaysia*. v.21, n.29, 2023.

LIMA, F.A.; LIMA, S.C. Construindo cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do Planejamento Estratégico Situacional. *Saúde Soc*. v.29, n.2, 2020.

LIN, J.S.; WEBBER, E.M.; BEAN, S.I.; MARTIN, A.M.; DAVIES, M.C. Policy actions for the integration of public health and health care in the United States. *Public Health*. v.11, 2023.

LIU, L. et al. The development and application of a two-step surveillance process for Healthy China Initiative based on wide coverage interagency data. *Global Health Research and Policy*, v. 8, n. 1, p. 42, 2023.

LIU, X. Countermeasures to promote sustainable construction and coordinated development of healthy cities: a case study of Dandong City. *Energy Informatics*. v.7, n.60, 2024.

LLORCA, E.; AMOR, M.T.; MERINO, B.; MÁRQUEZ, F.J.; GÓMEZ, F.; RAMÍREZ, R. Ciudades saludables: una estrategia de referencia en las políticas locales de salud pública. *Gac Sanit*. v.24, n.6, 435-436, 2010.

LUO J.; CHAN, E.; DU, J.; FENG, L.; JIANG, P.; XU, Y. Developing a Health-Spatial Indicator System for a Healthy City in Small and Midsized Cities. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. v.19, n.6, 2022.

LV, Z.; GUO, H.; ZHANG, L.; LIANG, D. Comparative Study on the Evaluation of Healthy City Construction in Typical Chinese Cities Based on Statistical Data and Land Use Data. *Sustainability*, v.14, n.5, 2022.

LY, E.H.; SMARD, P.; O'NEILL, M. Research into the applicability of the healthy cities movement in Dakar district (Senegal): Methodology and results. *Environment & Urbanization*. v.10, n.2, 1998.

MA, Wei et al. Urban health and sustainable cities: Strategies and frameworks for action. *Global Health Journal*, v. 6, n. 3, p. 89–102, 2022.

MACHADO, J. M. H. et al. Territórios saudáveis e sustentáveis: contribuição para saúde coletiva, desenvolvimento sustentável e governança territorial. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 7, p. 243-249, 2017. <https://doi.org/10.1590/1413 81232017227.02942017>.

MACHADO, J.M.H.; MARTINS, W.J.; SOUZA, M.S.; FENNER, A.L.; MACHADO, A.A. Territórios saudáveis e sustentáveis: contribuição para saúde coletiva, desenvolvimento sustentável e governança territorial. *Com. Ciências Saúde*. v.28, n.2, p.243-249, 2017.

MACINKO, J.; GUERRA, H. L. Avaliação da atenção primária à saúde no Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 37, n. 4/5, p. 233-240, 2015.

MAPBIOMAS. Tabela de camadas. 2024. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/tabela-de-camadas/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

MATIAS, J. L. N.; JEREISSATI, L. C.. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. *Revista de Direito da Cidade*, v. 14, n. 1, p. 643–672, jan. 2022.

MATIAS, J.L.N.; JEREISSATI, L.C. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. *Rev. Dir. Cid.* v.14, n.1, p.643-672, 2022.

MELLER, F. O. al. Qualidade de vida e fatores associados em trabalhadores de uma Universidade do Sul de Santa Catarina. *Cadernos saúde coletiva*, v. 28, p. 87-97, 2020.

MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

MERT-CAKAL, T; MIELE, M. 'Workable utopias' for social change through inclusion and empowerment? Community supported agriculture (CSA) in Wales as social innovation. *Agriculture and Human Values*. v.37, p.1241–1260, 2020.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Brasília: 2021.

MONKEN, M. et al. Território e processo saúde-doença: a abordagem da vigilância em saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 24, n. 10, p. 2219–2228, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008001000020>

MONKEN, M. Território e saúde: apontamentos conceituais para a proposta de territórios sustentáveis e saudáveis. Saúde em Debate. v. 48, n. 1, e8721, 2024. MONKEN, M.; BARROSO, R. A saúde nos territórios: intersetorialidade, território e planejamento em saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 5, p. 1237–1244, 2023.

MONKEN, Marcelo. Territórios saudáveis: dimensões políticas, simbólicas e ecológicas. In: BUSS, P. M.; PEPE, V. L. E. (Org.). Promoção da saúde e sustentabilidade: fundamentos, práticas e desafios. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2024. p. 131-152.

MOREIRA, M.F.R. et al. Mudanças climáticas e suas implicações para a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, produção agrícola e ambiente. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 50, p. eddsst5, 2025.

MOURA, R.A.; FERREIRA, K.P.M. Cidade saudável: o diagnóstico do território urbano por meio dos determinantes sociais de saúde: o caso Maracanaú. Saúde e Pesquisa. v.14, n.1, p.201-211. 2021.

NASCIMENTO, P.R.; WESTPHAL, M.F.; MOREIRA, R.S.; BALTAR, V.T.; MOYSÉS, S.T.; ZIONI, F. et al. Impact of the Social Agendas – Agenda 21 and Healthy Cities – upon Social Determinants of Health in Brazilian municipalities: measuring the effects of diffuse social policies through the dimensions of the Millennium Development Goals. Rev. Bras Epidemiol. Suppl DSS, p.1-14, 2014.

NIEMEYER, C.B.; LARA, P.C.; XAVIER, J.B.; AZEVEDO, L.O. 'O povo cuidando do povo': Agentes Populares na promoção de territórios mais sustentáveis e saudáveis. Saúde debate. v.48., n. esp.1, e8739, 2024.

OLIVEIRA, S. S. et al. Vigilância popular em saúde: conceitos, experiências e desafios no contexto brasileiro. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 28, p. e240304, 2024.

ONU – Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque: ONU, 2015.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 11 jun. 2025.

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde. Indicadores básicos: situação de saúde nas Américas. Washington, D.C.: OPAS, 2016. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/31286>.

PAHO – PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Health in All Policies and the Sustainable Development Goals: call for action. Washington, D.C.: PAHO, 2022.

PARK, S.; YEOM, H.Y.; SOK, S.R. Effects of health promoting education program for Korean middle-aged women. J Phys Ther Sci. v.31, n.1, p.5–11, 2019.

PATNAIK, S.; JHA, S. Caste, class and gender in determining access to energy: A critical review of LPG adoption in India. Energy Research & Social Science. v.67, 2020.

PEDERSON, A.; ROOTMAN, I. From Health Care to the Promotion of Health: Establishing the Conditions for Healthy Communities in Canada. In: DE LEEUW, E.; SIMOS, J. (eds) Healthy Cities. Springer, New York, NY. 2017.

PENAFORTE, T.R. A abordagem territorial nos Territórios Sustentáveis e Saudáveis: um alargamento conceitual a partir da antropologia. Saúde debate. v.48, n. esp.1, e8726, 2024.

PEREIRA, J. R. et al. Equidade na alocação de recursos para a APS: avanços com o IED. Cadernos de Saúde Pública, v. 40, n. 2, p. 123-134, 2024.

PETERS, D.; HARTING, J.; OERS, H.V.; SCHUIT, J.; VRIES, N.; STRONKS, K. Manifestations of integrated public health policy in Dutch municipalities. Health Promotion International. v.31, n.2, p. 290–302, 2016.

PETERSEN, R.S.; SILVEIRA, M.; FENNER, A.L.D.; CAMPOS, A.S.; MARTINS, W.J.; MACHADO, J.M.H. Índice de Território Saudável e Sustentável dos municípios do semiárido brasileiro. Cad. Saúde Pública. v.36, n.11, 2020.

PILON, A.F. Twenty steps for developing a healthy cities project. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen, 1992. Rev. Saúde Pública. v.27, n.4, p.308-10, 1993.

PINEO, H. et al. Promoting a healthy cities agenda through indicators: development of a global urban environment and health index. *Cities & health*, v. 2, n. 1, p. 27-45, 2018.

PORTNEY, K.E.; SANSOM, G.T. Sustainable cities and healthy cities: Are they the same? *Urban Planning*. v.2, n.3, 2017.

QGIS Development Team. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project, 2025. Disponível em: <https://qgis.org>.

RIBEIRO, R.C. A construção de um município saudável: descentralização e intersetorialidade-experiência de Fortaleza. *Saúde e Sociedade*, v. 6, p. 47-54, 1997.

RICHARDSON, Benjamin Ward. *Hygeia: A City of Health*. London: Macmillan and Co., 1876. Disponível em: <https://archive.org/details/HygeiaACityOfHealth>. Acesso em: 11 jun. 2025.

RIGOTTO, R. M. et al. Cartografias das injustiças socioambientais e saúde no Brasil. Fiocruz, 2021.

ROJAS-RUEDA, D.; NORBERCIAK, M.; MORALES-ZAMORA, E. Advancing Health Equity through 15-min Cities and Chrono-urbanism. *J Urban Health*. v.101, n.3, p.483-496, 2024.

SALAS-ZAPATA, L.; LÓPEZ-RÍOS, J. M.; GÓMEZ-MOLINA, S.; FRANCO- MORENO, D.; MARTÍNEZ-HERRERA, E. Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias visando qualidade de vida. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, v. 34, n. 1, p. 105–110, 2016.

SALAS-ZAPATA, L.; LÓPEZ-RÍOS, J.M.; GÓMEZ-MOLINA, S.; FRANCO- MORENO, D.; MARTÍNEZ-HERRERA, E. Cidades sustentáveis e saudáveis: estratégias para qualidade de vida. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública*. v.34, n.1, p.96-104, 2016.

SANTOS, E.L.; FRANZ, N.M.; SIMÃO, A.G.; TERNOSKI, S.; SILVA, C.L.; SANTOS, GD. Cidades inteligentes e sustentáveis: percepções sobre a cidade de Curitiba/PR a partir dos planos plurianuais de 2014 a 2021. *urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana*. v. 14, e20210299, 2022. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210299>

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2006.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996.

SCHELINGS, C.; DEFAYS, A.; ELSEN, C. Profiling citizens in the smart city: A quantitative study in Wallonia. *Smart Cities*, v. 6, n. 4, p. 2125–2149, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/smartcities6040098>.

SCOTT, A; HISLOP, M. What does good green and blue infrastructure policy look like: A comparative assessment of UK national planning guidance. *Urban Forestry & Urban Greening*, v. 99, p. 128440, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128440>.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Movimento "São Paulo - cidade saudável". São Paulo: Secretaria Municipal de Saúde, 1990.

SELLERA, P.E.; MORO, M.F.S.A.; ALBUQUERQUE, R.H.; BRAGA, L.I.; SOUZA, M.S.; LIMA, A.S.; MARTINS, W.J. A ativação de redes sociotécnicas na cidade estrutural/DF, Brasil: construindo um território saudável e sustentável. *Cien. Saúde Coletiva*. v.24, n.6, p.2185-91, 2019.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

SETTI, A.F.; RIBEIRO, H.; AZEITEIRO, U.M.; GALLO, E. Governance and the promotion of sustainable and healthy territories: the experience of Bocaina, Brazil. *Journal of Integrated Coastal Zone Management*. v.16, n.1, p.57-69, 2016.

SHAYA, F.T.; GBARAYOR, C.M. The Case for Cultural Competence in Health Professions Education. *Am J Pharm Educ*. v.70, n.6, 2006.

SILVA, C.V.P.; ALBUQUERQUE, P.C.; MELLO, L.M.B.D.; TAVARES, M.S. Agentes populares no contexto da pandemia de Covid-19: educação popular em saúde na construção de territórios saudáveis e sustentáveis. *Interface (Botucatu)*. v.28: e230142, 2024.

SILVA, K. L.; BERTOLLI FILHO, C. (org.). Territórios saudáveis e sustentáveis: caminhos da vigilância popular da saúde. São Paulo: Hucitec, 2020.

SILVA, M.A.; XAVIER, D.R.; ROCHA, V. Do global ao local: desafios para redução de riscos à saúde relacionados com mudanças climáticas, desastre e Emergências em Saúde Pública. *Saúde em Debate*, v. 44, p. 48-68, 2021.

SIRI, José G. Sustainable, healthy cities: making the most of the urban transition. *Public Health Reviews*, v. 37, n. 1, p. 1–23, 2016.

SPERANDIO, A.M.; CORREA, C.R.S.; SERRANO, M.M.; RANGEL, H.A. Caminho para a construção coletiva de ambientes saudáveis – São Paulo, Brasil. *Cien. Saude Coletiva*. v.9, n.3, p.643-654, jul. 2004.

SPERANDIO, A.M.G.; FRANCISCO FILHO, L.L.; MATTOS, T.P. Política de promoção da saúde e planejamento urbano: articulações para o desenvolvimento da cidade saudável. *Cien. Saúde Coletiva*. v.21, n.6, p.1931-37, 2016.

STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

STEPHEN, C. Expanding the Concept of Healthy Public Policy for Animals, Health, and Society. In: STEPHEN, C. *Animals, Health, and Society*. 1st ed., CRC Press, 2020.

STILLWELL, S.B. et al. Searching for the Evidence. Strategies to help you conduct a successful search. *American Journal Nursing*, v.110, n.5, p.41-47, 2010.

STUIFBERGEN, A.K.; SERAPHINE, A.; HARRISON, T.; ADACHI, E. An explanatory model of health promotion and quality of life for persons with post-polio syndrome. *Soc Sci Med*. v.60, n.2, p.383-93, 2005.

SZWARCWALD, C. L. et al. Desigualdades na mortalidade infantil no Brasil: tendências e determinantes. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 5, 2021.

TANGUAY, G. A.; RAJAONSON, J.; BILODEAU, P. Linking quality of life and sustainability in Canadian cities. *Cities*, v. 143, p. 104608, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104608>.

TERRABRASILIS/INPE. Plataforma de Dados Espaciais sobre o Desmatamento na Amazônia Legal. 2024. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br>. Acesso em: 13 jun. 2025.

TOBEY, M. B.; BINDER, R. B.; CHANG, S.; YOSHIDA, T.; YAMAGATA, Y.; YANG, P. P. J. Urban Systems Design: A Conceptual Framework for Planning Smart Communities. *Smart Cities*. v.2, n.4, p.522 – 537, 2019.

TRAVASSOS, C.; CASTRO, M. F. Determinantes e desigualdades sociais no acesso e na utilização dos serviços de saúde. In: GIOVANELLA, L. et al. (Org.). *Políticas e Sistema de Saúde no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. p. 183-206.

TRICCO, A. C. et al. PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Ann Intern Med*., v.169, n.7, p. 467-473, 2018.

TSOUROS, A. D. The WHO healthy cities project: state of the art and future plans. *Health Promotion International*, Oxford, v. 10, n. 2, p. 133–141, 1995.

TSOUROS, A.; GREEN, G. Healthy cities in Europe: editorial. *J Urban Health*. v.90, sup. 1, p.1-3, 2013.

TSOUROS, A.D. Twenty-seven years of the WHO European Healthy Cities movement: a sustainable movement for change and innovation at the local level. *Health Promotion International*. v. 30, sup.1, p.3-7, 2015.

TSOUROS, Agis D. *City leadership for health and well-being: Governance and action*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2015.

TSOUROS, Agis D.; GREEN, Geoff. Healthy cities: a political process and an innovative program. *Health Promotion International*, v. 28, n. 1, p. 4–10, 2013.

URBINATTI, A.M.; OMORI-HONDA, S.L.; CARVALHO, C.M.; FREY, K.; JACOBI, P.R.; GIATTI, L.L. 'Nexus' Narratives in Urban Vulnerable Places: Pathways to Sustainability via Municipal Health Programs in Brazil. *World*. v.4, n.1, 2023.

WANG, Jun; WANG, Xiangdong; GUAN, Yihong. Healthy Cities and Environmental Sustainability: A Review of Urban Health Indicators. *Environmental Science & Policy*, v. 75, p. 146–155, 2017.

WANG, Y.; WANG, X.; GUAN, F. The Beneficial Evaluation of the Healthy City Construction in China. *Iran J Public Health*. v.46, n.6, p.843-847, 2017.

WAYNSZTOK, L.; ROSSI, P.; CHIARA, M. Los espacios virtuales de asistencia técnica del programa nacional de municipios y comunidades saludables. *Revista Argentina de Salud Pública*, v. 2, n. 9, p. 40-42, 2011.

WEBSTER, P.; SANDERSON, D. Healthy Cities indicators--a suitable instrument to measure health? *J Urban Health*. v.90, Sup.1, p.52-61, 2013.

WEN, Y.; LI, Y.; ZHANG, Y.; LIU, B. Comprehensive evaluation of global health cities development levels. *Front. Public Health*. v.12, 2024.

WESTPHAL, M.F. O modelo de atenção na perspectiva de saúde integral: a promoção da saúde e a estratégia de "municípios saudáveis". *SANARE – Revista de Políticas Públicas*. v.2, n.3, 2013.

WESTPHAL, M.F. O Movimento Cidades/Municípios Saudáveis: um compromisso com a qualidade de vida. Cien. Saude Coletiva. v.5, n.1; 2000.

WESTPHAL, M.F.; MENDES, R. Cidade saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e intersetorialidade. RAP. v.34, n.6, p.47-61, 2000.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on health, environment and climate change: the transformation needed to improve lives and well-being sustainably through healthy environments. Geneva: WHO, 2016.

WHO – World Health Organization. Health indicators: a guide to their use in monitoring and evaluating health and health services. Geneva: WHO, 2010. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/62258>.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health indicators: proposal for a set of indicators to be used in health for all strategy monitoring. Geneva: WHO, 1998. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42174>. Acesso em: 11 jun. 2025.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO, 1986.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Healthy cities: effective approach to a rapidly changing world. Geneva: World Health Organization, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The Ottawa charter for health promotion. Geneve: WHO; 1986.

YANG, J.; LUO, X.; XIAO, Y.; SHEN, S.; SU, M.; BAI, Y.; GONG, P. Comparing the Use of Spatially Explicit Indicators and Conventional Indicators in the Evaluation of Healthy Cities: A Case Study in Shenzhen, China. Int. J. Environ. Res. Public Health. v.17, n.20, 2020.

YANG, L.; HE, B.; CHENG, L.; WANG, R.; AO, Y. Editorial: The physical environment and health: implications for the planning and management of healthy cities. Front Public Health. v.11, 1245561, 2023.

YOSHIZAWA, K. WHO Healthy City Initiative in Japan. Nihon eiseigaku zasshi, v. 68, n. 2, p. 138-143, 2013.

ZHAO, M.; QIN, W.; ZHANG, S.; QI, F.; LI, X.; LAN, X. Assessing the construction of a Healthy City in China: a conceptual framework and evaluation index system. *Public Health*. v.220, p.88-95, 2023.

ZHAO, Yifan et al. Healthy Cities in a global context: history, evolution, and lessons for future development. *Cities*, v. 142, p. 104394, 2023.

ZIAFATI, A.B.; CHESHMEHZANGI, A.; ANKOWSKA, A. A set of 99 healthy city indicators for application in urban planning and design. *Sustainable Development*, v. 31, n. 3, p. 1978-1989, 2023.

APÊNDICE A

Instrumento de coleta de dados - Indicadores de territórios saudáveis e sustentáveis elaborado pelos autores. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO	
TÍTULO DO ARTIGO:	
AUTOR(ES):	
ANO DE PUBLICAÇÃO:	
FONTE:	
LOCAL DE ESTUDO:	
TIPO DE ESTUDO:	

2. DESCRIÇÃO GERAL	
OBJETIVO DO ESTUDO:	
POPULAÇÃO OU CONTEXTO TERRITORIAL ANALISADO:	
MÉTODO DE COLETA / ANÁLISE DE DADOS:	
NÍVEL DE APLICAÇÃO DOS INDICADORES:	() Local () Regional () Nacional () Internacional () Outro: _____

3. INDICADORES RELATADOS	
TOTAL DE INDICADORES DO ESTUDO:	
INDICADORES QUANTITATIVOS:	(listar ou descrever)
INDICADORES QUALITATIVOS:	(listar ou descrever)
FONTE DOS DADOS UTILIZADOS:	() Primária () Secundária () Mista () Não informado
ESCALA DE MENSURAÇÃO (SE APLICÁVEL)	() Individual () Comunitária () Territorial / Ambiental () Outro: _____

4. CLASSIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES

PARA CADA INDICADOR DESCRITO, CLASSIFIQUE AS DIMENSÕES A QUE ELE SE REFERE (MARCAR MAIS DE UMA, SE NECESSÁRIO):

- () Qualidade do espaço urbano
 () Equidade e acesso universal
 () Governança participativa
 () Intersetorialidade
 () Promoção da saúde
 () Economia inclusiva e diversificada
 () Pertencimento e coesão social
 () Planejamento urbano inclusivo
 () Inovação e monitoramento contínuo
 () Qualidade de vida e bem-estar integral
 () Outra: _____

5. NÍVEL DE OPERACIONALIZAÇÃO

OS INDICADORES SÃO:	() Já aplicados na prática () Em construção ou propostos () Teóricos ou conceituais
HÁ DEFINIÇÃO DE MÉTODO DE CÁLCULO / FORMA DE MENSURAÇÃO?	() Sim () Parcial () Não
HÁ VALIDAÇÃO METODOLÓGICA DESCRITA?	() Sim () Parcial () Não

6. POTENCIAL DE SÍNTESE

OS INDICADORES SÃO COMPARÁVEIS COM OUTROS ESTUDOS INCLUÍDOS?	() Sim () Parcial () Não
OS INDICADORES APRESENTAM POTENCIAL DE AGRUPAMENTO POR DIMENSÃO TEMÁTICA?	() Sim () Parcial () Não

7. OBSERVAÇÕES RELEVANTES PARA A SÍNTESE OU CATEGORIZAÇÃO DOS INDICADORES:

--

Fonte: elaboração própria.



PRODUTO 04

DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO A SISTEMATIZAÇÃO DO DIÁLOGO REALIZADO EM RODA DE CONVERSA COM REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, A PARTIR DO CONCEITO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS, VISANDO EVIDENCIAR AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, EM CONSONÂNCIA COM O MARCO 3, COMPROMISSO 8, DO 6º PLANO DE AÇÃO BRASILEIRO NO ÂMBITO DA PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO (OGP).

Autores(as):

- Ana Suelen Pedroza Cavalcante;
- Equipe da Coordenação-Geral de Educação Popular em Saúde (Cgeps/Dgip/SE/MS);
- Marcos Aguiar Ribeiro.

1. INTRODUÇÃO

O 6º Plano de Ação Nacional, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP), é resultado de um amplo esforço de cooperação e construção colaborativa, que envolveu 80 instituições, sendo 47 organizações da sociedade civil e 33 entidades governamentais. Esse processo reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a transparência, a participação social e a inovação democrática na formulação e implementação de políticas públicas.

O debate sobre territórios saudáveis e sustentáveis parte do reconhecimento de que a saúde não se produz exclusivamente nos serviços assistenciais, mas, sobretudo, nas condições reais de vida, trabalho, cultura, relações sociais e ambientais que estruturam o cotidiano das populações. O território, nesse sentido, não se limita a um recorte geográfico ou administrativo, mas se configura como um espaço vivo, marcado por disputas de poder, produção de saberes, memórias coletivas e projetos de futuro.

No contexto do Marco 3, que versa sobre “Territórios Saudáveis e Sustentáveis”, vinculado ao Compromisso 8 do 6º Plano de Ação Nacional, a escuta ativa dos movimentos sociais e populares constitui elemento central para a construção de uma compreensão ampliada sobre como essas dimensões se expressam concretamente nos territórios, especialmente entre os povos do campo, da floresta e das águas. Esses grupos historicamente produzem práticas, saberes e estratégias de sustentabilidade em contextos de profundas desigualdades e adversidades sociais, econômicas e ambientais.

Em outubro de 2024, representantes da então Coordenação-Geral de Articulação Interfederativa e Participativa (CGAIP), atual Coordenação-Geral de Educação Popular em Saúde (CGEPS), vinculada ao Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DGIP/SE/MS), participaram da oficina de co-criação do compromisso 8 intitulado “Participação Social e Educação Popular nos Territórios” promovida pela Controladoria-Geral da União (CGU). Essa oficina teve como finalidade subsidiar a elaboração do 6º Plano de Ação Nacional da OGP.

No âmbito dessa construção, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de “definir e mapear territórios saudáveis e sustentáveis”, isto é, o Marco 3, como estratégia para “estabelecer uma rede colaborativa de formação de agentes territoriais para potencializar a participação social com educação popular, digital e midiática, promovendo territórios saudáveis e sustentáveis”.

A caracterização de territórios saudáveis e sustentáveis envolve tanto a análise de condições mensuráveis, por meio de pesquisas de base nacional e sistemas de informação, quanto de construtos que extrapolam esses registros formais. Assim, esse processo demanda a articulação entre determinantes sociais da saúde, indicadores de condições de saúde da população, acesso e organização dos serviços de saúde, indicadores ambientais e, de forma indissociável, as percepções e experiências vividas nos territórios, reflexões que problematizem os modos de viver e habitar os territórios.

Para construir esse marco, foram contratados, via Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), três consultores responsáveis pela elaboração de estudos que são complementares. O primeiro (produto 1) consistiu em uma revisão de escopo sobre territórios saudáveis e sustentáveis, identificando a polissemia do conceito e uma predominância de indicadores relacionados à sustentabilidade ambiental, à determinação social e ao acesso à saúde. O segundo (produto 2) aprofundou a análise conceitual, identificando antecedentes, atributos e consequentes do conceito, reforçando a centralidade da governança participativa, da intersetorialidade e da equidade. O terceiro (produto 3) estudo sistematizou e georreferenciou indicadores selecionados, evidenciando padrões territoriais críticos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país.

Diante desses achados, emergiu a necessidade de promover um espaço de diálogo direto com os movimentos sociais e populares, de modo a apresentar, tensionar, validar e complementar as evidências produzidas pelos estudos citados anteriormente. Nesse contexto, a roda de conversação configurou-se como estratégia metodológica fundamental, resultando na sistematização aqui apresentada, entendida como um produto adicional do Marco 3, alinhado aos princípios da participação social e da educação popular em saúde.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

- Retratar, à luz do conceito de territórios saudáveis e sustentáveis, os eixos temáticos, códigos e subtemas identificados nos diálogos com movimentos sociais e populares, evidenciando suas contribuições para a formulação de políticas públicas, para a defesa de um Sistema Único de Saúde (SUS) soberano e universal e para a construção de projetos coletivos de sociedade.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sistematizar os principais eixos temáticos relacionados aos territórios saudáveis e sustentáveis, a partir da socialização com movimentos sociais/populares e comunidades;
- Elencar os códigos e subtemas emergentes, articulando-os às diferentes dimensões que compõem o território;
- Contribuir para o fortalecimento da participação popular na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, fundamentado na sistematização de experiências territoriais, inspirado nos referenciais da educação popular em saúde, da pesquisa social crítica e da participação popular, ancorado em resultados de produção anterior.

Para coleta das informações utilizou-se o Círculo de Conversação (Júnior; Silva, 2020) assumindo a orientação metodológica do campo da educação popular. O Círculo de Conversação se configura como uma proposta de reinvenção com questões concretas sobre as etapas de desenvolvimento de processos, assumindo o diálogo junto aos sujeitos, de forma horizontal, tomando vivências, queixas, expressões, situações limites e necessidades específicas como centro dessa conversa, na perspectiva da construção do saber coletivo (Júnior; Silva, 2020).

O presente estudo, portanto, é resultante de diálogos estabelecidos com representantes de movimentos sociais e populares, por meio de uma roda de conversação virtual, configurada como espaço de escuta coletiva, reflexão compartilhada e produção de sentidos. Essa estratégia permitiu que os sujeitos coletivos expressassem suas vivências concretas, conflitos históricos, práticas comunitárias e projetos políticos enraizados nos territórios.

O encontro foi planejado para criar espaços de participação e produção coletiva além de verificar se o que fora encontrado como resultados nos trabalhos realizados, anteriormente, fazia sentido. O diálogo e a escuta das representações de populações de diferentes territórios foram capazes de promover a reflexão crítica sobre a promoção de territórios saudáveis e sustentáveis. A intenção foi ouvir as vozes para quem se constrói as políticas públicas, ao tempo em que contribuir com a protagonização dos sujeitos nessa ação. A realização desse espaço possibilitou ampliar os resultados produzidos, anteriormente, a partir de dados secundários.

Os participantes eram provenientes de todas as regiões do país e de vários estados. Atores e atrizes sociais que hoje estão cursando a Especialização em Educação Popular em Saúde, financiada pelo Ministério da Saúde numa parceria tecno-pedagógica com a Fiocruz Brasília. Por tratar-se de uma ação que envolveu seres humanos seguimos as diretrizes da Conep para pesquisa que obteve aprovação em comitê de ética sob o número 7.787.536.

Os eixos temáticos, códigos e subtemas emergiram das falas dos participantes, sendo posteriormente organizados a partir de categorias emergentes aos discursos proferidos, respeitando a centralidade do território como espaço de vida, cuidado, disputa e produção de saberes. A sistematização buscou articular essas narrativas às dimensões conceituais e analíticas dos territórios saudáveis e sustentáveis, conforme debatidas nos relatórios técnicos que subsidiaram o Marco 3, do Compromisso 8, do 6º Plano de Ação Nacional da OGP.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A roda de conversação ocorreu em 9 de outubro de 2025, no período noturno, das 19h às 21h, contando com a participação de representantes de movimentos sociais e populares de diferentes regiões do Brasil. Os participantes foram convidados por meio de mala direta da CGEPS, composta por contatos de movimentos e lideranças que já haviam participado de atividades promovidas pela coordenação, registrando a presença 20 participantes (figura 1).

Figura 01. Registro das pessoas presentes na reunião virtual. Brasília – DF, 2025.



Fonte: elaboração própria.

A atividade foi aberta pela coordenadora-geral de Educação Popular em Saúde, Maria Rocineide Ferreira da Silva, que acolheu os participantes, reforçou a relevância do espaço e contextualizou o Marco 3 do 6º Plano de Ação Nacional da OGP. Nesse momento ocorreu a pactuação em relação a dinâmica a ser seguida com apresentação dos facilitadores. De imediato, a facilitação foi assumida pelo pesquisador Marcos Aguiar Ribeiro.

Como aquecimento inicial, foi proposta a construção de uma nuvem de palavras, a partir da pergunta norteadora: “O que o termo territórios saudáveis e sustentáveis remete a você?”. Essa atividade permitiu captar percepções iniciais, sentidos compartilhados e elementos simbólicos que atravessam a compreensão dos territórios pelos sujeitos presentes (Figura 2).

Figura 02. Nuvem de palavras. Brasília – DF, 2025.



Fonte: elaboração própria.

Como aquecimento inicial, foi proposta a construção de uma nuvem de palavras, a partir da pergunta norteadora: “O que o termo territórios saudáveis e sustentáveis remete a você?”. Essa atividade permitiu captar percepções iniciais, sentidos compartilhados e elementos simbólicos que atravessam a compreensão dos territórios pelos sujeitos presentes (Figura 2).

Na sequência, foram apresentados os três produtos técnicos elaborados pelos consultores contratados via OPAS, pelo Ministério da Saúde, abordando evidências científicas, análise conceitual e mapeamento georreferenciado de indicadores relacionados aos territórios saudáveis e sustentáveis. Após as apresentações, foi aberto espaço para diálogo, reflexões críticas e contribuições dos movimentos sociais e populares. O momento possibilitou ampliar os achados dos estudos realizados identificando lacunas na literatura sobre o tema, além de incorporar novos elementos que foram possíveis de serem visibilizados com a corporeificação de exemplos realizada nas falas que circularam nesse momento.

4.2 SISTEMATIZAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS

CATEGORIA A - SUSTENTABILIDADE E MANEJO ECOLÓGICO DA TERRA

Esta categoria reúne temas que expressam práticas e princípios de equilíbrio ambiental, respeito à natureza e promoção de ecossistemas saudáveis. A sustentabilidade, nesse contexto, envolve não apenas a preservação dos recursos naturais, mas também a promoção ativa de ecossistemas saudáveis, resilientes e capazes de sustentar condições dignas de vida para as populações que deles dependem.

O manejo ecológico da terra representa um conjunto de práticas baseadas na observação dos ciclos naturais, na mitigação de impactos ambientais e na construção de alternativas contra a degradação. Essa perspectiva considera tanto o conhecimento científico quanto saberes tradicionais associados ao cultivo, à convivência com biomas diversos e à manutenção das condições ecológicas essenciais.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Agroecologia
- Quintais produtivos
- Biodiversidade
- Floresta
- Reflorestamento
- Combate ao desmatamento
- Água saudável
- Ar limpo
- Períodos de cheia e seca
- Semiárido
- Mudanças climáticas
- Catástrofes e ausência de planejamento

CATEGORIA B - DIREITOS TERRITORIAIS E JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

Abrange temas ligados à posse e soberania sobre os bens comuns, ao reconhecimento de direitos coletivos e ao enfrentamento das desigualdades históricas no campo. Algo já percebido nas produções anteriores foi a ausência da categoria campo e tudo que se associa a esta. A necessidade de visibilizar povos de diferentes territórios que habitualmente ficam a margem dos processos de produção da saúde por situarem-se geograficamente distante dos grandes centros e/ou capitais.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Direito à terra
- Subsolo é do povo
- Acesso às riquezas naturais
- Direito de produzir
- Saneamento básico e saneamento rural
- Poluição do campo e das florestas

CATEGORIA C - SABERES, ANCESTRALIDADE E PERTENCIMENTO

Reflete a dimensão simbólica, cultural e afetiva da relação com o território, valorizando a memória, os modos de vida e os conhecimentos tradicionais. A reafirmação dos diferentes modos de viver e a produção do comum a partir da consciência crítica além do reconhecimento da importância do encontro com outros e outras formas de viver.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Respeito aos saberes populares
- Ancestralidade
- Pertencimento
- Consciência coletiva para o manejo da terra

CATEGORIA D - INOVAÇÃO COMUNITÁRIA E TECNOLOGIAS SOCIAIS

Compreende as práticas coletivas e criativas de enfrentamento às desigualdades e de promoção da autonomia das comunidades rurais. Aqui um movimento com narrativas que reafirmam constituições históricas da memória dos povos e os modos de produção da saúde interseccionalizados com o cuidado e o bem viver.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Tecnologias sociais
- Hortas e cozinhas comunitárias
- Quintais produtivos (interseção com sustentabilidade)

CATEGORIA E - CONFLITOS E DESAFIOS ESTRUTURAIS

Engloba temas relacionados às desigualdades de poder, à degradação ambiental e as falhas de planejamento que ameaçam a vida no campo. Também foi mencionado os ataques a vida daquelas pessoas que organizam as lutas pelas vias do cotidiano expondo-se em âmbito pessoal e coletivo.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Devastação
- Hierarquia
- Ausência de planejamento
- Poluição do campo e das florestas

CATEGORIA F - SOBERANIA E PROJETO DE SOCIEDADE

Expressa a construção de um horizonte político baseado na soberania popular, na democracia participativa e na justiça social, afirmando o poder coletivo como fundamento de um projeto de sociedade solidário e digno. Aqui a afirmação com múltiplas vocalizações da necessidade de uma sociedade que repense princípios e modos de expressão e significados de poder.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Soberania
- Democracia
- Equidade
- Justiça
- Poder que emana do povo
- Projeto de sociedade
- SUS Forte
- Dignidade humana
- Espaço de participação social

CATEGORIA G - JUSTIÇA TERRITORIAL E ECONOMIA DA VIDA

Refere-se à defesa do território como espaço de vida e resistência, contrapondo-se aos impactos do capitalismo e aos empreendimentos de destruição. Valoriza a interdependência e a sustentabilidade como bases de uma economia que gere vida. Uma nova estética para expressar (com)posição de territórios e a dimensão de corpo.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Acesso
- Interdependência
- Discussão de classe
- Capitalismo e seus impactos
- Livre de empreendimentos de destruição e morte
- Fértil
- Território vivo

CATEGORIA H - COLETIVIDADE E PODER POPULAR

Reúne expressões de organização comunitária, participação cidadã e autonomia coletiva. Representa o fortalecimento do poder que surge do território e da ação política dos grupos sociais locais. A ação da vigilância que considere indicadores gerais, mas também, singularizados, potencializadora das tomadas de decisão contextualizadas e coletivas.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Coletividade forte
- Comunidade
- Autonomia
- Vigilância popular
- Indicadores singulares que surgem do território

CATEGORIA I - PERTENCIMENTO E ANCESTRALIDADE

Traduz o vínculo identitário e simbólico entre as pessoas e o território, valorizando a sucessão geracional, a memória coletiva e os saberes tradicionais como base de resistência e continuidade.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Pertencimento
- Sucessão
- Memórias
- Vínculo
- Conhecimentos tradicionais
- Cultura local

CATEGORIA J - TERRITÓRIO COMO ESPAÇO ÉTICO E POLÍTICO

Compreende o território como espaço de coexistência, decisões coletivas e valores éticos compartilhados. “O que queremos” sintetiza o ideal de futuro construído a partir da base, enraizada na participação e na dignidade.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Território vivo
- O que queremos
- Interdependência
- Espaço de participação social
- Dignidade humana

CATEGORIA K - SUS FORTE

Representa a defesa de um sistema único de saúde público, universal, gratuito e participativo, ancorado na justiça social e na democracia sanitária. Um SUS forte é aquele que reconhece o território como espaço de cuidado, integra saberes e práticas diversas e garante o direito à saúde como expressão da dignidade humana. Sustenta-se na gestão participativa, na intersetorialidade e na vigilância popular, fortalecendo a autonomia dos povos e a produção de políticas públicas a partir das necessidades reais das comunidades.

Abaixo elencamos os códigos e subtemas que compõe este eixo:

- Universalidade
- Equidade
- Integralidade
- Territorialização do cuidado
- Vigilância popular em saúde
- Controle social
- Gestão democrática
- Promoção da saúde
- Intersetorialidade
- Defesa da vida

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sistematização das contribuições dos movimentos sociais e populares reafirma que os territórios saudáveis e sustentáveis não podem ser compreendidos apenas a partir de indicadores técnicos ou análises quantitativas. Eles são, sobretudo, espaços de produção de vida, memória, luta, pertencimento, resistência e produção coletiva de projetos de sociedade.

O presente produto dialoga diretamente com os três estudos que compõem o Marco 3 do 6º Plano de Ação Nacional da OGP, ao incorporar a dimensão vivencial, simbólica e política dos territórios, complementando as evidências científicas com saberes produzidos no cotidiano das comunidades. Dessa forma, fortalece-se a perspectiva de que a construção de políticas públicas deve se dar de forma intersetorial, participativa e territorializada com escuta efetiva dos atores sociais que habitam lugares e espaços num dado território.

Ao articular os achados da roda de conversação com os objetivos do Marco 3 e com os princípios do governo aberto, este produto contribui para o aprimoramento do conceito de territórios saudáveis e sustentáveis, com destaque para a centralidade da participação popular, da educação popular em saúde e da defesa de um SUS forte, público, universal e democrático.

Por fim, destaca-se que a incorporação sistemática das vozes dos movimentos sociais e populares é condição indispensável para a efetivação de políticas públicas comprometidas com a justiça social, a equidade e a dignidade humana, capaz de refletir concepções abrangentes e inclusivas de territórios como espaços éticos, políticos e coletivos de produção das vidas humanas e não humanas.

REFERÊNCIAS

CASTRO JUNIOR, A. R., DA SILVA, M. R. F. Círculo de conversação como estratégia metodológica qualitativa na produção de saberes em enfermagem. *Research, Society and Development*, v. 9, n.6, e112963521, 2020.



ENCAMINHAMENTOS E DESDOBRAMENTOS

Território saudável e sustentável constitui um construto interdisciplinar que articula saúde, ambiente, economia, desenvolvimento social, participação comunitária, governança, entre outros. Compreende espaços dinâmicos moldados pela interação entre atores locais, políticas públicas e sociedade. É influenciado por múltiplos fatores e reflete a produção social da vida.

As reflexões aqui apresentadas demonstram que grande parte dos estudos identificados sobre o tema foi realizada no continente americano. Nesse contexto, o Brasil apresenta uma contribuição significativa para a temática, fato que pode estar relacionado ao histórico da saúde coletiva no país, marcada pela construção social e epistemológica que considera os determinantes sociais e sua relação com o processo saúde - doença com forte influência da participação social e da educação popular como prática emancipatória.

Neste sentido, um território saudável e sustentável constitui-se como um espaço que integra qualidade ambiental, equidade no acesso a serviços essenciais de saúde e governança participativa. Esse conceito abrange ainda a articulação intersetorial, uma economia diversificada e inclusiva, planejamento urbano inclusivo, sistemas contínuos de inovação e monitoramento, fortalecimento do pertencimento comunitário e coesão social, além do direcionamento estratégico para a promoção da saúde e do bem-estar integral da população. Todos estes preceitos preconizados na carta magna brasileira enquanto conquistas da democracia e direitos da cidadania.

Os produtos apresentados permitem também uma qualificação deste conceito sobre a forma como os territórios saudáveis são compreendidos e podem ser qualificados e mapeados, inclusive. As diversas dimensões já citadas acima se refletem em elenco robusto de indicadores que podem auxiliar na leitura sobre tais territórios. É preciso, sem dúvida, que tais dados sejam aprofundados e submetidos ao contexto brasileiro com maior constância, mas certamente apontam possibilidade de entendimento sobre como mapear e entender tais territórios.

Além dos indicadores qualitativos e quantitativos são apontados antecedentes (bases e preceitos) e os consequentes (consequências e resultados) que apontam os TSS como uma construção histórica e pautada em projetos político-sociais que agem nos ecossistemas e comunidades com a intenção de melhoria das condições de vida e existência de cada localidade, com participação.

Somada ao rol de indicadores a descrição de um caso modelo de territórios saudáveis, um caso-límitrofe e de um caso-contrário apresenta-se como uma possibilidade para georreferenciar tais práticas, auxiliando na leitura sobre a inserção da temática no âmbito das políticas públicas. No caso do setor saúde é preciso avançar na definição de diferentes categorias de indicadores, que permitam dialogar com a necessidade e características de cada território, uma vez que a desigualdade social se reflete amplamente nos resultados e perfil de morbi-mortalidade. Fato que se expressa, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste que apresentam os piores indicadores de saúde e sustentabilidade do país.

Estes elementos reforçam a importância da definição de um rol de indicadores macro que permita uma leitura e georreferenciamento nacional/regional, assim como de indicadores que possam ser utilizados a nível local/municipal e que conectem com a sempre necessária qualificação da atenção primária, da atuação dos movimentos sociais, organizações comunitárias e em diálogo com a vigilância popular.

Além disso, a sistematização das contribuições dos movimentos sociais e populares reafirma que os territórios saudáveis e sustentáveis não podem ser compreendidos apenas a partir de indicadores técnicos ou análises quantitativas. Eles são, sobretudo, espaços de produção de vida, memória, luta, pertencimento, resistência e produção coletiva de projetos de sociedade. Reafirmou-se a importância da centralidade da participação popular, da educação popular (em saúde) para conferir materialidade e poder de resposta as necessidades reais superando situações limites que atravessam a possibilidades de constituição de territórios saudáveis e sustentáveis. Sem escuta de quem vive e convive no território inviabiliza-se o encontro de respostas concretas e a efetivação de políticas.

Destaca-se a importância da continuidade do debate no âmbito intra e inter ministerial assim como a aproximação constante com as bases comunitárias mediadas pela educação popular em saúde. Conclui-se que o estudo sobre territórios saudáveis e sustentáveis apresenta uma oportunidade de qualificação da atuação das políticas públicas e do diálogo com a população e movimentos sociais em cada território, tendo como base os elementos já apresentados e sua posterior qualificação.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

